

MMPI UYGULAMA VE YORUMLAMA REHBERİ

John R. GRAHAM

Çeviren: Doç. Dr. Oya SORİAS



**Türk Psikologlar Derneği Yayınları
Ankara, 1998**

MMPI Uygulama ve Yorumlama Rehberi

Genişletilmiş 2. Baskı

John R. Graham

Çeviri: Doç. Dr. Oya Sorias

Teknik Editör: Psk. İlkcan PARLAK

Sayfa Düzeni ve Kapak Tas.: Renkli Tasarım **Tel:** 229 02 90

Baskı: Sözkesen Matbaacılık **Tel:** 342 50 25

- I. Baskı: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir, 1996
II. Baskı: Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 1998

© Türk Psikologlar Derneği, 1998

Bu kitap Türk Psikologlar Derneği yayınıdır. Kitabın tamamı ya da bölümleri, kaynak gösterilerek yapılacak kısa alıntılar dışında, yayıncının yazılı izni olmadan hiçbir yolla çoğaltılamaz.

İnkılap Sk. 31/6 Kızılay 06650 ANKARA

Tel: (0.312) 425 67 65 • Tel/Faks: (0.312) 417 40 59

e-mail:TPD@service.raksnet.com.tr

WEB:http://www.psikolog.org

Türk Psikologlar Derneği Yayınları No: 15

ISBN: 975-9756-15-3

İÇİNDEKİLER

Çevirenin Önsözü	88/86	72
I. GİRİŞ	69/96	72
MMPI Testinin Genel Özellikleri	78/87	73
Orjinal Amaç	89/98	73
Rasyonel		
Klinik Ölçeklerin Gelişimi		
Geçerlik Ölçeklerinin Gelişimi		
Günümüzde MMPI'nin Kullanımı		
II. UYGULAMA VE PUANLAMA		
Test Formları		
Kısa Formlar		
Profilin Çizilmesi		
III. GEÇERLİK ÖLÇEKLERİ		
Bilmiyorum (?) Ölçeği		
L Ölçeği		
F Ölçeği		
K Ölçeği		
Geçersiz Profiller		
IV. KLİNİK ÖLÇEKLER		
1. Ölçek (Hipokondria)		
2. Ölçek (Depresyon)		
3. Ölçek (Histeri)		
4. Ölçek (Psikopatik Sapma)		
5. Ölçek (Erkeklik-Kadınlık)		
6. Ölçek (Paranoya)		
7. Ölçek (Psikasteni)		
8. Ölçek (Şizofreni)		
9. Ölçek (Hipomani)		
0. Ölçek (Sosyal İçedönme)		
V. İKİLİ YÜKSELME TİPLERİ		
12/21		
13/31		
14/41		
18/81		
19/91		
23/32		
24/42		
27/72		
28/82		
29/92		
34/43		
36/63		
38/83		
45/54		
46/64		
47/74		
48/84		
49/94		
VI. SIK KULLANILAN ARAŞTIRMA ÖLÇEKLERİ		
Anksiyete (A) ve Represyon (R)		
Açık Anksiyete Ölçeği (MAS)		
Ego Gücü Ölçeği (Es)		
Bel Ağrısı Ölçeği (Lb)		
Arka Beyin Hasarı Ölçeği (Ca)		
Bağımlılık Ölçeği (Dy)		
Üstünlük Ölçeği (Do)		
Sosyal Sorumluluk Ölçeği (Re)		
Önyargı Ölçeği (Pr)		
Sosyal Durum Ölçeği (St)		
Kontrol Ölçeği (Cn)		
Son Bir Uyarı		
VII. GENEL BİR YORUMLAMA YAKLAŞIMI		
Genel Bir Yaklaşım		
Test Alma Tutumu		
Uyum Düzeyi		
Tiplik Özellikler ve Davranışlar		
Dinamik ve Etiyoloji		
Tanısal İzlenimler		
Tedavi Konusunda Öneriler		
Bazı Özel Başvuru Soruları		
İnlihar		
Acting-Out Davranışı		
Psikoz		
Organik/Fonksiyonel Etiyoloji		
Alkolizm ve Madde Bağımlılığı		
Bir Vaka Örneği		
Aştırma İçin Ek Profiller		
Son Bir Yorum		
VIII. MMPI KİŞİLİK ENVANTERİNİN BUGÜNKÜ DURUMU		
MMPI'nin Revizyonu ve Yeniden Standardizasyonu (MMPI-2)		
MMPI 2'deki Temel Değişiklikler		
Türkiye'de Yapılan MMPI Araştırmaları		
KAYNAKLAR		
EKLER		
Ek A. Sık Kullanılan Araştırma Ölçeklerinin Maddeleri		
Ek B. Grayson'un Kritik Maddeler		
Ek C. Aştırma İçin Türk Klinik Örneklerinden Profiller		

ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ

Bu el kitabı, John R. Graham'ın, "The MMPI: A Practical Guide" adlı eserinin 1982 yılında yayınlanan 6. baskısının çevirisidir. Yazarın amacı testin metodolojisi ve kullanımı hakkında bilgi edinmek isteyen, psikoloji, tıp, psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin ve klinisyenlerin (psikolog, psikiyatrist, sosyal çalışmacı, hekim gibi) çalışmalarında yararlanabilecekleri bir başvuru kitabı sunmaktır. MMPI testi üzerine yazılmış pek çok kitap içinde, açık ve sade anlatımı ile dikkati çeken eserde, yazarın, özellikle yorumlama işlemine yaklaşım tarzı uygulamaya yeni başlayan kişiler için iyi bir rehber niteliğindedir. Kitabın yazımında kullanılan yoruma ilişkin bulgular, değişik kaynaklardan alınmış ve yazar tarafından biraraya getirilmiştir. Kullanılan bilgilerin, klinik tecrübelerden çok ampirik çalışmalara dayalı olmasına özen gösterilmiştir.

Kitabın iki bölümü dışında tümü Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu bölümlerden biri, ülkemizde çok az araştırılan ve normları bulunmayan MMPI ölçeklerini içermektedir. Diğerinde ise, Amerika'daki bilgisayarlı MMPI yorum merkezleri tanıtılarak, raporlarından örnekler verilmektedir.

Çeviren tarafından yazılan son bölümde, MMPI testiyle ilgili son gelişmeler ve Türkiye'de yapılan MMPI çalışmaları gözden geçirilmiştir. Testi kullanmak isteyen herkesin özellikle ülkemizde yapılan araştırmalardan elde edilen verileri çok iyi bilmesi gerektiği düşünüyordum. Ayrıca okuyuculara ilk sekiz bölümde yer alan yoruma ilişkin bilgileri kullanırken çok ihtiyatlı davranmalarını gerektiğini hatırlatmak istiyordum. Bu bilgilerin tümünün başka bir kültürde yapılan geçerlik araştırmalarından elde edildiği hiçbir zaman unutulmamalıdır.

Son olarak, bu çevirinin gerçekleşmesinde bana yardımcı olan kişilere teşekkür etmek istiyordum. Uzm. Psk. Gül Varan ve 1989-1991 yılları arasında bölümümüzde yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan Nilüfer Karaca, Mürüvet Banaz, Meral Türk, Nevnihal Şengül, Nurcihan Bolel ve Birgül Gökçe'ye katkı ve yardımları için teşekkür ederim.

Doç.Dr. Oya Sorias

I GİRİŞ

MMPI TESTİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI-Minnesota Multiphasic Personality Inventory) kişinin kendi yanıtladığı 566 maddeden oluşmuştur. Testi alan kişi, her bir maddenin kendisine uygun olup olmadığını düşünerek, "doğru", "yanlış" ya da "bilmiyorum" yanıtlarından birini seçer. Uyarıcı belirsiz olmadığı ve kişinin teste verebileceği cevaplar sınırlandırıldığı için MMPI testi kişiliği objektif olarak değerlendiren bir teknik olarak kabul edilir. Bugüne kadar objektif ve projektif değerlendirme yöntemlerinin farklılıkları üzerine çok şey söylenmiştir. Kullanılan uyarıcının belirsizliği ve cevapların önceden sınırlandırılması gibi farklılıkların yanı sıra objektif ve projektif tekniklerin, testin yorumu sırasında gerek duyulan klinik beceri açısından da farklı oldukları öne sürülmüştür. Ancak klinik uygulamalarda her iki teknik arasında böyle bir ayırımdan söz etmek mümkün değildir. Matarazzo'nun (1972) belirttiği gibi, "hem objektif hem de projektif testlerin yorumu, son derece iyi eğitilmiş ve tecrübeli uygulayıcılar gerektiren subjektif bir sanattır. Ancak böyle uygulayıcılar sayesinde test puanları anlam kazanır ve kişinin "yaşamına ilişkin öngörülerde bulunmak mümkün olur."

Bireysel ya da grup uygulamasından sonra, kişinin yanıtları elle ya da bilgisayar aracılığıyla objektif bir şekilde puanlanır. Puanlama işlemi sonucunda 4 geçerlik ve 10 klinik ölçeğe ilişkin puanlar elde edilir. Bu standart ölçeklerin yanı sıra çok sayıda ilave ölçek geliştirilmiştir. Geçerlik ve klinik ölçeklerin ham puanları T puanlarına (ort.=50; s.s.=10) çevrilir. Ham puanlar T puanına dönüştürülürken Amerika'da, Minnesota normal grubundan elde edilen verilerden yararlanılır (Hathaway ve McKinley 1967). (Türk standardizasyon grubundan elde edilen T puanı değerleri Savaşır tarafından 1981 yılında yayınlanmıştır.) Envanterin kadın ve erkekler için ayrı normları vardır. Profil çizerken T puanlarından yararlanılır. Bu profil, incelenen kişinin özellikleri hakkında yapacağımız tahminler için bir temel görevi görür.

ORJİNAL AMAÇ

MMPI ilk olarak 1943 yılında Amerikan Psikoloji Birliği (American Psychological Corporation) tarafından yayınlanmıştır. Testin yazarları Starke Hathaway (Ph.D) ve Jovian McKinley (MD), Minnesota Üniversitesi hastanesinde çalışıyorlardı ve MMPI'nin rutin tanınal değerlendirme için yararlı olacağını ümit ediyorlardı. 1930'lu yılların sonu ve 1940'ların başında klinik psikologların ve psikiyatristlerin başlıca amaçları vakalara doğru ve isabetli tanınal etiketler koymaktı. Günlük uygulamalarda, her hasta bireysel görüşmeye alınmakta ve çeşitli psikolojik testlerle değerlendirmekteydi. İşte bu nedenle gruplara uygulanabilen bir kağıt-kalem kişilik envanterinin tanınal değerlendirme için çok yararlı olacağı düşünülüyordu.

RASYONEL

Hathaway ve McKinley, MMPI'nin ölçeklerini geliştirirken, cevap anahtarlarını ampirik yaklaşımla hazırlamışlardır. Denek gruplarını birbirinden ayıran maddeleri deneysel olarak belirlemeye dayanan bu yaklaşım günümüzde oldukça sık kullanılmaktadır. Ancak MMPI'nin yayınlandığı yıllarda önemli bir yenilikti. Daha önceki envanterlerin anahtarları hep mantıksal bir yaklaşımla oluşturulmuştu. Bu yaklaşım içinde, test maddeleri yüz geçerliğine (face validity) göre rasyonel bir şekilde seçilir ve yanıtların anahtarı yazarın ölçülen özellikle ilgili subjektif yargılarına göre hazırlanır. Hem klinik tecrübeler hem de araştırma bulguları mantıksal yaklaşım konusunda kuşkular uyandırmıştır. Zamanla, bu şekilde hazırlanan envanterlerde, kişinin yanıtlarını çarpıttığı ve kendini istenen şekilde gösterdiği açıkça ortaya çıkmaya başlamıştır. Ayrıca deneysel çalışmalar, yazarın subjektif yargılarına dayanılarak değerlendirilen tepkilerin sıklıkla, gruplar arasındaki gerçek farklılıklarla ilişkili olmadığını göstermiştir. Daha yeni olan ampirik yaklaşımda, bireyin test maddelerini nasıl yanıtlayacağı önceden tahmin edilmez ve kriter gruplarını birbirinden ayıran test maddelerini belirlemek için ampirik madde analizlerinden yararlanılır. Bu şekilde daha önceki subjektif yaklaşımdan kaynaklanan pek çok sorunun üstesinden gelinmiştir.

KLİNİK ÖLÇEKLERİN GELİŞİMİ

MMPI'nin hazırlanması sırasında ilk adım, çok sayıda maddeyi biraraya toplamak olmuştur. Hathaway ve McKinley, psikolojik ve psikiyatrik vaka öykülerinden, ders kitaplarından ve daha önce yayınlanmış kişilik ve sosyal tutum ölçeklerinden kişilikle ilgili çeşitli önermeler çıkarmışlardır. Yazarlar daha sonra, sayısı 1000'e yaklaşan bu önermeler içinden birbiriyle ilişkili görünmeyen 504 maddeyi ayırmışlardır.

İkinci adım, kriter gruplarını seçmek olmuştur. Kriter gruplarından birini, Minnesota Üniversitesi Hastanesinde yatan hastaların ziyaretçileri

oluşturmuştur. Minnesota normalleri olarak adlandırılan bu gruba daha sonra başka normal gruplar da (üniversite hazırlık kurslarına katılan lise mezunu kişiler, üniversite hastanesinde yatan medikal hastalar ve işçiler) eklenmiştir. Klinik grup olarak bilinen ikinci büyük grup ise aynı hastanede psikiyatrik tedavi gören hastalardan oluşmuştur. Bu gruptaki hastalar, o yıllarda kullanılan temel psikiyatrik tanı kategorilerinin tümünü temsil etmekteydi. Klinik grup aldıkları tanıya göre farklı alt gruplara ayrılmıştır. Hastanın tanısı kuşkuluydu ya da birden fazla tanısı varsa klinik örneklemeye dahil edilmemiştir. Farklı klinik alt gruplar şu şekilde ayrılmıştır: Hipokondri, depresyon, histeri, psikopatik sapma, paronaya, psikasteni, şizofreni ve hipomani. Ölçekleri hazırlamada son adım, testin maddelerini normal ve klinik gruplara uygulamak olmuştur. 504 maddenin, klinik gruplarla normal grubu anlamlı bir şekilde ayırt edip etmediğini belirlemek amacıyla her klinik grup için madde analizi yapılmıştır. Bu şekilde belirlenen maddeler ait oldukları klinik ölçeklerin içinde toplanmıştır.

Araştırmacılar hazırlanan klinik ölçeğin (örneğin depresyon ölçeğinin) geçerliğini araştırmak için yeni bir normal ve klinik gruba (depresyon tanısı almış) testi uygulamışlardır. Eğer normal ve tanısı belli klinik grubun puanları arasında anlamlı farklılıklar varsa, klinik ölçeğin geçerli olduğu ve bundan sonra tanısı bilinmeyen hastalar üzerinde ayrıntılı tanısız değerlendirme amacıyla kullanılabileceği sonucuna varmışlardır.

Bir süre sonra, envantere iki klinik ölçek daha eklenmiştir. Bunlardan biri olan Erkeklik (Masculinity)-Kadınlık (Femininity) (Mf) ölçeği, homoseksüel erkeklerle, heteroseksüel erkekleri ayırt edebilmek için hazırlanmıştır. Ancak bu iki grubun farklı yanıtladıkları madde sayısı çok az olduğundan, Hathaway ve McKinley Mf ölçeğini hazırlamak için kullandıkları yaklaşımları sonradan değiştirmek zorunda kalmışlardır. Sonuçta, ilk çalışmadan elde edilen az sayıdaki maddeye, normal erkeklerle normal kadınların farklı şekilde yanıtladığı MMPI maddelerini ve "Terman ve Miles I" (1936) ölçeğinden alınmış bazı maddeleri eklemişlerdir.

Sonradan envantere eklenen ikinci ölçek olan Sosyal İçedönme (Si) ölçeği, Drake (1946) tarafından hazırlanmış ve MMPI'nin temel ölçeklerinden biri haline gelmiştir. Her ne kadar başlangıçta bu ölçeğin maddeleri, ders dışında pek çok aktiviteleri olan kız üniversite öğrencileri ile sosyal katılmaları az olan kız üniversite öğrencilerini ayırt eden maddeler arasından seçilseyse de, ölçek, daha sonra erkekler için de kullanılmıştır.

GEÇERLİK ÖLÇEKLERİNİN GELİŞİMİ

Hathaway ve McKinley envanteri hazırlarken, daha sonra geçerlik ölçekleri olarak tanınan ve normalden sapmış yanıtlama tutumlarını gösteren dört ölçek daha geliştirmişlerdir. Bunlardan "Bilmiyorum" ölçeği ya da kategorisi basitçe, testi alan kişinin atladığı ya da boş bıraktığı maddelerin toplamını gösterir. Kuşkusuz boş bırakılan maddelerin sayısı çoğaldıkça klinik ölçeklerin puanları düşer ve profilin yorumlanabilirliği tartışılır.

Başlangıçta "Yalan" ölçeği olarak adlandırılan L ölçeği ise, kişinin kendini olumlu bir şekilde tanıtmak için başvurduğu, pek karmaşık ve ustaca olmayan çabaları belirlemek için hazırlanmıştır. Mantıksal yaklaşımla oluşturulan L ölçeği maddeleri, kişinin karakterindeki küçük zayıflıkları kabul etme cesaretini gösterip göstermediğini değerlendirir. Bu maddelere bir örnek, "Hergün gazetelerin baş yazılarını okumam"dır. İnsanların çoğu hergün gazetelerde yayınlanan baş yazıları okumadıklarını kolayca kabul ederken kendini olumlu bir şekilde tanıtmak isteyen kişiler, bu küçük ihmalkarlığı bile yadsırlar.

MMPI'nin F ölçeği, test alma görevine, yazarların amaçladığından farklı şekilde yaklaşan kişileri belirlemek için yapılandırılmıştır. Yazarlar F ölçeği maddelerini seçerken, Minnesota normal grubunun her maddeyi hangi sıklıkla işaretlediklerini incelemişler ve normallerin %10'nundan daha azı tarafından doğru ya da yanlış şeklinde işaretlenen maddeleri ayırmışlardır. Maddeleri, normallerden farklı yanıtlayan bir kişinin diğer tepkilerinde de sapma olabileceği düşünülmüştür.

MMPI'nin K ölçeği, klinik savunmacılığı belirlemek için geliştirilmiştir. K ölçeği maddeleri, hasta oldukları halde normal MMPI profili veren kişilerin test yanıtları ile psikopatoloji belirtisi göstermeyen ve normal profil veren kişilerin test yanıtları ampirik olarak karşılaştırılarak hazırlanmıştır. Yüksek K puanının savunmacılığı göstereceği ve kişinin testi yanıtlayış tarzı konusunda fikir vereceği düşünülmüştür. K ölçeği daha sonra, bazı klinik ölçeklerin puanını düzeltme amacıyla da kullanılmaya başlanmıştır.

Hathaway ve McKinley'in düşüncelerine göre, savunmacı test tutumu K ölçeğinde yükselmeye, klinik ölçeklerde ise düşmeye yol açıyorsa, bu tutum olmasaydı ölçeklerin ne kadar yükseleceği ve kişinin gerçek davranışlarının ne olacağı tahmin edilebilir. Bu nedenle yazarlar K ölçeği tarafından belirlenen savunmacılığı düzeltmek için her bir klinik ölçeğe belli K oranları eklemişlerdir. Ancak bazı ölçeklere, ham puan kişinin klinik durumunu daha iyi yansıttığı için K düzeltme işlemi uygulanmaz.

GÜNÜMÜZDE MMPI'IN KULLANIMI

Klinik uygulamaların ve geçerlik çalışmalarının üstünden on yıl geçtikten sonra, MMPI testinin, başlangıç amacına pek ulaşamadığı, yani tanısı bilinmeyen hastaları geçerli bir şekilde sınıflandıramadığı görünür hale gelmiştir. Belli bir tanı grubundan (örneğin depresyon) gelen bir hastanın, beklenen klinik ölçekten (Depresyon ölçeği) yüksek puan almasına rağmen, profile başka klinik ölçeklerin de yükseldiği görülmüştür. Üstelik pek çok normalin, bir ya da birkaç klinik ölçekten yüksek puanlar aldıkları bulunmuştur. Açıkça, klinik ölçeklerin, adlarının düşündürdüğü sendromların saf bir ölçümünü yansıtmadığı ortaya çıkmıştır.

MMPI'nin bu başarısızlığı için çok sayıda neden ileri sürülmüştür. İlerleyen çalışmalar, MMPI'nin klinik ölçeklerden çoğunun birbiriyle ilişkili olduğunu ve bu nedenle yalnızca tek bir ölçeğin yükselmesinin pek müm-

kün olmadığını göstermiştir. Aynı zamanda bazı psikiyatrik tanı kategorilerinin güvenilirliğinin düşük olması, MMPI ölçeklerinin klinik grupları ayırt etme gücünü azaltmaktadır.

Bu nedenle, MMPI günümüzde, başlangıç amacından oldukça farklı bir şekilde kullanılmaktadır. Farklı tanı gruplarından gelen kişilerin test puanları arasında güvenilir farklılıklar olduğu için, klinik ölçeklerin bazı özellikleri ölçtüğü kabul edilmektedir. Yeni bir yaklaşımla, bu özelliklerin ne olduğu, klinik tecrübeler ve deneysel çalışmalarla araştırılmıştır. Bir kişi herhangi bir ölçekten yüksek puan aldığı anda, klinisyen o kişinin daha önceki çalışmalarla, benzer puan almış kişilerde belirlenen özellikleri gösterebileceği sonucuna varır. Bu yeni yaklaşım, klinik ölçeklerin adlarına atfedilen anlamları değiştirme gereğini getirdiği için günümüzde, klinik etiketler yerine aşağıdaki numaralar kullanılır.

Ölçek Numarası	Ölçek Adı
1	Hipokondria
2	Depresyon
3	Histeri
4	Psikopatik Sapma
5	Erkeklik-Kadınlık
6	Paranoya
7	Psikastenî
8	Şizofreni
9	Hipomani
0	Sosyal İçedönme

Böylece, MMPI uzmanları kendi aralarında bir hastadan söz ederken 4-9 yada 1-2-3 gibi ifadeler kullanarak, dinleyiciye bu ifadelerle ilişkili belirli davranış tanımlamalarını iletirler.

Ampirik çalışmalarla, yalnız yüksek puanlara karşılık gelen davranışsal özellikleri değil, aynı zamanda düşük puanlara ve ölçeklerin çeşitli kombinasyonlarına karşılık gelen özellikleri belirlemek mümkün olmuştur. Bazı araştırmacılar, MMPI profillerini sınıflandırmak ve her bir grubu karakterizleyen davranışsal özellikleri belirlemek için son derece karmaşık kuralları bulmuşlardır. Sonuç olarak, MMPI testi başlangıç amacına ulaşamamasına rağmen, elde edilen profile dayanılarak kişi (normal ya da hasta) hakkında tahminlerde bulunulabileceği ve davranışlarının tanımlanabileceği kanıtlanmıştır.

II

UYGULAMA VE PUANLAMA

MMPI'nin önemli bir özelliği, ancak tecrübeli klinisyenler tarafından yorumlanabilmesine karşılık, profesyonel olmayan uygulayıcılar tarafından bireylere ya da gruplara kolayca verilebilmesidir. Farklı MMPI formları sayesinde testin uygulama alanı da bir hayli genişletilmiştir. Ayrıca, elle ya da bilgisayar aracılığıyla testi objektif bir biçimde puanlamak mümkündür. İşte bu özellikler nedeniyle, MMPI kullanıcılarının, testin uygulama ve puanlama aşamalarında bazen pek dikkatli davranmadıkları görülmektedir. Oysa diğer psikolojik testlerde olduğu gibi, gereken standart koşullara dikkatle uyulmalıdır. Testi uygulayan kişiler, "El Kitabında" (Manual: Hathaway & McKinley, 1967) anlatılanlar ve uygulama sırasında çıkabilecek sorunlar konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar.

El kitabında, en az 6 yıl eğitim görmüş, 16 yaş ve üstündeki herkesin MMPI testini tamamlayabileceği belirtilir. Eğer uygun bir şekilde motive edilip, dikkatle denetlenirse daha az eğitilmiş kişilerin bile testi alabildikleri görülmüştür. Testin kimlere uygulanabileceğini belirlerken, göz önünde bulundurulması gereken temel etken kişinin okuma düzeyidir. Bazı uygulayıcılar, kişinin testi alabilecek kadar iyi okuyup okumadığına karar verebilmek için testin bazı maddelerini yüksek sesle okuturlar. MMPI uygulamadan önce okuma yeteneğini değerlendiren kısa ölçeklerden yararlanan uygulayıcılar da vardır.

Testin kimlere uygulanabileceğini gösteren bir başka önemli etken yaşıdır. Görme engeli yoksa ya da başka fiziksel sorunlar engellemiyorsa test ileri yaşlarda da uygulanabilir. Her ne kadar, El Kitabında (Hathaway & McKinley, 1967) testin 16 yaş ve üzerindeki kişiler için uygun olduğu belirtilmişse de, testin 13 ya da 14 yaşındaki gençlere de başarıyla uygulanabildiği görülmüştür. Ancak, gençlerin test maddelerini kolayca anlayabilmelerine, uygulama sırasında dikkatli ve istekli görünmelerine rağmen yaşam deneyimlerinin kısıtlı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle pek çok maddenin içeriği gençler için yeterince anlamlı olmayabilir. "El Kitabının" ekler bölümünde gençler için ayrı norm tabloları sunulmuştur (Dahlstrom ve ark 1972).

Envanteri uygulamaya karar verirken, vakanın klinik tablosu da dikkate alınmalıdır. Pek çok insan için MMPI testini tamamlamak son derece uzun ve can sıkıcı bir iştir. Çok anksiyöz ve ajite kişiler genellikle bu işi

dayanılmaz bulurlar. Böyle kişilere test parçalara ayrılarak uygulanabilir. Konfüzyon içindeki kişiler ise, standart yönergeyi anlayamayabilir ya da uygulamakta güçlük çekebilirler. Bu durumda testin kitapçık formu yerine kutu ya da bant formu uygulanabilir. Bazı uygulayıcılar ise, test maddelerini yüksek sesle okumayı ve kişinin cevaplarını kendileri işaretlemeyi uygun bulmaktadır.

Testi bireysel olarak ya da grup içinde uygulamak mümkündür. Zeka düzeyi ortalama ya da ortalamadan üstünde olan kişiler, uygulamayı güçleştiren herhangi bir etken olmadığında, testi 1-1,5 saat arasında tamamlarlar. Zeka düzeyi biraz daha düşük ise ya da uygulamayı güçleştiren etkenler varsa test süresi 2 saatin üstüne çıkabilir. Bazen, deneğin testi evinde doldurup getirmesi daha uygun olsa da, uygulamanın klinisyenin odasında, profesyonel bir atmosfer içinde yapılmasına olabildiğince gayret edilmelidir.

MMPI testi hangi ortamda uygulanırsa uygulansın, testin verilme amacının deneye açıklanması ve test sonuçlarının gizli tutulacağı konusunda güvence verilmesi önemlidir. Testin niçin uygulandığını, sonuçların kimlere verileceğini ve elde edinilen bilginin kendi yararına kullanılacağını bilen bir kişi işbirliğine daha açık olur. Bu da verilerin daha anlamlı olmasına yol açar.

TEST FORMLARI

Farklı MMPI formlarının bulunması, testin hemen her kesimden insana uygulanabilmesini sağlamaktadır. Bireysel uygulamalar, grup uygulamaları, körler ya da okuma bilmeyenler için ayrı formlar vardır. Bu bölümde en sık kullanılanlar üzerinde durulacaktır.

Bireysel (Kutu) Formu

Kutu formunda 550 maddenin her biri 8 x 9 cm boyutlarında kartlara basılmıştır. Kartlar, içinde yönergenin de bulunduğu tahta kutuda rastgele bir sıra ile sunulur. Kutunun "DOĞRU", "YANLIŞ" ve "BİLMİYORUM" şeklinde adlandırılmış bölümleri vardır. Testi alan kişiye her maddeyi okuyup o maddenin kendine uyup uymadığına karar verdikten sonra "DOĞRU", "YANLIŞ" ya da "BİLMİYORUM" bölmlerinden birine yerleştirmesi söylenir. Yönergede bilmiyorum bölümüne konan kart sayısının 10'u geçmemesi belirtilir.

Kutu formu, özellikle eğitim düzeyi düşük olan ve kitapçık formunu tamamlamada güçlük çeken kişiler için uygulanır. Bu form, cevapları ayrı bir kağıtta işaretlemekte zorlanan şaşkın ve huzursuz görünümlü kişiler için de kullanılabilir.

Grup (Kitapçık) Formu

Hem bireysel hem de grup uygulamalarında kullanılabilen bu formda 566 madde küçük bir kitapçıkta toplanmıştır. Puanlamayı daha ekonomik bir hale getirebilmek için 16 madde tekrarlanmıştır. Kitapçığın önünde

bulunan yönergede, kişilerden, test maddelerini teker teker okuyarak kendileri için uygun olup olmadığına karar vermeleri ve buna göre yanıt kağıdındaki "DOĞRU" ya da "YANLIŞ" seçeneklerinden birini işaretlemeleri istenir. Eğer maddenin içeriği kendisi için birşey ifade etmiyorsa ya da o konuda hiç bir şey bilmiyorsa cevap vermemesi söylenir.

Grup formu için farklı tipte yanıt kağıtları vardır. En çok kullanılan yanıt kağıdı, IBM 805 puanlama makinesine uygun şekilde hazırlanmış olanıdır. Bu yanıt kağıdında "DOĞRU" ya da "YANLIŞ" diye ayrılan boşluklar 1'den 566'ya kadar sıralanmıştır ve incelenen kişi kendi yanıtına uygun olacak şekilde boşlukları karalar. Bu kağıt, bilgisayarda ya da puanlama şablonlarının yardımıyla elle puanlanabilir. Elle puanlama yapılırken "BİLMİYORUM" puanı, boş bırakılan ve hem "DOĞRU" hem de "YANLIŞ" olarak işaretlenen maddeler sayılarak bulunur. L puanı ise aşağıdaki maddelere verilen YANLIŞ yanıtlarının sayılması ile elde edilir: 15, 45, 75, 105, 135, 165, 195, 225, 255, 285, 30, 60, 90, 120, 150. Bu maddelerin yanıt kağıdına kolayca belirlenebilecek şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. F ve K ölçekleri ile diğer 10 temel klinik ölçeğin ham puanları, uygun şablonların yanıt kağıdının üzerine konulması ve karalanmış yerlerin sayılması ile kolayca belirlenir. K, Pa, Pt, Sc ve Si ölçekleri için iki (ön ve arka olarak), diğer ölçekler için ise birer şablon vardır. Mf ölçeğinin ham puanı kadın ve erkekler için ayrı şablonlar kullanılarak bulunur.

R Formu

Testin, R Formunda, 566 maddenin yer aldığı kitapçık sert kapaklar arasına alınarak bir tele geçirilmiştir. Bu özelliği nedeniyle bir masa ya da sıra olmasa da kullanılabilir.

Teyp Formu

MMPI maddelerinin standart bir teyp kaydı da vardır. Okuma zorluğu olan ve diğer formları doldurmada zorluk çeken kişiler için bu form uygundur. Teyp kişi tarafından çalıştırılır ve her maddeden sonra durdurulur. Yanıtlar ya denek tarafından ya da uygulayıcı tarafından kaydedilir. Maddeler grup formuyla aynı sıradadır. Bu nedenle aynı yanıt kağıdı ve puanlama yöntemi kullanılabilir.

KISA FORMLAR

MMPI'ı tamamlamak uzun bir süre gerektirdiğinden, testin kısaltılmış formlarının geliştirilmesi için çok çaba harcanmıştır. Ancak kısa formların kullanımı daima bilgi kaybına neden olmaktadır. Sonradan geliştirilen pek çok ilave ölçek bütün MMPI maddeleri uygulanmadıkça puanlanamamaktadır. Kısa bir form kullanmaya karar vermeden önce, uygulayıcı, kimin için zamanın önemli olduğunu düşünmelidir. Çünkü, MMPI genelde klinisyen tarafından uygulanmaz. Kısa form kullanılarak elde edilecek olan zaman tasarrufu testi alan kişi ya da testi veren memur için önemlidir. Co-

ğu kez, test uygulama süresini azaltmayı gerektiren bir neden yoktur. Ancak test süresi sınırlı ise, uygulayıcı kısa bir form kullanmayı düşünebilir.

En çok kabul gören kısaltılmış form, yalnızca geçerlik ve temel klinik ölçekleri puanlamaya yarayan maddeleri içerir. Testin grup formunda deneklere ilk 366 maddeyi yanıtlamaları daha sonra bunlara ilaveten kitapçıta dağınık halde bulunan 33 maddeyi daha yanıtlamaları söylenir. Bu maddelerin kitapçık numaraları şöyledir: 371, 374, 377, 383, 391, 397, 398, 400, 406, 411, 415, 427, 436, 440, 446, 449, 450, 451, 455, 461, 462, 469, 473, 479, 481, 482, 487, 502, 505, 521, 547, 549, 564. Bazı kişiler bu yönergeyi yerine getirirken şaşırdıkları için, uygulayıcının bu 33 maddeyi ayrı bir kağıda yazarak standart test kitapçığının sonuna eklemesi daha uygundur. Bu kısa form kullanıldığında K ve Si ölçeklerinin şablonlarının uygun biçimde değiştirilmesi gerekmektedir. R Formunun kitapçığında tüm geçerlik ölçekleri ve temel ölçekleri puanlamaya yarayan maddeler ilk 399 madde içinde toplanmıştır. Bu nedenle kişiye sadece ilk 399 maddeyi yanıtlamasını söylemek yeterli olur.

PROFİLİN ÇİZİLMESİ

Profil çizilirken ilk önce yanıt kağıdındaki ham puanlar profil kağıdındaki uygun boşluklara geçirilir. Profil kağıdının cinsiyete uygun olmasına ve kimlik bilgilerinin (isim, yaş, uygulama tarihi, eğitim gibi) kaydedilmesine dikkat edilmelidir. Profil çizilmeden önce Hs, Pd, Pt, Sc ve Ma ölçeklerinin ham puanlarına K düzeltme puanı eklenmelidir. Bu ölçeklere eklenecek olan K düzeltme puanı oranları profil kağıdında belirtilmiştir.

Daha sonra uygulayıcı her bir ölçek için, ölçek adlarının üzerindeki kolondaki T puanlarına bakmalıdır. Kolonda, elde edilen ham puana (gerekirse K puanı eklenmiş şekilde) karşılık gelen sayı uygulayıcı tarafından işaretlenir. Standart yöntemde 30'dan daha az BİLMİYORUM (?) puanı için profilde 30 noktası işaretlenir. Ancak bazı uygulayıcılar boş bırakılan madde sayısı 30'dan daha az ise uygun boşluğa bunu kaydetmeyi ve profile işaret koymamayı tercih eder. Her bir ölçek için kolonların üzerine nokta ya da x şeklinde birer işaret konduktan sonra, profil işaretlenmiş noktalar birleştirilerek tamamlanır. Üç geçerlik ölçeğinin kendi arasında birleştirilmesine fakat klinik ölçeklerin puanlarıyla birleştirilmemesine dikkat edilmelidir.

T puanları profilin iki tarafında da basılı olduğu için puanların profil üzerine işaretlenmesi ile, her ölçeğin ham puanının T puanına çevrilmiş şekli kolayca görülebilir. T puanının ortalaması 50, standart sapması 10'dur. Bir ölçekten elde edilen 50 T puanı, o kişinin aldığı puanın normal standardizasyon grubunun ortalamasına eşit olduğunu gösterir.

III

GEÇERLİK ÖLÇEKLERİ

MMPI testinin doğru ve yararlı bilgi sağlayabilmesi için, uygulama yapılan kişinin test yanıtlama işine nasıl yaklaştığını bilmek gerekir. Beklenen tutum, kişinin her maddeyi dikkatle okuması, içeriğini düşünmesi ve olabildiğince dürüst cevap vermesidir. Test yanıtlanırken bu sıra izlenmez ya da bazı aksaklıklar ortaya çıkarsa elde edilen profil geçersiz olacağı için, ya daha ileri bir yoruma gidilmemeli ya da veriler kişinin bu tutumu göz önünde tutularak yorumlanmalıdır. Daha önceki envanterler yanıtların çarpıtılmasına uygun oldukları ve kişinin test tutumu hakkında çok az bilgi verdikleri için eleştirilmişlerdir. MMPI'nin gelişiminde kullanılan ampirik yaklaşımın, yanıtların çarpıtılmasını kısmen de olsa önleyeceği düşünülmüş, ayrıca, test alma tutumlarındaki sapmaları ortaya çıkarmak üzere 4 geçerlik belirleyicisi kullanılmıştır. Test alma tutumuna ilişkin önemli bilgiler sağlamalarının yanı sıra, geçerlik ölçekleri, klinik ölçekler gibi kişinin test dışı davranışları konusunda da başvuru kaynakları olarak kullanılırlar. Bu bölümde geçerlik ölçeklerinin her iki yönü de ele alınacaktır.

BİLMİYORUM (?) ÖLÇEĞİ

Bu ölçek basitçe yanıtlanmamış madde sayısını gösterir. İnsanların test maddelerini boş bırakma nedenleri birbirinden hayli farklıdır. Bazen maddeler dikkatsizlik ya da şaşkınlık nedeniyle boş bırakılabilir. Yanıtlanmamış maddeler aynı zamanda kişinin kabul etmek istemediği özelliklerinden yalan söylemeksizin kaçınma çabasını da yansıtabilir. İki seçenekten biri üzerinde karar kılmada güçlük çeken kararsız kişiler de, pek çok maddeyi cevaplamadan bırakabilirler. Bazı maddeler ise, anlamlı bir cevap için gerekli bilgi ve deneyimin olmaması nedeniyle boş bırakılır. Örneğin, "Kütüphaneci olarak çalışmayı seveceğimi sanıyorum", "Dansa gitmeyi severim" gibi maddeler, bu tür yaşantılara yabancı bir kişi tarafından fazla bir anlam taşımadığı için yanıtlanmayabilir.

Nedeni ne olursa olsun, boş bırakılan madde sayısı çok fazla ise diğer ölçeklerin puanlarının düşmesine neden olur. Bu nedenle yanıtlanmayan madde sayısı yüksekse profilin geçerliği kuşkuludur. Genel olarak boş bırakılan maddelerin sayısı 30'dan yüksek ise, profil geçersiz kabul edilir. 2. bölümde belirtildiği gibi, en iyisi hiçbir maddenin boş bırakılmamasını, ya da bunların birkaç taneden fazla olmamasını sağlamaya çalışmaktır. İnsanlar MMPI'ya başlamadan önce, bütün maddeleri cevaplandırmaları konusunda teşvik edilirlerse genellikle boş bırakılan madde sayısı çok az olur.

Ayrıca uygulayıcı, test tamamlandığında cevap kağıdını inceler ve atladığı maddeleri yanıtlaması için kişiyi gayretlendirirse, testin hemen hemen eksiksiz cevaplandığı görülür. Eğer bu tür yollarla boş bırakılan maddeler azaltılamıyorsa, 30'dan fazla yanıtsız madde bulunan profiller yorumlanmamalıdır.

L ÖLÇEĞİ

1. Bölümde değinildiği gibi L ölçeği kendini olduğundan daha iyi göstermek için kişinin başvurduğu amaçlı ve pek ustaca olmayan girişimleri ortaya çıkarmak için hazırlanmıştır (Meehl ve Hataway 1946). Rasyonel yaklaşımla oluşturulan L ölçeğinin 15 maddesi, çoğu insanın kolayca kabul ettiği küçük kusur ve hatalarla ilgilidir. Ancak amaçlı olarak kendilerini çok olumlu bir şekilde tanıtmak isteyenler bu küçük kusurlarını bile kabul etmek istemezler. Sonuçta böyle kişilerin L ölçeği puanları çok yükselir.

İnsanların büyük bir kısmı L ölçeğinin maddelerini hayır şeklinde yanıtlamazlar, ancak yine de bu şekilde yanıt veren pek çok normal vardır. MMPI standardizasyon grubunda ortalama ham puan 4 olarak bulunmuştur. Daha sonraki araştırmaların sonuçları L ölçeği puanlarının, eğitim düzeyi, zeka, sosyo-ekonomik durum ve psikolojik bilgi düzeyi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. İyi eğitim almış, sosyo-ekonomik durumu iyi, zeki ve bilgili kişilerin yalan ölçeği puanları oldukça düşüktür. Örneğin, yüksek okul öğrencileri için tipik L ölçeği puanı 0 veya 1'dir.

L Ölçeğinde Yüksek Puanlar

L ölçeği puanları ile demografik değişkenler arasındaki ilişki nedeniyle elde edilen puanın yüksek olup olmadığına karar vermeden önce, bu değişkenleri gözden geçirmek gerekir. L ölçeğinin ham puanının 4 ya da 5 olması alt orta sınıftan gelen, zeka düzeyi ortalama ya da ortalamanın biraz altında olan bir kişi için normal iken, yüksek eğitilmiş, üst orta sınıftan gelen bir kişi için biraz yüksektir.

L ölçeği puanları demografik değişkenler dikkate alındığında beklendikenden daha yüksek ise kişinin diğer MMPI maddelerine de dürüst ve içten cevap vermemesi olasıdır. Bu tür test alma tutumunun sonucu olarak klinik ölçeklerin hepsi ya da pek çoğu psikolojik uyumu iyi olan kişilerde görüldüğü gibi alçalmıştır.

Savunmacı bir test tutumunu düşündürmesinin yanısıra, yüksek L ölçeği puanlarının, test dışı önemli bazı tutum ve davranışlarla ilişkili olduğu ampirik olarak bulunmuştur. Yüksek puanlı kişiler geleneksel, sosyal açıdan boyun eğici ve uysaldır. Düşünceleri basmakalıptır, sorunlarına esnek bir yaklaşım gösteremezler. Buna ilaveten baskı ve stres toleransları düşüktür. Katı, tutucu ve kendilerine aşırı değer veren kişilerdir. Bastırma ve inkar mekanizmalarını çok fazla kullanırlar. Kendi motivasyonlarına karşı içgörülerini yoktur ya da çok azdır. Aynı zamanda davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğinin farkında değildirler. Bazı ender vakalarda çok

yüksek L puanı organik ya da fonksiyonel kökenli klinik konfüzyonu düşündürebilir.

L Ölçeğinde Düşük Puanlar

Öte yandan L ölçeğinin puanının düşük olması kişinin maddelere içten yanıtlar verdiğini ve küçük hata ve eksikliklerini kabul edebilecek kadar kendine güvendiğini gösterir. Gough, McKee ve Yandell (1955) düşük puanlıları, anlayışlı, sosyal açıdan uyumlu, kendine güvenen ve bağımsız kişiler olarak tanımlamışlardır. Aynı zamanda güçlü, doğal, rahat ve lider rolünde başarılıdırlar.

Düşüncelerini ustaca anlatabilirler ancak bazen diğer insanlarda alaycı bir kişi izlenimi bırakırlar.

L Ölçeği İçin Tanımlamaların Özeti*

L ölçeği puanının yükselmesi şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. maddeleri yanıtlarken kendini gizleyerek iyi bir izlenim bırakmaya çalışan,
2. geleneksel, boyun eğici,
3. basmakalıp düşünen; sorunlara yaklaşımda esnek olamayan,
4. stres ve gerilime karşı dayanıksız,
5. katı ve tutucu,
6. kendine aşırı önem veren,
7. bastırma ve inkar mekanizmalarını aşırı kullanan,
8. kendi motivasyonlarına karşı içgörüsü çok az olan ya da hiç olmayan,
9. kendi davranışlarının diğer insanları nasıl etkilediğini bilmeyen,
10. şaşkınlık (konfüzyon) içinde olan.

L ölçeği puanının düşmesi şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. maddeleri içten bir şekilde cevaplandıran,
2. küçük hata ve eksikliklerini kabullenecek kadar kendine güvenen,
3. anlayışlı, sosyal açıdan güvenli,
4. kendine güvenen, bağımsız,
5. güçlü, doğal ve rahat,
6. liderlik rolünde başarılı,
7. düşüncelerini ustaca iletebilen,
8. başkaları tarafından alaycı olarak tanımlanan.

* Bu listede ve daha sonraki özetlerde yer alan tanımlamalar, istatistiksel açıdan en sık görülen özellikler olmasına rağmen her vakaya tümüyle uyması beklenmemelidir. Bu tanımlamalar bireyin yaşam öyküsüne, davranışlarına ve diğer testlerden elde edilen verilere başvurularak, geçerliliği araştırılacak, hipotezler olarak kabul edilmelidir.

F ÖLÇEĞİ

F ölçeği, test maddelerini atipik ya da normalden farklı bir şekilde yanıtlayanları ortaya çıkarmak için geliştirilmiştir (Meehl ve Hathaway, 1946). F skalasındaki 64 madde normal yetişkinlerin ancak %10'undan daha azı tarafından puan alacak şekilde işaretlenir. Böylece incelenen kişi, F ölçeğindeki maddelerin büyük bir kısmından puan alırsa, teste verdiği cevapların normal insanların çoğundan farklı olduğu söylenebilir. F ölçeğinin 64 maddesini faktör analizi ile inceleyen Comrey (1958), paranoid düşünce, antisosyal tutum ya da davranış, düşmanlık ve kötü fiziksel sağlık gibi özelliklerle bağlantılı 19 içerik alanı belirlemiştir. Bu 19 içerik alanından yalnızca bazılarının işaretlenmesi ile kişinin F puanı yükselebilmektedir. MMPI testinin ölçekleri kendi içlerinde ilişkili olduklarından F ölçeğindeki yükselme ile diğer klinik ölçeklerdeki yükselmeler (özellikle 6 ve 8) bağlantılıdır. F puanlarının aynı zamanda yaş ve ırkla ilişkili olduğu, gençlerle zencilerin F puanlarının diğer gruplara kıyasla daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Klinisyenlerin uygulamalarında kullandıkları şekilde F ölçeğinin üç önemli görevi vardır. Birincisi, test alma tutumunun göstergesidir ve cevaplayış tarzındaki sapmaları ortaya çıkarmak için yararlıdır. İkincisi, eğer profil geçersiz değilse F ölçeği, psikopatolojinin derecesinin bir göstergesidir. Yüksek puanlar psikopatolojinin ciddiyetini belirtir. Son olarak, F ölçeği tipki diğer ölçekler gibi kişinin test dışı davranışlarını tahmin etmek için kullanılabilir.

F Ölçeğinde Yüksek Puanlar

F ölçeğinden elde edilen T puanı 100'e eşit veya 100'den fazla olduğunda (ham puan > 26) profili geçersiz kılan, normalden sapmış bir cevaplayış tarzı düşünülmelidir. Örneğin, rastgele cevap verme, bütün doğruları işaretleme, amaçlı biçimde kendini olduğundan daha kötü göstermeye çalışma, F puanının 100 ve daha üzerinde yükselmesine yol açar. Ciddi ruhsal bozukluğu olan kişilerde F puanı nadiren bu kadar yükselir. Gynther, Altman, Warbin (1973) F ölçeği T puanları 100'e eşit veya 100'den fazla olan psikiyatrik hastalarda bu durumla bağlantılı önemli ve güvenilir özellikler tanımlamışlardır. Bu hastaların referans delirleri, işitsel ve görsel hallüsinasyonlar, konuşmada fakirleşme, içe çekilme, yargılamada yetersizlikler gibi semptomlar gösterdiklerini bulmuşlardır. Bunlara ilaveten, tek heceli (monosyllabic) konuşma, çok dar bir dikkat alanı ve yer dezoryantasyonuna rastlanabileceğini belirtmişlerdir. Niçin hastanede olduklarını bilmeyebilirler, psikoz tanısı almışlardır ve organik etiyolojiye ilişkin kanıtlar olabilir.

T puanı 80-99 arasında olduğunda (ham puan = 16-25), F puanı bütün yanıtların işaretlendiğini ya da kişinin hasta numarası yaptığını gösterir. Ancak kişinin testi yardım çağrısı için kullanarak, sorunlarını abartmış olması da mümkündür. Eğer cevaplayış tarzında bir sapma yoksa,

F puanının bu düzeyde yükselmesi çok ciddi psikopatoloji düşündürür. Açık psikotik semptomları olan pek çok kişi bu düzeyde F puanı alır.

Psikotik kişilerle ağır nevrotiklerin F ölçeği T puanları 65-79 arasındadır (ham puan = 10-15). Bunların dışında politik, sosyal ve dini inançlarında sapma olan kişilerin de F puanlarının bu düzeyde olduğu bulunmuştur. Böyle durumlarda maddelerin incelenmesi normalden sapmış inançların ortaya çıkarılmasında yararlı olabilir. Gough ve arkadaşları (1955), önemli bir psikopatoloji bulunmayan kişilerde, puanların bu düzeyde olmasının karamsarlık, sabırsızlık, hassasiyet, huzursuzluk ve hoşnutsuzluk gösterdiğini bulmuşlardır. Ayrıca bu tür kişiler, karamsar, kararsız, meraklı, karmaşık, sabit fikirli ve fırsatçı olabilirler.

F puanı T = 50-64 (ham puan = 3-9) arasına düştüğünde, genellikle bazı özel alanlarla (aile ilişkileri, cinsel ilgiler, sağlık endişeleri, antisosyal inançlar) ilişkili olan maddeler işaretlenmiştir. Bu tür kişiler, yaşamlarının diğer alanlarında fonksiyonlarını sürdürebilmelerine rağmen belli bir alanda güçlük çekiyor olabilirler. Sorun alanı konusunda bilgi edinmek isteyen klinisyenler, işaretlenen her F ölçeği maddesini basitçe kağıda yazarak, bu maddeleri içerik ve bilgi açısından inceleyebilirler.

F Ölçeğinde Düşük Puanlar

T puanının 45-49 (ham puan = 0-2) arasında olması kişinin maddeleri normal insanların çoğu gibi yanıtladığını gösterir ve bu nedenle günlük davranışlarının sosyal açıdan uyumlu olması beklenir. Önemli bir ruhsal bozukluğu olduğu bilinen kişilerde F ölçeğinden düşük puanlar elde edilirse, ruhsal sorunların inkarı akla gelir. Bu düzeydeki puanlara, aynı zamanda, testte amaçlı bir şekilde iyi bir izlenim bırakmak isteyen kişilerde de rastlanır.

F Ölçeği İçin Tanımlamaların Özeti

Yüksek F ölçeği puanları

T puanının 100'e eşit veya 100'den fazla (ham puan > 26) olması şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. MMPI maddelerine gelişigüzel cevap verme olasılığı olan,
2. MMPI maddelerinin hepsini "doğru" olarak işaretleme olasılığı olan,
3. MMPI testini kendisini olduğundan kötü gösterecek şekilde yanıtlama olasılığı olan,
4. hastanede tedavi gören psikiyatrik bir hasta ise aşağıda sayılan özellikleri gösterebilir:
 - a. referans delirleri,
 - b. işitsel veya görsel hallüsinasyonlar,
 - c. konuşmada fakirleşme,
 - d. içe çekilme,
 - e. yargılamada yetersizlik,
 - f. tek heceli konuşma,
 - g. dikkat alanında daralma,

- h. niçin hastahanedede olduğunu bilmeme,
- 1. klinik olarak psikoz tanısı,
- i. organik etiyojinin test dışı kanıtları.

T puanının 80-99 (ham puan = 16-25) arasında olması şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

- 1. bütün MMPI maddelerini "yanlış" olarak işaretleme olasılığı olan,
- 2. hasta numarası yapma olasılığı olan,
- 3. yardıma duyduğu gereksinim ile septomlarını abartan,
- 4. test işlemine direnç gösteren,
- 5. bilinen kriterlerle açıkça psikotik olan.

T puanının 65-79 (ham puan = 10-15) arasında olması şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

- 1. sosyal, politik ya da dini konularda içinde yaşadığı toplumdan hayli farklı inançlara sahip,
- 2. klinik olarak ciddi nevrotik ya da açıkça psikotik olabilen,
- 3. eğer önemli bir psikopatoloji yoksa kişi şöyle tanımlanabilir:
 - a. karamsar
 - b. sabırsız
 - c. hassas
 - d. huzursuz
 - e. doyumsuz
 - f. tutarsız
 - g. meraklı
 - h. karmaşık
 - i. inatçı
 - j. fırsatçı

T puanının 50-64 (ham puan = 3-9) arasında olması şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

- 1. testte özel sorun alanlarıyla ilişkili bazı maddeleri işaretleyen,
- 2. özel sorunlarına rağmen yaşamın çoğu alanında başarılı bir şekil de işlevlerini sürdürebilen.

Düşük F ölçeği puanları

T puanının 45-49 (ham puan = 0-2) arasında olması şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

- 1. maddeleri normallerin çoğu gibi yanıtlayan,
- 2. sosyal açıdan uyumlu,
- 3. yetersizliğe yol açan ruhsal bir bozukluğu olmayan,
- 4. iyi bir profil vermeye uğraşan.

K ÖLÇEĞİ

MMPI ile yapılan ilk uygulamalar, L ölçeğinin testi yanıtlayan kişinin sonuçları çarpıtmak için giriştiği çabalardan bazılarını karşı hayli duyarlı olduğunu göstermiştir. K ölçeği ise, uygulama yapılan kişinin ruhsal bozukluğunu inkar ederek, kendini olumlu bir şekilde tanıtmak ya da tam tersi, ruhsal bozukluğunu abartarak, kendini hasta göstermek için başvurduğu çabaları daha gizli ve etkili bir şekilde belirlemek için hazırlanmıştır (Meehl, Hataway, 1946; McKinley ve ark., 1948). Böylece, yüksek K puan-

larının, teste yönelik savunucu yaklaşımla ilişkili olacağı, buna karşılık düşük puanların ise olağandışı açık sözlülük ve kendini eleştirinin bir göstergesi olacağı düşünülmüştür. Test alma tutumunda görülen sapmaları yansıtmasının yanısıra bu ölçekten yararlanılarak bazı klinik ölçeklerin puanlarını düzeltmek için bir istatistiksel yöntem de geliştirilmiştir (Bölüm II'deki K düzeltme kısmına bakınız).

K ölçeği, normal profil veren hastaların belli maddelere verdikleri yanıtlarla, aynı maddelere bir grup normal bireyin verdiği yanıtlar karşılaştırılarak ampirik olarak geliştirilmiştir.

Ancak daha sonraki yıllarda MMPI ile yapılan araştırma ve uygulama sonuçları K ölçeğinin başlangıçta amaçlanandan daha karmaşık olduğunu gösterdi. Ölçek puanlarının sosyo-ekonomik düzey ile ilişkili olduğu, üst sosyo-ekonomik düzeyden kişilerin bu ölçekten yüksek puanlar aldıkları bulundu. K-düzeltilme puanının her vakaya uygulanması gerektiği şeklindeki düşünce ise çok az sayıdaki araştırma ile desteklendi. K-düzeltilme işleminin klinik ölçeklerin ayırt edici gücünü artırmakla birlikte hemen her zaman, profilin tümüyle doğruluğunu etkilemediği görüldü. Yine de, K-düzeltilme işlemi, MMPI puanlamasının bir bölümü olarak kabul edildiği ve profil yorumuna ilişkin tüm bilgiler düzeltilmiş puanlara dayandığı için bu işlemin her vakaya uygulanması önerilir.

K ölçeğinin maddeleri, kişinin sorunlarını (hostilite, kuşkuculuk, aile kavgaları, güvensizlik, aşırı endişe gibi) inkar edebileceği farklı içerik alanlarını kapsar. K ölçeğinin maddelerinin içeriği, L'ninkine kıyasla daha gizlidir. Bu nedenle, savunmacı bir kişinin maddelerin amacını farkedip kendini gizlemeye çalışması daha zordur.

K ölçeği puanları yorumlanırken, kişinin sosyo-ekonomik durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek okul öğrencileri ve yüksek eğitilmiş kişiler için, K ölçeği T puanı ortalaması 55-70 arasındadır. Bu nedenle, bu düzeyden gelen kişilerde 70'in üzerindeki puanlar yüksek, 50'nin altındakiler ise düşük olarak kabul edilir. Oysa alt orta ve düşük sosyo-ekonomik düzeyde, tipik T puanı 40-60 arasında bulunduğundan, 40'ın altı düşme, 60'ın üstü yükselme olarak ele alınmalıdır.

K Ölçeğinde Yüksek Puanlar

K ölçeği puanları, içinde bulunulan sosyo-ekonomik düzeye göre beklenenden daha yüksek ise, sorunları ve psikopatolojiyi amaçlı bir şekilde reddetme çabaları sonucu testte ortaya çıkan iyi bir görünümü ya da tüm maddelerin "yanlış" şeklinde yanıtlanma olasılığını düşündürmelidir (her iki yanıtlama şekli geçersiz profiller başlığı altında ayrıntılarıyla incelenmiştir). K ölçeğinden yüksek puan alan kişiler, yeterli, kontrollü ve etkili bir görünüm vermeye çalışıyor olabilirler. Bu kişiler utangaç ve çekingendirler, başka insanlarla duygusal ilişkilere girme konusunda çekimser davranmaya eğilimlidirler. Ayrıca, insanların farklı (geleneksel olmayan) inanç ve davranışlarına karşı hoşgörüsüzdürler. İçgöründen ve kendini anlayıştan yoksundurlar. K ölçeğinden yüksek puan alan kişilerde suça yönelik davranışlara pek rastlanmaz. K ölçeği ile birlikte klinik ölçekler de yükselmisse, oldukça

ciddi bir ruhsal rahatsızlığa rağmen kişinin sorunlarının pek farkında olmadığı görülebilir.

K Ölçeğinde Ortalama Puanlar

K ölçeği puanları, içinde bulunulan sosyo-ekonomik düzeyden beklenen puanlar arasında ise, kişi kendine olumlu değer verme ile kendini eleştirme arasında sağlıklı bir denge kurmuştur. Bu kişiler psikolojik açıdan iyi uyumludurlar ve pek fazla emosyonel bozukluk belirtisi göstermezler. Bağımsız, kendine güvenen, günlük yaşam sorunları ile başa çıkabilen kişilerdir. Üstün entellektüel yeteneklere ve çok sayıda ilgi alanına sahip, becerikli, girişken, çok yönlü ve içten kişiler olabilirler. Düşünceleri açıktır, sorunlarına akılcı ve sistematik bir şekilde yaklaşırlar. Sosyal ortamlarda insanlarla kolay kaynaşırlar, heyecanlı ve konuşkandırlar, grup içinde üstün bir rol almaya eğilimlidirler.

K Ölçeğinde Düşük Puanlar

Eğer kişinin K puanı, sosyo-ekonomik düzeyine göre beklenenden daha düşük ise, bütün maddeleri "doğru" olarak yanıtlamış ya da bilerek kendini olumsuz bir şekilde tanıtmaya çalışmış olabilir (her iki yanıtama şekli geçersiz profiller başlığı altında ayrıntılarıyla incelenmiştir). Düşük puanlar, aynı zamanda kişinin yardıma duyduğu gereksinimle problemlerini abarttığını ya da organik veya fonksiyonel kökenli bir konfüzyon yaşadığını gösterebilir.

Düşük puanlılar, kendilerine ve diğer insanlara karşı aşırı eleştiricidirler. Hiç bir şeyden hoşnut değildirler. Günlük yaşam sorunları ile mücadelede başarısızdırlar. Davranışlarına ve güdülerine karşı içgöruları çok azdır. Sosyal açıdan itaatkar ve otoriteye aşırı boyun eğen kişilerdir. Çekin-gen, içine çekilmiş ve yavaşlırlar. Sosyal ortamlarda beceriksizdirler, kişilerarası etkileşimlerde patavatsız ve ters davranışlara eğilim gösterirler. Yaşama genel bakışları, alaycılık, şüphe, eleştiri ve inançsızlıkla karakterizedir. Başka insanların davranışlarına kuşkuyla yaklaşırlar.

K Ölçeği İçin Tanımlamaların Özeti

K ölçeği puanının yükselmesi şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. iyi bir profil vermeye çalışan,
2. MMPI maddelerinin çoğunu "yanlış" olarak işaretleyen,
3. yeterli, kontrollü ve etkili bir kişi görünümünü vermek isteyen,
4. utangaç ve çekingen,
5. diğer insanlarla duygusal ilişkiler kurmaya çekinen,
6. insanların farklı (geleneksel olmayan) tutum ve davranışlarına karşı hoşgörüsüz,
7. kendine yönelik içgörüsü olmayan, kendini tanımayan,
8. açıkça suça yönelik davranışları olmayan,
9. eğer aynı anda klinik ölçekler de yükselmisse, ruhsal açıdan ciddi sorunlara rağmen bu durumun pek farkında olmayan.

K ölçeği puanının orta düzeyde olması şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. MMPI maddelerini yanıtlarken, kendini olumlu değerlendirme ile eleştirme arasında sağlıklı bir dengeyi koruyabilen,
2. psikolojik açıdan uyumu iyi,
3. az sayıda duygusal bozukluk belirtisi gösteren,
4. bağımsız, kendine güvenen,
5. günlük yaşam sorunları ile mücadele edebilen,
6. entellektüel yeteneği yüksek,
7. ilgi alanı geniş,
8. içten, girişken, çok yönlü, becerikli,
9. berrak düşünen, problemlere akılcı ve sistematik bir şekilde yaklaşan,
10. sokulgan, insanlarla kolay kaynaşan,
11. coşkulu ve güzel konuşan,
12. grup içinde üstün roller alabilen.

K ölçeği puanının düşük olması şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. MMPI maddelerinin çoğunu "doğru" olarak işaretleyen,
2. kötü bir profil vermeye çalışan,
3. yardım gereksinimiyle sorunlarını abartan,
4. açıkça akut psikoz ya da organik konfüzyon belirtileri gösteren,
5. kendini ve başkalarını eleştiren, kendinden memnun olmayan,
6. günlük yaşam sorunları ile etkin bir şekilde mücadele edemeyen,
7. kendi davranış ve güdülerine karşı çok az bir içgörüsü olan,
8. sosyal açıdan itaatkar (kurallara uyan),
9. otoriteye aşırı boyun eğen,
10. çekingen, iç çekilmiş, yüzeysel,
11. kişisel temposu yavaş,
12. sosyal ortamlarda beceriksiz,
13. patavatsız ve ters,
14. alaycı, kuşkucu, kanayan ve inançsız,
15. diğer insanların davranışlarına karşı kuşkucu.

GEÇERSİZ PROFİLER

Bazı MMPI uygulayıcıları, 30'dan fazla madde boş bırakılmışsa ya da geçerlik ölçeklerinden (L, F, K) bir veya birkaçında T puanı 70'in üzerine çıkmışsa, profili geçersiz ve yorumlanamaz olarak nitelendirirler. Bu konu her ne kadar çok tartışmalı ise de, böyle bir yaklaşım konuyu aşırı basitleştirmektedir ve pek çok geçerli profilin elenmesine neden olur. Örneğin, Dahlstrom ve Welsh (1960), ağır nevrotik ve psikotik hastaların F ölçeği T puanlarının

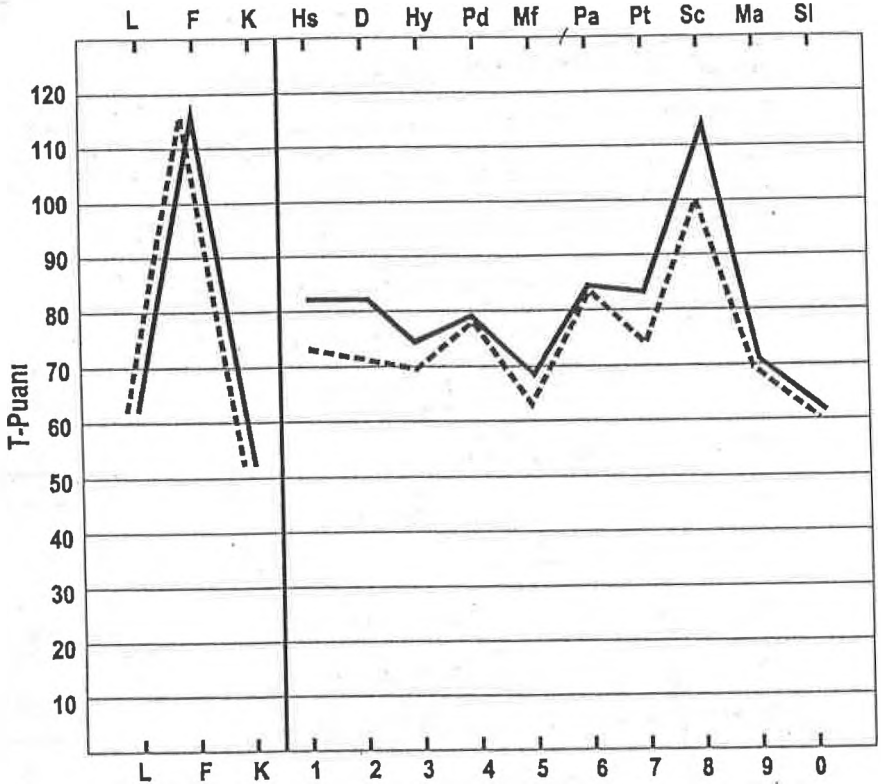
sıklıkla 65-80 arasında olduğunu belirtmişlerdir. Gynther ve arkadaşları (1973) 100'e eşit veya 100'den fazla olan F puanları ile test dışı davranışlar ve kişilik özellikleri (dezoryantasyon, hallüsinasyonlar, delirler, dikkat alanında daralma gibi) arasında ilişki bulunduğunu göstermişlerdir. Ayrıca, deneyimli klinisyenler için, yüksek eğitilmiş kişilerde K puanının 70'in üzerinde olması şaşırtıcı bir durum değildir. Bu nedenle, profilin geçersiz olup olmadığına karar verirken, daha özenli bir yaklaşım gerekli görülmektedir.

Yanıtlama Tarzında Görülen Sapmalar

Profilin geçerli olması için kişi, MMPI maddelerinin hepsini tek tek okumalı, içeriklerini düşünmeli ve doğru ya da yanlış olarak bir cevap vermelidir. Bazen maddeler içerikleri dikkate alınmaksızın, belli bir tarzda (örneğin, tüm maddeler için yanlış şeklinde) cevaplandırılır. Bu tür davranışlar, genellikle, okuma becerisi pek gelişmemiş, yönergeyi takip etmekte güçlük çeken veya değerlendirme işlemine karşı olumsuz tutumu olan kişilerde görülür. O halde uygulayıcı, testi vermeden önce bu tür faktörleri belirlemeye çalışmalıdır. Ancak bazen, özellikle testin grup halinde uygulandığı durumlarda, bu tür kişiler de testi tamamlarlar.

Gelişigüzel cevap verme

Normalden sapmış bir cevaplama tarzı, test maddelerini gelişigüze ya da neredeyse gelişigüzel olacak şekilde cevaplamaktır. Kişi maddeler rastgele ya da kendine özgü bir tarzda yanıtlayabilir. Örneğin, her blokta 8 maddeyi doğru, doğru, yanlış, yanlış, doğru, doğru, yanlış, yanlış ya da doğru, yanlış, doğru, yanlış şeklinde cevapladıktan sonra bunu daha sonraki bloklarda da tekrarlayabilir. Cevaplar maddelerin içeriği dikkate alınmaksızın işaretlendiği için böyle bir profil geçersiz kabul edilmelidir. Şekil'de tüm maddeleri gelişigüzel yanıtlanan bir MMPI profil örneği sunulmuştur.

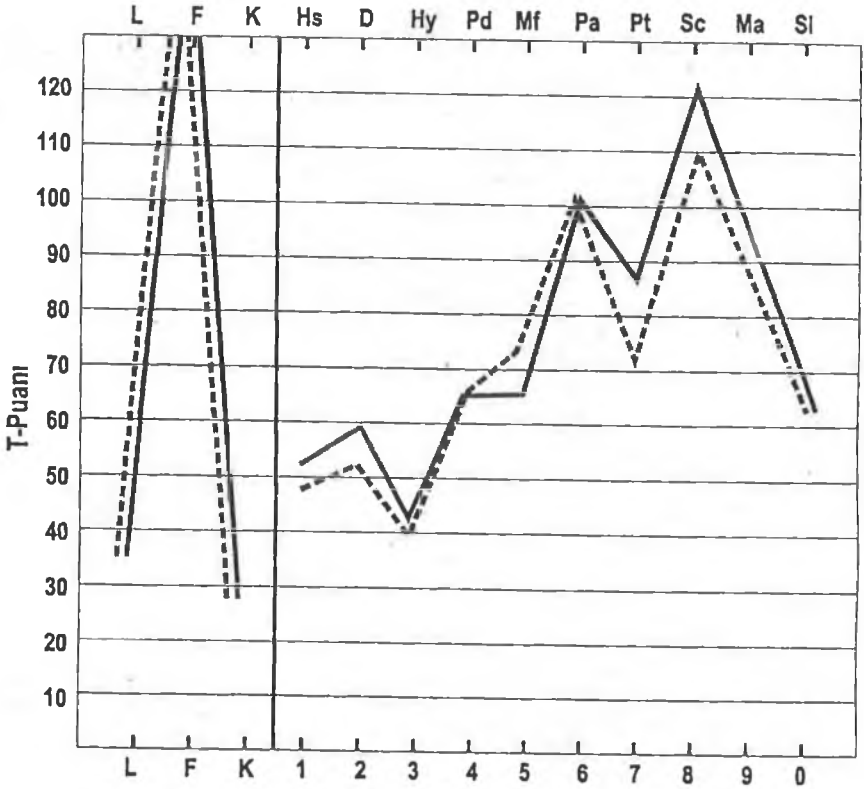


Şekil 1. Erkekler (---) ve kadınlar (—) için K-düzeltilmeli gelişigüzel yanıtlanmış profil.

Gelişigüzel yanıtlanan testlerin profillerinde F ölçeği T puanı 100'den daha büyük, L ve K ölçekleri ise 50'nin biraz üzerindedir. Klinik ölçeklerde sıklıkla 8'in ve 6'nın sivri olduğu, "psikotik bir eğilim" dikkat çeker. 5 ve 0, 70'nin altındadır.

Tüm maddeleri "doğru" yanıtlama

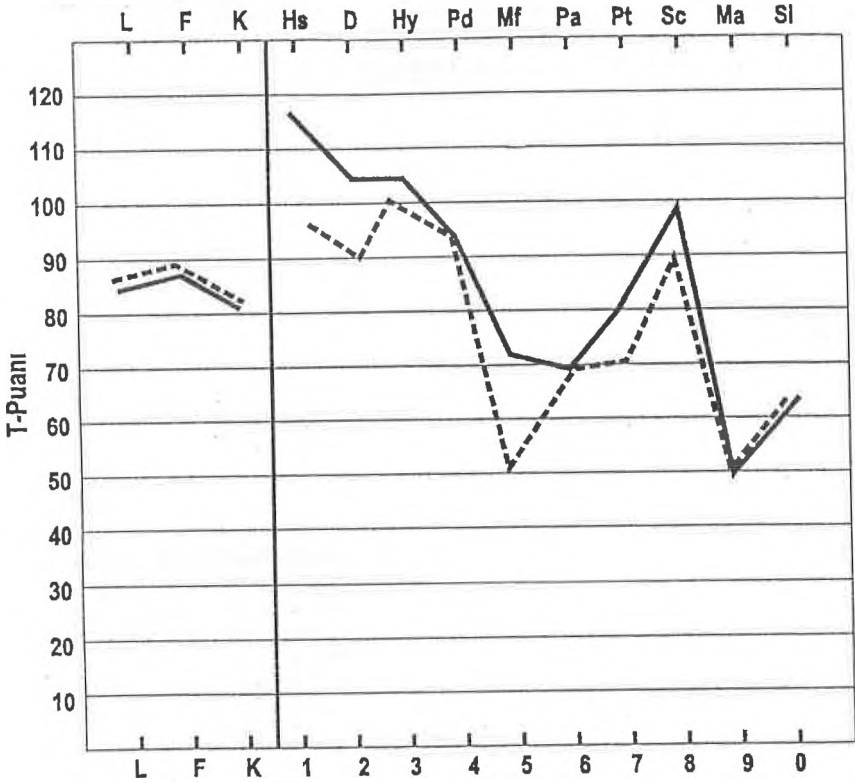
Eğer tüm maddeler "doğru" olarak cevaplanırsa, Şekil 2'dekine benzer bir profil ortaya çıkar. Bu durumda, profilin dikkat çeken özellikleri F puanlarının çok fazla yükselmesi (sıklıkla profil kağıdının tepesine kadar çıkar), L ve K'nın 50'nin iyice altında olması, 8 ve 6'nın sivrilerek "psikotik bir eğilimin" görülmesidir.



Şekil 2. Erkekler (—) ve kadınlar (---) için K-düzeltilmeli tüm maddeleri "doğru" olarak yanıtlanmış profil.

Tüm maddeleri "yanlış" yanıtlama

Tüm maddeleri yanlış olarak yanıtlayan kişilerin profilleri Şekil 3'deki gibidir. Aynı anda yükselen L, F, K ölçekleri ile klinik ölçeklerdeki "nevroitik benzeri eğilime" dikkat ediniz.



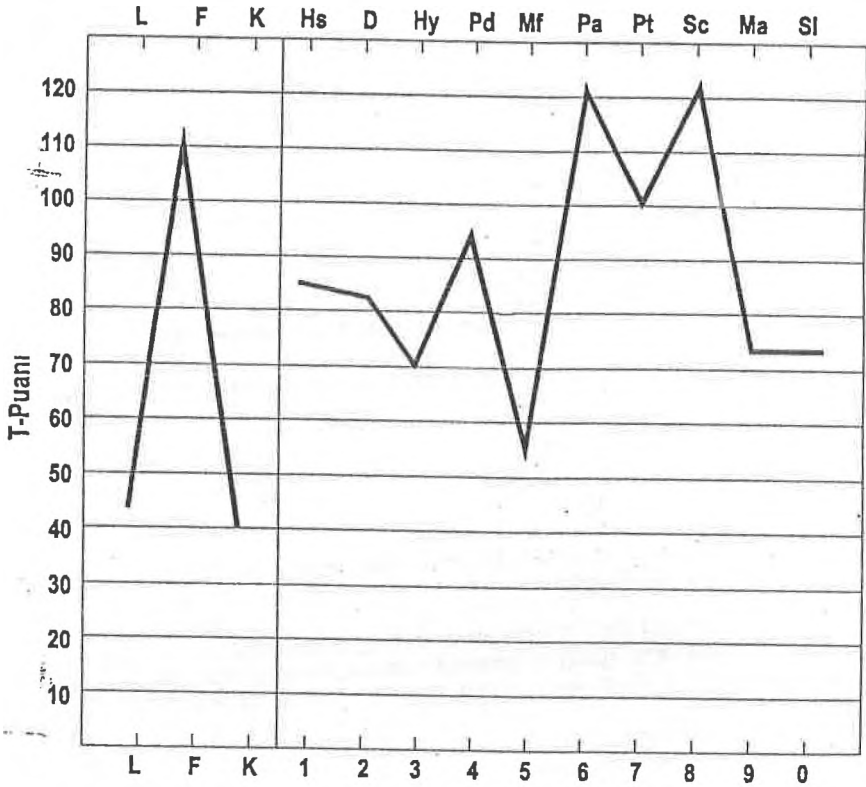
Şekil 3. Erkekler (—) ve kadınlar (---) için K-düzeltilmeli tüm maddeleri "yanlış" olarak yanıtlanmış profil.

Kötü gösterme

Bazı kişiler (örneğin, adli vakalar) MMPI testini yanıtlarken kendilerini olduklarından çok daha kötü ve hasta göstermek isteyebilirler. Bu istek çok açık ve belirgin ise elde edilen profil, ilk bakışta ciddi bozukluk düşündürcek şeklindedir. Şekil.4'de kendini olduğundan kötü göstermeye çalışan kişiler için tipik bir profil görülmektedir.

Bu tür profiller çok yüksek F ölçeği puanları (sıklıkla 100'ün üzerinde) ve ortalamanın biraz altındaki L ve K puanları ile karakterizedir. 5 dışındaki klinik ölçekler (6 ve 8 en fazla olmak üzere) sıklıkla yükselmiştir.

Gough (1950) ciddi ruhsal bozukluk izlenimi vermeye çalışan kişilerde F puanlarının belirgin biçimde K'dan daha yüksek olduğunu bulmuştur. Bunun üzerine F ile K ölçeklerinin ham puanları arasındaki farkın hasta numarası yapan kişileri belirlemek için bir gösterge olabileceğini öne sürmüştür. Gough (1950) ve Meehl (1951)'e göre gösterge sayısı (F'in ham puanı - K'nın ham puanı) pozitif ve 9'dan büyük ise kendini olduğundan kötü gösterme çabası düşünülmelidir. Carson (1969) "+ 11'in kötü profil vermek isteyen kişileri belirlemek için kesme noktası olarak kullanılmasını önermiştir. Tek bir puana bakarak hemen her koşulda aynı şeyi söylemek pek mümkün olmasa da, F'in ham puanı K'dan ne kadar büyükse kişinin kendini kötü gösterme olasılığı o kadar fazlalaşır diyebiliriz.



Şekil 4. Kendini kötü göstermeye çalışan kişiler tarafından verilen MMPI profiline tipik bir örnek (K-düzeltilmeli)

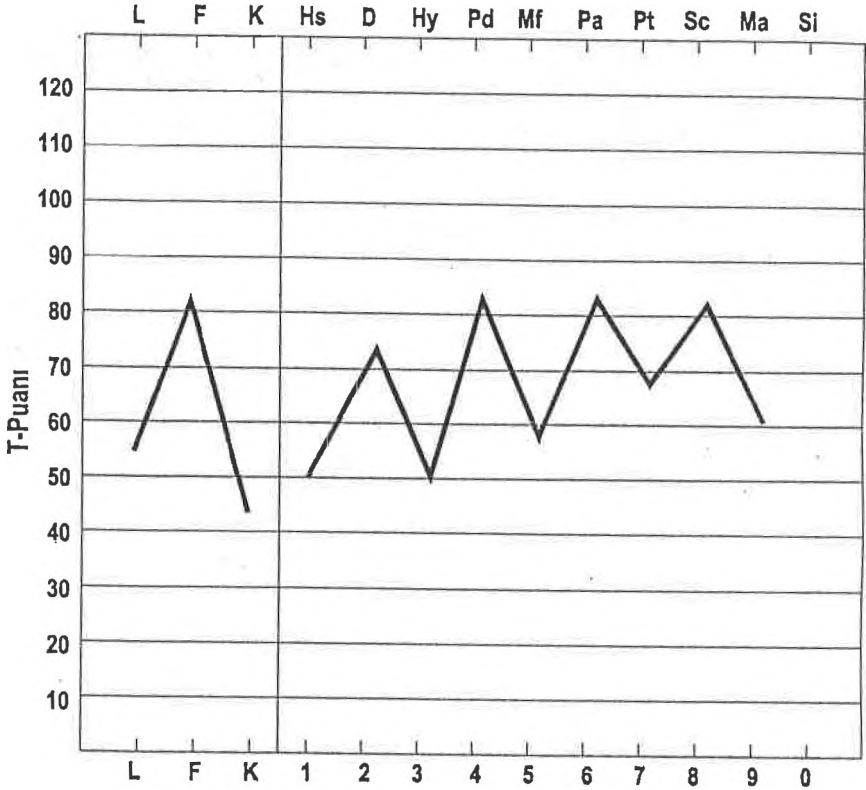
Hasta izlenimi bırakmak isteyenleri gerçekten önemli sorunları olan kişilerden ayırdetmek mümkündür. Birincisi, kendini olduğundan kötü göstermek isteyenlerin F ölçeği puanları genellikle daha yüksektir. Klinik olarak psikoz tanısı almış kişilerde F'in T puanı 70-90 arasındadır. Oysa kendini kötü göstermek isteyenlerde 100'ün oldukça üstündedir. Ayrıca hasta bir kişiden elde edilen geçerli bir profilde, L ve K ölçekleri F ölçeği ile birlikte tipik bir şekilde yükselir. Son olarak, kendini kötü gösteren kişilerin profillerinde klinik ölçekler gerçekten hasta olan kişilerin profillerine oranla daha fazla yükselmeye eğilimlidir.

Kendini kötü gösteren kişilerin profillerini, testi gelişigüzel yanıtlayanlardan ayırmak da mümkündür. Birinci grupta L ve K ölçekleri genelde ortalamanın altında, ikinci grupta ise ortalamanın biraz üstündedir. Ayrıca testi rastgele yanıtlayanların profillerinde genellikle 8. ölçek tek başına sıvırılmış, kendini kötü göstermek isteyenlerde 6 ve 8 aynı anda çok fazla yükselmiştir.

Eğer kendini kötü göstermek isteyenlerin profilleri ile tüm maddeleri doğru olarak yanıtlayanların profilleri karşılaştırılırsa, bazı farklılıklar hemen göze çarpar. İlk olarak tüm doğruların işaretlendiği profillerde F puanı çok fazla yükselmiş (120'den fazla) ve L ile K puanları kendini kötü gösteren kişilerin profillerine kıyasla oldukça alçalmıştır. Ancak her iki tip profilde de 6. ve 8. ölçekler yükselerek, psikotiklerde görülen profillere benzemiştir. İki grupta da 1. 2. ve 3. ölçeklerin T puanları 50 civarındadır.

Kendini kötü gösteren kişilerin profillerini tüm maddeleri yanlış cevaplayanların profillerinden ayırdetmek mümkündür. Hasta izlenimi vermek isteyenlerde F ölçeği L ve K'dan epeyce yüksek iken, hep yanlış yanıtı verenlerde üç geçerlik ölçeği birlikte yükselir. Buna ilaveten tüm yanlışları işaretleyenlerde açıkça negatif bir eğilim (profilin solunda yükselme) görülür.

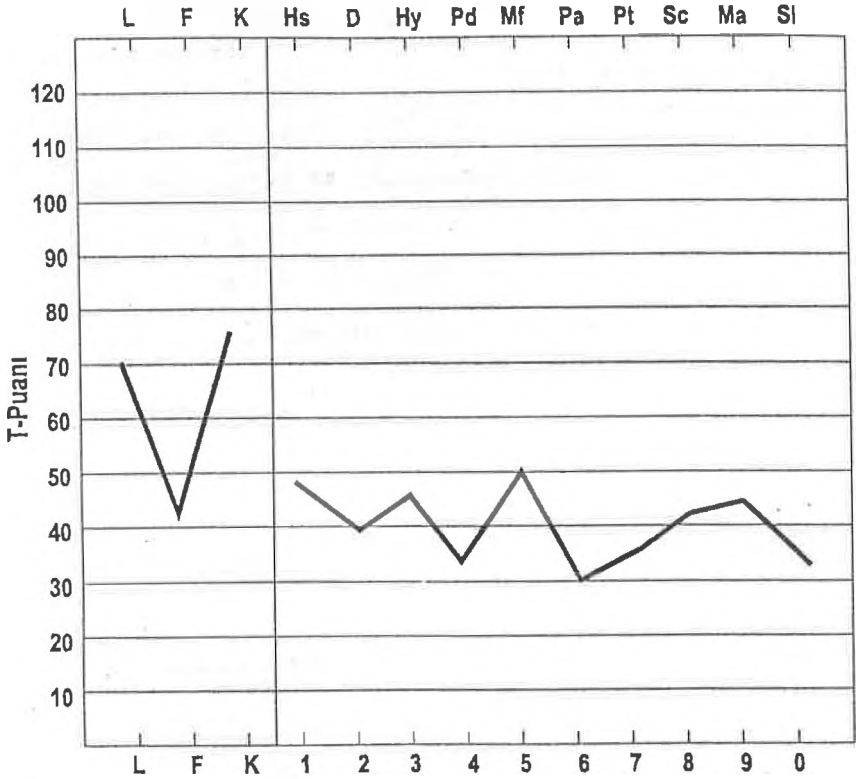
Kişi sorunlarını abartmaya eğilimli ise, ancak açıkça hasta numarası yapmıyorsa elde edilen profili, gerçekten önemli ruhsal sorunları olan bir kişinin geçerli profilinden ayırdetmek epey güçtür. Amaçlı bir şekilde hasta numarası yapan kişilerin (malingering) profillerinde F ölçeği kötü bir profil vermeye çalışanlar kadar yükselmemiştir ve L ile K ölçekleri genellikle 50 dolaylarındadır. Bu kişilerin profillerinde en fazla göze çarpan özellik "testere dişleri" görünümüdür (Şekil 5). Bunun nedeni hasta numarası yapanların 2, 4, 6 ve 8. ölçeklerdeki açıkça patolojik maddeleri kabul etmeleridir.



Şekil 5. Hasta numarası yapan kişilerde görülen "testere dişli MMPI profili" (K-düzeltilmeli).

Kendini İyi Gösterme

Bazı kişiler -bunlar arasında kendi isteği ile tedaviye gelenlerin olması da ilginçtir- bazen sorunlarını inkar ederek, ruhsal durumlarını gerçekte olduğundan daha iyi göstermek isterler. Bu eğilimin en bariz şekli "kendini iyi gösterme" olarak bilinir. Şekil 6'da bu tarz bir test tutumu sonucunda ortaya çıkan tipik bir profil görülmektedir. Olduğundan iyi görünme çabalarının en açık belirtisi, F'in T puanı 40-50 arasında iken L ve K'nın birlikte yükselerek, üçlünün "V" şeklini almasıdır. Klinik ölçeklerden çoğunun T puanı 30-50 arasında olup, en yüksek ölçek sıklıkla 5'tir.



Şekil 6. Kendini iyi göstermeye çalışan kişilerin verdiği MMPI profiline tipik bir örnek (K-düzeltilmeli).

L ölçeği maddeleri çok aşikar olduğundan, parlak zekalı, iyi eğitilmiş, psikolojik konularda bilgili kişiler, maddelerin amacını farkederek L ölçeğinden düşük puanlar elde edebilirler. Ancak K ölçeğinin maddeleri bu kadar açık olmadığından bu tür bilgili kişiler bile eğer testte kendilerini iyi göstermeye çalışmışlarsa, yüksek K puanları alırlar. Yüksek K puanının iyi görünme taktiği olup olmadığına karar vermeden önce kişinin sosyo-ekonomik durumu gözden geçirilmelidir. Üst sosyo-ekonomik düzeyden kişiler, alt sosyo-ekonomik düzeyde olanlara kıyasla daha yüksek K puanı alırlar. Bu nedenle K ölçeği puanının 60-70 arasında olması üst sosyo-ekonomik düzeyden kişilerde kendini iyi gösterme tutumunu belirtmez.

Bazı klinisyenler kendini olduğundan iyi gösterme tutumunu belirlemek için F - K göstergesini kullanırlar. Eğer F'in ham puanından K'nın

ham puanının çıkardığımızda elde edilen sayı negatif ve büyükse, kendini iyi gösterme tutumundan söz edilebilir. İyi bir izlenim bırakmak isteyenlerin K puanlarının F puanlarından yüksek olduğu açıktır, ancak iyi görünme isteğini gösterecek bir kesme puanı belirlemek mümkün değildir. F - K göstergesi, kendilerini iyi göstermeye çalışmadıkları halde K puanları yükselen üst sosyo-ekonomik düzeyden kişilere uygulanamaz.

III. BÖLÜMÜN HAZIRLANMASINDA YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Carson, R. C. (1969). *Interpretive manual to the MMPI*. In J.N. Butcher (Ed), *MMPI: Research developments and clinical applications* . New York: McGraw-Hill.
- Dahlstrom, W. G., Welsh, G. S., & Dahlstrom, L. E. (1972). *An MMPI Handbook : Volume I. Clinical interpretation* . Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Duckworth, J. C., & Duckworth, E. (1975). *MMPI interpretive manual for clinicians and counselors* . Muncie, Ind.: Accelerated Development, Inc.
- Lachar, D. (1974). *The MMPI: Clinical assessment and automated interpretation* . Los Angeles. Western Psychological Services.

IV

KLİNİK ÖLÇEKLER

Bu bölümün başlıca amacı, her bir klinik ölçeğin doğasını tartışarak, MMPI kullanıcısının ölçeklerin yansıttığı boyutları anlamasına yardımcı olmaktır. Buna ilaveten her bir ölçek için düşük ve yüksek puanlara ilişkin tanımlayıcı materyal de sunulmuştur. Ölçeklere ilişkin bilgiyi, klinisyen için en yararlı olacak şekilde sunmak amacıyla her tanımlamadan sonra kaynak gösterilmemiştir. Kullanılan genel yaklaşım, her bir ölçek için önceden bildirilen tanımlayıcı bilgilerin tümünün gözden geçirilmesi, bu bilgilere yazarın kendi araştırma ve deneyimlerinin eklenerek, tüm verilerin anlamlı bir analizinin sunulması şeklinde olmuştur. Bu bölüm hazırlanırken başvuru-lan kaynaklar kitabın sonunda sunulmuştur.

Literatürde "yüksek puan" tanımı konusunda birbirinden farklı görüşler vardır. Bazı yazarlar, 70'in üzerindeki T puanını yüksek puan olarak kabul ederler. Diğer bir grup, en üst quartil içine giren puanları yüksek olarak nitelendirirler. Bir başka yaklaşım ise, T puanının değerine bakmaksızın profildeki en yüksek ölçeği belirlemektir. Ancak, dikkatli bir literatür incelemesi, hangi yaklaşım kullanılırsa kullanılsın, yüksek puandan çıkarılan genel tablonun aynı olduğunu düşündürmüştür. Kitabın yazarı, kendi klinik uygulamalarında 70'in üzerindeki T puanını yüksek olarak kabul etmektedir.

Genelde puanlar yükseldikçe, biraz sonra belirtilecek olan tanımlamaların kişiye uyma olasılığında artar. Ayrıca, yükselme ile birlikte, test sonuçlarından çıkarılan test dışı semptomların yada davranışların şiddetinin ve çarpıcılığının artması beklenir. Bu bölümde, yüksek puanlar farklı düzeyler için farklı anlamlar taşıdığına, bunların neler olduğu da tartışılmıştır.

Düşük puanların anlamına ilişkin bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Genelde kişi bir ölçekte düşük puan aldığına, yüksek puanlar için belirtilen özellikleri ya da davranışları göstermediği düşünülürse de, bu her zaman doğru olmayabilir. Literatürde farklı tanımlara rastlansa da, genellikle 45'in altındaki T puanları "düşük puan" olarak kabul edilir. Bu bölümde düşük puan farklı bir şekilde ele alındığında bunun ne olduğu açıklanmıştır.

1. ÖLÇEK (HIPOKONDRIA)

1. ölçek, hipokondria tanısı almış hastalarınkine benzeyen bir semptom modeli gösteren kişileri belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Sendrom, bedene yönelik aşırı zihinsel ilgi ve hastalık korkularıyla karakterizedir. Bu korkular, delir düzeyinde olmasa da, devamlı ve ısrarlıdır.

1. ölçek, MMPI'nin tüm klinik ölçekleri içinde, açıkça tek bir boyutu değerlendirmesi ile dikkat çeker. Ölçekteki 33 maddenin hepsi bedene ya da genel fiziksel yeterliliğe ilişkin endişeleri içerir.

Faktör analizi çalışmaları sonucunda, 1. ölçek puanlarında görülen yükselmenin yalnızca tek bir faktörle açıklanabileceği bulunmuştur. Bu, kişinin sağlıklı olduğunu yadsıyıp, çeşitli bedensel semptomları kabul etmesidir.

1. Ölçekte Yüksek Puanlar

Yüksek puanlı kişilerin bedensel ilgilerinin çok fazla olması beklenmektedir. Özellikle puanlar biraz daha yükseldiğinde, genellikle belirsiz ve özgün olmayan yakınmalara eğilim görülebilir. Eğer özgün semptomlar varsa, bunlar daha çok mide ve karın bölgesiyle ilişkili olabilir. Bu kişilerin özellikleri arasında kronik yorgunluk, ağrı ve güçsüzlük yakınmaları da bulunabilir. Gerçek fiziksel sorunları olan hastalar 1. ölçekten yüksek puan alsalar bile, puanları somatik tepkiler gösteren psikiyatrik hastalarınkine kıyasla daha düşüktür. Bu nedenle, psikiyatrik hastalarda 1. Ölçeğin yükselmesi, hipokondria, nevrasteni, depresyon ya da anksiyete gibi klinik tanılardan biri ile kendini gösteren nevrotik bir durumu düşündürür. Psikopatik acting-out enderdir.

Hem psikiyatrik hem de psikiyatrik olmayan örneklerde 1. ölçekte yüksek puan alanlar kendilerine özgü bazı kişilik özellikleri göstermeye eğilimlidirler. Bu kişiler bencil, ben-merkezci, narsisistik olabilirler. Yaşama bakışları kötümser, yıkıcı ve alaycıdır. Genellikle hiçbirseyden hoşnut olmayan mutsuz kişilerdir. Çevrelerindeki insanlara dert olurlar. Fazla yakınır, ilişkilerinde sürekli sızlanan bir tavır içindedirler. Başkalarından çok şey beklerler ve onların yaptıklarına karşı aşırı eleştiricidirler. Düşmanlık duygularını dolaylı yollarla ifade ederler. 1. Ölçeğin puanları ile entelektüel yetenekler arasında negatif bir ilişki var gibi görünmektedir. Bu nedenle yüksek puan alanlar sıklıkla künt, heyecansız, isteksiz ve sözlü anlatımda başarısız kişilerdir.

Yüksek puan alanlar, genellikle, çok fazla açık anksiyete ve büyük yetersizlik belirtileri göstermezler. Kendilerinden beklenen sosyal ve mesleki işlevleri düşük bir düzeyde karşılayabilirler. Sorunları durumsal ya da geçici olmaktan çok uzun sürelidir.

İçgörü azlığı ve alaycı yaklaşım nedeniyle yüksek puan alanlar, psikoterapi ya da psikolojik danışma için çok uygun değildirler. Terapist karşı aşırı eleştirici davranmaya ve onun gösterdiği ilgi ve desteği yeterli bulmadıklarında ilişkiyi sonlandırmaya yatkındırlar.

1. Ölçekte Düşük Puanlar

1. Ölçeğin doğası tek boyutlu olduğu için düşük puan alanlar, yüksek puan alanlara zıt özellikler gösterirler. Ayrıca bu kişiler somatik uğraşları olmayan, iyimser, atak, duyarlı, anlayışlı ve genellikle günlük yaşamlarında etkin kişilerdir.

1. Ölçek İçin Tanımlamaların Özeti

1. Ölçek puanının yükselmesi, şu özellikleri taşıyan birini gösterir:

1. bedeniyle aşırı ilgilenen,
2. genellikle belirsiz somatik semptomlardan yakınan, (özgün bir semptom varsa, bu daha çok mide ve karın bölgesiyle ilişkili olabilir),
3. kronik yorgunluk, ağrı ve güçsüzlükten yakınan,
4. genellikle nevrotik bir tanı alan (hipokondria, nevrasteni ya da depresyon gibi),
5. açık anksiyete belirtileri göstermeyen,
6. bencil, ben-merkezci, narsisistik,
7. kötümser, yıkıcı, alaycı,
8. doyumsuz, mutsuz,
9. diğer insanları üzen,
10. sürekli yakınan ve sızlanan,
11. mızız,
12. talepkar ve başkalarına karşı eleştirici,
13. düşmanlığı dolaylı anlatan,
14. psikopatik davranışlar gösterme olasılığı düşük,
15. künt, heyecansız, isteksiz,
16. sözlü ifadede başarısız,
17. sorunları uzun süreden beri devam eden,
18. test dışı davranışsal uyumda büyük bir yetersizlik göstermeyen, pek başarılı olmasa da işlevlerini sürdürebilen,
19. içgörü azlığı ve alaycı yaklaşım nedeniyle danışma yada, psikoterapilere iyi yanıt vermeyen,
20. terapisti eleştiren,
21. terapistin kendine yeterince ilgi ve destek göstermediğini düşündüğünde terapiyi bırakma eğilimi olan,

1. ölçek puanının düşmesi şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. somatik düşünsel uğraşları olmayan,
2. iyimser,
3. duyarlı,
4. içgörülü,
5. genellikle günlük yaşamda etkin,

2. ÖLÇEK (DEPRESYON)

2. ölçek, semptomatik depresyonu belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Semptomatik depresyonun başlıca özellikleri; moral bozukluğu, gelecekte umutsuzluk ve kişinin kendi yaşamına yönelik genel bir hoşnutsuzluktur. Ölçekteki 60 maddenin büyük bir kısmı, mutsuzluk ve değersizlik duyguları, psikomotor yavaşlama, iç çekilme, çevreye ilgisizlik gibi depresyonun farklı yönlerine değinir. Ölçekteki diğer maddeler ise, fiziksel yakınmaları, endişe ya da gerilimi, dürtülerin inkarnı, düşünceleri kontrol etme güçlüğünü ve dini inançları içine alan çeşitli semptom ve davranışlarla ilişkilidir. 2. ölçek, kişinin yaşamıyla ilgili hoşnutsuzluk ve hoşnutsuzluğun kusursuz bir göstergesidir. Bu ölçekte puanların çok fazla yükselmesi klinik depresyonu yansıtabilir, yükselme daha ılımlıysa moral bozukluğu ve ilgisizlik ile karakterize genel bir tutumu ya da yaşam tarzını belirtebilir.

2. Ölçekte Yüksek Puanlar

Bu ölçekteki yüksek puanlar (özellikle T puanı 80'i geçmişse), çoğu kez depresif semptomları gösterir. Bu kişiler depresyon, elem ve mutsuzluk duyguları belirtebilirler. Daha özgün olarak da, sorunlarına çözüm bulma ve durumlarını düzeltme konusunda oldukça kötümser olabilirler. Kendini yeme ve suçluluk duyguları yaygındır. Psikomotor yavaşlık, ağlama, konuşmayı reddetme gibi davranışlar sergileyebilirler. Yüksek puanlı hastalar çoğu kez depresif tanılar (depresif nevroz ya da reaktif depresyon gibi) alırlar. Yüksek puanlılarda fiziksel yakınmaları, güçsüzlüğü, bitkinlik ya da enerji kaybını, ajitasyonu ya da gerilimi içeren başka semptomlar da sık görülür. Aynı zamanda üzüntüye eğilimli, sinirli ve çabuk kızan kişiler olarak tanımlanırlar.

Yüksek puan alanlarda belirgin bir kendine güvensizlik de vardır. Çeşitli durumlarda, bir işe yaramama ve yetersizlik duyguları ifade ederler. Bu kişiler, okulda ve işte yeterince başarılı olamadıklarını düşünürler.

İç çekilme ve insanlara ilgisizlik ile karakterize bir yaşam tarzı oldukça sıkır. Yüksek puan alanlar, utangaç, ketum, içedönük, ürkek ve çekingen kişiler olarak tanımlanırlar. Davranışları soğuktur, diğer insanlarla aralarında psikolojik bir uzaklık bırakma eğilimindedirler. Sıklıkla ilgi alanları ciddi bir şekilde kısıtlanmıştır ve bu nedenle evvelce katıldıkları aktivitelerden uzaklaşabilirler. Hareketlerinde son derece ihtiyatlı ve gelekseldirler.

Yüksek puan alan kişiler, basit kararlar alırken bile büyük güçlük çekerler. Meslek, evlilik, vb., önemli yaşam kararları ile yüz yüze geldiklerinde ise iyice bunahlr. Aşırı kontrollüdürler ve kendi dürtülerini inkara eğilimlidirler. Tatsız ve hoş gitmeyen durumlardan kaçınırlar. Sorunlarla yüz yüze gelmek istemezler.

2. ölçekteki yükselme, büyük bir sıkıntı duygusuyla ilişkili olduğundan, bu durum aynı zamanda psikoterapi ve psikolojik danışma için iyi bir prognoz belirtisi olarak ele alınabilir. Bununla beraber yüksek puanlar

alan kişilerin içinde bulundukları krizi atlattıklarında, tedaviye son vermeye eğilimli oldukları görülmüştür.

2. Ölçekte Düşük Puanlar

2. ölçekte düşük puan alanlar, yüksek puan alanlara kıyasla çok daha rahattırlar. Depresyon, suçluluk, anksiyete ve gerilim duyguları gibi olumsuz yaşantılar belirtmezler. Doğal ve sakinlerdir. Düşük puan alan kişiler, kendine güvenen ve genellikle duygusal açıdan dengeli, çoğunlukla etkili işlev görebilen bireylerdir. Neşeli ve iyimserdirler, sözel anlatımda çok az güçlük çekerler. Atak, aktif ve enerjiktirler. Fazladan sorumluluk üstlenmeye eğilimlidirler ve başkaları tarafından yarışmacı kişiler olarak görülürler.

Düşük puan alanlar, sosyal ortamlarda rahattırlar ve lider rolünü çabucak üstlenebilirler. Zeki, esprili, renkli görünürler ve insanlar üzerinde bıraktıkları ilk izlenim çok olumlu olur.

Düşük puan alan kişilerin davranışları bir miktar dürtüsel (impulsif) ve kontrolsüzdür. İnhibisyonlarının bulunmaması, dikkat çekici ve gösterişçi tavırlara yol açar. Bu nedenle insanlarda kırgınlık ve düşmanlık duyguları uyandırabilirler. Bunun yanı sıra, çoğu kez kendilerini otorite figürleri ile çatışma içinde bulurlar.

2. Ölçek İçin Tanımlamaların Özeti

2. ölçek puanının yükselmesi şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. depresif, mutsuz, kederli ve sıkıntılı,
2. gelecek hakkında kötümser,
3. kendini aşağılayan,
4. suçluluk duyguları olan,
5. konuşmak istemeyen,
6. ağlayan,
7. yavaş hareket eden, hareketsiz,
8. depresif bir tanı almış (genellikle depresif nevroz yada reaktif depresyon),
9. somatik yakınmaları olan,
10. yorgunluk, güçsüzlük ve enerji azlığından yakınan,
11. huzursuz (ajite) ve gergin,
12. kolay kızan, sinirli,
13. üzüntüye eğilimli,
14. kendine güvenmeyen,
15. yetersizlik ve yetersizlik duyguları taşıyan,
16. işte ya da okulda başarısız olduğunu düşünen,
17. içedönük, utangaç, çekingen, ürkek, yalnızlığa eğilimli ve ke-tum,
18. soğuk,
19. kişilerarası ilişkilerden kaçınan, insanlara fazla yaklaşmayan,

20. ihtiyatlı, geleneksel,
21. karar vermede güçlük çeken,
22. agresif olmayan,
23. aşırı kontrollü, dürtülerini inkar eden,
24. hoş olmayan durumlardan kaçınan,
25. sıkıntısı nedeniyle terapi için istekli,
26. varolan stres yatıştığında tedaviye son vermeye eğilimli.

2. ölçek puanının düşmesi, şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:
 1. gerginlik, anksiyete, suçluluk ve depresyon duygularından uzak,
 2. rahat ve huzurlu,
 3. kendine güvenen,
 4. duygusal yönden dengeli ve tutarlı,
 5. çoğu durumda etkin bir biçimde işlev gören,
 6. neşeli, iyimser,
 7. sözel anlatımda güçlük çekmeyen,
 8. atak, aktif, enerjik,
 9. yarışmacı,
 10. sorumluluk isteyen,
 11. sosyal ortamlarda rahat,
 12. liderlik rolünü üstlenen,
 13. zeki, esprili, renkli,
 14. ilk bakışta olumlu bir izlenim bırakan,
 15. dürtüsel (impulsif), kontrolsüz,
 16. serbest, gösterişçi, dikkat çekici,
 17. diğer insanlarda kırgınlık ve düşmanlık uyandıran,
 18. otorite figürleri ile çatışan.

3. ÖLÇEK (HİSTERİ)

Bu ölçek stres verici durumlarda histerik tepkiler kullanan hastaları belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Histerik sendrom, fonksiyon bozukluğu ya da istenmeden ortaya çıkan psikojenik kayıp ile karakterizedir.

3. ölçeğin içine giren 60 madde, iki genel tiptedir. Maddelerin bir kısmı; baş ağrısı, uyku düzensizliği, mide bulantısı, kusma, kalp ya da göğüs ağrısı gibi çeşitli özgün somatik yakınmalarla ve fiziksel sağlığın genel inkarıyla ilişkilidir. Diğer madde grubu ise, psikolojik ve duygusal sorunlar ile sosyal ortamlardaki huzursuzluğun genel inkarını kapsamaktadır. Normal grupta bu iki madde kümesi birbiriyle ilişkili olmamasına rağmen, histerik savunmaları kullanan kişiler her iki kümeden de yüksek puan alırlar. Zaten madde gruplarından biri kabul edilmezse, T puanının 70'in üzerine çıkması mümkün değildir.

3. ölçeğin puanları, entellektüel yetenek, eğitim durumu ve sosyal sınıfla ilişkilidir. Zeki, iyi eğitim almış ve üst sosyal sınıftaki kişiler daha

yüksek puan almaya eğilimlidirler. Yüksek puanlara, özellikle 3. ölçeğin en yüksek nokta olduğu profil tipine, hem normal hemde psikiyatrik popülasyonda kadınlarda daha çok rastlanır.

Diğerlerinden farklı olarak, 3. ölçeğin yükselme düzeyi önemlidir. Belirgin yükselişler ($T > 80$) klasik histerik semptomatoloji ile karakterize olan psikolojik bir durumu gösterirken, orta derecedeki puanlar, histerik bozukluklarda görülen (ancak klasik histerik semptomları içermeyen) bazı özellikleri düşündürür.

3. Ölçekte Yüksek Puanlar

3. ölçekte belirgin yükselme, strese tepki gösteren ve fiziksel semptomlar geliştirerek sorumluluktan kaçan kişileri düşündürür. Kişinin semptomları genellikle bilinen herhangi bir organik bozukluk modeline uymaz. Bu semptomlar, baş ağrısı, göğüs ağrısı, güçsüzlük, taşikardi ve akut anksiyete ataklarının bir kombinasyonu şeklinde olabilir. Bu kişiler çoğunlukla semptomsuz olmalarına rağmen, stres karşısında aniden semptomlar çıkarabilirler. Stres sonlandığında ise, semptomlar yine aniden kaybolur.

Yüksek puan alan kişilerde, fiziksel semptomların dışında başka semptomlar pek görülmez. Bazen kendilerini üzüntüye yatkın kişiler olarak tanımlasalar da, anksiyete, gerilim ya da depresyondan söz etmezler. Hallüsinasyonlar, delirler ve kuşkuculuk nadirdir. Gerçekten 3. ölçekten yüksek puan alanlarda psikotik bir tanı hemen hemen hiç görülmez. Psikiyatrik hastalar arasında en sık rastlanan tanı histerik nevrozdur (konversiyon histerisi).

Yüksek puanlıların çarpıcı bir özellikleri, semptomlarının altında yatan olası nedenlere karşı içgörülerinin yok denecek kadar az olmasıdır. Buna ilaveten, bu kişiler, kendi güdü ve duygularını anlamaktan da yoksundurlar.

Yüksek puan alanlar, çoğu kez psikolojik bakımdan aşırı derecede immatür olarak tanımlanırlar ve hatta zaman zaman çocuksu ya da bebeksi görünebilirler. Ben-merkezci, narsistik ve bencildirler; diğer insanlardan çok fazla ilgi ve ilgi beklerler. Genellikle arzu ettikleri ilgi ve sevgiyi elde etmek için dolaylı ve dolambaçlı yollara başvururlar. Diğer insanlar beklenmelerine karşılık vermezlerse kızabilir ve düşmanca davranabilirler. Ancak bu duygularını da inkar ederek doğrudan ve açık bir şekilde anlatmaktan kaçınırlar.

3. ölçekten yüksek puan alanlar, duygusal açıdan ilgili, dost tavırlı, gayretli ve ataktırlar. İlgi ve sevgi ihtiyaçları onları sosyal etkileşime zorlasa da, kişilerarası ilişkileri yüzeysel ve çocuksudur. Aslında insanlara yönelik ilgileri içten değildir, başkalarıyla daha çok kendi çıkarları için ilgilenirler.

Yüksek puan alanlar zaman zaman cinsel ya da saldırgan eyleme geçmeler (acting-out) sergileyebilirler ancak bu davranışları önemsemeyiz ve anlamaz görünürlükler. Davranışlarının gerçek nedenleri ile yüzleştirildiklerinde şaşırıp kızabilirler ve düşman olabilirler.

Yüksek puan alanlar, onay ve sevgi ihtiyaçlarından dolayı başlangıçta psikoterapi ya da psikolojik danışma için oldukça istekli görünebilirler. Genellikle doğrudan telkin ve öğütde oldukça iyi karşılık verirler. Ancak davranışlarının altında yatan nedenleri anlamaları yavaştır ve psikolojik yoruma çok direnç gösterirler. Yüksek puan alanların belirttikleri sorunlar arasında sıklıkla otorite ile çatışma, sosyal gruplar tarafından kabul edilmeme, evlilikle ilgili mutsuzluklar, iş ya da okulda başarısızlık endişeleri bulunur. Yaşam öykülerinde, kadınların bedensel yakınmalarla, erkeklerin ise isyankarlık ve düşmanlıkla tepki gösterdiği reddedici bir baba figürüne rastlanabilir.

3. Ölçekte Düşük Puanlar

3. ölçekten düşük puan alanlar günlük davranışlarında geleneksel ihtiyatlı ve uysaldırlar. Başkaları tarafından macera sevmeyen, tembel ve ilgi alanı dar kişiler olarak tanımlanırlar. Uzak ve soğuk davranışlı kişilerdir, künt bir duygulanım gösterirler. Sosyal ilgi ve katılımları çok sınırlıdır ve liderlik sorumluluğundan kaçmaya eğilimlidirler. Sıklıkla arkadaş sevmeyen, katı ve güç anlaşılır kişiler olarak görülürler. Diğer insanlara güvenmezler ve genelde oldukça kuşkucu davranırlar.

Sorunlarına yaklaşırken gerçekçi, mantıklı ve tutarlı davranırlar impulsif (dürtüsel) kararlar vermezler. Başkalarının sönük ve hareketsiz olarak nitelendirdikleri yaşam tarzlarından memnun görünürler.

3. Ölçek İçin Tanımlamaların Özeti

3. ölçek puanının yükselmesi şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. strese tepki gösteren ve fiziksel semptomlar geliştirerek sorunluluktan kaçan,
2. baş ağrısı, göğüs ağrısı, güçsüzlük, çarpıntı ve anksiyete atakları belirten,
3. semptomları aniden ortaya çıkan ve aniden kaybolan,
4. semptomlarının nedenlerine karşı içgörüsü olmayan,
5. kendi güdüyü ve duygularını anlamayan,
6. üzüntüye eğilimli,
7. anksiyete, gerilim ve depresyon belirtileri göstermeyen,
8. delir, hallüsinasyon ve kuşkuculuk şeklindeki semptomlar nadi ren gösteren,
9. psikotik bir tanı alma olasılığı düşük,
10. eğer psikiyatrik bir hasta ise sıklıkla histerik nevroz (konversiyon histerisi) tanısı alan,
11. psikolojik açıdan olgunlaşmamış,
12. ben-merkezci, narsisistik, bencil,
13. diğer insanlardan sevgi ve ilgi bekleyen,
14. istediği sevgi ve ilgiyi dolambaçlı ve dolaylı yollarla elde etmeyi çalışan,

15. düşmanlık ve kızgınlık duygularını açıkça ifade etmeyen,
16. sosyal açıdan ilgili,
17. dost tavırlı, konuşkan, gayretli ve atak,
18. kişilerarası ilişkileri yüzeysel ve olgunlaşmamış olan,
19. insanlarla kendi çıkarları için ilgilenen,
20. zamanı zaman önemsemediği ve anlamaya çalışmadığı cinsel ya da saldırgan eyleme geçmeler (acting-out) sergileyen,
21. başlangıçta tedaviye istekli,
22. doğrudan öğüt ya da telkine olumlu tepki veren,
23. davranışlarının nedenini anlamada (içgöründe) yavaş,
24. tedaviye ve psikolojik yoruma dirençli,
25. işte ya da okulda başarısızlık endişeleri olan,
26. evlilikle ilgili mutsuz yaşantıları olan,
27. sosyal gruplar tarafından kabul edilmeme duygusu taşıyan,
28. otorite figürleri ile sorunları olan,
29. yaşam öyküsünde reddedici bir baba figürü bulunan,

3. Ölçek puanının düşük olması şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. temkinli, geleneksel, uysal,
2. maceracı ve çalışkan olmayan,
3. ilgi alanı dar,
4. sosyal katılımı sınırlı,
5. liderlik rolünden kaçınan,
6. soğuk, katı ve zor anlaşılabilen,
7. kuşkucu ve diğer insanlara karşı güvensiz,
8. sorunlara gerçekçi, mantıklı ve tutarlı bir şekilde yaklaşan,
9. sönük ve hareketsiz yaşam tarzından hoşnut.

4. ÖLÇEK (PSİKOPATİK SAPMA)

4. ölçek, psikopatik ya da antisosyal kişilik bozukluğu tanısı alan hastaları belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Orijinal kriter grubundaki deneklerin günlük davranışlarında aşırı içme, gelişigüzel cinsel ilişki, çalma, yalan söyleme ve benzeri suça yönelik eylemler dikkati çekmekteydi. Ancak denek grubunda daha önemli suç işleyen kişiler yoktu. Bu ölçekteki 50 madde, otoriteyle ilişkili sorunlar, suç işleme, aile sorunları ve yaşamdan hoşnutsuzluk gibi farklı alanları kapsar. Anahtar oluşturan yanıtların, hem sosyal uyumsuzluğun kabulüne hem de sosyal denge ve güven iddialarına ilişkin olması ilginçtir.

4. ölçeğin puanları yaşla ilişkilidir. Gençler ve üniversite öğrencilerinin puanları genellikle $T = 55-65$ arasında dağılım gösterir. Aynı zamanda siyahların puanlarının beyazlara oranla daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Bu bulgu, siyahların birçok sosyal kuralı haksız bulduklarını ve bu nedenle pek önemsemediklerini düşündürülebilir.

4. Ölçekte Yüksek Puanlar

4. ölçekte yüksek puan alanlar, toplum kurallarını ve değerlerini özümsemeye büyük güçlük çekerler ve çok sayıda asosyal ya da antisosyal davranış sergilerler. Bu davranışlar yalan söylemeyi, dolandırıcılığı ve hırsızlığı içerebilir. Cinsel acting-out ve aşırı alkol ya da uyuşturucu madde kullanımı yaygındır. Yüksek puan alanlar, otorite figürlerine karşı isyankar davranmaya eğilimlidirler ve genellikle otoritenin bir türü ile çatışma içindedirler. Sıklıkla aile ilişkileri fırtınalıdır; sorunları için anne-babalarını suçlamaya yatkındırlar. Okulda başarısızlık, kötü çalışma öyküsü ve evlilik sorunları yüksek puan alanların tipik özellikleridir.

Yüksek puan alanlar, dürtülerinin anında doyumunu için uğraşan çok impulsif kişilerdir. Genellikle davranışlarını planlamazlar ve eylemlerinin sonuçlarını düşünmeksizin harekete geçebilirler. Çok sabırsızdırlar ve engellenmeye dayanma güçleri çok sınırlıdır. Davranışları mantıksız olabilir, kolayca büyük risklere atılabilirler. Yüksek puanlılar, diğerleri tarafından olgunlaşmamış ve çocuksu olarak tanımlanır. Narsistik, ben-merkezci ve bencildirler. Diğer insanların duygu ve ihtiyaçlarına karşı duyarsızdırlar ve insanlarla ilgilenirken onları nasıl kullanabileceklerini düşünürler. İlk bıraktıkları izlenim hoş ve olumlu ise de, insanlarla ilişkileri sıg ve yüzeyseldir. Bunun nedeni, insanlara kötü davrandıkları için onlar tarafından istenmemeleri olabilir. Ancak bu durum aynı zamanda insanlarla yakın ve sıcak ilişkiler kuramadıklarını da düşündürmektedir.

Yüksek puan alanlar tipik olarak çok dışa dönük ve sempatik kişilerdir. Konuşkan, aktif, maceraperest, enerjik ve rahattırlar. İnsanlar tarafından zeki ve kendine güvenen kişiler olarak değerlendirilirler. İlgileri geniş bir alana yayılmış, pek çok aktivite ile uğraşan kişiler olmalarına rağmen belirli amaçları yoktur ve davranışlarının yönü açık değildir.

Yüksek puan alanlar, düşmanca ve saldırgan davranmaya eğilimli olabilirler. Tavrılarında küçümseyici ve alaycı özellikler dikkat çeker. Çok öfkeli ve isyankardırlar, agresif dürtülerini eyleme dönüştürme eğilimindedirler. Aynı zamanda muhalif ve inatçı kişiler olarak da tanımlanırlar. Zaman zaman şiddet davranışlarının eşlik ettiği saldırgan öfke patlamaları oldukça sıktır ve genellikle bu davranışlara suçluluk duyguları eşlik etmez. Başları dertteyken pişman ve suçluymuş gibi davransalar da, bu tepkiler kısa sürelidir ve içinde bulunulan kriz dönemi sonlandığında kaybolurlar.

Genellikle yüksek puan alanlarda, yeti kaybına yol açan depresyon ve anksiyete duyguları yoktur. Aynı şekilde, psikotik semptomlar da nadirdir. Psikiyatrik hastalar arasında en sık görülen tanı kişilik bozukluğudur (antisosyal ya da pasif-agresif kişilik bozukluğu). Ancak, tasasız ve rahat kişi görünümünü altında endişe ve doyumsuzluğa ilişkin kanıtlar bulunabilir. Duygusal tepkilerin derinliği olmayabilir ve bu yoksunluğa bağlı olarak kişi, sıkıntı ve boşluk duyguları hissedebilir. Sözel becerileri, sempatik tavırları ve hemen farkedilen entelektüel yetenekleri ile psikoterapi ya da psikolojik danışma için iyi bir aday olarak görülürler. Ne yazık ki, tedavinin prognozu kötüdür. Buna rağmen, daha tatsız durumlardan (cezaevi, boşanma vs.)

kurtulmak için tedaviyi kabul edebilirler. Genellikle kendi hatalarının sorumluluğunu kabul etmezler ve kısa sürede tedaviye son verirler. Entellektüalizasyona başvurmaya ve kendi sıkıntıları için başkalarını suçlamaya eğilimlidirler.

4. Ölçekte Düşük Puanlar

4. ölçekte düşük puan alanlar, çok geleneksel, uysal ve otoriteye boyun eğen kişilerdir. Pasif, itaatkar ve çekingendirler. İnsanların kendilerine nasıl tepki gösterecekleri ile ilgilenirler. Kişilerarası ilişkilerde samimi ve güvenilirdirler.

Düşük puanlılarda rastlanan tipik bir özellik enerji düzeyinin düşük olmasıdır. Sosyal statü ve güvenlikle çok ilgili olmalarına rağmen, rekabetten kaçınma eğilimindedirler. İlgili alanları dardır, sorunlarına yaklaşırken yaratıcı ve spontan olmamalarına rağmen çok inatçı davranabilirler. Düşük puan alanlar, aynı zamanda, görüşlerinde katı ve kuralcıdır. Erkekler cinsellikle çok fazla ilgilenmezler ve kadınlardan korkabilirler.

Düşük puan alanlar, kendilerini aşırı eleştirmeye yatkındırlar ve nedensiz bir kendinden hoşnutsuzluk duygusu yaygındır. Başlangıçta psikoterapi ya da psikolojik danışmaya iyi yanıt verseler de tedaviye çok fazla bağlanma ve genellikle davranışlarının sorumluluğunu üstlenmekten korkma eğilimindedirler.

4. Ölçek İçin Tanımlamaların Özeti

4. ölçek puanının yükselmesi şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. toplumun kurallarını ve değerlerini özümsemede güçlük çeken,
2. sosyal ya da antisosyal davranışları olan:
 - a. yalan söyleme, dolandırıcılık, çalma,
 - b. cinsel acting-out,
 - c. aşırı alkol ya da uyuşturucu kullanma,
3. otorite figürlerine karşı isyankar,
4. fırtınalı aile ilişkileri,
5. kendi problemleri için anne-babasını suçlayan,
6. yaşam öyküsünde okul başarısızlığı,
7. yaşam öyküsünde kötü bir iş yaşamı,
8. evlilik sorunları olan,
9. impulsif davranan, dürtülerine anında doyum sağlamak için çabalayan,
10. plansız,
11. eylemlerinin sonucunu düşünmeksizin harekete geçen,
12. sabırsız, engellenmeye dayanma gücü sınırlı,
13. yargılaması yetersiz, düşünmeden tehlikeye atılan,
14. geçmiş deneyimlerinden yararlanamayan,
15. olgunlaşmamış, çocuksu,
16. narsisistik, ben-merkezci, bencil,

17. gösterişçi ve dikkat çekici,
 18. diğer insanlara karşı duyarsız,
 19. insanlarla ilgilenirken onları nasıl kullanacağını düşünen,
 20. hoş, iyi bir izlenim bırakan,
 21. kişilerarası ilişkileri yüzeysel ve sığ,
 22. sıcak ve yakın ilişkiler kuramayan,
 23. dışadönük, sempatik,
 24. konuşkan, aktif, maceraperest, enerjik, rahat,
 25. zeki, kendine güvenen,
 26. ilgi alanı geniş,
 27. belirli amaçları olmayan,
 28. düşmanca, saldırgan,
 29. küçümseyici, alaycı,
 30. acting-out'lar sergileyen,
 31. öfkeli, isyankar,
 32. muhalif, inatçı,
 33. ani saldırgan patlamalar, şiddet davranışları,
 34. davranışları için çok az suçluluk duyan,
 35. başı dertteyken pişman ve suçlu taklidi yapan,
 36. yeti kaybına yol açan anksiyete, depresyon ve psikotik semptomları bulunmayan,
 37. daha çok bir kişilik bozukluğu (antisosyal ya da pasif-agresif kişilik bozukluğu) tanısı alan,
 38. sıkıntıya yatkın, doyumsuz,
 39. duygusal tepkilerinde derinlik olmayan,
 40. can sıkıntısı ve boşluk duyguları,
 41. psikoterapi ya da psikolojik danışmada kötü prognoz,
 42. sorunları için başkalarını suçlamaya eğilimli,
 43. entellektüalizasyon mekanizmasını kullanan,
 44. cezaevinden ya da diğer bazı tatsız yaşantılardan kurtulmak için tedaviyi kabul eden ancak vaktinden önce tedaviyi bırakan.
4. ölçek puanının düşmesi şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:
 1. geleneksel, uysal,
 2. otoriteye boyun eğen,
 3. pasif, itaatkar, çekingen,
 4. diğer insanların göstereceği tepkilerle ilgilenen,
 5. samimi ve güvenilir,
 6. enerji düzeyi düşük, yarışmacı değil,
 7. toplumsal statü ve güvenlikle ilgili,
 8. ilgi alanı dar,
 9. yaratıcı ya da spontan olmayan,
 10. inatçı,
 11. kuralcı, katı,
 12. eğer erkekse, cinsellikle ilgilenmeyen, kadınlardan korkan,

13. kendine karşı eleştirici, kendinden hoşnut olmayan,
14. öğüt ve telkini kabul eden,
15. tedavide çok bağımlı olmaya eğilimli,
16. davranışlarının sorumluluğunu üstlenmekten korkan.

5. ÖLÇEK (ERKEKLİK-KADINLIK)

5. ölçek Hathaway ve McKinley tarafından homoseksüel erkekleri belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Homoseksüel örneklemin heterojen özelliği nedeniyle, test yapımcıları, tipik özellikleri cinsel sapma olan ve nevrotik, psikotik ya da antisosyal eğilimleri bulunmayan az sayıda vaka bulabilmişlerdir. Bu nedenle maddelere, "Terman Miles Tutum İlgisi Testinde" normal erkekler ve kadınlar tarafından farklı biçimlerde yanıtlanan maddeler de eklenmiştir. Hathaway ve McKinley bu ölçeği bir öntest olarak düşünmelerine rağmen, başlangıçtan bu yana standart bir klinik ölçek şeklinde kullanılmıştır.

Test yapımcılarının, kadınlarda cinsel sapmayı belirleyen bir ölçek geliştirme çalışmaları başarılı olmamıştır. Bu nedenle standart uygulamada hem kadınlar hem de erkekler için 5.ölçek kullanılır. Maddelerin 55'i, her iki cinsiyet için benzer şekilde, açıkça cinsel materyalle ilişkili olan 5 madde ise, kadın ve erkeklerde zıt yönde değerlendirilir. Elde edilen ham puanlar T puanlarına dönüştürülürken cinsiyete göre değiştirilir. Böylece erkeklerde yüksek ham puanlar otomatik olarak profil kağıdında yüksek T puanlarına dönüşürken, kadınlarda yüksek olan ham puanlar düşük T puanlarına dönüşür. Sonuçta her iki cinsiyet için de yüksek T puanı kendi cinsiyetinden sapma durumunu gösterir.

5. ölçekteki 60 maddeden bir kısmı açıkça cinsel konularla ilişkilidir. Bazı maddeler ise aile ilişkileri, dini tercihler, sosyal aktiviteler, endişe, korku ve duyarlılık alanları, hobi, eğlence ve iş alanındaki ilgiler gibi cinsellikle ilişkili olmayan farklı konuları kapsar.

5. ölçeğin puanları, zeka, eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey ile ilişkilidir. Zeki, iyi eğitim almış ve üst sosyo- ekonomik düzeyden kişiler yüksek puanlar elde ederler. Üniversite öğrencileri ya da yüksek eğitimli kişilerde T puanı sıklıkla 60-70 arasındadır. T puanının yüksek olup olmadığına karar vermeden önce, bu tür beklentilerin gözönünde bulundurulması gerekir. 80 T puanı, az eğitim görmüş, düşük sosyo-ekonomik düzeyden bir kişi için çok yüksek, iyi eğitimli, orta veya üst sosyal sınıftan bir kişi için orta yükseklikte bir puan olarak ele alınabilir.

5. ölçeğin puanları ters çevrildiği için, yüksek T puanları kadın ve erkekler için farklı anlamlar taşır. Bazı yazarlar erkeklerdeki yüksek puanın kadınlardaki düşük puana eşdeğer olduğunu, her ikisinin de kadınsı ilgi ve tutumları gösterdiğini öne sürmüşlerdir. Yüksek puanlı kadın ve erkekler dikkatlice incelendiğinde, bu tür bir yaklaşımın konuyu aşırı basitleştirme olduğu görülür. Bu nedenle bu kitapta, yüksek ve düşük puanlar, kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı ele alınmıştır.

5. Ölçekte Yüksek Puanlar (Erkekler)

Her ne kadar 5. ölçek yükseldiğinde ilk akla gelen homoseksüalite olsa da, homoerotik eğilimler ya da eşcinsel davranma olasılığı, elde edilen puan, kişinin zeka, eğitim ve sosyal sınıfına göre beklenenin çok üstünde ise düşünülmelidir. Kuşkusuz kişinin homoseksüel olup olmadığını tartışmadan önce bu düşünceyi doğrulayan başka bulgulara da ihtiyaç vardır. Yüksek puanlar, aynı zamanda, cinsel kimlik çatışmalarını ve kişinin erkek rolünde güvensiz olduğunu gösterebilir. Bu kişiler açıkça kadınsı davranışlar sergileyebilirler.

5. ölçekte yükselme, erkeklerde basmakalıp erkeksi ilgilerin bulunmadığını gösterir. Yüksek puan alan erkekler estetik ve artistik ilgilere sahip olan, ev işleri, çocuk bakımı gibi aktivitelere çoğu erkekten daha fazla katılan kişilerdir.

Yüksek puan alan erkekler, zihinsel uğraşlara önem veren, zeki ve yetenekli kişilerdir. Hırslı, sebatkar ve yarışmacıdırlar. Akıllı, berrak düşünceli, düzenli, mantıklı, iyi muhakeme yapabilen ve sağduyulu kişilerdir. Çok meraklıdırlar. Sorunlarına yaklaşıırken bireysel ve yaratıcı olabilirler.

Yüksek puan alan erkeklerin bir başka özellikleri, sosyal ve diğer insanlara karşı duyarlı olmalarıdır. İnsanlara karşı oldukça hoşgörülüdürler ve rahatlıkla sıcak duygularını ifade edebilirler. Kişilerarası ilişkilerde çok pasif, bağımlı ve itaatkardırlar. Barışsever kişilerdir ve sorunları ile yüzleşmekten kaçınırlar.

Yüksek puanlı erkeklerin kendilerini iyi kontrol edebildiklerini gösteren bazı kanıtlar vardır. Yüksek puanlılar arasında acting-out davranışları nadirdir. Suça eğilim gösteren alt gruplarda bile, 5. ölçek yükseldiğinde açık suç davranışları görülmez.

5. Ölçekte Yüksek Puanlar (Kadınlar)

5. ölçekte yüksek puan alan kadınların en çarpıcı özellikleri, geleneksel kadın rolünü reddetmeleridir. Spor, hobi ve diğer aktivitelerdeki ilgileri daha çok erkeksidir ve geleneksel olarak erkeklerle özgü kabul edilen iş ya da meslekleri seçme eğilimindedirler. Aktif, güçlü ve girişken olarak tanımlanırlar. Aynı zamanda çok yarışmacı, agresif ve başattırırlar. Diğerleri tarafından kaba, sert ve çetin kişiler olarak görülürler.

Yüksek puan alan kadınlar sokulgan, serbest ve kendine güvenen kişilerdir. Rahat, dengeli ve sakinlerdir. Oldukça mantıklı, hesaplı ve akılcı davranabilen kişiler olabilirler. Birçok insan tarafından soğuk tavrılı kişiler olarak görülürler.

Hastanede yatan psikiyatrik kadın hastalar arasında, psikotik tanı alanlara rastlanabilir. Bu kişiler hallüsinasyonlar, delirler ve şüphecilik gösterebilirler. Ancak acting-out davranışları nadirdir.

5. Ölçekte Düşük Puanlar (Erkekler)

5. ölçekte düşük puan alan erkekler kendilerini aşırı erkeksi olarak tanıtır. İş yaşamlarında, hobilerinde ve diğer aktivitelerinde açıkça er-

keksi seçimleri vardır. Fiziksel güç ve cesarete büyük önem verirler. Aynı zamanda agresif, heyecan arayan, maceraperest ve pervasız olarak tanımlanırlar. Kaba, adi ve terbiyesiz konuşma ve davranışlar yaygındır. Tutum ve davranışlarındaki abartı, bu kişilerin aslında kendi erkeklikleri konusundaki kuşkularını gizlemeye çabışıyor olabileceklarini düşündürür.

Düşük puan alan erkekler, başkaları tarafından, pek zeki olmayan kişiler olarak görülürler. İlgı alanları dardır. Sorunlarına yaklaşımını katı ve sıradandır. Eylemi düşünceye, pratik konuları teoriye tercih ederler.

Diğer insanlar, düşük puan alan erkekleri, yumuşak başlı, sakin ve rahat olarak algırlar. Aynı zamanda, neşeli, şen ve komik olarak da tanımlanırlar. Hayatlarından memnun görünürler. Ancak kendilerinin diğer insanları nasıl etkilediklerinden habersizdirler ve kendi dürtülerine karşı içgözüleri yoktur.

5. Ölçekte Düşük Puanlar (Kadınlar)

5. ölçekten düşük puan alan kadınlar hakkında elimizde bulunan bilgi sınırlıdır. Yine de düşük puan alan kadınların kendilerini basmakalıp bir kadın rolü çerçevesi içinde tanımladıkları açıktır. Yine düşük puanlı erkeklerde olduğu gibi, abartılı davranış ve tutumların altında kişinin kendi kadınlığına ilişkin kuşkuları gizlenebilir.

Düşük puan alan kadınlar çok pasif, itaatkar ve boyun eğicidir.

Kararları erkeklere bırakma eğilimindedirler. Kendilerine acıyan, şikayetçi ve herşeye kusur bulan kişiler olabilirler.

Diğer insanlar düşük puan alan kadınları duygulu, sıkıcı, mütevazı ve idealist olarak tanımlarlar. Hastanede yatan psikiyatrik hastalar arasında düşük puan alan kadınlar muhtemelen psikotik değildirler ve diğer kadın hastalara kıyasla daha sosyaldirler.

5. Ölçek İçin Tanımlamaların Özeti

5. ölçek puanının yükselmesi, erkeklerde şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. cinsel kimlik konusunda çatışma yaşayan,
2. erkeklik rolünde güvensiz,
3. kadınsı,
4. estetik ve artistik ilgiler,
5. zeki, yetenekli, zihinsel uğraşlara önem veren,
6. hırslı, yarışmacı, sebatkar,
7. zeki, berrak düşünceli, düzenli, mantıklı,
8. iyi bir yargılama yeteneği olan, sağduyulu,
9. meraklı,
10. yaratıcı, hayal gücü zengin ve sorunlara yaklaşımında bireysel,
11. sosyal, insanlara duyarlı,
12. hoşgörülü,
13. insanlara duyduğu sıcak duyguları rahat anlatabilen,
14. kişilerarası ilişkilerde pasif, bağımlı, boyun eğici,

15. barışsever, çatışmadan kaçmak için boyun eğmeyi tercih eden,
16. kendini iyi kontrol edebilen, acting-out nadir,
17. homoerotik eğilimler ya da açık homoseksüel davranışlar.

5. ölçek puanının yükselmesi, kadınlarda şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. geleneksel kadın rolünü reddeden,
2. iş yaşamında, sporda ve hobilerde erkeksi ilgilere sahip,
3. aktif, güçlü, girişken,
4. yarışmacı, agresif, başat,
5. kaba, sert, çetin,
6. girgin, scrbest, kendine güvenen,
7. rahat, dengeli, sakin,
8. mantıklı, hesaplı,
9. duygusuz,
10. soğuk tavırlı,
11. eğer psikiyatrik bir hasta ise hallüsinasyonlar, delirler ve kuş-kuculuk gösterebilir, fakat acting-out'lara rastlanmaz,
12. eğer psikiyatrik bir hasta ise, psikotik bir tanı alma olasılığı vardır.

5. ölçek puanının düşmesi, erkeklerde şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. kendini aşırı derecede erkeksi gösteren,
2. fiziksel güç ve cesarete aşırı önem veren,
3. agresif, heyecan arayan, maceraperest, pervasız,
4. kaba, incelikten yoksun, terbiyesiz,
5. erkeklik konusunda kuşkuları olan,
6. zeka yeteneği sınırlı,
7. ilgi alanı dar,
8. sorunlarına yaklaşırken inatçı ve sıradan,
9. eylemi düşünmeye tercih eden,
10. pratik,
11. yumuşak başlı, sakin, rahat,
12. neşeli, şen, komik,
13. halinden memnun,
14. çevresini nasıl etkilediğini farketmeyen,
15. kendi güdülerine karşı içgöründen yoksun.

5. ölçek puanının düşmesi, kadınlarda şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. kendini sıradan kadın rolü çerçevesinde tanımlayan,
2. kendi kadınlığı konusunda kuşkuları olan,
3. pasif, boyun eğici, itaatkar,
4. karar verirken erkeklerin düşüncelerine başvuran,

5. kendine acıyan,
6. şikayetçi, kusur arayan,
7. sıkıcı,
8. duygulu,
9. alçak gönüllü,
10. idealist,
11. eğer hastanede yatan psikiyatrik bir hasta ise büyük olasılıkla psikotik değildir,
12. eğer hastanede yatan psikiyatrik bir hasta ise diğer kadın hastalara kıyasla daha sosyaldır.

6. ÖLÇEK (PARANOYA)

6. ölçek, etkilenme (referans) ve kötülük görme (perseküsyon) düşünceleri, grandiyözite, şüphencilik, aşırı alınganlık, katı düşünce ve tutumlar gibi paranoid semptomları olan hastaları belirlemek için geliştirilmiştir. Geçerlik sorunları nedeniyle ölçek bir ön test olarak düşünülmüşse de, hastaları oldukça iyi ayırt edebildiği görüldüğünden korunmuştur. Bu ölçekten yüksek puan alan kişilerin genellikle paranoid semptomları vardır. Ancak buna rağmen açıkça paranoid semptomları olan bazı hastaların, 6. ölçekten ortalama puanlar alabildikleri de görülür.

Ölçekteki 60 maddenin bir kısmı açıkça psikotik davranışlarla (kuşkuculuk, etkilenme düşünceleri, perseküsyon delirleri, grandiyözite gibi) ilişkilidir. Geri kalan maddeler ise, duyarlılık, sosyalleşmemiş davranış, aşırı moral özellikler, katılık ve diğer insanlardan yakınma gibi birbirinden farklı alanları içine alır. Psikotik özellikleri düşündüren maddeleri işaretlemeksizin 70'den fazla T puanı elde etmek mümkündür.

6. ölçeğin puanları yaştan, eğitimdən ve zekadan pek fazla etkilenmez, ancak siyahların puanları beyazlara kıyasla hemen her zaman daha yüksektir. Bu durum, önemli bir psikopatolojiden çok siyahların kendilerini hayatta hep haksızlığa uğrayan kişiler olarak gördüklerini ve beyazların davranışlarına kuşkuyla yaklaştıklarını düşündürmektedir.

6. ölçeğin yorumu, maddeler tek bir boyut altında toplanmadığı için çok karmaşıktır. Çok yüksek puanlar ($T > 75$), genellikle açık paranoid veya psikotik davranış düşündürür. Daha ılımlı yükselmeler ($T = 65-75$ arası), paranoid eğilimle ilişkilidir. Hafif yükselmeler ($T = 55-65$ arası), olumlu özellikleri olan kişilerde görülmektedir. Biraz düşük puanlar ($T = 35-45$ arası), normal ve hastalar için farklı anlamlar taşımaktadır. Bu durumda normaller genellikle olumlu, hastalar ise olumsuz şekilde tanımlanırlar. 6. ölçekteki puan çok düşük olduğunda ($T < 35$), özellikle profilin en düşük ölçeği ise, aşırı yükselmeye olduğu kadar apaçık olmasa da, paranoid veya psikotik davranıştan şüphelenilir. Karmaşık yapısı nedeniyle ölçeği yüksek puanlar ve düşük puanlar diye iki grupta incelemek konuyu aşırı basitleştirmek olur.

6. Ölçekte Yüksek Puanlar

Aşırı yükselme

6. ölçek, 75 T puanının üstüne çıktığında özellikle aynı zamanda profildeki en yüksek ölçek ise, kişi açık psikotik davranışlar gösterebilir. Düşüncede bozukluk, perseküsyon ve/veya büyüklük delirileri olabilir. Et-kilenme (referans) düşünceleri de oldukça yaygındır. Kendilerine kötü davranılıyormuş ve alay ediliyormuş gibi hissedebilirler; kızgın ve gücümüş olabilirler; insanlara kin besleyebilirler. Yansıtma (projeksiyon) ortak savunma mekanizmalarıdır. Paranoid şizofreni ya da paranoid bozukluk tanısına oldukça sık rastlanır.

İlmli Yükselme

6. ölçekten elde edilen T puanı 65-75 arasında olduğunda, açık psikotik davranışlar pek fazla görülmez. Ancak, bu kişilerde, paranoid eğilimi düşündürülen davranış ve kişilik özellikleri dikkati çeker. Bu kişiler, aşırı hassas ve başka insanların düşüncelerine karşı çok duyarlı olabilirler. Kendilerini yaşamda haksızlığa uğramış gibi hissederler. Rasyonalize etmeye ve kendi sorunları için başkalarını suçlamaya yatkındırlar. Ayrıca kuşkucu ve temkinli görünürler. Düşmanca tutumlar, alınganlık ve iddialı tavır yaygındır. Tutum ve görüşlerinde çok tutucu ve katı olma eğilimindedirler. Mantıklılığın aşırı vurgulanması mümkündür. Psikoterapide prognozları kötüdür, çünkü duyguları hakkında konuşmaktan hoşlanmazlar ve çoğunlukla rasyonalizasyonlara başvururlar. Terapistle bağlanmaları çok güç olur. Tedavi sırasında daha çok aile üyelerine duydukları kızgınlık ve hostiliteden söz ederler.

Hafif Yükselme

T puanı 55-65 arasında olan kişiler, özellikle psikiyatrik hasta de-ğışeler, genellikle olumlu şekilde değerlendirilirler. Kibar, müşfik, cömert, duygusal, iyi kalpli ve barışçı insanlar olarak tanımlanırlar. Çevrelerinde olup bitenlere duyarlı olma ve diğer insanlara güvenme eğilimindedirler. Ayrıca işbirlikçi ve açıktırlar. Geniş bir ilgi alanları vardır. Enerjik ve çalışkan görünürler. Girişimci ve yaptıkları işe kendilerini veren kişilerdir. Zeki, dengeli, mantıklı, gerçekçi, berrak düşünceli, anlayışlı kişiler olarak görülürler. Daha olumsuz özellikleri olan hasta grubundaki kişiler ise sosyal ilişkilerde itaatkar ve bağımlıdırlar. Kendilerine güvenleri yoktur. Kendilerini çok sinirli ve çabuk üzülen kişiler olarak tanımlarırlar.

6. Ölçekte Düşük Puanlar

6. ölçekteki hafif düşme ($T = 35 - 45$ arası) normaller ve psikiyatrik hastalar ya da başka türden uyumsuzluk belirtileri olan kişiler için farklı anlamlar taşır. Normaller, özellikle eğitim ve zeka düzeyi açısından ortalamanın üzerinde olanlar, dengeli, neşeli, ağrbaşlı, düzenli, olgun ve mantıklı gibi hayli olumlu sıfatlarla tanımlanırlar. Akıllı, kararlı ve sebatkar kişiler olarak görülürler. Sosyal açıdan ilgili ve yaşam sorunlarını cesaretle karşılayan kişilerdir. Sorunlara yaklaşırken dikkatli, tedbirli ve kontrollü davranıma eğilimlidirler. Eğer aynı aralığa giren puanlar hasta olduğu bilinen

kişilerde görülürse, olumsuz davranışlar ve kişilik özellikleri akla getirir. Bu kişiler inatçı, kaçamak tavrılı ve ihtiyatlı olarak görülürler. Benmerkezcidirler ve kendilerini doğrudan etkilemeyen şeylerle pek fazla ilgilenmezler. Kendinden hoşnut olmayan ve diğer insanların tepkilerine aşırı duyarlı kişiler olabilirler. Ayrıca, içgörüsüz, sosyal ilgi ve becerileri olmayan kişilerdir. Dar bir ilgi alanları vardır ve problemlere yaklaşım biçimleri esneklikten yoksundur. Güçlü bir vicdanları yoktur; ilkelere pek az önem verirler. Bu kişiler kaba, beceriksiz, güvenilir olmayan, huysuz, muhalif ve yeteneksiz gibi sıfatlarla tanımlanırlar. Hastanede yatan psikiyatrik hastalar arasında psikotik semptomlar ya da böyle bir tanı pek görülmez.

Son derece düşük puanlarda ($T < 35$), klinisyen bir paranoid bozukluk olasılığına karşı çok dikkatli olmalıdır. Elde edilen puan düşük olmasına rağmen kişinin, çok açık olmayan referans düşünceleri, delirleri ve kuşkucu tutumları bulunabilir. Kaçamak cevap veren, savunmacı ve ihtiyatlı kişilerdir. Düşmanca ve saldırgan bir görünümünden çok, utangaç, ketum ve içe çekilmiş kişi izlenimi bırakırlar.

6. Ölçek İçin Tanımlamaların Özeti

6. ölçek puanının aşırı yükselmesi ($T > 75$), şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. açık psikotik davranışlar gösteren,
2. düşünce bozukluğu,
3. kötülük görme (perseküsyon) ve/veya büyüklük delirleri,
4. etkilenme (referans) düşünceleri,
5. kendine kötü davranıldığını veya kendiyle alay edildiğini hisseten,
6. kızgın, gücenmiş, kindar,
7. savunma mekanizması olarak projeksiyonu kullanan,
8. sıklıkla şizofreni veya paranoid bozukluk tanısı alan.

6. ölçek puanının ılımlı yükselmesi ($T = 65-75$), şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. paranoid eğilimi olan,
2. hassas; diğerlerinin tepkilerine fazla duyarlı,
3. kendini yaşamda haksızlığa uğramış gibi hisseden,
4. rasyonalize eden; kendi sorunları için başkalarını suçlayan,
5. kuşkucu, ihtiyatlı,
6. düşman, gücenmiş, inatçı,
7. tutucu ve katı,
8. mantıklılığı aşırı vurgulayan,
9. psikoterapide kötü prognoz gösteren,
10. duygusal sorunları hakkında konuşmaktan hoşlanmayan,
11. terapistle ilişki kurmakta güçlük çeken,
12. aile üyelerine karşı kızgınlığını ve gücenikliğini ifade eden.

6. ölçek puanının hafif yükselmesi (T=55-65), şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. nazik, müşfik, cömert,
 2. duygusal, iyi kalpli, barışçı,
 3. duyarlı,
 4. güvenilir,
 5. işbirlikçi,
 6. açık,
 7. ilgi alanı geniş,
 8. enerjik ve çalışkan,
 9. girişimci,
 10. dengeli, zeki, mantıklı, gerçekçi, berrak düşünceli, anlayışlı.
- Hasta grubunda :
11. itaatkar,
 12. kendine güvenmeyen,
 13. çabuk sinirlenen ve kolay üzülen.

6. ölçek puanının hafif düşmesi (T = 35-45), şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. Psikiyatrik hasta değilse ya da uyumsuzluk belirtisi göstermiyorsa;
 - a. neşeli,
 - b. dengeli,
 - c. düzenli,
 - d. ağırbaşlı, olgun, mantıklı,
 - e. sosyal açıdan ilgili,
 - f. akıllı, kararlı, sebatkar,
 - g. yaşam sorunlarıyla başarıyla mücadele edebilen,
 - h. güvenilir ve sadık,
 - i. dikkatli, temkinli ve kontrollü,
2. Psikiyatrik bir hasta veya uyumsuzluk belirtileri gösteren biri ise;
 - a. inatçı, kaçamak tavırlı, ihtiyath,
 - b. ben-merkezci,
 - c. kendisini doğrudan etkilemeyen şeylerle pek fazla ilgilenmeyen,
 - d. kendinden hoşnut olmayan,
 - e. başkalarının tepkilerine karşı aşırı duyarlı,
 - f. anlayışsız,
 - g. sosyal ilgi ve becerileri olmayan,
 - h. zayıf vicdanlı, ilkelere pek önem vermeyen,
 - ı. kaba ve beceriksiz,
 - i. güvenilmez,
 - j. huysuz, muhalif (zıtlaşmaya eğilimli),
 - k. yeteneksiz,
 - l. psikotik semptomlar pek görülmez, psikotik tanılar sık konmaz.

6. ölçek puanının aşırı düşmesi ($T < 35$), şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. açıkça paranoid bir bozukluğu olabilir,
2. delirler, kuşkuculuk, etkilenme (referans) düşünceleri görülebilir,
3. semptomlar aşırı yükselme durumunda görülenler kadar açık değildir,
4. kaçamak tavırlı, savunmacı, ihtiyatlı,
5. utangaç, ketum, içe çekilmiş.

7. ÖLÇEK (PSİKASTENİ)

7. ölçek temel olarak psikasteni adı altında toplanan semptomları ölçme amacıyla geliştirilmiştir. Her ne kadar bu tanı bugün artık pek kullanılsa da, ölçeğin geliştirildiği yıllarda oldukça sık kullanılmaktaydı. Günümüz tanı kategorileri içinde, obsesif-kompulsif nevroz, orjinal psikasteni tanısına en yakın olanıdır. Psikasteni tanısı alan kişilerin düşüncelerinde yoğun endişeler, kompülsiyonlar, obsesyonlar ve mantık dışı korkular dikkati çeker. Bu semptom modeli yatan hastalardan çok ayaktan tedavi görenlerde bulunur. Bu nedenle ölçek küçük bir vaka grubu üzerinde yapılandırılmıştır.

7. ölçeğin 48 maddesi çeşitli semptom ve davranışları içine almaktadır. Maddelerin çoğu kontrol edilemeyen veya obsesif düşünceler, korku ve anksiyete duyguları ve kişinin kendi yeteneklerine duyduğu güvensizlikle ilişkilidir. Mutsuzluk, fiziksel yakınmalar ve konsantrasyon güçlüğü bu ölçekte anlatım bulur.

7. Ölçekte Yüksek Puanlar

7. ölçek psikolojik karmaşa ve huzursuzluk için iyi bir göstergedir. Yüksek puan alanlar anksiyöz, gergin ve ajite olabilirler. Önemsiz sorunlar karşısında bile çok kaygılı, korkulu ve endişelidirler. Sinirli ve tedirgindirler, dikkatlerini yoğunlaştırmada güçlük çektiklerini belirtirler.

Yüksek puan alanlar kendilerini incelemeye yatkındırlar. Obsesif düşünceler, kompulsiyonlar, ritüel tarzı davranışlar ve tekrarlayıcı düşünceler yaygındır. Obsesyonlar ve tekrarlayıcı düşünceler genellikle güvensizlik ve aşağılık duygularını içerir. Kendine güvensiz, kendini eleştiren ve küçük gören, sıkılgan, kendi değeri ile ilgili kuşkuları olan kişilerdir. Yüksek puan alanlar katı ve tutucu olma eğilimindedirler. Kendileri ve diğer insanların davranışları için koydukları standartlar yüksektir. Mükemmelli yetçi ve dürüst olabilirler; kendi standartlarına göre davranmadıklarında suçluluk duyabilirler ve amaçlarına erişemedikleri için depresif olabilirler.

Genellikle yüksek puan alanlar, temiz, düzenli, tertipli ve titiz kişilerdir. İnatçı ve güvenilirdirler. Ancak sorunlarına yaklaşım biçimleri orjinaliteden ve yaratıcılıktan yoksundur. Başkaları tarafından sıkıcı ve resmi olarak görülürler. Karar vermede büyük zorluk çekerler, küçük ve

sıradan kararlar karşısında bile çok tereddüt edip, kararsız kalabilirler. Bunlara ek olarak, sorunların önemini çarpıtmaları ve stres durumlarında aşırı tepki göstermeleri mümkündür.

Yüksek puan alanlar utangaç ve sosyal etkileşimlerde başarısızdırlar. Anlaşılması güç kişiler olarak tanımlanırlar. İnsanlar tarafından sevilme ve onaylanma konularında endişeleri vardır. Diğer insanlar tarafından duygusal, barışçı, iyi kalpli, güvenilir, duyarlı ve nazik olarak görülürler. Ayrıca bu kişiler, bağımlı, heyecanlı, olgunlaşmamış ve konuşkan gibi sıfatlarla tanımlanırlar. Yüksek puan alan kişilerden bazıları fiziksel yakınmalardan söz ederler. Bu yakınmalar kalp bölgesinde, sindirim ve boşaltım sisteminde odaklaşabilir. Yorgunluk, bitkinlik ve uykusuzluk şikayetleri de görülebilir. Yüksek puan alan kişiler huzursuz ve mutsuz olmalarına rağmen, kısa süreli psikoterapiye veya psikolojik danışmaya pek iyi yanıt vermezler. Sorunları ile ilgili biraz içgörü sahibi olmalarına rağmen, rasyonalizasyona ve entellektüalizasyona eğilimlidirler. Yorumlara karşı direnirler ve terapiste karşı düşmanca davranabilirler. Bununla birlikte terapiye pek çok hastadan daha uzun bir süre devam edebilirler ve çok yavaş fakat düzenli bir iyileşme gösterebilirler. Terapiye getirilen sorunlar, otorite figürleri ile problemleri, kötü iş ve çalışma alışkanlıklarını veya homoseksüel dürtülerle ilişkili kaygıları içerebilir.

7. Ölçekte Düşük Puanlar

7. ölçekten düşük puan alanlar yetenekli ve iyi uyumlu kişiler olarak görünürler. Yeti kaybına yol açan korku ve anksiyeteden uzaktırlar. Kendilerine güvenirlir, sıcakkanlı, neşeli ve arkadaş canlısı kişiler olarak değerlendirilirler. Geniş bir ilgi alanları vardır. Sorumluluk sahibi, etkin, gerçekçi ve uyumlu kişilerdir. Başarı, statü, kabul görme onlar için önemlidir.

7. Ölçek İçin Tanımlamaların Özeti

7. ölçek puanının yükselmesi, şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. karmaşa içinde ve huzursuz,
2. anksiyöz, gergin, ajite,
3. kaygılı ve endişeli,
4. sinirli ve tedirgin,
5. dikkatini yoğunlaştırmada güçlük çeken,
6. kendini inceleyen (içebakış), tekrarlayıcı düşünceleri olan,
7. obsesif düşünceler,
8. kompulsif davranışlar,
9. aşağılık duyguları,
10. güvensizlik,
11. kendi değeri ile ilişkili endişeleri olan, kendini eleştiren ve küçük gören,
12. katı ve tutucu,

13. kendi ve diğer insanlar için yüksek standartlara sahip,
 14. mükemmeliyetçi ve dürüst,
 15. kendini suçlu hisseden, depresif,
 16. temiz, düzenli, tertipli, titiz,
 17. inatçı,
 18. güvenilir,
 19. sorunlara yaklaşım biçimi yaratıcılık ve orjinaliteden yoksun,
 20. sıkıcı ve resmi,
 21. tereddüt eden ve kararsız,
 22. sorunların önemini çarpıtan, aşırı tepki gösteren,
 23. utangaç,
 24. sosyal etkileşimlerde başarısız,
 25. anlaşılması güç,
 26. sevilme ve onaylanma konusunda endişeler taşıyan,
 27. duygusal, sakın, iyi kalpli, güvenilir, duyarlı ve nazik,
 28. bağımlı,
 29. bireysel,
 30. heyecanlı,
 31. olgunlaşmamış,
 32. fiziksel yakınmalar:
 - a. kalp,
 - b. boşaltım sistemi,
 - c. sindirim sistemi,
 - d. yorgunluk, bitkinlik, uykusuzluk,
 33. kısa terapiye iyi yanıt vermeyen,
 34. sorunları hakkında bir parça içgörü sahibi,
 35. entellektüalizasyon, rasyonalizasyon,
 36. psikoterapide yapılan yorumlamalara karşı direnç,
 37. terapistle karşı düşmanca duygular,
 38. psikoterapiye pek çok hastaya kıyasla daha çok devam eden,
 39. psikoterapide yavaş fakat düzenli ilerleme gösteren,
 40. terapide otorite çatışmalarından, kötü iş ve çalışma alışkanlıklarından ve homoseksüel dürtülerle ilişkili kuşkulardan söz eden.
7. ölçek puanının düşmesi, şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:
1. yetenekli,
 2. iyi uyumlu,
 3. korku ve kaygılardan uzak,
 4. kendine güvenli,
 5. ilgi alanı geniş,
 6. sorumluluk sahibi, etkin, gerçekçi, uyumlu,
 7. başarıya, statüye, kabul görmeye önem veren.

8. ÖLÇEK (ŞİZOFRENİ)

8. ölçek şizofreni tanısı almış hastaları belirlemek için geliştirilmiştir. Bu kategori düşünce, mizaç ve davranış bozuklukları ile karakterize heterojen bir grup bozukluğu içerir. Gerçeği yanlış değerlendirme, delirler ve hallüsinasyonlar görülebilir. Bu kişilerde amovalans ve duygusal tepkilerde azalma oldukça siktir. Davranışlar içe çekilmiş, saldırgan ya da garip olabilir. 8. ölçekteki 78 madde birbirinden farklı davranışları kapsar. Bazı maddeler garip düşünce ve algılar, perseküsyon delirleri, hallüsinasyonlar gibi açık psikotik semptomlarla ilişkilidir. Maddelerin geri kalanı ise sosyal yabancılaşma, bozuk aile ilişkileri, cinsel endişeler, dürtü denetiminde ve konsantrasyonda güçlük, korku, kaygı ve doyumsuzluklar gibi konularla bağlantılıdır.

8. ölçeğin puanları yaşla ve ırkla ilişkilidir. Gençler ve üniversite öğrencilerinden elde edilen T puanının sıklıkla 55-65 arasında olması, içinde bulunulan yaşam dönemine özgü karmaşanın yansıması olarak ele alınabilir. Siyahlar, özellikle de erkekler beyazlardan daha yüksek puan alma eğilimindedirler. Siyahların daha yüksek puanlar alması, bu grupta psikopatolojinin daha fazla olduğu anlamına gelmez. Bu siyahların kendilerini topluma uzak ve yabancı hissetmelerinin basit bir göstergesi olabilir. Madde kullanımına bağlı olarak çok sayıda garip yaşantı, algı ve duygulardan söz eden kişilerde 8. ölçeğin yükseldiği bulunmuştur.

8. Ölçekte Yüksek Puanlar

Her ne kadar 8. ölçeğin T puanına dayanarak şizofreni tahmininde bulunmak doğru değilse de, 80 ile 90 arasındaki T puanı test dışında psikotik bir durum olasılığını akla getirir. Konfüzyon, dezorganizasyon, dezoryantasyon görülebilir. Bazen delir düzeyine varabilen garip düşünceler ya da tutumlar, hallüsinasyonlar ve yargılamada bozukluk olabilir. Çok yüksek puanlar (T > 100) genellikle psikotik olmayan kişilerden elde edilir. Bu tür aşırı yükselme, kişinin şiddetli bir ruhsal karmaşa içinde olabileceğini ya da yardım isteği nedeniyle düşünce, duygu ve davranışlarda sapma düşündüren maddelerin çoğunu kabul etmiş olabileceğini gösterir.

8. ölçekteki yükselme, şizoid bir yaşam biçimini akla getirir. Yüksek puan alanlar kendilerini sosyal çevrelerinin dışında hissederler. Kendilerini toplumdan ayrılmış, yabancılaşmış, yanlış anlaşılan ve akranları tarafından kabul edilmeyen kişiler olarak görürler. İçe çekilmiş, yalnız, ketum ve ulaşılmazdırlar. İnsanlarla ve yeni durumlarla karşılaşmaktan kaçınabilirler. Diğer insanlar tarafından utangaç, soğuk ve uzak olarak tanımlanırlar.

Yüksek puan alanlar yaygın bir anksiyete içindedirler. Kendilerini gücümüş, hostile ve saldırgan hissedebilirler. Ancak bu duygularını ifade edemezler. Stres karşısında gösterdikleri tipik tepki, gündüz rüyalarına ve hayallere sığınmaktır. Bazıları için gerçek ve hayali birbirinden ayırmak güç olabilir.

Yüksek puan alanlar kendileri ile ilgili kuşkularını dert edinebilirler. Kendilerini aşağı, yetersiz ve doyumсуз hissedebilirler. Cinsel düşünce uğraşları, cinsel konfüzyon görülebilir. Davranışları başkaları tarafından alışımadık, olağandışı, garip ve tuhaf olarak nitelendirilir. Fiziksel yakınmaları olabilir. Bunlar genellikle belirsiz ve uzun süreden beri devam eden yakınmalardır.

Yüksek puan alanlar kimi zaman çok inatçı, içe kapanık ve dik kafalı olabilirler. Kimi zamanlar ise cömert, sakin ve duygusal olarak görülebilirler. Yüksek puan alanları tanımlarken kullanılan diğer sıfatlar ise, olgunlaşmamış, impulsif, maceraperest, zeki, dürüst ve sinirlidir. Geniş bir ilgi alanına sahip olmalarına, sorunlara yaklaşırken yaratıcı düşünceler üretebilmelerine rağmen amaçları genellikle soyut ve belirsizdir.

Yüksek puan alanlar sorunlarının süregen yapısı ve terapist ile anlamlı bir ilişkiye girme konusundaki isteksiz tutumları nedeniyle, psikoterapide iyi bir prognoz göstermezler. Yine de terapiye birçok hastaya kıyasla daha uzun süre devam edebilirler ve giderek terapistte güvenmeye başlayabilirler.

8. Ölçekte Düşük Puanlar

8. ölçekte düşük puan alanlar, arkadaş canlısı, neşeli, iyi huylu, duyarlı ve güvenilir olma eğilimindedirler. Dengeli, uyumlu ve sorumluluk sahibi kişilerdir. Bunların yanı sıra, düşük puan alanlar ilişkilerinde çekingen davranırlar, derin duygusal ilişkilerden kaçınırlar. Kişilerarası ilişkilerde itaatkar ve uysaldırlar. Otoriteyi açıkça kabul ederler. Temkinli, geleneksel, tutucu olma eğilimindedirler. Sorunlarına yaklaşırken hayal güçlerinden yararlanamazlar, pratiktirler, somut düşünürler. Başarı, statü ve güç ile ilgilenirler, ancak aşırı kontrollü olduklarından, açıkça rekabeti gerektiren ortamlardan kaçınırlar.

8. Ölçek İçin Tanımlamaların Özeti

8.ölçek puanının yükselmesi şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. belirgin psikotik davranış gösterme olasılığı yüksek olan,
2. şaşkın, dezorganize, dezoryante,
3. garip düşünceler ya da tutumlar,
4. hallüsinasyonlar,
5. yargılamada yetersizlik,
6. şizoid bir yaşam biçimi,
7. kendini sosyal çevrenin dışında hisseden,
8. kendini toplumdan ayrılmış, yabancılaşmış hisseden,
9. yanlış anlaşılma, akranları tarafından istenmeme duygusu içinde,
10. içe çekilmiş, yalnız, ketum ve ulaşılmaz,
11. insanlarla ve yeni durumlarla karşılaşmaktan kaçınan,
12. utangaç, soğuk, uzak,
13. yaygın anksiyete yaşantıları olan,

14. gücenmiş, hostile, saldırgan hisseden,
15. duygularını ifade edemeyen,
16. strese tepki olarak gündüz rüyalarına ve hayallere sığınan,
17. gerçek ile hayali birbirinden ayırmada güçlük çeken,
18. kendi ile ilgili kuşkularını dert eden,
19. kendini aşağı, yetersiz ve doyumsuz hisseden,
20. cinsellikle ilgili düşünsel uğraşları olan, cinsel rol karmaşası içinde,
21. olağandışı, alışılmamış, garip ve tuhaf,
22. yakınmaları belirsiz ve süregen,
23. inatçı, içe kapanık, dik kafalı,
24. cömert, sakın, duygusal,
25. olgunlaşmamış, impulsif,
26. maceraperest,
27. zeki,
28. dürüst,
29. sinirli,
30. ilgi alanı geniş,
31. yaratıcı ve hayal gücü zengin,
32. soyut ve belirsiz amaçları olan,
33. problem çözümü için gerekli olan temel bilgilerden yoksun,
34. psikoterapide kötü bir prognoz gösteren,
35. terapiste bağlanma konusunda isteksiz,
36. terapiye pek çok hastadan daha uzun süre devam eden,
37. zamanla terapiste güven duymaya başlayan.

8. ölçek puanının düşmesi şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. arkadaş canlısı, neşeli, iyi huylu, duygusal, güvenilir,
2. dengeli, uyumlu,
3. sorumluluk sahibi,
4. ilişkilerde çekingen, derin duygusal ilişkilerden kaçan,
5. itaatkar, uysal, otoriteyi açıkça kabul eden,
6. temkinli, geleneksel, tutucu, sorunlara yaklaşırken hayal gücünden yararlanmayan,
7. pratik, somut düşünen,
8. başarı, statü ve güç ile ilgili,
9. açıkça rekabet gerektiren durumlara girmek istemeyen.

9. ÖLÇEK (HİPOMANİ)

9. ölçek, hipomanik semptomlar gösteren psikiyatrik hastaları belirlemek için hazırlanmıştır. Hipomani, yükselmiş mizaç, hızlanmış konuşma ve motor aktivite, kolay heyecanlanma, düşünce uçuşmaları ve kısa depresyon dönemleri ile karakterizedir. 9. ölçekte yer alan 46 maddeden bir kısmı, özellikle hipomanik bozukluk belirtilerini (örneğin, aktivite düzeyi,

heyecanlılık, iritabilite, büyüklük düşünceleri gibi) içerir. Diğer maddeler ise, aile ilişkileri, ahlaki değerler, tutumlar, fiziksel ya da bedensel ilgiler gibi konularla ilişkilidir.

9. ölçeğin puanları yaşla ve ırkla açıkça ilişkili gözükmemektedir. Gençlerde (ergenler ve üniversite öğrencileri) T puanı sıklıkla 55 ile 65 arasındadır, oysa yaşlılar arasında 9. ölçeğin T puanının 50'nin altına düşmesi ender değildir. 9. ölçek puanları beyazlardan daha yüksek olan siyahılarda 60 ile 70 arasındaki T puanlarına sık rastlanır.

9. Ölçekte Yüksek Puanlar

Aşırı yükselmeler ($T > 90$), manik depresif bozukluğun manik dönemini düşündürülebilir. Puanları bu kadar yüksek olan hastalar, aşırı ve amaçsız bir aktivite içindedirler, konuşmaları hızlanmıştır. Hallüsinasyonları ve büyüklük delirileri olabilir. Puanları daha ılımlı bir yükselme gösteren kişiler ise, açıkça psikotik semptomlar göstermemelerine rağmen, aşırı aktiviteye ve kendi önemlerini abartmaya eğilimli olabilirler. Yüksek puan alanlar, enerjik, konuşkan, eylemi düşünceye tercih eden kişilerdir. İlgileri çok geniş bir alana dağılmıştır ve hemen gerçekleştirmek istedikleri çok sayıda projeleri vardır. Ancak enerjilerini akıllıca kullanamadıkları için projelerini tamamlayamazlar. Yaratıcı, girişken ve becerikli olabilirler, fakat alışılmış işlerle ya da ayrıntılarla pek ilgilenmezler. Yüksek puanlılar kolay sıkılan ve huzursuz olan kişilerdir. Engellenmeye dayanma güçleri fazla değildir. Dürtülerini basturmada güçlük çekerler, periyodik iritabilite ve hostilite dönemleri ile saldırgan öfke patlamaları oldukça sık görülür. Yüksek puanlıların bir başka özellikleri, gerçek dışı bir iyimserlik içinde olmalarıdır. Hiçbir şeyin imkansız olmadığını düşünür gibidirler ve büyük bir enerjileri vardır. Aynı zamanda kendi değer ve önemlerini abartabilirler ve kendi yeteneklerinin sınırlarını göremezler.

Yüksek puanlılar, sempatik, sosyal ve toplum hayatını seven kişilerdir. Genellikle ilk bıraktıkları izlenim olumludur. Arkadaş canlısı, gayretli, dengeli ve güvenli tavırları ile diğer insanları etkilerler. İnsanlarla olan ilişkileri genellikle oldukça yüzeyseldir. Diğer insanlar, yönlendirici, aldatici ve güvenilir olmayan davranışları farkettilerinde bu kişileri daha iyi tanımsa olurlar.

Güvenli ve dengeli dış görünüme rağmen, yüksek puan alanlar, yaşından elde ettikleri şeylerden hoşnut değildirler. Kendilerini keyifsiz, gergin, sinirli, anksiyöz ve ajite hissedebilirler. Kendilerini kolay üzülen kişiler olarak tanımlarlar. Periyodik depresyon dönemleri görülebilir. Psikoterapide, dominan anne-babaya karşı olumsuz duygular açıklanabilir. Okulda ve işte karşılaştıkları sorunlardan söz edebilirler; suça yönelik davranışlarını kabul edebilirler. Kadınlar basmakalıp kadın rolüne karşı isyankar olabilirler; erkekler homososeksüel dürtülerle ilgilenebilirler. Psikoterapide prognoz kötüdür. Yapılan yorumlara direnç gösterirler, tedaviye düzenli devam etmezler ve henüz başındayken tedaviyi bırakabilirler. Entellektüalizasyonları çok fazla kullanırlar ve tekrar tekrar aynı sorunlardan söz edebilirler. Düş-

manlık ve saldırganlık duygularının hedefi haline gelen terapiste bağlanmaları güçtür.

9. Ölçekte Düşük Puanlar

9. ölçekteki düşme, özellikle de profilin en düşük ölçeği ise, enerji ve aktivitelerde azalmayı yansıtır. Bu kişiler uyuşuk, kayıtsız, ilgisiz ve soğukkanlı görünürler. Harekete geçirilmeleri güç olan insanlardır. Kronik yorgunluk, fiziksel tükenme yakınmaları oldukça sık görülür. Gerilim ve anksiyete duygularının eşlik ettiği depresyona rastlanabilir.

Düşük puan alanlar, sorumluluk sahibi ve güvenilir kişilerdir. Sorunlarına yaklaşım biçimleri geleneksel, pratik ve akılcıdır. Dürüst ve sebatkar olabilirler. Kendilerine güven duymayabilirler ve başkaları tarafından içten, sessiz, alçakgönüllü ve saygılı kişiler olarak görülebilirler. Aynı zamanda bir miktar içe çekilmiş ve ketum kişilerdir. Pek fazla tanınmadıklarını düşünürler. Aşırı kontrollü davranmaya eğilimlidirler ve duygularını doğrudan ve açık bir şekilde anlatamazlar.

Düşük puanlı erkekler evleri ve aileleri ile ilgilidirler. Hastanede yatan hastalar için 9. ölçekte düşme iyi prognoz belirtisi olabilir.

9. Ölçek İçin Tanımlamaların Özeti

9. ölçek puanının yükselmesi şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. aşırı amaçsız aktivite içinde,
2. konuşması hızlanmış,
3. hallüsinasyonlar, büyüklük delirileri olan,
4. enerjik, konuşkan,
5. eylemi düşünceye tercih eden,
6. ilgileri geniş bir alana yayılmış, pek çok işle uğraşan,
7. enerjisini akılcıca kullanamayan, projelerini tamamlayamayan,
8. yaratıcı, girişken, becerikli,
9. günlük işlerle ya da ayrıntılarla pek fazla ilgilenmeyen,
10. kolayca sıkılan, huzursuz olan; engellenmeye karşı dayanıksız,
11. dürtülerini bastırmada güçlük çeken,
12. iritabl, düşmanlık dönemleri ve saldırgan öfke patlamaları olan,
13. gerçekçi olmayan bir iyimserlik içinde,
14. büyük emellere sahip,
15. kendi değerini ve önemini abartan,
16. kendi yeteneklerinin sınırlarını göremeyen,
17. sempatik, sosyal, toplum yaşamını seven,
18. diğer insanlarla birlikte olmaktan hoşlanan,
19. olumlu bir ilk izlenim bırakan,
20. arkadaş canlısı, hoş, gayretli,
21. dengeli, kendine güvenli,
22. insan ilişkileri yüzeysel,
23. yönlendirici, aldatıcı, güvenilmez,

24. doyumsuzluk duyguları taşıyan,
25. kendini keyifsiz, gergin, sinirli, anksiyöz hisseden,
26. ajite, kolay üzülen,
27. periyodik depresyon dönemleri olan,
28. dominan anne-babaya karşı olumsuz duygular besleyen,
29. okulda ya da işte sorunlar, suça yönelik davranışlar gösteren,
30. kadın ise, basmakalıp kadın rolünü reddedebilen,
31. erkek ise, homoseksüel dürtülerden endişelenebilen,
32. psikoterapide kötü prognoz,
33. psikoterapide yorumlara direnç gösteren,
34. psikoterapiye düzenli devam etmeyen,
35. tedaviyi henüz başındayken bırakan,
36. tekrar tekrar aynı sorunlardan söz eden,
37. terapistle bağlanmayan,
38. terapistle karşı düşmanca ve saldırgan tutumlar içinde.

9. ölçek puanının düşmesi şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir.

1. enerji düzeyi ve aktivite düzeyi düşük,
2. uyuşuk, kayıtsız, ilgisiz, soğukkanlı,
3. güç harekete geçirilen,
4. kronik yorgunluk, fiziksel tükenme yakınmaları olan,
5. depresif, anksiyöz, gergin,
6. güvenilir, sorumluluk sahibi,
7. sorunlara geleneksel, pratik ve akılcı bir biçimde yaklaşan,
8. kendine güvensiz,
9. içten, sessiz, alçakgönüllü, saygılı,
10. içe çekilmiş, ketum,
11. başkalarınca pek tanınmayan,
12. aşırı kontrollü, duygularını açıkça anlatamayan,
13. erkek ise, eve ve ailesine karşı ilgili,
14. psikiyatrik bir hasta ise, iyi bir prognoz gösteren.

0. ÖLÇEK (SOSYAL İÇEDÖNME)

0. ölçek, diğerlerinden daha sonra geliştirilmesine rağmen standart bir klinik ölçek gibi kabul edilmiştir. Ölçek kişinin sosyal temaslardan ve sorumluluklardan kaçma eğilimini değerlendirmek için hazırlanmıştır. Maddeler, Minnesota "T-S-E Envanterinin" Sosyal İçedönme- Dışadönme ölçeğinde düşük puan alanlarla, yüksek puan alanlar karşılaştırılarak seçilmiştir.

Ölçeğin 70 maddesini iki gruba ayırmak mümkündür. Birinci grup maddeler sosyal katılımı, ikinci gruptakiler ise genel nevrotik uyumsuzluk ve kendini küçük görmeye bağlanmıştır. Yalnızca bir grubun ya da her ikisinin de kabul edilmesi puanın yükselmesine neden olabilir.

0. Ölçekte Yüksek Puanlar

0. ölçekte yüksek puan alan kişilerin en belirgin özellikleri sosyal içedönmedir. Bu kişiler sosyal ortamlarda çok güvensiz ve huzursuz olabirirler. Utangaç, çekingen, ürkek ve bir kenara çekilme eğiliminde olan kişilerdir. Kendilerini yalnızken ya da bir iki yakın arkadaşın yanında daha rahat hissederler. Bir çok sosyal aktiviteye katılmazlar. Özellikle de karşı cinsten kişilerin yanında huzursuz olurlar. Yüksek puan alanlar kendilerine güvenmezler ve kendilerini göstermek istemezler. Anlaşılması güç insanlardır ve başkaları tarafından soğuk ve uzak olarak tanımlanırlar. Başka insanların kendileri ile ilgili düşüncelerine duyarlıdırlar. İnsanlara katlamadıkları için üzülebilirler. Aşırı kontrollüdürler, duygularını doğrudan anlatamazlar, İnsanlararası ilişkilerde itaatkar ve uysaldırlar, otoriteyi açıkça kabul ederler.

Yüksek puan alanlar, aynı zamanda ciddi ve yavaş kişilerdir. Güvenilir kişilerdir, sorunlarına yaklaşırken temkinli, geleneksel ve sıradan davranırlar. Tutum ve düşüncelerinde bir miktar katı ve tutucudurlar. Küçük kararlar verirken bile tereddüt ederler. İşlerinden hoşlandıkları ve üretken olmaktan zevk aldıkları izlenimi verirler.

Yüksek puan alanlar, endişeli, kolay sinirlenen ve kaygılanan kişiler olabilirler. Başkaları tarafından karamsar olarak tanımlanırlar. Suçluluk duyguları ve depresyon dönemleri görülebilir.

0. Ölçekte Düşük Puanlar

0. ölçekte düşük puan alanlar sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Sempatik, toplum yaşamını seven, arkadaş canlısı ve konuşkandırlar. İnsanlarla birlikte olmaya ihtiyaçları vardır, başkalarıyla kolay kaynaşırlar. Zeki, güzel konuşan ve kendini ifade edebilen kişiler olarak görülürler. Aktif, enerjik ve gayretlidirler. Bu kişiler için güç, statü ve tanınma önemlidir, bu nedenle rekabeti gerektiren durumları arayabilirler.

Düşük puan alanların, dürtü denetimine ilişkin sorunları vardır, eylemlerinin sonuçlarını düşünmeksizin harekete geçebilirler. Olgunlaşmamış ve kendilerine karşı hoş görülürler. Diğer insanlarla ilişkileri yüzeysel ve yapmacık olabilir. Diğer insanları kullanma ve fırsatçılık görülebilir. Gösterişçi ve dikkat çekici tavırları başkalarında kırgınlık ve düşmanlık uyandırabilir.

0. Ölçek İçin Tanımlamaların Özeti

0. ölçek puanının yükselmesi şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. sosyal açıdan içedönük,
2. yalnızken ya da bir iki yakın arkadaşın yanında kendini daha rahat hisseden,
3. çekingen, ürkek, utangaç, yalnız,
4. karşı cinsten kişilerin yanında huzursuz,
5. kendine güvensiz, kendini küçük gören,

6. anlaşılması güç,
7. başkalarının düşüncelerine duyarlı,
8. diğer insanlara katılmadığı için üzülen,
9. aşırı kontrollü, duygularını açıkça anlatamayan,
10. itaatkar, uysal, boyun eğici,
11. otoriteyi kabul eden,
12. ciddi, yavaş,
13. güvenilir,
14. sorunlara yaklaşırken temkinli, geleneksel ve sıradan,
15. tutum ve düşüncelerinde katı ve tutucu,
16. küçük kararlar verirken bile tereddüt eden,
17. çalışmaktan hoşlanan, üretken olmaktan zevk alan,
18. endişeye eğilimli, kolay sinirlenen, anksiyöz,
19. karamsar,
20. suçluluk duyguları, depresyon dönemleri olan.

0. ölçek puanının düşmesi şu özellikleri taşıyan bir kişiyi gösterir:

1. sosyal, dışa dönük,
2. sempatik, toplum hayatını seven, arkadaş canlısı, konuşkan,
3. insanlarla birlikte olmaya ihtiyaç duyan,
4. çabuk kaynaşan,
5. zeki, güzel konuşan, kendini ifade edebilen,
6. aktif, enerjik, gayretli,
7. güç, statü ve tanınmak isteyen,
8. yarışmayı gerektiren durumları arayan,
9. dürtü denetimine ilişkin sorunları olan,
10. eylemlerinin sonunu düşünmeksizin harekete geçen,
11. olgunlaşmamış, kendine karşı hoşgörülü,
12. yüzeysel, insan ilişkileri yapmacık,
13. insanları kullanan, fırsatçı,
14. başkalarında kırgınlık ve düşmanlık uyandıran.

IV. BÖLÜMÜN HAZIRLANMASINDA YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Boerger, A. R., Graham, J. R., & Lilly, R. S. (1974). Behavioral correlates of single scale MMPI code types. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 42, 398-402.
- Carkuff, R. R., Barnette, W. L., & McCal, J. N. (1965). *The Counselor's handbook: Scale and profile interpretations of the MMPI. Urbana, III* .: Parinson.
- Carson, R. C. (1969). Interpretative manual to MMPI. In J. N. Btcher (Ed), *MMPI: Research developments and clinical applications* . New York: McGraw-Hill.
- Dahlstrom, W. G., Welsh, G. S., & Dahlstrm, L. E. (1972). *An MMPI Handbook. Volume I: Clinical interpretation*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Drake, L. E., & Oetting, E. R. (1959). *An MMPI codebook for counselors* . Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Dunbar, J. R., & Rabourn, R. E. *A Working manual for the MMPI* . Unpublished materials (date unknown).
- Giberstad, H., & Duker, J. A (1965). *Handbook for clinical and actuarial MMPI interpretation* . Philedelphia: Saunders.
- Good, P. K. E., & Brantner, J. P. (1961). *The physician's guide to the MMPI* . Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Gough, H. (1954). *Brief descriptive and interpretational summary of scales of the Minnesota Multiphasic Personality Inventory* . Unpublished materials.
- Hovey, H. B., & Lewis, E. G. (1967). *Semiautomatic interpretation of the MMPI* . Brandon, Vt.: Clinical Psychology Publishing Co.
- Lachar, D. (1974). *The MMPI: Clinical assessment and automated interpretation* . Los Angeles: Western Psychological Services.
- Marks, P. A., & Seeman, W. (1963). *Actuarial description of abnormal personality* . Baltimore: Williams & Wilkins.
- Peårson, J. S., & Swenson, W. M. (1967). *A user's guide to the Mayo Clinic Automated MMPI Program* . New York: Psychological Corporation.
- Schubert, H. J. P. (1973). *A Wide-range MMPI Manual* . Unpublished materials.
- Welsh, G. S., & Dahlstrom, W. G. (1956). (Eds). *Basic readings on the MMPI in psychology and medicine* . Minneapolis: University of Minnesota Press.

V

İKİLİ YÜKSELME TİPLERİ

Başlangıçtan itibaren, Hathaway ve McKinley, ölçek puanları tek tek değil de toplu ele alınır ve aralarındaki ilişki incelenirse, yapılan yorumun tanısal açıdan daha zengin ve yararlı olacağını açıklamışlardır. Meehl (1951), Meehl ve Dahstrom (1960), Taulbee ve Sisson (1957) ve daha bir çok araştırmacı, MMPI'nin yorumunda konfigür al yaklaşımın önemini vurgulamışlardır. İlk geçerlik çalışmalarında, Black (1953), Guthrie (1952) ve Meehl (1951) gibi bazı araştırmacılar, en yüksek iki klinik ölçeğe göre profilleri gruplandırmışlar ve her bir profil tipiyle ilişkili test dışı davranışları belirlemeye çalışmışlardır. Başka bir grup ise (örn., Gilberstadt & Duker, 1965; Marks & Seeman, 1963) birden fazla ölçeğin yükseldiği profilleri sınıflandırmak amacıyla karmaşık kurallar geliştirmişler ve daha sonra her bir grubun test dışı davranışlarını saptamaya çalışmışlardır. Örneğin Gilberstadt ve Duker sisteminde bir profilin 4-9 tipi olarak sınıflandırılabilmesi için:

- (1) Pt ve Ma'nın T puanı 70'den büyük,
- (2) diğer ölçeklerin hepsinin T puanı 70'den küçük,
- (3) L'nin T puanı 60'dan küçük,
- (4) Ma'nın T puanı: Sc'den 15 puan veya fazla büyük,
- (5) Pd'nin T puanı: Mf'den 7 puan veya daha fazla büyük olmalıdır.

Klinisyenler, başlangıçta profil sınıflamasında bu tür karmaşık yaklaşımlardan yana olmalarına rağmen, araştırma ve klinik uygulama sonuçları biriktükçe, tipik bir psikiyatrik ortamda karşılaşılan MMPI profillerinin ancak çok küçük bir bölümünün bu tür karmaşık kod tiplerine göre sınıflandırılabileceğini görmüşlerdir (Fowler & Coyle, 1968; Huff, 1965; Meikle & Gerritse, 1970).

Son zamanlarda, profillerin sınıflamasında karmaşık kurallara duyulan ilginin giderek azaldığı ve dikkatin daha basit olan ikili sınıflama yaklaşımına yöneldiği görülmektedir. Gynther ve ark., ile Lewardowski ve Graham (1972), en yüksek iki klinik ölçeğe göre sınıflandırılan profiller için güvenilir test dışı karşılıkların belirlenebileceğini göstermişlerdir. İkili kod yaklaşımının en açık üstünlüğü, klinik ortamların çoğunda karşılaşılan profillerin büyük bir kısmının az sayıdaki ikili profillere göre sınıflanabilmesidir. Marks ve ark., (1974), daha önce Marks ve Seeman (1963) tarafından

yapılan çalışmayı yeniden gözden geçirip genişlettiklerinde, MMPI profillerinin karmaşık kurallara göre değil de, ikili kod tiplerine göre sınıflandığında, test dışı tanımlamaların doğruluğunda önemli bir kaybın olmadığını görmüşlerdir.

Bu bölümde, MMPI'nin bazı ikili kod tiplerine ilişkin araştırma verileri sunulmuştur. Bir önceki bölümde olduğu gibi, yazar, konuyla ilgili mevcut literatürü inceledikten sonra, bu verilere kendi klinik deneyimlerinden ve araştırmalarından elde ettiği bilgileri ekleyerek, anlamlı bir sentez sunmaya çalışmıştır. Her tanımlamadan sonra referans belirtmek yerine, bölümü hazırlarken yararlanılan kaynaklar en sonda toplanmıştır. Bu bölümde ikili kodlar genelde birbirleri yerine (örneğin, 12 ve 21 kodları aynı tip olarak kabul edilmiştir) kullanılmış, ikili kodun içindeki ölçeklerin yüksekliklerinin ne olduğu dikkate alınmamış ve iki ölçekten hangisinin daha yüksek olduğu hesaba katılmamıştır. Eldeki literatür dikkatle incelendiğinde de, ikili kodda yer alan ölçeklerin tek tek yüksekliklerinin ve birbirine oranla yüksekliklerinin yorumda pek bir şeyi değiştirmedikleri görülmüştür. Eğer sözü edilen bu özellikler yorumda farklılığa neden oluyorsa yeri geldiğinde üzerinde durulmuştur.

İkili kodlar birbiri yerine kullanıldığında, 10 klinik ölçekten 40 tane ikili kombinasyon ortaya çıkmaktadır. Bu bölümde incelenen ikili kodlar, klinik ortamlarda en sık karşılaşılanlar ve haklarında elimizde yeterli miktarda yorumlayıcı bilgi olanlardır. Okuyucu bu bölümde, 5 ve 0 ölçeklerini içeren kodların çok az olduğunu görecektir. Bunun nedeni, ikili kodların araştırma pek çok çalışmada envantere sonradan eklenen 5 ve 0 ölçeklerinin bulunmamasıdır. Biraz sonra sunulacak olan tanımlamaların "ortalamaları" temsil ettiği ve hepsinin hemen herkese uymasının beklenmemesi gerektiği unutulmamalıdır. Eğer profil, burada sunulan ikili kod tiplerine uymuyorsa, klinisyen tek tek ölçeklerdeki yükselme ve düşmeleri göz önünde bulundurmalıdır.

12/21

12/21 kodunun en belirgin özellikleri, bedensel rahatsızlık ve ağrıdır. Bu kodu alan kişiler, belirtilerinin organik bir dayanağı olmamasına rağmen, kendilerini fiziksel bir rahatsızlıkları varmış gibi gösterirler. Sağlıkları ve bedensel işlevleri ile yakından ilgilenirler; önemsiz ya da küçük fiziksel bozukluklara karşı aşırı tepki gösterirler. Bedensel şikayetleri çok yönlü olabilir ya da yakınmaların hepsi tek bir sistemde sınırlanabilir. Başağrıları ve kalp ile ilgili yakınmaların yanı sıra sindirim sistemine ilişkin sorunlar da görülebilir. Özellikle ülser benzeri yakınmalar yaygındır; kişide, iştahsızlık, bulantı, kusma bulunabilir. 12/21 kodunu alan kişiler baş dönmesi, uykusuzluk, yorgunluk, halsizlik ve güçsüzlükten şikayetçi olabilirler. Sorumluluk gerektiren stres koşullarına fiziksel semptomlarla tepki gösterirler ancak semptomlarının emosyonel ya da psikolojik faktörlere bağlı olduğunu kabul etmezler.

12/21 bireyleri genellikle anksiyöz, gergin ve sinirlidirler. Pek çok şeyden endişelenirler, rahatsız, huzursuz ve iritedirler. 12/21 kodu alan bireylerin, bu grupta klinik depresyon yaygın olmamasına rağmen, mutsuzluk ya da disforiden, karamsar düşüncelerden ve inisiyatif kaybından yakındıkları görülmüştür.

12/21 kodunu alan kişiler sıkılganlıklarından yakınurlar. Sosyal ilişkilerde, özellikle karşı cinsle olan ilişkilerinde, utangaç ve içe kapanıktırlar. Kendi yeteneklerinden emin değildirler, ufak günlük sorunlar karşısında bile karar vermekte güçlük çekerler. Başkalarının kendi haklarındaki düşünceleri konusunda aşırı duyarlıdırlar. Kişilerarası ilişkilerde şüpheli ve güvensiz olabilirler. Ayrıca ilişkilerinde pasif-bağımlı bir tutuma eğilimlidirler. İnsanlara kendileri ile yeterince ilgilenmedikleri ya da yardımcı oldukları düşüncesi ile kin besleyebilirler.

Aşırı alkol kullanımı 12/21 kodunu alan bireyler için bir sorun olabilir. Bu durum özellikle psikiyatrik hastalar için söz konusudur. Yaşam öykülerinde işten atılmalar, tutuklanmalar ve içkiden kaynaklanan aile sorunları bulunabilir. 12/21 kodunu alan kişilere sıklıkla bir nevrotik bozukluk (hipokondria, anksiyete veya depresyon) tanısı konur. Ancak bu kodu alan hastaların küçük bir bölümünün kişilik bozukluğu veya şizofreni tanısı aldığı da görülmüştür. Bu grupta (şizofreni) genellikle 1. ve 2. ölçekle birlikte 8. ölçek de yükselmiştir.

12/21 kodunu alan bireyler geleneksel psikoterapi için pek uygun görülmezler. Değişmek için bir istek duymadan, aşırı derecede rahatsızlıklara katlanabilirler. Represyon ve somatizasyondan aşırı derecede yararlanırlar. İçgörü ve kendini anlamadan yoksundurlar. Ayrıca pasif-bağımlı yaşam şekilleri kendi davranışlarının sorumluluklarını üstlenmelerini engeller. Psikoterapi sonrası uzun vadeli bir değişiklik mümkün değilse de, kısa süreli semptomatik değişiklikler görülebilir.

13/31

13/31 kodu erkek ve gençlerden çok kadınlarda ve yaşlılarda görülür. 13/31 kodunu alan psikiyatrik hastalar genelde bir psikofizyolojik veya nevrotik bozukluk (histeri, hipokondria) tanısı alırlar. Özellikle 2. ölçeğin 1. ve 3. ölçekten belirgin şekilde düşük olduğu durumlarda klasik konversiyon semptomları bulunabilir (bu nedenle "Konversiyon V" modeli olarak adlandırılır).

13/31 bireyleri gerilimden bahsederlerse de, aşırı anksiyete ve depresyon genellikle yoktur. Aynı şekilde psikotik semptomlara da rastlanmaz. 13/31 bireylerinde büyük yetersizlikler görülmez pek başarılı olmasalar da işlevlerini sürdürebilirler.

Bu kodu alan kişilerin bedensel yakınmaları, baş ağrısı, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, uyuşma hissi ya da el ve ayaklarda aşırı titremeler şeklindedir. Anoreksiya, bulantı, kusma, şişmanlık gibi yemeyle ilişkili sorunlar sıkıdır. Güçsüzlük, yorgunluk, halsizlik ve uyku düzensizliği sık görülen

fiziksel şikayetlerdir. Stres durumunda fiziksel semptomlar artar ve sıklıkla bu belirtilerle bağlantılı açık bir sekonder kazanç vardır.

13/31 kodunu alan bireyler, kendilerini normal, sorumluluk sahibi ve kusursuz görürler. İnkâr, projeksiyon ve rasyonalizasyon mekanizmalarını çok fazla kullanırlar, kendi sorunları için başkalarını suçlarlar. Semptomlarının tıbbi açıklamasını tercih ederler, belirtilerinin temelindeki psikolojik nedenleri anlamaktan (içgöründen) yoksundurlar. Durumlarına ve yaşama genelde aşırı iyimser, "Polyana" tarzı bir yaklaşım gösterirler. Semptomları ve sorunları ile yeterince ilgilenmezler.

13/31 kişileri çocuksu, egosantrik ve bencildir. Güvensizlik içindedirler. İlgî, sevgi ve şefkat gereksinimleri çok güçlüdür. Aşırı derecede bağımlıdırlar, ancak bundan rahatsızlık duyarlar ve bu nedenle çatışma yaşarlar. Dost tavrılı ve dışa dönük görünüme rağmen sosyal ilişkileri aslında yüzeyseldir ve diğer kişilerle duygusal bir katılımdan yoksundurlar. Kendi gereksinimlerini karşılamak için sosyal ilişkilerini kullanma eğilimleri vardır. Karşı cinsle ilişki kurma yetenekleri yoktur. Heteroseksüel dürtülerde yetersizlikler olabilir.

13/31 kişileri diğer insanlara karşı içlerinde kırgınlık ve düşmanlık beslerler. Bunlar özellikle kendileriyle yeterince ilgilenmediğini düşündükleri kişiler olabilir. Çoğu kez aşırı kontrollüdürler. Olumsuz duygularını dolaylı ve pasif yollarla yansıtır, ancak bazen kendilerine hakim olamayarak kızgınlıklarını yıkıcı olmayan şekillerde doğrudan anlatırlar.

13/31 kişileri için sosyal kabul görececek davranışlar sergilemek önemlidir. Mantıklı ve akıllı oldukları konusunda başkalarını inandırmaya gereksinim duyarlar; tutum ve değer yargılarında geleneksel ve boyuncıcidirler.

Semptomlarının temelinde yatan psikolojik nedenleri kabul etmek istemedikleri için, bu kişilerde geleneksel psikoterapi için istek uyandırmak güçtür. Psikoterapistten sorunları için kesin cevaplar ve çözümler beklerler, bu dilekleri yerine getirilmezse terapiye başlangıç aşamasında son verebilirler.

14/41

Klinik uygulamalarda sık rastlanmayan 14/41 kodu erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Bu kodu alan kişiler sıklıkla önemli hipokondriak semptomlardan özellikle de spesifik olmayan baş ağrılarından söz ederler. Kararsız ve anksiyözdürler. Sosyal açıdan dışa dönük olmalarına rağmen, karşı cinsle ilişkide başarısızdırlar. Eve ve ebeveynlerine karşı isyankardırlar, ancak bu duygularını açıkça ifade etmezler. Aşırı alkol kullanımı sorun olabilir. Yaşam öykülerinde içki alemi, iş kaybı ve içme davranışından kaynaklanan aile sorunları bulunabilir. Okul ve iş hayatında güdüden ve iyi tanımlanmış bir amaçtan yoksundurlar. Yaşama bakış açılarını tatminsiz ve kötümserdir. Hep isterler, asık çehrelidirler ve başkaları ile olan ilişkilerinde şirret olarak nitelendirilirler. Psikolojik sorunlarını inkâr ettikleri için geleneksel psikoterapilere direnç gösterme eğilimindedirler.

18/81

18/81 kodunu alan kişiler düşmanlık ve saldırganlık duyguları taşırlar, ancak bu duygularını uyumlu ve yumuşak bir şekilde ifade edemezler. Ya duygularını tamamen bastırır ya da aşırı derecede kavgacı ve yıkıcı olurlar.

18/81 kişileri özellikle karşı cinsin yanında kendilerini sosyal açıdan yetersiz hissederler. Başkalarına güvenmezler, insanlara fazla yaklaşmazlar, genellikle kendilerini yabancı ve dışarda hissederler. Göçebe tarzı bir yaşam ve kötü bir çalışma öyküsü yaygındır.

18/81 kodu alan psikiyatrik hastalara sıklıkla şizofreni tanısı konur. Ancak bazen anksiyete nevrozu ve şizoid kişilik bozukluğu tanısı verildiği de olur.

18/81 bireyleri mutsuz ve deprese olmaya eğilimlidirler; duygularının açısından donuk bir görünüm sergileyebilirler. Bedensel ilgileri zaman zaman çok şiddetlenerek delir sınırına kadar varabilir. Bu kişilerin düşüncelerinde konfüzyon görülebilir, dikkatleri önemsiz uyaranlar tarafından kolayca dağılır.

19/91

19/91 kişileri aşırı derecede sıkıntı ve gerilim içindedirler. Aşırı anksiyöz, gergin ve huzursuzdurlar. Sindirim sorunları, baş ağrısı ve bitkinlik gibi bedensel yakınmalar yaygındır ve bu kişiler semptomlarının psikolojik açıklamalarını kabul etmek istemezler. İlk bakışta konuşkan, dışa dönük, saldırgan ve kavgacı görünürlerse de temelde pasif-bağımlı kişilerdir. Ancak kişiliklerinin bu yönünü inkar etmeye çalışırlar.

Aşırı derecede hırslıdırlar, çok şey başarmak isterler, fakat kesin ve açık amaçları yoktur. 19/91 kodu bazen sınırlılıkları ve eksiklikleri ile mücadelede zorluk çeken beyin hasarlı kişilerde görülür.

23/32

23/32 kodunu alan kişiler işlevlerde yetersizliğe yol açacak düzeyde anksiyete yaşamamalarına rağmen, sinirli, tedirgin, gergin ve endişeli olduklarını söylerler. Aynı zamanda üzüntü, mutsuzluk, yorgunluk, depresyon ve bitkinlik yakınmaları sık görülür. Yaşama karşı ilgisiz ve isteksizdirler. Bir işe başlamakta zorlanırlar. Benzer şekilde fiziksel aktiviteleri de yavaşlamıştır. Genellikle sindirim sistemi sorunlarını içeren somatik yakınmalar görülebilir.

23/32 kişileri pasif, uysal ve bağımlıdırlar. Kendilerine güvenleri yoktur. Yetersizlik, değersizlik ve çaresizlik duyguları taşırlar. Başkalarında destekleyici ve koruyucu tutumlar uyandırmaya eğilimlidirler. Başarı, statü

ve güç meraklısıdır. Üretici ve yarışmacı kişiler gibi görünürlerse de doğrudan rekabet gerektiren durumlara, başarısız olacakları endişesi ile girmezler. Sorumluluk isterler ama getireceği stres ve baskıdan korkarlar. Sıklıkla başarılarının yeterince farkedilmediğini düşünürler ve en ufak bir eleştiriden bile kolayca incinirler.

Aşırı derecede kontrollüdürler. Duygularını ifade etmekte zorluk çekerler, çoğu zaman kendilerini susturulmuş gibi hissedebilirler. Kabul görmeyen dürtülerini inkara eğilimlidirler. Bu inkar başarılı olmazsa, anksiyete ve suçluluk duyarlar. Sosyal ilişkilerde yetersiz olduklarını düşünürler ve başka insanlara katılmama eğilimindedirler. Özellikle karşı cinsle olan ilişkilerinde rahatsızdırlar, cinsel soğukluk ve empotansı içeren cinsel uyumsuzluklar sık görülür.

23/32 kodu, kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür. Yeti kaybına yol açan semptomlardan çok, uzun zamandan beri süregelen düşük bir randıman düzeyini aklı getirir. Sorunları uzun sürelidir. 23/32 kişileri büyük mutsuzluklara katlanmayı öğrenmişlerdir. Psikiyatrik hastalar arasında en yaygın tanı depresif nevrozdu, bazen psikotik depresyon tanısına da rastlanır. 23/32 kişilerinde psikotik tanılar son derece az görülür.

Geleneksel psikoterapiye yanıtları oldukça kötüdür. İç gözlem yetenekleri yoktur, kendi davranışlarına karşı içgöründen yoksundurlar. Sorunlarının psikolojik açıklamalarına karşı direnirler ve değişme isteği duymaksızın büyük mutsuzluklara katlanabilirler.

24/42

24/42 kodu alan kişiler genellikle başları yasalarla yada aileleri ile derde girdiğinde uzmanlara başvururlar. Bunlar dürtüsel (impulsif) ve doyumunun gecikmesine tahammül edemeyen kişilerdir. Toplumsal kurallara saygıları yoktur ve sıklıkla kendilerini toplumsal değerlerle çatışma içinde bulurlar.

Acting-out davranışları sıklıkla aşırı içme şeklindedir, öykülerinde alkole bağlı tutuklanma, işten atılma, aile tartışmaları gibi sorunlar vardır.

Bu kişiler kendi başarısızlıkları nedeniyle hayal kırıklığı hissederler ve insanlar onlardan istekte bulunduklarında kızarlar. Stres verici durumlara aşırı içki içerek veya bağımlılık yapan ilaçlar kullanarak tepki gösterebilirler. Acting-out deneyimlerinin ardından hatalı davranışları için pişmanlık ve suçluluk duyduklarını ifade ederler. Depresif düşünceler, anksiyete ve değersizlik duygularından söz etseler de bunda pek içten gözükmezler. Yaşantılarını yeniden düzenleme kararı almalarına rağmen, ilerde yine aynı şekilde dürtüsel davranma olasılıkları yüksektir. Literatürde 2. ve 4. ölçekler çok yükseldiğinde intihar düşünceleri ve girişimlerinin oldukça sık görüldüğü bildirilmiştir. Sıklıkla intihar girişimleri başkalarında suçluluk yaratma amacına yöneliktir.

Başları dertte olmadığında 24/42 kişileri enerjik, sosyal ve sempatik kişilerdir. İlk bıraktıkları izlenim olumludur. Ancak daha sürekli ilişkilerde,

başkalarını kullanma eğilimleri kızgınlık duyguları doğurur. Yeterli ve rahat dış görünüm altındaki kişinin içedönük, sıklılgan ve pasif-bağımlı özellikler taşıması mümkündür. Yetersizlik duyguları içinde, kendilerinden memnun olmayan kişilerdir. Sosyal etkileşimlerde özellikle karşı cinsle ilişkilerde huzursuzdurlar.

Bu kişiler yardıma ihtiyaç duyduklarını ve değişmek istediklerini ifade edebilirler. Ancak buna rağmen, geleneksel psikoterapide prognoz kötüdür. İçinde bulundukları stres dönemini atlattıklarında ya da adli sorunlardan kurtulduklarında psikoterapiyi bırakabilirler.

27/72

27/72 kodunu alan kişiler, anksiyöz, sinirli, gergin ve tedirgindirler. Aşırı endişelidirler, gerçek ve hayal ürünü tehditlere karşı çok duyarlıdır. Henüz ortada yokken, sorunları beklemeye başlarlar ve küçük streslere aşırı tepkiler gösterirler. Bu kişilerde bedensel semptomlar sık görülür. Genellikle halsizlik, bitkinlik, yorgunluk gibi belirsiz yakınmalardan, zaman zaman da uykusuzluk, kalp ağrısı ve iştahsızlıktan söz ederler. Depresyon bu kişilerin en önemli özelliklerinden biridir. Özellikle üzüntü ve mutsuzluk duygularından söz etmeseler de, kilo kaybı, hareketlerde, konuşmada ve düşüncede yavaşlama gibi klinik depresyon semptomları gösterirler. Genel olarak dünyaya bakışları kötümserdir. Daha özgün olarak ta sorunlarına çözüm bulamayacaklarını düşünürler. Zamanlarının çoğunu tekrar tekrar aynı sorunları düşünmekle geçirirler.

Başarılı olmaya ve başarılarının farkedilmesine ihtiyaç duyarlar. Kendilerinden çok fazla şey beklerler ve amaçlarına ulaşamadıklarında suçluluk duyarlar. Kararsızdır, yetersizlik, güvensizlik ve aşağılık duyguları taşırlar. Kendilerini cezalandırmaya eğilimlidirler ve yaşamda karşılaştıkları tüm sorunlar için kendilerini suçlarlar. Düşünceleri ve sorunlarını çözme biçimleri katıdır. Günlük etkinliklerinde titiz ve mükemmeliyetçi kişilerdir. Aynı zamanda aşırı dindar ve tutucu olabilirler.

Başkaları ile ilişkilerinde yumuşak başlı ve pasif bağımlıdır. Kendi haklarını savunmada bile zorluk çekebilirler. Derin duygusal ilişkiler kurabilme yeteneğine sahiptirler ve stres altında bu kişilere sıkıca sarılıp aşırı bağımlı hale gelebilirler. Şiddetli bir huzursuzluk içinde olduklarından psikoterapiye isteklidirler. Psikoterapiye çoğu hastaya kıyasla daha fazla devam ederler ve giderek gelişme gösterebilirler.

27/72 kodunu alan psikiyatrik hastalara nevrotik bir tanı (depresyon, anksiyete bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk) verilir. Ancak, bazen melankoli ya da manik-depresif bozukluk tanıları aldıkları da görülmüştür. Bu kişilerde psikopatik tanılara çok ender rastlanır.

28/82

Bu kişiler anksiyöz, ajite, gergin ve tedirgin olduklarından yakınır. Uykusuzluk, dikkati toplayamama, düşüncede konfüzyon ve unutkan-

lık gibi özellikleri göze çarpar. Bu kişilere yaşam sorunlarını taşımak güç gelebilir. Düşünceleri orjinal değildir, sorunlarını çözerken kalıplaşmış yaklaşımları seçerler. Kendilerini fiziksel hasta olarak tanıtır. Baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şeklinde bedensel yakınmaları vardır. Sorunlarının psikolojik yorumlarına karşı direnç gösterirler, aynı zamanda değişmeye karşı da dirençlidirler. Sorunlarının önemini küçümserler ve kendi yetenekleri konusunda gerçekçi olmayabilirler.

Temelde bağımlı ve etkisizdirler; bu kişilerin girişkenlikle ilişkili sorunları olabilir. Çoğu zaman kolay sinirlenip, gücenirler. Denetimi kaybetme korkusu içindedirler ve kendilerini doğrudan ifade edemezler. Toplumca onaylanmayan dürtülerini inkar etmeye çalışırlar, bu dürtülerin doğrudan davranışlarla anlatıldığı yaşam dönemleri unutulur ve inkar edilebilir. Acting-out tipi davranışların görüldüğü bu dissosiyatif dönemlerin ardından ise, sıklıkla suçluluk duyguları ve depresyon ortaya çıkar. 28/82 kodunu alan kişiler başkalarının tepkilerine karşı duyarlıdır ve onların isteklerini kuşkuyla karşılama eğilimindedirler. Öykülerinde duygusal açıdan zedeleyici yaşantılara rastlanabilir ve bu kişiler artık daha fazla incinmek istemezler. Yakın insan ilişkilerinden kaçarak ve insanlar aralarında duygusal bir uzaklık bırakırlar. Öte yandan anlamlı kişilerarası ilişkilerinin olmaması keder ve değersizlik duygularını artırarak durumlarını daha da güçleştirir.

2 ve 8 numaralı ölçeklerin her ikisi de çok yükseldiğinde önemli psikopatolojiyi düşündürür. Bu kodu alan psikiyatrik hastalara en sık verilen tanı, manik-depresif psikoz, melankoli ve şizoaffectif şizofrenidir. Bu kişilerin kronik ve yeti kaybına yol açan semptomları vardır. Suçluluk duyguları ile hareket ederler ve açıkça depresif olabilirler. İçer çekilme, konuşmada yavaşlama ve azalma, düşünce akışında gecikme ve ağlama en önemli özellikleridir. İlgisizlik, kayıtsızlık, değersizlik duyguları sık görülür. 28/82 kodunu alan psikiyatrik hastalar yoğun bir şekilde intihar düşünceleriyle uğraşabilirler; düşüncelerini gerçekleştirmek için özel bir plan yapabilirler.

29/92

Bu gruptaki kişiler, ben-merkezci ve narsisistik olma eğilimin de- dirler. Kendi değerlerini abartabilirler. Başarılı olmayı istemekle beraber çoğu kez başarısızlığa hazırlanır gibidirler. Gençlerde 29/92 kodu, kişisel ve mesleki yönelim eksikliği ile belirgin bir kimlik krizini düşündürülebilir.

Sıkıntılı ve gergin olduklarını söylerler genelde sindirim sisteminin üst bölgesiyle ilişkili bedensel yakınmalar sık görülür. İnceleme sırasında depresif görünmemelerine rağmen, öykülerinde ağır depresyon dönemleri bulunabilir. Stres ve baskandan kurtulma amacıyla aşırı alkol kullanabilirler.

29/92 kodu temelde altta yatan yetersizlik ve değersizlik duygularını inkar eden ve depresyona karşı kendilerini aşırı aktivite ile savunan kişilerde görülür. Yüksek aktivite döneminin ardından yorgunluk dönemi ortaya çıkabilir. 29/92 kodunu alan psikiyatrik hastalarda en sık görülen tanı manik depresif psikoz olmakla birlikte, zaman zaman kontrolünü kay-

betmiş yada yetersizliklerini aşırı aktivite ile kapamaya çalışan beyin hasarlı kişilerde de aynı koda rastlanabilir.

34/43

34/43 grubundaki kişilerin en belirgin özellikleri kronik ve şiddetli öfkedir. Düşmanca ve saldırgan dürtüleri vardır, ancak olumsuz duygularını uygun bir biçimde anlatamazlar. Eğer 3. ölçek 4. ölçekten daha yüksek ise, öfkenin dolaylı anlatımı söz konusu olabilir. 4. ölçek 3. ölçekten daha yüksek olduğunda ise kişi, çoğunlukla aşırı kontrollü olmasına rağmen, kısa saldırganlık dönemlerinde şiddet davranışları gösterebilir. 43 kodunu alan mahkumların öyküleri incelendiğinde saldırı ve şiddet dikkat çeker. Bazı ender vakaların kendilerini saldırgan davranışlardan uzak tutabilmeyi başardıkları görülmüştür. Başkalarını cezalandırmaya ve kendi sorunları için diğer insanları suçlamaya eğilimlidirler. Başkaları bu kişilerin davranışlarının sorun yarattığını düşünmelerine rağmen, kendileri aynı görüşte değildirler.

34/43 kodunu alan kişilerde aşırı anksiyete ve depresyona rastlanmaz ancak başağrısı, üst sindirim sistemi rahatsızlığı, geçici bilinç kaybı nöbetleri ve göz rahatsızlıkları sık görülebilir. Zaman zaman kendilerini gergin hissetmelerine rağmen, bu durum dış streslerle doğrudan bağlantılı değil gibi görünür.

Bu kişilerin çoğunda sorunlar aile üyelerine yönelik kronik düşmanlık duygularından kaynaklanır. Başkalarından ilgi ve onay beklerler. Reddedilmeye karşı çok duyarlıdır, eleştirildiklerinde düşman kesilirler. Dıştan oldukça uysal görünürlerse de, içten içe çok isyankardır. Cinsel açıdan uyumsuz olabilirler; evlilik sorunları ve gelişigüzel cinsel ilişkiler oldukça sık görülür. 34/43 kodunu alan kişilerde intihar düşünceleri ve girişimleri dikkat çeker. Bunlar çoğu kez aşırı içki içme ve acting-out davranışlarının ardından ortaya çıkar. Sıklıkla bir kişilik bozukluğu tanısı alırlar. Pasif- agresif ve unstable kişilik özelliklerine sık rastlanır.

36/63

Bu kişiler orta derecede gerginlik ve anksiyete belirtileri gösterebilirler ve başağrısı, sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi bedensel yakınmaları olabilir. Ancak sorunları akut ya da yeti kaybına yol açacak kadar şiddetli değildir. Sorunlarının çoğu aile bireylerine karşı duydukları derin ve kronik düşmanlık duygularından kaynaklanır. Bu duyguları doğrudan anlatamazlar ve hatta çoğu kez içlerindeki bu düşmanlık duygusunun farkında olmayabilirler. Öfkelerini farkettilerinde bunu başkalarının davranışlarına bağlayarak kendilerini haklı göstermeye çalışırlar. Genellikle sürekli karşı çıkan, işbirliğine yanaşmayan, birlikte yaşanılması güç kişilerdir. Başkalarına karşı hafifçe kuşkucu olabilirler, alıngandırlar. Ben-merkezci ve narsistik kişilerdir. Önemli ruhsal sorunlarını inkar ederek, dünyaya karşı Polyanna tarzı saf bir iyimserlik gösterirler.

38/83

38/83 kodunu alan kişiler büyük bir ruhsal karmaşa içindedirler. Anksiyete, gerilim ve sinirlilikten yakınır. Aynı zamanda korkulu ve endişeli olabilirler; fobiler görülebilir. Depresyon ve umutsuzluk duyguları bu kişiler arasında yaygındır. Küçük ve önemsiz kararlar verirken bile tereddüt ederler. Çok çeşitli fiziksel yakınmalar (sindirim sistemi rahatsızlıkları, adale ağrıları, göz kararması, baş dönmesi, göğüs ağrısı, genital bölgede ağrı, baş ağrısı, uykusuzluk) görülebilir. 38/83 kodunu alan kişiler, sorunlarından söz ederken oldukça belirsiz ve kaçamak davranırlar.

Bu kişiler olgunlaşmamış ve bağımlıdırlar, ilgi ve sevgiye büyük gereksinim duyarlar. Engellenme karşısında kendilerini cezalandırma eğilimi gösterebilirler. Yaşama aktif bir biçimde katılmazlar, ilgisiz ve kötümserdiler. Sorunlarına yaklaşımları orjinal değildir; sıradan çözümleri denerler. İlgörü yönelimli psikoterapi için uygun olmamalarına rağmen, destekleyici psikoterapi ilişkisinden yarar sağlarlar.

38/83 kodu, düşüncede bozulma olasılığını akla getirir. Bu kodu alan kişiler, berrak düşünemediklerini, dikkatlerini toplamakta güçlük çektiklerini ve bellek yanlışları olduğunu ifade edebilirler. Garip ve olağandışı düşünceleri olabilir; çağrışımlarda çözümlere görülebilir. Obsesif düşüncelere, açık delirlere, hallüsinasyonlara, anlamsız ve enkoheran konuşmaya rastlanabilir. Psikiyatrik hastalar arasında en sık görülen tanı şizofrenidir. Ancak bazen bu kişiler histerik nevroz tanısı da alabilir.

45/54

45/54 kodunu alan kişiler olgunlaşmamış ve narsistiktirler. Duygusal açıdan pasiftirler; bağımlılık gereksinimleri çok güçlüdür. Sosyal değerleri kendi kişilikleri ile bütünleştirmede güçlük çekerler. Boyun eğici ve uysal değildirler; giyiniş, konuşma ve davranışları ile geleneklere meydan okur gibi görünürler. 45/54 konfigürasyonunda, 5. ölçek denetimin yeterli olduğunu ve açıkça suça yönelik davranışların pek görülmeceğini düşündürür. Ancak engellenmeye dayanıksızlık, yoğun öfke ve kırgınlık duyguları ile birleştğinde kısa saldırgan acting-out dönemleri görülebilir. Bu davranışları geçici pişmanlık ve suçluluk duyguları izleyebilir, ancak yine de bu kişiler, benzer dönemlerin önüne geçemezler. Psikiyatrik hastalarda en sık görülen tanı pasif-agresif kişiliktir.

45/54 kodunu alan kişilerin cinsel kimlikle ilişkili sorunları olabilir. Geleneksel cinsel rollere karşı çıkabilirler, özellikle 4. ve 5. ölçek aynı anda çok yükselmisse, açık homoseksüel davranışlar görülebilir. 45/54 kodunu alan erkekler, kadınlar tarafından idare edilmekten korkarlar ve bu nedenle kadınların isteklerine karşı çok duyarlı olabilirler.

46/64

46/64 kodunu alan kişiler, olgunlaşmamış, narsistik ve kendilerine karşı hoşgörülüdürler. Pasif-bağımlı kişilerdir, başkalarının kendileriyle çok fazla ilgilenmelerini isterler ancak aynı şey bir miktar da kendilerinden beklendiğinde, gücenip kızarlar. 46/64 kodunu alan kadın hastalar, geleneksel kadın rolüne ait özellikleri çok iyi benimsemiş görünürler; erkeklere aşırı bağımlı olabilirler. Bu kodu alan kadın ve erkekler, sosyal ortamlarda başkaları ile iyi anlaşamazlar, özellikle de karşı cinsten kişilerin yanında huzursuzdurlar. Diğer insanların isteklerini kuşkuyla karşılarlar ve derin duygusal ilişkilerden kaçınırlar. Çalışma öyküleri kötüdür, evlilik sorunları sık görülür. 46/64 kişlerinde bastırılmış düşmanlık ve öfke duyguları dik-kati çeker. Kolay sinirlenen, kavgacı ve huysuz kişilerdir. Özellikle otoriteye karşı kızgın oldukları ve otorite figürlerini aşağılamaya çalıştıkları görülür.

46/64 kodunu alan kişiler ruhsal sorunlarını inkara eğilimlidirler. Mantığa uydurma, başkalarını suçlama gibi yollarla, davranışlarının sorumluluğunu üstlenmekten kaçınırlar. Kendilerini değerlendirme biçimleri gerçekdışı ve grandiyöz olabilir. Duygusal sorunlarını inkar ettikleri için genellikle, geleneksel psikoterapileri kabul etmezler.

Psikiyatrik hastalar arasında, 46/64 kodu iki ayrı tanı gurubunda aynı oranda sık görülür. Bunlar pasif-agresif kişilik bozukluğu ile paranoid tip şizofrenidir. Genelde, 4. ve 6. ölçekler çok yüksek ve 6. ölçek, 4. ölçekten daha yüksek ise, bir prepsikotik ya da psikotik durum olasılığı artar. 46/64 kodunu alan kişilerde belirsiz duygusal ve fiziksel yakınmalar olabilir. Orta düzeyde depresyon ve sinirlilik görülebilir. Fiziksel semptomlar, astımı, yüksek tansiyonu, baş ağrılarını, geçici bilinç kayıplarını ve kalple ilişkili yakınmaları içerebilir.

47/74

47/74 kodunu alan kişiler, bazen eylemlerinin sonuçlarına karşı büyük bir duyarsızlık içinde, bazen de davranışlarıyla aşırı ilgili olabilirler. Aşırı içmenin ve gelişigüzel cinsel ilişkilerin görüldüğü acting-out dönemlerini, geçici suçluluk duyguları izleyebilir. Ancak, pişmanlık, daha sonraki acting-out dönemlerini engellemez. Bu kişilerin baş ve karın ağrısı gibi belirsiz somatik yakınmaları olabilir. Bunların yanısıra gerginlik, yorgunluk ve tükenme hissinden söz edebilirler. Oldukça bağımlı ve sürekli, değerli olduklarına dair başkalarından teminat bekleyen güvensiz kişilerdir. Psikoterapide destek ve teminat sonucu semptomatik düzelme gösterebilirler, ancak kişilikte değişme kolay olmaz.

48/84

48/84 kodunu alan kişilerin, içinde bulundukları çevreye uymadıkları görülür. Diğer insanlar tarafından garip ve tuhaf kişiler olarak nite-

lendirilirler. Otoriteye karşı isyankardırlar ve genellikle radikal dini ya da politik görüşleri benimserler. Davranışları tutarsızdır ve önceden tahmin edilemez. Dürtü denetimine ilişkin önemli sorunları vardır. Ökeli, kolay sinirlenen, alıngan kişilerdir. Antisosyal acting-out'lar sergileyebilirler. Suç işlediklerinde saldırı ve şiddete eğilim gösterirler. Ayrıca, bu davranışların çoğunlukla saçma sapan ve kötü planlanmış oldukları görülür. 48/84 kodunu alan kişilerde, fahişelik, gelişigüzel cinsel ilişkiler ve cinsel sapma oldukça sıktır. Bunların yanı sıra, aşırı içme ve madde kötüye kullanımı görülebilir. Yaşam öykülerinde başarısızlık, dengesiz davranışlar ve uyumun sınırdan oluşu dikkati çeker.

48/84 kodunu alan kişiler derin güvensizlik duyguları içindedirler. İlgisi ve sevgi gereksinimleri çok fazladır. Benlik algıları olumsuzdur, kendilerini başarısızlığa ve reddedilmeye hazırlıyor gibidirler. Obsesif intihar düşünceleri bulunabilir. Bu kişiler başkalarına pek güvenmezler ve yakın ilişkiden kaçınırlar. Kişilerarası ilişkilerde empati yapamazlar ve başkalarını kendi gereksinimlerinin doyumu için kullanmaya çalışırlar. Sosyal becerileri gelişmemiştir, sosyal izolasyona ve içe çekilmeye eğilimlidirler. Bu kişiler için dünya, tehdit edici ve reddedici. Zedelenmemek için, savunma olarak kendi içlerine çekilebilirler ya da öfkeyle saldırabilirler. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenmek istemezler, rasyonalize etmeye ve kendi sorunları için başkalarını suçlamaya eğilimlidirler. Bu kişiler, kendi kadınlıkları ya da erkeldikleri konusunda ciddi kuşkular taşıyabilirler. Obsesif cinsel düşünceleri olabilir ve cinsel ilişkilerde yeterince başarılı olamamaktan korkabilirler. Cinsel yeterliliklerini kanıtlamak için antisosyal cinsel eylemlere girişebilirler.

48/84 kodunu alan psikiyatrik hastalar şizofreni (paranoid tip), antisosyal, şizoid ya da paranoid kişilik bozukluğu tanılarını alırlar. Eğer her iki ölçekte (4 ve 8) çok yükselmişse ve özellikle 8, 4'ten yüksekse, paranoid kuşkuculuk ve garip düşüncelerin görüldüğü psikotik bir durum olasılığı yüksektir.

49/94

Bu kodu alan kişilerin en belirgin özellikleri sosyal kural ve değerlere önem vermemeleridir. Antisosyal davranışları nedeniyle sık sık başları derde girer. Vicdanları pek gelişmemiştir, ahlaki değerleri zayıftır ve kolayca değişir. Alkolizm, kavga, evlilik sorunları, cinsel acting-out ve çeşitli suç eylemleri gibi sorunlarla oldukça sık karşılaşılırlar.

Bu kişiler, narsisistik, bencil ve kendilerine karşı hoşgörülüdürler. Dürtüleri ile hareket ederler ve doyumu erteleyemezler. Yargılamaları yetersizdir, sıklıkla eylemlerinin sonuçlarını düşünmeksizin harekete geçerler ve geçmiş deneyimlerinden yararlanamazlar. Davranışlarının sorumluluğunu kabul etmek istemezler, hata ve başarısızlıklarını rasyonalize ederler ve sorunları için başkalarını suçlarlar. Engellenmeye dayanma güçleri yoktur, çoğunlukla karamsar, sinirli ve iğneleyicidirler. Yoğun öfke ve düşmanlık

duyguları taşırlar. Bu duygular zaman zaman duygusal patlamalar şeklinde ifade bulur.

Hırslı, enerjik ve aşırı aktiftirler. Duygusal uyarılma ve heyecan arayışı içinde olabilirler. Sosyal ortamlarda serbest, dışa dönük ve konuşkandırılar, ilk bıraktıkları izlenim olumludur. Ancak ben-merkezci olmaları ve insanlara güvenmemeleri nedeniyle ilişkileri yüzeyseldir ve doyum verici değildir. Derin duygusal ilişkiler kuramazlar. İnsanlarla aralarında duygusal bir uzaklık bırakırlar. Kendine güven ve emniyet maskesinin altında, inkar etmeye çalıştıkları güvensizlik duygularını saklayan, bağımlı ve olgunlaşmamış kişilerdir. Bu kodu alan kişilere en sık verilen tanı antisosyal kişilik bozukluğudur. Ancak, zaman zaman, manik-depresif psikoz tanısı aldıkları da görülmüştür.

68/86

Bu kodu alan kişilerde yoğun aşağılık ve güvensizlik duyguları dikkati çeker. Kendilerine güven ve saygıları yoktur. Başarısız olduklarını düşünerek suçluluk duyarlar. Günlük aktivitelerden uzaklaşma ve duygusal kayıtsızlık sık görülür. İntihar düşünceleri bulunabilir. 68/86 kodunu alan kişiler başka insanlarla duygusal ilişki kuramazlar. İnsanlara karşı kuşku ve güvensizdirler. Sosyal becerilerinde önemli yetersizlikler vardır ve yalnızken daha rahat ederler. Başka insanlar tarafından, karamsar, sinirli ve negativist kişiler olarak görülürler. Yaşam tarzları, genellikle şizoid olarak nitelendirilir.

68/86 kodunu alan kişilerin bazıları paranoid ya da şizoid kişilik bozukluğu tanısı almasına rağmen, psikiyatrik hasta grubunda, bu konfigürasyonun daha çok paranoid tip şizofreni tanısıyla ilişkili olduğu görülmüştür. Bu, özellikle 6 ve 8 çok yükseldiğinde ve her iki ölçek 7'den önemli ölçüde yüksek olduğunda söz konusudur. 68/86 grubuna giren kişilerin düşünceleri hem yapı hem de içerik açısından bozulmuş olabilir. Dikkat ve dikkati yoğunlaştırma sorunları, bellek yetersizlikleri, yargıda bozulma oldukça sıktır. Kötülük görme ve/veya büyüklük delirileri ve hallüsinasyonlar olabilir; gerçek dışılık hissinden söz edebilirler. Bu kişiler soyut ya da teorik konularla aşırı ilgilenirler. Duygusal küntlük görülebilir, konuşma hızlanabilir ve zaman zaman tutarsızlaşabilir. Başarılı savunmalardan yoksundurlar, stres durumlarına hayal dünyasına ve gündüz rüyalarına çekilerek tepki gösterirler. Bu kişiler için gerçek ile hayali birbirinden ayırmak oldukça güçtür.

69/96

Bu kişiler oldukça bağımlıdır; sevgi ve şefkate büyük gereksinimleri vardır. Gerçek ya da hayali tehditlerden kolayca zedelenirler. Çoğunlukla gergin ve anksiyözdürler. Ağlamaklı bir görünüm içinde olabilirler. Bu kodu alan kişilerin dikkat çekici bir özellikleri, küçük streslere aşırı

tepki göstermeleridir. Ciddi stresler karşısında gösterdikleri tipik tepki hayal dünyasına sığınmadır. 69/96 kodunu alan kişiler duygularını uyumlu ve dengeli bir biçimde ifade edemezler; aşırı kontrol ile kontrolsüz duygusal patlamalar arasında gidip gelebilirler.

Bu kodu alanlar hemen her zaman paranoid tip şizofreni tanısı alırlar ve düşünce bozukluğu belirtileri gösterirler. Düşünme ve dikkati toplama güçlüğünden yakınır; düşünce akışı yavaşlamış olabilir. Tekrarlayan düşünceler ve obsesyonlar bulunabilir. Delir ve hallüsinasyonlara rastlanabilir. Konuşma anlamsız ve tutarsız görünebilir. Dezoryante ve şaşırılmış olabilirler; yargı hataları yapabilirler.

78/87

78/87 kodunu alanların tipik özellikleri büyük bir karmaşa içinde olmalarıdır. Ruhsal sorunlarını tereddütsüz kabul ederler ve kendilerini biraz olsun rahatlatacak savunmalardan yoksun gibidirler. Depresyon, endişe, gerilim ve sinirlilikten yakınır. Ruh sağlığı uzmanları tarafından ilk görüldüklerinde son derece şaşkın ve panik içinde olabilirler. Yargılamaları yetersizdir, deneyimlerinden yeterince yararlanamazlar. İçgözleme eğilimlidirler, tekrar tekrar aynı düşünceleri kafalarında evirip çeviren, aşırı mükemmelliyetçi kişilerdir.

78/87 kodunu alan kişiler, kronik yetersizlik, güvensizlik ve aşağılık duyguları olan bireylerdir. Oldukça kararsızdırlar. Sosyal deneyimleri çok sınırlı olduğu için ilişkilerinde güvenli değildirler. Sosyal etkileşimlerden kaçarlar. Kişilerarası ilişkilerde dominan bir rol alamayan pasif bağımlı bireylerdir. Bu kişiler için olgun heteroseksüel ilişkiler kurabilmek özellikle güçtür. Geleneksel cinsel rollerde kendilerini yetersiz hissederler ve cinsel performans kötü olabilir. Bu eksiklikleri telafi etmek amacıyla zengin cinsel hayallerle uğraştıkları görülür.

78/87 kodunu alan bireylerde, nevroz, psikoz ve kişilik bozukluğu tanılarından hepsine rastlanmaktadır. En sık görülen nevrotik tanımlar obsesif kompulsif bozukluk ve depresyondur. Bu kişilere çok farklı psikotik tanımlar verilebilmektedir, ancak manik-depresif bozukluk nadiren görülür. Kişilik bozukluğu tanılarından en sık rastlanan şizoid kişilik bozukluğudur. 7. Ölçek ile 8. ölçek arasındaki yükseklik farkı nevrotikler psikotiklerden ayırmada önemlidir. 8. ölçek 7'den daha yüksek ise psikoz olasılığı artar (aradaki fark ne denli fazla ise bu olasılık o denli güçlüdür). Ancak psikoz tanısı konmasına rağmen bu kişilerde açık psikotik semptomlar görülmez.

89/98

Bu gruptaki kişiler, ben merkezci ve başkalarından çocuksu beklentileri olan bireylerdir. Diğer insanlardan çok fazla ilgi beklerler ve bu istekleri gerçekleşmediğinde gücenip düşmanca davranabilirler. Duygusal

ilişkilerden korktukları için yakın insan ilişkilerinden kaçarak. Başka insanlardan ayrı ve içe çekilmiş kişilerdir. Özellikle heteroseksüel ilişkilerde huzursuz görünürler; cinsel uyumsuzluk oldukça sık görülen bir durumdur.

89/98 kodunu alan kişilerde, aşırı hareketlilik ve duygusal tutarsızlık dikkati çeker. Ajite ve heyecanlı görünürler. Yüksek bir ses tonu ile çok fazla konuşabilirler. Kendilerini değerlendirme biçimleri gerçekçi değildir; başka insanlarda grandiyöz, övünge ve maymun iştahlı bir kişi izlenimi bırakırlar. Sorunları hakkında konuşurken açık değildirler ve inkara başvururlar; profesyonel yardıma ihtiyaçları olmadığını söyleyebilirler.

Bu kişiler başarılı olmaya büyük bir gereksinim duyarlar, ancak gösterdikleri performans orta düzeydedir. Altta yatan güvensizlik ve yetersizlik duyguları yarışmayı gerektiren durumlara katılmalarını engeller.

89/98 kodu, özellikle 8 ve 9 çok yükselmişse ciddi bir ruhsal bozukluk düşündürür. En sık görülen tanı şizofrenidir (katatonik, şizoaffektif ve paranoid tip). Düşüncede önemli bozukluklar olabilir. Şaşkın ve dezoryante görünürler; gerçek dışılık hissinden söz edebilirler. Düşünmede ve dikkati toplamada güçlükleri vardır; bir konu üzerinde odaklaşamazlar. Düşünce aynı zamanda garip, olağandışı ve otistik olabilir. Klang çağrışımları, neolojizm ve ekolali görülebilir. Delir ve hallüsinasyonlara rastlanabilir. 89/98 koduna madde kullanan ergenlerde de sık rastlanır.

V. BÖLÜMÜN HAZIRLANMASINDA YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Carson, R. C. (1969). *Interpretive manual to MMPI*. In J.N. Butcher (Ed.), *MMPI: Research developments and clinical applications*. New York: Mc Graw-Hill.
- Dahlstrom, W. G., Welsh, G. S., Dahlstrom, L. E. (1972). *An MMPI Handbook : Volume I. Clinical interpretation*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Davis, K. R., & Sines, J. O. (1971). An antisocial behavior pattern associated with a specific MMPI profile. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 36, 229-234.
- Drake, L. E., & Oetting, E. R. (1959). *An MMPI codebook for counselors*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Duckworth, J. C., & Duckworth, E. (1975). *MMPI interpretative manual for clinicians and counselors*. Muncie, Ind.: Accelerated Development, Inc.
- Gilberstadt, H., & Duker, J. (1965). *A Handbook for clinical and actuarial MMPI interpretation*. Philadelphia: Saunders.
- Good, P. K. E., & Brantner, J. P. (1961). *The Physician's guide to the MMPI*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Gynther, M. D., Altman, H., & Sletten, I. W. (1973). Replicated correlates of MMPI two point types: The Missouri Actuarial System. *Journal of Clinical Psychology*, Monograph Supplement No. 39.
- Hovey, H. B., & Lewis, E. G. (1967). *Semiautomatic interpretation of the MMPI*. *Journal of Clinical Psychology*, Monograph Supplement 22.
- Lachar, D. (1974). *The MMPI: Clinical assessment and automated interpretation*. Los Angeles: Western Psychological Services.
- Lewandowski, D., & Graham, J. R. (1972). Empirical correlates of frequently occurring two-point code types: A replicated study. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 39, 467-472.
- Marks, P. A., Seeman, W., & Haller, D. L. (1974). *The actuarial use of the MMPI with adolescents and adults*. Baltimore: Williams & Wilkins.
- Persons, R. W., & Marks, P. A. (1971). The violent 4-3 MMPI personality type. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 36, 189-196.
- Schubert, H. J. P. (1971). *A Wide-range MMPI Manual*. Unpublished manuscript.

VI

SIK KULLANILAN ARASTIRMA ÖLÇEKLERİ

MMPI'nin madde havuzunu oluşturan 566 madde, madde ve faktör analizi ya da sezgisel yaklaşım gibi yöntemlerin kullanılmasıyla, çeşitli şekillerde biraraya getirilerek, standart geçerlik ve klinik ölçeklerin yanısıra çok sayıda başka ölçek daha geliştirilmiştir. Dahlstrom, Welsch ve Dahlstrom (1975), 450 nin üzerinde ilave ölçeğin bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu ölçeklerin içinde "Represyon" ve "Kuşkuculuk" gibi alışılmış adları taşıyanların yanısıra, "Beybol Başarısı" ve "Yeshiva Koleji Alt Kültür Ölçeği" gibi alışılmadık adları taşıyanlar da vardır. Ölçekler arasında yapı ve geçerlik açısından da büyük farklar bulunmaktadır. İlave ölçeklerin çoğu, yeterince geçerli olmadıkları için rutin klinik uygulamalara uygun değildirler.

İlave ölçeklerin 12 tanesi, MMPI puanlayan ve yorumlayan merkezlerin bazılarında rutin olarak kullanıldıkları için, klinisyenlerce daha fazla bilinirler. Bunlar:

A	- Anksiyete	Dy	- Bağımlılık
R	- Represyon	Do	- Üstünlük
Es	- Ego Gücü	Re	- Sosyal Sorumluluk
MAS	- Açık Anksiyete	Pr	- Önyargı
Lb	- Bel Ağrısı	St	- Sosyal Durum
Ca	- Arka Beyin Hasarı	Cn	- Kontrol

Bu ölçeklerin bilgisayar puanlaması için seçilmesinin temel bir nedeni, ölçeklere ait normatif verilerin yayınlanmış olmasıdır (Hathaway & Briggs, 1975; Taylor, 1953). Ancak bu bölüm hazırlanırken, mevcut literatür gözden geçirildiğinde, çoğu ölçek için elimizde fazla bir bilginin bulunmadığı görülmüştür. Yine de, araştırmacıları bu ölçekleri kullanmaya teşvik etme ve böylece daha fazla bilginin toplanmasını sağlama umuduyla ölçekler burada tartışılmıştır.

Bu bölümdeki her ölçek daha önceki sırayla gözden geçirilmiştir. Ölçeklerin gelişimine ilişkin bilgi sunulduktan sonra, mevcut bilginin elverdiği oranda güvenilirlik ve geçerlik verileri belirtilmiştir. Bunların yanısıra, düşük ve yüksek puanların yorumuna ilişkin bilgi özetlenmiştir. Geçerlik ve klinik ölçeklerde olduğu gibi, yüksek ve düşük puanlar için belirlenmiş

kesme noktaları yoktur. Genelde 70 in üzerindeki T puanları yüksek, 40 ın altındaki T puanları düşük kabul edilebilir. Özel bir kesme puanı olduğunda ayrıca belirtilmiştir. Bu kitapta, yoruma ilişkin bilgilerin araştırma bulgularına dayanmasına özen gösterilmesine rağmen, bazı durumlarda araştırma bulguları çok az olduğu için, daha subjektif bulgular olan içerik analizi ve klinik izlenimlere de yer verilmiştir.

Her ölçeğin hangi maddelerden oluştuğu ve nasıl puanlandığı Ek A'da sunulmuştur. Araştırma ölçeklerini puanlayabilmek için tüm MMPI'nin (566 maddenin) uygulanması gerektiği unutulmamalıdır. (Çevirenin notu: Bu ölçekler için Türk normları mevcut değildir. Bu nedenle ölçeklerin ülkemizde kullanılabilmeleri için öncelikle standardizasyon çalışmalarına ihtiyaç vardır.)

ANKSİYETE (A) VE REPRESYON (R) ÖLÇEKLERİ **(Anxiety (A) and Repression (R) Scales)**

Ölçeğin Gelişimi

Temel geçerlik ve klinik ölçekler, faktör analizi ile ortak bölümlere ayrılmak istendiğinde, sürekli olarak iki temel boyut ortaya çıkmıştır (Block, 1965; Eichman 1961, 1962; Welsh, 1956). Welsh (1956), bu iki temel boyutu değerlendirmek için Anksiyete (A) ve Represyon (R) ölçeklerini geliştirmiştir. Erkek hastaların MMPI puanlarını, faktör analiziyle inceleyen Welsh ilk önce "genel uyumsuzluk " adını verdiği bir faktör belirlemiştir. Daha sonra bu faktörle en fazla ilişkisi bulunan maddeleri belirleyerek, bu faktörü değerlendiren A ölçeğini geliştirmiştir. Bu ilk ölçek bir grup psikiyatrik hastaya uygulanmış, iç tutarlılık yönteminden yararlanılarak yeniden düzenlenmiştir. Sonuçta belirlenen 39 madde A ölçeğini oluşturmuştur. Welsh, bu 39 madde üzerinde yaptığı incelemeye dayanarak ölçekteki maddelerin içeriğinin dört gruba ayrılabilceğini ileri sürmüştür: düşünme ve düşünce süreçleri; olumsuz duygusal ton ve disfori; enerji kaybı ve karamsarlık; kötü düşüncelere dalma. Cevap anahtarı, yüksek puanlar patolojideki artış göstercek şekilde düzenlenmiştir.

R ölçeği, Welsh (1956) tarafından, MMPI'nin temel klinik ve geçerlik ölçeklerinin faktör analizi sonucunda ortaya çıkan ikinci büyük boyutu ölçmek için yapılandırılmıştır. R ölçeği için de, A ölçeği hazırlanırken kullanılan yöntemin benzeri kullanılmıştır. Ölçeğin son şekli 40 maddedir. Welsh, R ölçeği maddelerinin içeriğine bakarak şu grupların ayrılabilceğini ileri sürmüştür: Sağlık ve fiziksel semptomlar; duygusallık; şiddet ve aktivite; sosyal ortamlarda başka insanlara gösterilen tepkiler; sosyal üstünlük; kişisel yeterlik duyguları ve kişisel görünüm; kişisel ve mesleki ilgiler.

Güvenirlilik ve Geçerlik

Welsh'in (1956), A ve R ölçekleri için bildirdiği güvenirlik verileri Kooser ve Stevens'in araştırmalarından elde edilmiştir. 108 üniversite öğ-

rencisi üzerinde yapılan bu çalışmalarda, A'nın yarım test güvenilirliği 0.88, R'nin ise 0.48 olarak bulunmuştur. A ve R ölçekleri 60 üniversite öğrencisine 4 ay ara ile iki kez verildiğinde test tekrar test güvenilirlik kat sayıları A için 0.70, R için 0.74 olarak saptanmıştır. Gocka (1965), 220 erkek psikiyatrik hasta üzerinde yaptığı çalışmada A ve R ölçeklerinin Kuder Richardson 21 (içsel tutarlılık) değerlerini, 0.94 ve 0.72 olarak bildirmiştir.

Edwards'a (1964) göre, A ölçeği basitçe, testi yanıtlayan kişinin toplumca onaylanmayan özellikleri kabul etme konusundaki içtenliğini değerlendirebilir. Messick ve Jackson (1961), R ölçeğinin, kişinin çeşitli duygusal sorunları kabul etme konusunda ne ölçüde istekli davrandığını gösterdiğini ileri sürmüşlerdir. R ölçeğinin cevap anahtarında hep "yanlış", olarak işaretlenen maddelerin puan alması bu görüşü destekler niteliktedir.

Welsh (1956), Gough'un bir grup normal denekten elde ettiği bazı yayınlanmamış verileri bildirmiştir. Gough A ölçeğinin K, L ve 1 ile olumsuz, F, 9 ve 0 ile olumlu yönde ilişkili olduğunu bulmuştur. Gough bunların yanı sıra yüksek puanların yavaşlığı, karamsarlığı, şüpheciligi ve çekingenliği gösterdiğini bildirmiştir. Sheriffs ve Boomer (1954) yüksek A puanlarının sınav ortamlarında kendine güvensizliği gösterdiğini bulmuşlardır. A ölçeği puanlarının, yatarak psikiyatrik tedavi görme sırasında düştüğünü gösteren bazı kanıtlar vardır (Lewinsohn, 1965). Duckworth ve Duckworth (1975), yüksek puanların, içinde bulundukları huzursuzluk nedeniyle psikoterapi-de değişmeye istekli kişileri gösterdiğini ileri sürmüşlerdir. Block ve Bailey (1955) yüksek ve düşük puanlarla ilişkili olan güvenilir test dışı davranışsal özellikler bildirmişlerdir. Bunlar, aşağıda yüksek ve düşük puanların yorumu sırasında sunulmuştur.

Welsh (1956), Welsh ve Roseman tarafından yapılan bir çalışmada, insülin şoku tedavisinden en fazla yararlanan kişilerin A ve R puanlarında bir düşme görüldüğünü bildirmiştir. Lewinsohn (1965), hastanede yatarak psikiyatrik tedavi gören hastaların R puanlarında tedavi boyunca sadece küçük bir değişiklik olduğunu bulmuştur. Duckworth ve Duckworth (1975), yüksek R puanlarını inkar, rasyonalizasyon ve içgörü azlığının belirtisi olarak tanımlamışlardır. Çeşitli araştırmalarda A ve R ölçekleri ile ilişkili bulunan özellikler aşağıda özetlenmiştir.

Yüksek A Puanlarının Yorumu

A ölçeği puanının yükselmesi kişinin şu özellikleri taşıyabileceğini gösterir:

1. anksiyöz, huzursuz,
2. yavaş,
3. karamsar,
4. ilgisiz, duygusuz, heyecansız,
5. utangaç, sıkılgan,
6. kendi yeteneklerine güvenmeyen,
7. şüpheli, kararsız,
8. çekingen, aşırı kontrollü,

9. duygularının etkisinde kalan,
10. savunmacı,
11. rasyonalize eden; güçlükler için başkalarını suçlayan,
12. sosyal ortamlarda huzursuz,
13. otoriteyi kabul eden, uyan,
14. uysal, itaatkar, telkine açık,
15. ihtiyatlı,
16. titiz,
17. erkekse, kadınsı davranışları olabilen,
18. soğuk, uzak, insanlara katılmayan,
19. stres altında şaşkın, dezorganize ve uyumsuz,
20. psikoterapide değişme için istekli.

Özetle, A ölçeğinden yüksek puan alan bir kişi eğer normal popülasyondan ise, mutsuz ve zavallı bir kişidir; yok psikiyatrik bir ortamdan ise, nevroitik, uyumsuz, itaatkar ve aşırı kontrollü bir kişi olduğunu söyleyebiliriz.

Düşük A Puanlarının Yorumu

A ölçeği puanının düşmesi kişinin şu özellikleri taşıyabileceğini gösterir:

1. anksiyöz ya da huzursuz olmayan,
2. aktif, canlı,
3. kendini kolay ifade eden, renkli, akıcı konuşan,
4. açık, açık sözlü,
5. dışa dönük, sosyal, arkadaş canlısı, samimi,
6. kendini üstün gören,
7. ikna edici,
8. dikkat çekici, gösterişçi,
9. etkili, yeterli, berrak düşünceli,
10. becerikli,
11. kendine güvenen,
12. yarışmacı; başarıya ve başarmaya önem veren,
13. güç ve statüye meraklı,
14. başka insanları ustalıkla idare eden,
15. dürtülerinin doyumunu geciktiremeyen,
16. eylemi düşünceye tercih eden; davranışlarının sonuçlarını düşünmeden harekete geçen.

Özetle, düşük A puanı alan kişiler, dışa dönük, yeterli, güvenli ve bir ölçüde dürtüleri ile hareket eden insanlardır. Bu kişiler ciddi bir ruhsal karmaşa yaşamamalarına rağmen uyum sorunları ile karşılaşabilirler.

Yüksek R Puanlarının Yorumu

R ölçeği puanının yükselmesi kişinin şu özellikleri taşıyabileceğini gösterir:

1. itaatkar,
2. heyecansız,
3. geleneksel, resmi,
4. berrak düşünceli,
5. yavaş; dikkatli,

Özetle, yüksek bir R puanı alan kişiler oldukça dikkatli ve ihtiyatlı bir yaşam tarzı sürerler.

Düşük R Puanlarının Yorumu

R ölçeği puanının düşmesi kişinin şu özellikleri taşıyabileceğini gösterir:

1. dışa dönük, açık sözlü, konuşkan,
2. heyecanlı, duygusal,
3. gayretli,
4. öfkeli, cüretkar,
5. teklifsiz,
6. güçlü kuvvetli, neşeli,
7. cömert,
8. etkili ve yöneten,
9. dürtüleri ile hareket eden,
10. saldırgan, sert,
11. alaycı, tartışmacı,
12. kendini araştıran, kendine karşı hoşgörülü,
13. kurnaz, uyanık, düzenbaz.

A ve R Ölçeklerinin Birlikte Yorumu

Welsh (1956, 1965) eğer A ve R puanları birlikte ele alınırsa, kişiyi daha iyi anlayabileceğimizi öne sürmüştür. Bildirdiği ilk çalışmada, Pearson'la birlikte yatan psikiyatrik hastaların MMPI profillerini yüksek A-düşük R, yüksek A-yüksek R, düşük A-düşük R, ve düşük A-yüksek R diye sınıflandırmıştır. Bu dört grup profil tipinin farklı psikiyatrik tanımlarla ilişkili olduğu bulunmuştur (örneğin, yüksek A-yüksek R tipinde depresif tanımlara, düşük A-düşük R tipinde karakter bozukluğu tanımlarına daha çok rastlanmıştır). Gynther ve Brilliant(1968) aynı sınıflandırmayı kullanarak, ayaktan tedavi gören psikiyatrik hastaları incelediklerini, ancak, aynı sonuçları bulamadıklarını bildirmişlerdir.

Daha sonraki yıllarda, Welsh (1965) A ve R ölçeklerini, yüksek, orta ve düşük diye ayrılarak dokuz grup oluşturmuştur. Bunun ardından, erkek hastaları kullanarak, önce, her gruba uygun protokolleri belirlemiştir. Daha sonra ise, her grup için tipik protokolleri ayırmış ve profil konfigürasyonuna dayanarak kişilik tanımlamalarını çıkarmıştır. Welsh, bu tanımlamaların, normallerden çok hastalar için uygun olduğunu ve klinik vakaların profille-

rini yorumlamak için de kullanılmamaları gerektiğini belirtmiştir. Bu tanımlamaların şimdilik ilerki çalışmalarda hipotezler geliştirmek için yararlı olabileceğini söylemiştir. Duckworth ve ark.(1975), yüksek A - yüksek R profil tipine ilişkin yorumlar dışında, Welsh'in tanımlamalarının, üniversite öğrencisi danışanlar için pek geçerli olmadığını belirtmişlerdir.

AÇIK ANKSİYETE ÖLÇEĞİ

Manifest Anxiety Scale (MAS)

Ölçeğin Gelişimi

Açık Anksiyete ölçeği (MAS), Taylor (1951) tarafından, deneysel çalışmalarda, anksiyetenin performans üzerindeki etkilerini inceleyebilmek için, yüksek ve düşük anksiyeteli kişileri ayırmak amacıyla geliştirilmiştir. Beş klinisyene açık anksiyetenin bir tanımı verilerek, orijinal MMPI madde havuzu içinden açık anksiyeteyi gösteren maddeleri işaretlemeleri istenmiştir. Hakemlerin %80 fikir birliğine vardıkları 65 madde ile 135 tampon madde, Biyografik Envanter adı altında birleştirilmiş ve amaç gizlenerek deneklere verilmiştir. Daha sonra birkaç kez gözden geçirilen ölçeğin son şekli 225 maddeden oluşmuştur. Bu ölçekte, ilk belirlenen 65 madde içinden toplam anksiyete puanı ile yüksek korelasyon gösteren 50 madde ve MMPI'nin L, F ve K ölçekleri ile bir "Katılık (Rigidity)" ölçeğinden alınmış tampon maddeler bir araya getirilmiştir.

MAS ölçeğinin 50 maddesi çok çeşitli davranışları içerir. Maddelerin çoğu anksiyetenin açık belirtileri (terleme, kızarma, titreme gibi) ile ilişkili iken, bazı maddeler sinirlilik, gerilim, anksiyete ve altüst olma gibi duyguların subjektif bildirimlerini içerir. Bunların yanı sıra, bedensel yakınmaları (bulantı, baş ağrısı, diyare, mide sorunları gibi) içeren pek çok madde vardır. Ayrıca, dikkati yoğunlaştırma ile ilişkili sorunları, heyecan ve yerinde duramamayı araştırın maddeler de vardır. Bazı maddeler ise kendine güven-sizlik, başkalarının tepkilerine aşırı duyarlılık ve yararsızlık duygularıyla ilişkilidir. Ölçeğin cevap anahtarına göre yüksek puanlar anksiyetenin yükseldiğini gösterir.

Güvenirlilik ve Geçerlik

Hilgard, Jones ve Kaplan (1951), MAS'ın yarı test güvenirlik katsayısını 0.92 olarak bildirmişlerdir. Gocka (1965), 220 erkek psikiyatrik hasta üzerinde, Kuder Richardson 21 (içsel tutarlılık) değerini 0.92 olarak belirlemiştir. Taylor (1953), üniversite öğrencilerinden oluşan bir örneklemde, test-tekrar test güvenirlik katsayılarını, 3 haftalık, 5 aylık ve 7-19 aylık aralarla araştırdığında sırayla 0.89, 0.82 ve 0.81 değerlerini bulmuştur.

Spence ve Spence (1966), basit öğrenmeye dayanan işlerde yüksek MAS puanlarının daha iyi bir performansı, daha karmaşık işlerde ise daha kötü bir performansı önceden tahmin etmeye yarayabileceğini öne sürmüş-

lerdir. Bu tür ön kestirimlerle ilişkili araştırma verileri çok tutarlı olmasa da Spence ve Spence'nin görüşlerini destekler nitelikte bulunmuştur. Ancak anksiyete ve öğrenme arasındaki ilişkinin basit bir ilişki olmadığı, işin güçlüğü, algılanan stres gibi diğer değişkenlerin de hesaba katılması gerektiği açıktır.

Byrne (1974), yaptığı bir literatür incelemesinden sonra, MAS puanlarının, diğer anksiyete ölçeklerinin (örneğin, ayrılık anksiyetesi, sınav anksiyetesi) puanları ve anksiyetenin fizyolojik ölçümleri ile pozitif bir ilişki içinde olduğunu ileri sürmüştür. Ayrıca MAS puanları yüksek olan kişiler gözlemciler tarafından da manifest anksiyetesi yüksek olarak değerlendirilmektedir. Psikiyatrik hastaların medikal hastalara ve üniversite öğrencilerine kıyasla daha yüksek MAS puanı aldıklarını gösteren veriler, ölçek puanlarının genel ruhsal uyumla ilişkili olduğunu düşündürmüştür. Ayrıca, yüksek MAS puanı alan kişilerin, düşük puanlılara kıyasla daha fazla tıbbi ve psikiyatrik semptom kabul ettikleri görülmüştür. Psikoterapi sonrasında MAS puanlarında terapi öncesine kıyasla bir düşüş olduğu bulunmuştur. Bunların yanı sıra, MAS puanı yüksek olan kişilerin çevrelerini kendi kontrolleri dışında ve tehdit edici olarak algıladıkları, stres durumlarında otonomik tepkilerini düşük puanlılara kıyasla daha az kontrol edebildikleri görülmüştür. Yüksek MAS puanı alanlar gelecekte çok, şimdiki zaman üzerinde odaklaşmaya eğilimlidirler ve beklentilerini oluştururken yakın geçmişteki tecrübelerine dayanırlar.

Spielberger (1966b), durumsal ve sürekli anksiyeteyi birbirinden ayırmıştır. Sürekli anksiyete, stres verici durumlar karşısında oldukça stabil bir biçimde ortaya çıkan anksiyöz tepkilerdir. Durumsal anksiyete ise, durumdaki değişikliğe bağlı olarak değişen geçici gerilim duygularını ve otonomik sinir sistemi aktivitesini gösterir. MAS'ın durumsal anksiyeteden çok sürekli anksiyeteyi değerlendirdiği açıktır. MAS puanları gevşeme eğitimi ya da stres verici görüşme gibi durumsal değişikliklere bağlı olarak değişmez.

Yüksek MAS Puanlarının Yorumu

MAS ölçeğinden alınan yüksek puan, stres verici durumlarda, kişinin büyük bir duygusal rahatsızlık yaşadığını gösterir. Bu durumlarda kendini anksiyöz, gergin ve diken üstünde hissederek; aşırı terleme, kalp atışının hızlanması gibi bazı fizyolojik değişiklikleri yaşar. Çevreyi tehdit edici bir ortam olarak algılar ve kendini kontrolü dışındaki kuvvetlerin insafına kalmış gibi hisseder. Gelecekte çok şimdiki zaman üzerinde durur ve beklentilerini hemen o anda yaşadıklarına göre belirir. Yüksek MAS puanı alanlar, basit işlerde iyi bir performans gösterebilirler de, çalışma ya da okul performansı gibi daha karmaşık işlerde başarılı değildirler. MAS ölçeği puanının yükselmesi kişinin şu özellikleri taşıyabileceğini gösterir:

1. çok sayıda fiziksel ya da bedensel yakınma bildiren,
2. çoğu zaman kendini heyecanlı ve yerinde duramaz hisseden,
3. dikkatini toplamakta güçlük çeken,

4. kendine güvenmeyen,
5. başkalarının tepkilerine karşı çok duyarlı,
6. kendini mutsuz ve güvensiz hisseden.

Düşük MAS Puanlarının Yorumu

Düşük MAS puanı, stres verici durumlarda kişinin büyük bir rahatsızlık yaşamadığını gösterir. Böyle durumlarda sakin kalır ve durumu kontrol edebileceğini hisseder. Karmaşık öğrenme durumlarında, MAS puanı yüksek olan kişilere kıyasla daha iyi bir performans göstermesi beklenir. Ayrıca düşük MAS puanı, kendine güvenen ve fiziksel ya da bedensel yakınması az olan bir kişiyi düşündürür.

EGO GÜCÜ ÖLÇEĞİ

Ego Strenght (Es) Scale

Ölçeğin Gelişimi

4. Ego gücü (Es) ölçeği, Barron (1953) tarafından, özellikle, nevrotik hastaların bireysel psikoterapiye gösterdikleri tepkileri önceden tahmin edebilmek için geliştirilmiştir. Es ölçeğinin 68 maddesi, altı aylık psikoterapi süresi içinde gelişme gösteren 17 hasta ile bu süre içinde gelişme göstermeyen 16 hastanın MMPI testine verdikleri yanıtlar karşılaştırılarak ampirik olarak belirlenmiştir. Es ölçeğinin maddeleri, fiziksel işlevler, yalnızlık, dini tutumlar, ahlaki durum, kişisel yeterlilik, başa çıkma yeteneği, fobi ve anksiyeteye ilişkilidir.

Güvenirlilik ve Geçerlilik

Es ölçeğinin geçerliği, Barron (1953) tarafından, üç ayrı grup nevrotik hastanın psikoanalitik oryantasyonlu kısa bir psikoterapi sırasında gösterdikleri gelişmeler incelenerek araştırılmıştır. Üç grupta da tedavi öncesi belirlenen Es puanları ile gösterilen gelişme arasında olumlu bir ilişki bulunduğu için, Barron, Es ölçeğinin, psikoterapi sırasında ortaya çıkan kişilik değişikliğini önceden tahmin etmeye yarayabileceğini ileri sürmüştür. Barron, 126 vakalık bir hasta örnekleminde yarım test güvenirliliğini (tek ve çift sayılı maddelerle) 0.76, 30 vakalık bir örnekleimde üç ay ara ile test-tekrar test güvenirliliğini 0.72 olarak bildirmiştir. Gocka (1965) 220 erkek psikiyatrik hastadan oluşan bir örnekleimde, Kuder Richardson 21 (içsel tutarlılık) değerini 0.78 bulmuştur.

Ne yazık ki, Es ölçeğinin psikoterapiye gösterilen yanıtları tahmine yarayıp yaramadığını araştıran başka geçerlik çalışmalarında elde edilen bulgular birbiriyle tutarlı değildir. Bazı bulgular, tedavi sırasında daha fazla değişen hastaların tedavi öncesi Es puanlarının, daha az değişme gösterenlere kıyasla daha yüksek olduğunu gösterirken (Wirt, 1955, 1956), bazı bulgular, tedavideki değişikliğin Es puanlarıyla ilişkili olmadığını düşündürmektedir (Ends ve Page 1957; Fowler, Teel ve Coyle 1967; Getter ve

Sundland 1962; Sullivan, Miller ve Smelser, 1958). Distler, May ve Tuma (1964), erkek psikiyatrik hastalarda hospitalizasyon sonucuyla tedavi öncesi Es puanları arasında olumlu, kadın hastalarda ise olumsuz bir ilişki saptamışlardır. Simmet (1962), tedavi öncesi Es puanları daha yüksek olan psikiyatrik hastaların, psikoterapi sırasında, düşük puanlı hastalara kıyasla daha fazla kişilik gelişmesi gösterdiklerini, fakat Es puanlarının, aynı hastaların gösterdiği semptomatik değişikliklerle ilişkili olmadığını bildirmiştir.

Dahlstrom ve ark. (1975), Es puanlarıyla tedavi sonucu arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların tutarsız sonuçlarını açıklamaya çalışmışlardır. Araştırmacılara göre sorunları ortada olduğu halde bunları inkar eden kişilerde, yüksek Es puanları, olumlu tedavi sonucunun bir göstergesi olmayabilir. Buna karşılık, duygusal sorunlarını kabul eden kişilerde, yüksek puanlar tedaviye verilecek olumlu yanıtı gösterebilir. Mevcut literatürde görüldüğü gibi, Es puanı ile tedavi sonucu arasındaki ilişki basit bir ilişki değildir; ön kestirim için hastalık tipinin, tedavi şeklinin ve tedavi sonucunu değerlendirmeye biçiminin de hesaba katılması gerektiği açıktır. Genel olarak, yüksek Es puanının, geleneksel bireysel psikoterapi uygulanan nevrotik hastalar için olumlu kişilik değişikliğini öngördüğü söylenebilir.

Es ölçeğinin genel psikolojik uyumun bir göstergesi olarak kabul edilebileceğini gösteren araştırma bulguları da vardır. Es ölçeğinden alınan yüksek puanlar, MMPI ve test dışı kriterlerle değerlendirilen psikolojik uyumla ilişkili bulunmuştur. Es puanları, psikiyatrik hastalarda hasta olmayanlara, ruhsal tedavi görenlerde tedavi görmeyenlere kıyasla daha düşüktür (Gottesman, 1959; Himelstein, 1964; Kleinmuntz, 1960; Quay, 1955; Spiegel, 1969; Taft, 1957). Es ölçeğinin suçlu ve suçlu olmayan ergenleri ayırt edemediği de bildirilmiştir (Gottesman, 1959). Es puanları, nevrotik hastalarda psikotiklere kıyasla daha fazla yükselse de, ölçeğin özel tanı kategorilerini ayırt edemediği bulunmuştur, (Hawkinson 1962; Rosen 1963; Tamkin 1957; Tamkin ve Klett 1957).

Es puanlarının psikoterapi ya da diğer tedaviler sonucu yükselmediğini gösteren bazı araştırma bulguları da vardır. Lewinsohn (1965), hastaneye yatma ile taburcu edilme arasında geçen süre içinde psikiyatrik hastaların Es puanlarının yükseldiğini bildirmiştir. Ancak Barton ve Leary (1955), bireysel ya da grup tedavisi uygulanan kişilerin Es puanlarının, aynı süreci bekleme listesinde geçiren hastalarınkinden daha fazla değişmediğini bulmuşlardır. Ayrıca, psikoterapiye kendisi başvuran hastaların Es puanlarının, başkası tarafından psikoterapiye gönderilenlerden yüksek olması (Himelstein 1964), yüksek puanların içsel çatışmaları farketmeyle ilişkili olduğunu düşündürmüştür.

Es ölçeği puanları zeka, (Tamkin ve Klett 1967; Wirt 1955) ve eğitimle (Tamkin & Klett 1967) pozitif ilişki içindedir. Es puanları ile yaş arasındaki ilişki ise bu kadar açık değildir. Tamkin ve Klett (1967) Es puanlarıyla yaş arasında ilişki bulamamışlar fakat Getter ve Sundland (1962) yaşlılarda Es puanlarının düşme eğilimi gösterdiğini bildirmişlerdir. Erkeklerde

kadınlara kıyasla daha yüksek bulunan Es puanlarıyla kendini gösteren cinsiyet farklılığına ilişkin bulgular ise hayli tutarlıdır (Distler ve ark. 1964; Getter ve Sundland 1962; Taft 1957). Bu cinsiyet farklılığı, Kadınların sorunlarını ve yakınmalarını kabul etme konusunda daha istekli oldukları şeklinde yorumlanmıştır (Getter & Sundland, 1962). Ancak daha mantıklı bir açıklama, ölçeğin erkek rolünün benimsenmesiyle ilişkili pek çok maddeyi içermesi ve bu nedenle erkeklerin kadınlara kıyasla daha yüksek puanlar almalarıdır (Holmes 1967).

Yüksek Ego Gücü Puanlarının Yorumu

Yukardaki tartışmadan, yüksek Es puanlarının tedavi sırasında ortaya çıkan olumlu kişilik değişikliklerini gösterdiği sonucu çıkarılabilir. Ancak daha önce de belirttiği gibi Es puanları ile tedavinin gidişi arasındaki ilişki basit bir ilişki olmadığı için hasta ve tedavi değişkenlerinin de hesaba katılması gerekir. Bunun yanı sıra, yüksek Es puanı alan kişilerin psikolojik uyumları daha iyidir; yaşam stresi ve yaşam sorunlarıyla düşük puanlılara kıyasla daha iyi başa çıkabilirler. Psikiyatrik hastalar arasında yüksek Es puanları daha çok nevroz tanılarıyla ilişkilidir ve düşük Es puanları psikotik hastalar arasında daha çok görülür. Bunlara ilaveten yayınlanmış çalışmalarda (örneğin, Barton 1953, 1956; Dahstrom ve ark. 1975; Duckworth ve Duckworth 1975; Good ve Brantner 1961; Quay 1955) yüksek Es puanı alan kişilerin şu özellikleri taşıyabileceği ileri sürülmüştür:

1. kronik bir psikopatolojisi bulunmayan,
2. tutarlı, güvenilir, sorumluluk sahibi,
3. hoşgörülü; önyargısız,
4. atik,
5. kararlı, inatçı,
6. kendine güvenen, açık sözlü, sosyal,
7. zeki, becerikli, bağımsız,
8. gerçeklik duygusu sağlam,
9. başkalarıyla ilgilenen,
10. ilk izlenimde iyi bir etki bırakan,
11. başkaları tarafından kabul gören,
12. fırsatçı, insanları idare eden,
13. gelişmiş ilgileri olan,
14. erkekse, uygun erkeksi davranışları olan,
15. düşman, otoriteye karşı isyankar,
16. yarışmacı,
17. alaycı, müstehzi, iğneleyici,
18. sorunlar karşısında yardım isteyen,
19. psikoterapide yüzleşmeye dayanabilen.

Özetle, psikiyatrik olmayan ortamlarda yüksek Es puanı, kişinin ciddi duygusal sorunları bulunmadığı gösterir. Duygusal sorunları olan

kişilerde yüksek Es puanları, sorunların kronik olmadığını ve bu sorunları çözerken yararlanabileceği psikolojik kaynaklara sahip olduğunu düşündürür.

Düşük Es Puanlarının Yorumu

Es puanı düşük olan kişilerin psikolojik uyumları, genel olarak daha kötüdür. Ayrıca bu kişilerin sorunlar ve stres karşısındaki donanımları iyi değildir. Tedavi sırasında olumlu kişilik değişiklikleri, düşük puanlılarda, yüksek puanlılara kıyasla daha az görülür. Bunlara ilave olarak, Barron (1953, 1956), Dahlstrom ve Welsh (1960), Dahlstrom ve ark.(1975), Duckworth ve Duckworth (1975), Good ve Brantner (1961), Es puanı düşük olan bir kişinin şu özellikleri taşıyabileceğini ileri sürmüşlerdir:

1. benlik kavramı yetersiz, kendini değersiz hisseden, düşünceli,
2. kendini çaresiz hisseden,
3. şaşkın,
4. süregen (kronik) fiziksel yakınmaları olan,
5. devamlı yorgunluktan yakanan,
6. korku ve fobileri olan,
7. içe çekilmiş, yalnız,
8. çekingen, uyumsuz,
9. sorunlarına basmakalıp yollarla yaklaşan,
10. terbiyeli, kibar,
11. temel dini inançlara sahip,
12. katı, tutucu,
13. sorunları abartan,
14. kötü bir çalışma (iş) geçmişi olan,
15. erkekse, davranış biçimi kadınsı olan,
16. sorunları daha çok karakterolojik nitelikte olan,
17. psikoterapide değişme konusunda iyi niyet belirten ancak bunları uygulamaya sokmayan.

Özetle, Es ölçeğinden düşük puan alan kişilerin psikolojik uyumları ciddi şekilde bozulmuştur. Sorunları uzun zamandır devam etmektedir; sorunlarla başa çıkmada kullanabilecekleri kişisel kaynakları son derece sınırlıdır; psikoterapideki gidişleri kötüdür.

BEL AĞRISI ÖLÇEĞİ **Low Back Pain (Lb) Scale**

Ölçeğin Gelişimi

Bel Ağrısı (Lb) ölçeği, hiçbir organik neden olmaksızın kronik bir bel ağrısı olan hastalarla, benzer ağrıdan yakanan ancak hastalığın organik belirtilerini gösteren kişileri ayırt etmek için Hanvik (1949, 1951) tarafından geliştirilmiştir. Lb ölçeğindeki 25 madde, bel ağrısından yakanan iki grup

hastanın MMPI maddelerine verdikleri yanıtların sıklıkları karşılaştırılarak belirlenmiştir. Gruplardan biri, ağrı yakınmaları için organik bir neden bulunan 30 hastadan, diğeri ise, ağrı yakınmalarını açıklayacak hiç bir organik bozukluğu bulunmayan 30 hastadan oluşmuştur. Ölçeğin anahtarı, yüksek puanlar fonksiyonel ağrıyı düşük puanlar ise organik bir bozukluktan kaynaklanan ağrıyı gösterecek şekilde düzenlenmiştir. Lb ölçeğinin maddeleri çok sayıda fiziksel yakınmayı, sosyal anksiyetenin inkarını, insanlar hakkında olumsuz duyguları, geleneksel dini inançların bulunmamasını, yerinde duramamayı, disforiyi, tutum ve inançları ifade etme konusundaki başarısızlığı içerir. Hanvik fonksiyonel ve organik ağrı vakalarını ayırt etmek için 11 ham puanının, kesme noktası olarak kullanılabileceğini ileri sürmüştür.

Güvenirlilik ve Geçerlik

Gocka (1965), 220 erkek psikiyatrik hastadan oluşan bir örneklemede, Lb ölçeğinin Kuder Richardson 21 (içsel tutarlılık) değerini, 0.22 olarak bulmuştur. Dahlstrom (1954), Lb ölçeğinin, kronik bel ağrısı yakınmaları için hiçbir fiziksel açıklama bulunamayan kişileri belirlemede yararlı olduğunu belirtmiştir. Dahlstrom, aynı zamanda, Lb puanı yüksek olan kişilerin, ağrıya neden olan fiziksel bozuklukları ameliyatla düzeltildikten sonra da, daha az iyileştiklerini bildirmiştir. Lewinsohn (1965), psikiyatrik hastaların taburculuk sırasındaki Lb puanlarının yatışa kıyasla daha düşük olduğunu bulmuştur.

Yüksek Lb Puanlarının Yorumu

Kronik bel ağrısından yakanan kişilerde, Lb ölçeğinin yükselmesi, özellikle ağrıyı açıklayacak hiçbir tıbbi bulgu bulunamamışsa, ağrının fonksiyonel nitelikte olabileceğini gösterir. Her ne kadar, Hanvik (1949, 1951), fonksiyonel ve organik vakaları ayırmada en iyi yolun, 11 ham puanını kesme noktası olarak kullanmak olduğunu belirtmişse de, Good ve Brantner (1961), kesme noktası olarak 70 T puanını kullanmayı önermişlerdir. Yüksek Lb puanıyla ilişkili test dışı davranışları araştıran başka çalışmalar yoktur. Ancak maddelerin içeriği incelendiğinde yüksek puan alan bir kişinin şu özellikleri taşıdığı söylenebilir:

1. bel ağrısının yanısıra başka fiziksel rahatsızlıkları (baş ağrısı, kalp çarpıntısı gibi) olan,
2. huzursuz,
3. insanlara duyduğu kızgınlığı inkar eden,
4. disforik (kaygılı ve kederli duygudurum),
5. görüş ve tutumlarını açıklamayan,
6. sosyal ortamlardaki etkileşimlerde rahat,
7. geleneksel dini inançları olmayan,
8. kendini yetersiz ve güvensiz hissettiği konuları saklamaya çalışan.

Özetle, diğer klinik bulgularla birlikte değerlendirildiğinde yüksek Lb puanı, bel ağrısı yakınmasında psikolojik faktörlerin ağır bastığını düşündürür. Yüksek Lb puanı alan bir kişi duygularını ve sorunlarını içe yönelterek bedensel yakınmalarla ifade etme eğilimi gösterebilir.

Düşük Lb Puanlarının Yorumu

Kronik bel ağrısı olan kişilerde görülen düşük Lb puanı, ağrının fonksiyonel nitelikte olmadığını düşündürür. Bu kişilerde rahatsızlığı açıklayan organik bir nedenin tıbbi kanıtları vardır. Yukarıda belirtilenin dışında düşük puanlarla ilişkili test dışı davranışları araştıran bir çalışma yapılmamıştır. Maddelerin içeriği incelendiğinde düşük puan alan bir kişinin şu özellikleri taşıdığı söylenebilir:

1. bel ağrısı dışında fiziksel ya da bedensel bir rahatsızlık belirtmeyen,
2. mutlu ve doyumlu,
3. insanlara duyduğu kızgınlığı ve rahatsızlığı kabul eden,
4. görüş ya da tutumlarını açıklayan,
5. sosyal ortamlarda rahatsız ve utangaç,
6. geleneksel dini inançlara sahip,
7. kendini yetersiz ve güvensiz hissettiği konularda oldukça açık.

Özetle, diğer klinik bulgularla birlikte ele alındığında düşük Lb puanı, belirtilen bel ağrısı yakınmasında psikolojik faktörlerden çok organik faktörlerin rol oynadığını düşündürür. Düşük Lb puanı alan kişiler, duyguları ve kendilerini güvensiz hissettikleri konular hakkında oldukça dürüstler.

ARKA BEYİN HASARI ÖLÇEĞİ

Caudality (Ca) Scale

Ölçeğin Gelişimi

Frontal ve parietal lob hasarının ayırıcı tanısı, nörolojik ve tıbbi bulgulara dayanılarak yapılır. Buna rağmen, bu önemli klinik problemin çözümüne yardımcı olacak bir MMPI ölçeği geliştirmeye çalışılmıştır. Sorumluluk sahibi hiçbir klinisyen, kortikal beyin hasarının yerini belirleme gibi önemli bir kararı, bir kağıt kalem testinin sonucuna dayanarak vermese de, bu tür ölçekler, eğer yeterince geçerli iseler ek bir bilgi sağlayabilirler.

Şimdiki Caudality (Ca) ölçeği, Friedman (1950) tarafından, frontal ve parietal lob hasarını ayırtmak amacıyla geliştirilen daha önceki bir ölçeğin uzantısı ve yeniden düzenlenmiş şeklidir. Williams (1952), şimdiki Ca ölçeğini geliştirirken Friedman'ın ölçeğinin geçerliğini frontal ve parietal lob hasarlı kişilerden oluşan yeni bir örnekleme araştırmış, MMPI madde havuzu içinden bu iki grup hastayı ayırt eden yeni maddeler belirlemiş ve bu yeni maddelerle Friedman'ın ölçeğinden aldığı bazı maddeleri birleştirerek

36 maddelik Ca ölçeğini oluşturmuştur. Ölçekteki maddeler düşük Ca puanları frontal hasarı, yüksek Ca puanları frontal olmayan beyin hasarını öngörecektir şekilde puanlar. Ca ölçeğinin 36 maddesi, anksiyete, depresyon, somatik yakınmalar, sosyal içe dönme, duygusal kontrol sorunları ve düşünce süreci üzerindeki kontrolü kaybetme korkularıyla ilişkilidir.

Güvenirlilik ve Geçerlilik

Gocka (1965), 220 erkek psikiyatrik hastadan oluşan bir grupta Ca ölçeğinin Kuder Richardson 21 (içsel tutarlılık) değerini 0.86 bulmuştur. Williams (1952), 11 ham puanı kesme noktası olarak alındığında, ölçeğin frontal lob hasarlı hastaları, parietal lob hasarlı hastalardan %78 oranında doğru olarak ayırdığını bildirmiştir. Williams'ın verileri, Ca puanları ile MMPI'nin 7 numaralı ölçeğinin puanları arasında pozitif, K puanları arasında ise negatif bir ilişki bulunduğunu göstermiştir.

Meier ve French (1964), 50 T puanı kesme noktası olarak alındığında, temporal lob anormallikleri olan hastaların belirlenebildiğini bulmuşlardır. Meier ve French, uygun klinik bulgularla birlikte kullanıldığında Ca ölçeğinin temporal lob anormalliklerini lokalize etmeye yaradığını ve görülen yüksek Ca puanlarının, temporal lob hasarı sonucu ortaya çıkan kişilik değişiklikleriyle (anksiyete, suçluluk, yetersizlik duyguları gibi) ilişkili olduğunu öne sürmüşlerdir.

Yüksek Ca Puanlarının Yorumu

Beyin hasarının yerini belirlemek için hiçbir zaman tek başına kullanılmaması gereken Ca ölçeği, diğer bulgularla birlikte ele alındığında yararlı olabilir. Yüksek Ca puanlarıyla ilişkili test dışı davranışların neler olduğunu araştıran çalışmalar yapılmamıştır. Ancak ölçekteki maddelerin içeriği incelendiğinde yüksek Ca puanı alan bir kişinin şu özellikleri taşıdığı söylenebilir:

1. kendini anksiyöz, suçlu ve depresif hisseden,
2. çok sayıda fiziksel yakınma bildiren,
3. yaşam stresiyle mücadelede yeterince güçlü olmadığını hisseden,
4. aşırı endişeli,
5. sosyal açıdan dışa dönük,
6. duygusal tepkilerini kontrol etmekte güçlük çeken,
7. düşünce süreçleri üzerindeki kontrolünü kaybetmekten korkan.

Özetle, geçerliği henüz yeterince araştırılmadığı için Ca ölçeğinin öncelikle bir araştırma aracı olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak, diğer klinik bulgularla birlikte kullanıldığında yüksek puanlar, kortikal hasarın pariyetal lobta lokalize olduğunu gösterebilir. Yüksek Ca puanı alan pariyetal hasarlı kişilerde, klinik gözlemler sırasında da dikkati çeken, duygusal ve kognitif kontrol sorunları olabilir.

Düşük Ca Puanlarının Yorumu

Beyin hasarının belli bir bölgede toplandığı nörolojik bulgularla birlikte olduğunda, düşük Ca puanları sorunun frontal lobla ilişkili olabileceğini gösterir. Düşük Ca puanlarıyla ilişkili test dışı davranışları araştıran çalışmalar olmamasına rağmen, ölçekteki maddelerin içeriği incelendiğinde düşük Ca puanı alan bir kişinin şu özellikleri taşıdığı söylenebilir:

1. anksiyeteyi, sorunları ve rahatsızlığı inkar eden,
2. bedensel yakınmaları ve rahatsızlığı olmayan,
3. sosyal ortamlarda kendini rahat ve emin bir kişi olarak gösteren,
4. duygularını ve düşünce süreçlerini kontrol edebildiğini hisseden.

Özetle, geçerliği henüz yeterince araştırılmadığı için Ca ölçeğinin öncelikle bir araştırma ölçeği olarak kabul edilmesi gerekir; diğer klinik bulgularla birlikte kullanıldığında düşük Ca puanları kortikal hasarın frontal lobda lokalize olduğunu gösterebilir.

BAĞIMLILIK ÖLÇEĞİ Dependency (Dy) Scale

Ölçeğin Gelişimi

Bağımlılık (Dy) ölçeği, Navran (1954) tarafından, bağımlılık gereksiniminin gücünü değerlendirmek için rasyonel yaklaşımla hazırlanmıştır. Ölçeği ampirik yaklaşımla hazırlama girişiminde başarılı olamayan Navran, 16 hakemden birbirlerinden bağımsız olarak ve kendi klinik deneyimlerine dayanarak bağımlılıkla ilişkili olduğunu düşündükleri MMPI maddelerini belirlemelerini istemiştir. Hakemler tarafından belirlenen 157 madde, herbiri 50 psikiyatrik hastadan oluşan iki ayrı örnekleme uygulanmış ve içsel tutarlığı araştıran yöntemlerle ayırt edici gücü en yüksek maddeler belirlenmiştir. Sonuçta, kalan 57 madde Dy ölçeğini oluşturmuştur. Dy ölçeğinin maddeleri, yanlış anlaşılma hissi, kararsızlık, kendine güvensizlik, başkalarının tepkilerine aşırı duyarlılık, bedensel yakınmalar, sosyal ortamlarda utangaçlık ve dini ilgilerle ilişkilidir.

Güvenirlilik ve Geçerlik

Navran (1954), 100 kişilik bir hasta örnekleminde 57 maddelik Dy ölçeğinin güvenirliğini (içsel tutarlılığını) 0.91 bulmuştur. Gocka (1965), 220 erkek psikiyatrik hastadan oluşan örnekleminde aynı Kuder Richardson 21 (içsel tutarlılık) değerini elde etmiştir. Button (1956), 64 alkolik hasta üzerinde, bir hafta ara ile yaptığı test-tekrar test çalışmasında güvenirlik kat sayısını 0.85 olarak saptamıştır.

Navran (1954), psikiyatrik hastaların Dy puanlarının, Hathaway ve Mc Kinley'nin standardizasyon grubundaki normallerin puanlarından; standardizasyon grubundaki normallerin puanlarının, bir grup yüksek lisans öğrencisinin puanlarından ve psikiyatrik hasta örnekleminde paranoid

olmayan şizofreniklerin puanlarının paranoid şizofreniklerin puanlarından anlamlı şekilde yüksek bulunduğunu bildirmiştir. Başka bir çalışmada Button (1965), alkolik hastaların Dy puanlarının normallerden farklı olmadığını, fakat hem alkolik hem de normal örneklemin puanlarının psikiyatrik hasta örneklemine kıyasla daha düşük olduğunu bulmuştur. Dahlstrom ve Welsh (1960), Warn tarafından yapılan bir çalışmada, tüberkülozlu ve epileptik hastaların Dy puanlarının kontrol grubunun puanlarından yüksek, felçli hastaların puanlarının ise kontrol grubunun puanlarından farklı olduğunu bildirmişlerdir. Zuckerman, Levitt ve Lubin (1961), Dy ölçeğinin maddeleri ile Gough'un "Üstünlük (Do)" ölçeğinin maddelerini birleştirmişler ve iki ölçekten elde edilen toplam puan ile kişinin kendinin ve akranlarının değerlendirdiği bağımlılık arasında anlamlı fakat düşük bir ilişki bulmuşlardır. Nelson (1959), Dy puanlarının tedavinin süresini öngörmeye yaramadığını ancak yüksek Dy puanı alan kişilerin tedaviye daha uzun süre devam etmeye eğilimli olduklarını bildirmiştir. Button (1956) kişisel bir görüşme sırasında Navran'ın, Dy ölçeğinin bağımlılığın tam bir ölçümü yerine, kişinin kendi bildirdiği bağımlılığın derecesini yansıttığı görüşünde olduğunu söylediğini bildirmiştir. Eğer Dy puanları ile davranışlar ya da başka bağımlılık belirtileri arasında tutarsızlık varsa, çelişkili duygularla ortaya çıkan bir çatışma söz konusu olabilir.

Yüksek Dy Puanlarının Yorumu

Yüksek Dy ölçeği puanları ile genel uyumsuzluk arasında bir ilişki vardır. Dy ölçeğinden yüksek puan alan bir kişinin davranışlarında güçlü bağımlılık gereksinimi belirtilerine rastlanmıyorsa, bağımlılık konusunda bir çatışma akla gelir. Ölçekteki maddelerin içeriği incelendiğinde yüksek puan alan bir kişinin şu özellikleri taşıdığı söylenebilir:

1. güçlü bağımlılık gereksinimlerini kabul eden,
2. yanlış anlaşıldığını düşünen,
3. kendini mutsuz ve üzgün hisseden,
4. bedensel rahatsızlıkları olan,
5. kendine güvenmeyen,
6. sosyal ortamlarda utandığını ve sıkıldığını hisseden,
7. başkalarının tepkilerine aşırı duyarlı,
8. geleneksel dini inançlara sahip ve dini konularda kaygıları olan.

Özetle, Dy ölçeğinden yüksek puan alan kişinin güçlü bağımlılık gereksinimleriyle ilişkili sorunları olabilir. Bunun yanı sıra mutsuzluk ve üzüntü duygularına yol açan önemli duygusal sorunlar da bulunabilir.

Düşük Dy Puanlarının Yorumu

Dy puanının düşmesi genel olarak psikolojik uyumun iyi olduğunu gösterir. Dy puanı düşük olmasına rağmen, kişinin davranışlarında bağımlılık belirtilerine rastlanıyorsa, bağımlılık gereksinimiyle ilişkili bir çatışma akla gelir. Dy ölçeğindeki maddelerin içeriği düşük puan alan bir kişinin şu özellikleri taşıyabileceğini düşündürür:

1. güçlü bağımlılık gereksinimlerini kabul etmeyen,
2. başkalarının kendisini anladığını hisseden,
3. mutlu,
4. bedensel rahatsızlığı olmayan,
5. kendine güvenen,
6. sosyal ortamlarda rahat ve güvenli,
7. başkalarının tepkilerine pek duyarlı olmayan,
8. geleneksel dini inançları olmayan ve dini konularda endişelenmeyen.

Özetle, Dy puanı düşük olan kişi bağımlılık gereksinimlerini inkar eder ve başkalarının tepkileriyle fazla ilgilenmez. Uyumlu, kendini mutlu ve güvenli hisseden bir kişidir.

ÜSTÜNLÜK ÖLÇEĞİ **Dominance (Do) Scale**

Ölçeğin Gelişimi

Üstünlük (Do) ölçeği, politik katılımı araştıran büyük bir projenin bir parçası olarak Gough, Mc Closky ve Mechl (1951) tarafından geliştirilmiştir. 60 maddelik bu ölçeğin içinde, ayrı olarak puanlanabilen ve normatif verileri bulunan 28 MMPI maddesi vardır. Kalan 32 madde, MMPI maddesi değildir. Lise ve üniversite öğrencilerine üstünlüğün bir tanımını veren araştırmacılar, deneklerden, "en üstün" ve "en az üstün" arkadaşlarının isimlerini vermelerini istemişlerdir. Yüksek ve düşük üstünlük kriter grupları böylece akranların belirlemelerine göre oluşturulmuş ve her iki gruba, içinde bazı MMPI maddelerinin de yer aldığı 150 maddelik bir soru listesi verilmiştir. Madde analizleri sonucunda 28'i MMPI maddesi olan 60 maddenin yüksek ve düşük üstünlük kriter gruplarını ayırt edebildiği görülmüştür. Ölçeğin cevap anahtarına göre puan yükseldikçe üstünlük artar. Ölçekte yer alan 28 MMPI maddesi, dikkati yoğunlaştırma, obsesif kompulsif davranışlar, kendine güven, sosyal ortamlarda rahatsızlık, fiziksel görünüş konusunda kaygılar, ısrar ve politik görüşler gibi birbirinden farklı içerik alanlarıyla ilişkilidir.

Güvenirlilik ve Geçerlilik

Gough ve ark. (1951), 60 maddelik Do ölçeğinin Kuder-Richardson 21 güvenirlik katsayısını 0.79 bulmuşlardır. Gocka (1965), 220 erkek psikiyatrik hasta üzerinde, 28 maddelik Do ölçeğinin Kuder Richardson değerini 0.60 olarak saptamıştır. Knapp (1960), orduda, deniz subaylarıyla yaptığı çalışmada, test-tekrar test kat sayısını 0.86 olarak belirlemiş, ayrıca 28 maddeden oluşan Do ölçeği puanları ile toplam 60 maddelik Do ölçeği puanları arasındaki korelasyonları 0.75 ve 0.79 bulmuştur.

Gough ve ark. (1951), 60 maddelik Do ölçeğinde, 36 ham puanı kesme noktası olarak alındığında, üstün ve üstün olmayan lise öğrencilerinin %94 oranında belirlenebildiğini bulmuşlardır. Üniversite öğrencilerinde ise, 39 ham puanının bu iki grubu % 92 oranında olarak ayırt ettiği bulunmuştur.

Knapp (1960), denizcilerle yaptığı çalışmanın sonucunda, ölçeğin, asker seçiminde iyi bir tarama aracı olabileceği yargısına varmıştır. Ancak Olmstead ve Monachesi (1965), MMPI Do ölçeğinin itfaiye erleri ile itfaiye şeflerini ayırt edemediğini bildirmişlerdir. Eshenback ve Dupree (1959), Do puanlarının durumsal strese bağlı olarak değişmediğini bulmuşlardır.

Yüksek Do Puanlarının Yorumu

Do ölçeğinden yüksek puan alan kişiler, kendileri ve başkaları tarafından, yüz yüze ilişkilerde güçlü, kolay kolay gözü korkutulamayan, güvenli ve kendinden emin insanlar olarak görülürler. Lider pozisyonundaki kişilerde yüksek Do puanlarına daha sık rastlandığını gösteren bazı bulgular olmasına rağmen Do puanlarının işlevi konusunda fikir verecek (örneğin, bu kişilerin liderlik durumunda gösterdikleri performansın yeterli olup olmadığını gösteren) araştırmalar yoktur. Yüksek Do puanı alan bir kişi şu özellikleri gösterebilir:

1. dengeli ve kendinden emin,
2. kendine güvenen,
3. dürüst ve açık davranma konusunda özgür görünen,
4. iyimser,
5. becerikli, etkili,
6. gerçekçi,
7. sorunlarla başa çıkmada kendini yeterli bulan,
8. azimli, sebatkar,
9. sorumluluk duygusu güçlü,
10. gerçekte yüzleşmek isteyen.

Özetle, yüksek Do puanı alanlar, yaşam stresleri ve sorunlarıyla başa çıkma konusunda kendi yeteneklerine güvenen kişilerdir.

Düşük Do Puanlarının Yorumu

Do ölçeğinden düşük puan alan kişiler, kendileri ve başkaları tarafından, boyun eğici, yüz yüze ilişkilerde yetersiz, çekingen, kendi görüşlerini ve haklarını savunamayan ve kolay etki altında kalan insanlar olarak görülürler. Do ölçeğindeki maddelerin içeriği incelendiğinde düşük puan alan bir kişinin şu özellikleri taşıdığı söylenebilir:

1. kendine güvenmeyen,
2. kötümser,
3. etkisiz, sorunlara basmakalıp biçimde yaklaşan,
4. sorunlarla başa çıkmakta kendini yetersiz hisseden,
5. kolay vazgeçen,
6. kendini başkalarına karşı sorumlu hissetmeyen,
7. kendi yaşamındaki gerçeklerle yüzleşmeyen.

SOSYAL SORUMLULUK ÖLÇEĞİ **Social Responsibility (Re) Scale**

Ölçeğin Gelişimi

Sosyal Sorumluluk (Re) ölçeği, Gough, McClosky ve Meehl (1952) tarafından, politik katılımı araştıran büyük bir projenin bir parçası olarak geliştirilmiştir. Orijinal Re ölçeği, 32 si MMPI madde havuzundan gelen toplam 56 maddeden oluşmuştur. 32 MMPI maddesi ve toplam 56 madde ayrı ayrı puanlanabildiği gibi 32 maddelik MMPI-Re ölçeği için ayrı normatif veriler mevcuttur. Gough ve ark., lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan büyük bir örneklemede, en çok ve en az sorumluluk sahibi kişileri ampirik bir yaklaşımla belirlemişlerdir. Bunun için önce sorumluluğun bir tanımını yapan araştırmacılar, akranların ve öğretmenlerin bu tanıma dayanarak yaptıkları değerlendirmelere göre kriter gruplarını oluşturmuşlardır. Daha sonra, en az ve en çok sorumluluk sahibi kişilerden oluşan grupların MMPI madde havuzuna ve rasyonel yaklaşımla hazırlanan bazı maddelere verdikleri yanıtları karşılaştırmışlardır. İki örneklemini birbirinden en iyi ayıran maddeler Re ölçeğini oluşturmuştur. Re ölçeğinde yer alan 32 MMPI maddesi, sosyal ve ahlaki konulara duyulan ilgi, ayrıcalık ve iltiması onaylama, görevler ve öz disiplin üzerinde durma, toplumsal kurallara isyan etme, denge, güven ve emniyetle ilişkilidir (Gough ve ark., 1952).

Güvenirlilik ve Geçerlik

Gough ve ark.(1952), lise öğrencilerinden oluşan bir örneklemede, 56 maddelik ölçeğin düzeltilmemiş yarım test güvenirlik kat sayısını 0.73 bulmuşlardır. Gocka (1965), 220 erkek psikiyatrik hastadan oluşan örnekleminde 32 maddelik Re ölçeğinin Kuder Richardson 21 (içsel tutarlılık) değerini 0.63 olarak saptamıştır. Gough ve arkadaşları üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan örneklemelerinde 32 maddelik MMPI Re ölçeğiyle, 56 maddelik Re ölçeği puanları arasında 0.84 ve 0.88'lik korelasyonlar bulmuşlardır.

MMPI Re ölçeği puanlarıyla, kriter grubundaki kişilerin arkadaşlarının yaptığı değerlendirmeler arasındaki korelasyon üniversite öğrencileri grubunda 0.47, lise öğrencileri grubunda 0.53 tür. MMPI Re puanları ile kişinin kendi değerlendirdiği sorumluluk arasındaki korelasyon lise öğrencilerinde 0.23 , üniversite öğrencilerinde 0.20 bulunmuştur.

İki çalışmada (Knapp 1960; Olmstead ve Monachesi 1956), yüksek Re puanı alan kişilerin sorumluluk ve liderlik rolü üstlenmeye eğilimli oldukları bildirilmiştir.

Duckworth ve Duckworth'a (1975) göre, 25 yaşın üstünde, yüksek Re puanları, kişinin mevcut değer sistemini benimsediğini ve bunları sürdürmeye niyetli olduğunu gösterirken, düşük Re puanları, kişinin şimdiki

değerlerini sorguladığını ya da reddettiğini gösterir. Daha genç kişilerde, yüksek Re puanları ana babanın değerlerinin kabul edildiğini, düşük puanlar ana babanın değerlerinin reddedildiğini akla getirir. Duckworth ve Duckworth ayrıca, yaşı ne olursa olsun Re puanı yüksek olan kişilerin değer yargılarının daha katı olduğunu ve bu kişilerin başkalarının değerlerini araştırma konusunda daha isteksiz olduklarını öne sürmüşlerdir. Bunların yanı sıra, yaşlıların gençlere kıyasla daha yüksek puanlar aldıklarını ve ana babalarının değerlerini sorgulayan üniversite öğrencilerinin Re puanlarının oldukça düştüğünü belirtmişlerdir.

Yüksek Re Puanlarının Yorumu

Yüksek Re puanı alanlar, kendileri ve başkaları tarafından, kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenen, güvenilir, grupla bütünleşme ve grup sorumluluğu duygusuna sahip kişiler olarak görülürler. Liderlik ve sorumluluk gerektiren pozisyonlardaki kişilerde yüksek Re puanlarına daha sık rastlanır. Yüksek puan alanlar katı değer yargıları olan ve başkalarının değerlerini anlamaya istek duymayan kişilerdir. Re puanı yüksek olan gençler ana babalarının değerlerini kabul etmeye eğilimlidirler. Bunların yanı sıra Re puanı yüksek olan bir kişi şu özellikleri gösterebilir:

1. ahlaki sorunlarla çok fazla ilgilenen,
2. güçlü bir adalet duygusu olan,
3. kendisi için yüksek standartlara sahip,
4. ayrıcalık ve iltiması reddeden,
5. kendine düşen görev ve sorumluluğu taşımaya aşırı önem veren,
6. kendine güvenen.

Özetle, yüksek Re puanı alanlar, sosyal ve kültürel değerleri içselleştirmiş ve bu değerlere uygun şekilde davranmaya kararlı kişilerdir. Ayrıca dürüstlüğü ve adalete çok önem verirler.

Düşük Re Puanlarının Yorumu

Düşük Re puanı alanlar, kendileri ve başkaları tarafından davranışlarının sorumluluğunu kabul etmek istemeyen kişiler olarak görülürler. Grup sorumluluğu ve grupla bütünleşme duygusundan yoksun, güvenilir olmayan kişilerdir. Düşük puan alanların değer yargıları yüksek puan alanlara kıyasla daha az katıdır ve başkalarının değerlerini anlama konusunda daha isteklidirler. Re puanı düşük olan gençler, ana babalarının değerlerini reddetmeye ve bunların yerine başka değerler benimsemeye eğilimlidirler. Daha yaşlılarda ise, düşük Re puanı, önceki değerlerini sorgulayan ve yeni politik ya da dini görüşleri benimseyen kişileri düşündürür.

ÖNYARGI ÖLÇEĞİ **Prejudice (Pr) Scale**

Ölçeğin Gelişimi

Önyargı (Pr) ölçeği, Gough (1951a) tarafından, Yahudilere karşı önyargısı bulunan kişileri belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Levinsohn-Stanford Yahudi Aleyhtarlığı Ölçeği 271 lise öğrencisine uygulanarak yüksek puanlı (ön yargısı fazla) ve düşük puanlı (ön yargısı az) 40 ar öğrenci belirlenmiştir. Daha sonra bu öğrencilere MMPI uygulanarak iki grubun teste verdikleri yanıtlar karşılaştırılmıştır. Düşük ve yüksek ön yargı gruplarını anlamlı şekilde ayırt eden 47 madde Pr ölçeğinde toplanmıştır. Pr ölçeğinin maddeleri, entellektüel ilgiler, kötümserliğe karşı iyimserlik, kişilerarası güven, düşmanlık ve saldırganlık, kişisel hoşnutsuzluk, kendine güven, katı düşünceler, izolasyon ve yabancılaşma duyguları gibi farklı alanlarla ilişkilidir.

Güvenirlilik ve Geçerlilik

Gocka (1965), 220 erkek psikiyatrik hasta üzerinde Pr ölçeğinin Kuder Richardson 21 (içsel tutarlılık) değerini 0.82 bulmuştur. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmalarda, Pr ölçeğinin yarı test güvenirlik kat sayıları 0.79 ve 0.81 olarak saptanmıştır. Pr ölçeğinden elde edilen puan ile başka önyargı ölçeklerinden elde edilen puanlar arasındaki korelasyonun 0.30 ile 0.62 arasında değiştiği bildirilmiştir (Gough, 1951 a; Altus & Tafajian, 1953; Jensen, 1957; Sundberg & Bachelis, 1956; Tafajian, 1951). Pr puanları cinsiyetle ilişkili görünmemektedir (Jensen 1957). Ancak yüksek puan alan kişilerin daha çok alt sosyal sınıflardan geldiğini (Gough 1951 b), IQ puanlarının daha düşük olduğunu (Gough, 1951b ; Jensen, 1957), ve akademik yaşamda daha başarısız olduğunu (Jensen, 1957) gösteren kanıtlar vardır. Bunların yanı sıra Pr puanı yüksek olan kişilerin psikolojik uyumlarının daha kötü olduğunu gösteren bulgular da vardır (Gough, 1951b; Jensen, 1957). Sundberg ve Bachelis (1956), önyargılı ve hoşgörüsüz bir kişi gibi yanıt vermeleri istenen deneklerin Pr puanlarının yükseldiğini, önyargısız ve hoşgörülü bir kişi gibi yanıt vermeleri istenen deneklerin ise Pr puanlarının düştüğünü göstermişlerdir.

Yüksek Pr Puanlarının Yorumu

Yüksek Pr puanı alan kişilerin görüş ve tutumları hoşgörüsüz ve önyargılıdır. İnançları son derece katıdır ve genellikle kendilerinininkinden farklı görüşlerin olabileceğini düşünmek bile istemezler. Yüksek puanlar, alt sosyo ekonomik sınıflardan gelen, pek zeki olmayan ve az eğitim görmüş kişiler arasında daha sık görülür. Pr puanı yüksek olan kişilerin akademik

başarıları ve psikolojik uyumları Pr puanı düşük olanlara kıyasla daha kötüdür. Bunların yanı sıra Pr puanı yüksek olan kişi şu özellikleri gösterebilir:

1. entelektüel olmayan,
2. kötümser, gelecekte umutsuz,
3. alaycı, kuşkucu, şüpheli,
4. başkalarına güvenilmeyeceğini düşünen,
5. başkaları tarafından kullanılmaktan korkan,
6. kendine saygısı olmayan,
7. başkalarının yetenek ve başarılarını karalayan,
8. düşman, buruk,
9. şimdiki durumundan hoşnut olmayan,
10. dogmatik düşünen (nedenini araştırmaksızın kesin sonuçlara varan),
11. denge ve kendine güvenden yoksun,
12. izolasyon ve yabancılaşma duygusu içinde.

Özetle, yüksek Pr puanı alan bir kişinin inançları katı ve hoşgörüsüzdür. Bunun yanı sıra aynı zamanda başka insanlara ve dünyaya karşı genel bir kuşkuculuk ve güvensizlik içindedir.

Düşük Pr Puanlarının Yorumu

Düşük Pr puanı alanlar hoşgörülü ve önyargısız kişilerdir. Esnek düşünceli, açık fikirli ve kendilerinkinden farklı görüşlerin olabileceğini kabul eden insanlardır. Düşük Pr puanları, üst sosyal sınıflardan gelen, IQ puanı yüksek ve iyi eğitim görmüş kişiler arasında daha sık görülür. Üniversite öğrencilerinin Pr puanları genellikle çok düşüktür. Düşük Pr puanı alanların akademik başarıları ve psikolojik uyumları iyidir. Bunların yanı sıra Pr puanı düşük olan kişi şu özellikleri gösterebilir:

1. entelektüel ilgileri olan,
2. iyimser,
3. diğer insanlara güvenebilen,
4. kendine güvenen, dengeli,
5. düşmanlık duyguları beslemeyen,
6. şimdiki durumundan hoşnut.

Özetle, Pr puanı düşük olanlar, açık fikirli ve kendilerinkinden farklı inanç ve tutumlara karşı hoşgörülü olabilen kişilerdir. Dünyayı olumlu algılar ve yaşamla etkin biçimde başa çıkabilirler.

SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ **Social Status (St) Scale**

Ölçeğin Gelişimi

Sosyal Durum (St) ölçeği, Gough (1948a) tarafından üst ve alt sosyo ekonomik düzeyi temsil eden lise öğrencilerinin MMPI yanıtları karşılaştırılarak geliştirilmiştir. Sosyal durum objektif bir ölçekte değerlendirilmiş ve 223 lise öğrencisinden oluşan bir örneklem içinde en yüksek ve en düşük puanları alan 38 er kişi ayrılmıştır. Madde analizleri sonucu 34 maddenin bu iki kriter grubunu ayırt edebildiği görülmüştür. Gough (1948a), St ölçeği maddelerinin beş gruba ayrılabilceğini öne sürmüştür: Edebi-estetik tutumlar; sosyal denge, güvenlik, kendine ve başkalarına güven; korku ve anksiyetelerin inkarı; ahlaki, dini ve cinsel konulara karşı serbest tutumlar ve olumlu, kesin ve kendini üstün gören düşünceler.

Güvenirlilik ve Geçerlilik

Gough (1948a), 223 öğrenciden oluşan ilk örnekleminde, St ölçeğinin düzeltilmiş yarı test güvenirlik katsayısını .74 bulmuştur. Gough, 110 kişilik daha küçük bir öğrenci örnekleminde test-tekrar test güvenirlik kat sayısını .87 olarak belirlemiştir. Gocka(1965), 220 erkek psikiyatrik hasta üzerinde St ölçeğinin Kuder Richardson 21(içsel tutarlılık) değerini .55 bulmuştur.

Gough (1949), ölçeği hazırlarken kullandığı ilk örnekleminde St puanları ile statünün objektif ölçümleri arasındaki korelasyonu .67 olarak saptamıştır. Geçerliğin araştırıldığı başka bir örnekleme ise St puanları ile sosyo ekonomik durumu değerlendiren başka bir ölçeğin puanları arasındaki korelasyon .50 bulunmuştur.

Lise öğrencileri arasında, St ölçeğinden yüksek puan alanların daha güvenli, zeka ve yetenek testlerinde daha yüksek puan alan ve akademik başarıları daha yüksek kişiler oldukları bildirilmiştir (Gough 1948b). Yüksek puan alanlar, Gough tarafından, sosyal açıdan dışa dönük, savunmacı ve geleneksel kişiler olarak tanımlanmışlardır. Bu kişilerin somatik yakınmaları daha az ve psikolojik uyumları daha iyidir.

Gough (1949) ve Duckworth ve Duckworth (1975), bazı durumlarda St ölçeği puanlarının gerçek sosyal durumdan çok istenen durumu yansıttığını ileri sürmüşlerdir. Özellikle sosyal durumun objektif kanıtları ile (gelir, eğitim gibi) St puanları arasında bir tutarsızlık varsa böyle bir olasılık söz konusu olabilir. Gough objektif sosyal durumuyla St puanları benzer ve farklı olan kişilerin özelliklerini tanımlamıştır. Yüksek sosyal statünün objektif belirtilerini gösteren ve aynı zamanda St puanı yüksek olanlar, iyi ailelerden gelen, hırslı, güvenilir ve başarı potansiyeli olan kişilerdir. Hem objektif belirtilerin hem de St puanının düşük sosyal durumu göstermesi, itaatkar, uysal, güvensiz ve motivasyonu düşük kişileri aklı getirir. St puanı objektif belirtilerin gösterdiğinden daha yüksek bir sosyal durumu gösteriyorsa daha üst sosyal sınıflara geçmek isteyen, uysal ve itaatkar olmayan

kişileri düşündürür. St puanı düşük olmasına rağmen yüksek sosyal durumun objektif belirtileri varsa uysal ve itaatkar kişiler söz konusudur.

Duckworth ve Duckworth (1975), yüksek St puanı alan kişilerin, güzel evler, eşyalar gibi yaşamdan daha iyi şeyler beklediklerini ve eğer yaptıkları iş, statü gereksinimlerini karşılamıyorsa iş doyumsuzluğundan yakındıklarını söylemişlerdir. Önemli duygusal sorunları için yardım isteyen bir kişide St puanı yükselmişse, danışma yada psikoterapi için motive olduğunu düşündürür. St puanında düşme benlik saygısında azalmayı ve kendine güvensizliği gösterebilir. Düşük puan alan kişiler daha iyi bir yaşamı hakkettiklerini düşünmelerine rağmen kendilerini geliştirmek için çalışma konusunda pek istekli görünmezler.

Yüksek St Puanlarının Yorumu

St puanı yüksek olan bir kişi şu özellikleri gösterebilir:

1. üst sosyal sınıftan ya da statü istekleri üst sosyal sınıftan gelen kişilerininkine benzeyen,
2. zeki,
3. yaşam öyküsünde üstün akademik başarı olan,
5. güvenli, sosyal açıdan dışa dönük,
6. işi statü gereksinimlerini karşılamıyorsa iş doyumsuzluğundan yakan,
7. savunmacı ve kişisel sorunları konusunda ağzı sıkı,
8. geleneksel,
9. genellikle psikolojik uyumu iyi,
10. hırslı, güvenilir,
11. danışma ya da psikoterapiye değişme konusunda motive.

Özetle, St ölçeğinden yüksek puan alan bir kişi genellikle üst sosyo ekonomik düzeyden kişilerin gereksinimlerine ve isteklerine (lüks, güç gibi) sahiptir. Alt sosyo ekonomik düzeylerden gelen kişilerde yüksek bir St puanı, içinde bulunulan sosyal durumu iyileştirme isteğini düşündürür. Yüksek St puanı alan kişilerin genellikle başarıları yüksek, sorunlar ve stresler karşısında uyumları iyidir.

Düşük St Puanlarının Yorumu

St puanı düşük olan bir kişi şu özellikleri gösterebilir:

1. alt sosyal sınıftan ya da statü istekleri alt sosyal sınıflardan gelen kişilerininkine benzeyen,
2. daha iyi bir yaşamı hakkettiğini düşünen fakat kendini geliştirmek için çalışma konusunda pek istekli olmayan,
3. motivasyonsuz,
4. kendine güvenden yoksun,
5. itaatkar, uysal, boyun eğici.

KONTROL ÖLÇEĞİ Control (Cn) Scale

Ölçeğin Gelişimi

Cuadra'ya (1953) göre, aynı ruhsal bozukluk nedeniyle yatarak tedavi edilen hastalarla ayakta tedavi gören hastalar arasındaki temel fark ikinci gruptakilerin patoloji belirtilerini daha fazla kontrol etmeleridir. İşte Cn ölçeği bu kontrol boyutunu değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Cuadra, yaş, cinsiyet, profildeki yükselmeler ve profil konfigürasyonu açısından benzeyen kişilere ait 30 çift MMPI toplamıştır. Çiftlerden birinin yatarak diğerinin ise ayakta psikiyatrik tedavi gören bir hasta olmasına dikkat etmiştir. Bu iki grup hastanın MMPI yanıtları karşılaştırıldığında 50 maddenin farklı yanıtladığı görülmüştür. Cevap anahtarı, yüksek puanlar ayakta tedavi gören hastalarınkine benzer tepkileri gösterecek şekilde düzenlenmiştir. Cn ölçeğindeki maddelerin içeriği, kendi güçsüzlüklerinin farkında olma, sosyal eleştirilere duyarlılık, dini inançlar, heyecanlı ve tehlikeli aktivitelere katılmayla ilişkilidir.

Cuadra (1953), kendi kriter gruplarının Cn ölçeği puanlarının anlamlı biçimde farklı olduğunu, ayakta tedavi gören hastaların daha yüksek puanlar aldıklarını bildirmiştir. Ancak bunun dışında herhangi bir geçerlik çalışmasından söz etmemiştir. Cn ölçeği ile L ve K ölçekleri arasında olumsuz, F ölçeği arasında olumsuz bir ilişkinin bulunması, Cuadra'nın Cn ölçeğinin kendini gerçekçi değerlendirmeye ilişkin olduğu sonucuna varmasına neden olmuştur.

Güvenirlilik ve Geçerlik

Gocka (1965), 220 erkek psikiyatrik hasta üzerinde Cn ölçeğinin Kuder Richardson 21 (içsel tutarlılık) değerini .58 bulmuştur. Cn ölçeğinin güvenilirlik ve geçerliğini araştıran başka bir çalışma bildirilmemiştir.

Yüksek Cn Puanlarının Yorumu

Önemli ruhsal sorunları olan kişiler arasında yüksek Cn puanı alanlar, düşük Cn puanı alanlara kıyasla problem davranışlarını başkalarına pek göstermeyen ve hastanede yatmadan da sorunlarla başa çıkabilen kişilerdir. Duckworth ve Duckworth (1975), Cn ölçeğinin, MMPI'nin klinik ölçekleriyle birlikte yorumlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Klinik ölçekleri çok yüksek olan kişilerde yüksek bir Cn puanı problemleri kontrol edebilme yeteneğini ve başkalarına sadece kendi istediği kadarını göstermeyi düşündürür. Yüksek Cn puanı klinik ölçekler yükselmeden görülürse ağzı sıkı ve heyecansız bir kişiyi akla getirir. Böyle kişiler duygularını daha fazla gösterilmeyi istediklerini ifade edebilirler. Cn puanı yüksek olan bir kişi ayrıca şu özellikleri gösterebilir:

1. başkaları tarafından sofistike ve gerçekçi kişiler olarak tanımlanan,

2. saf, tutucu ve inatçı kişilere tahammül edemeyen,
3. kendi güçsüzlüklerinin farkında olan,
4. sosyal eleştirilere karşı duyarlı,
5. geleneksel dini inançları kabul etmeyen,
6. otoriteye karşı isyankar,
7. sosyal açıdan kabul görmeme tehlikesi olsa bile çevreyi inceleyen.

Özetle, Cn ölçeğinden yüksek puan alan bir kişi sorunlarını başkalarına açıklamak yerine kendi içinde saklamayı tercih eder. Bu eğilim aynı zamanda kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu kabul etmesini güçleştirebilir.

Düşük Cn Puanlarının Yorumu

Önemli ruhsal sorunları olan kişilerde Cn puanının düşük olması kişinin problemleri davranışlarını kontrol edemediğini ve yatarak tedavi görmeye ihtiyacı olabileceğini düşündürür. Duckworth ve Duckworth (1975) klinik ölçekleri fazla yükselmeyen bir kişide Cn puanı düşükse önemli bir ruhsal bozukluğun bulunmayabileceğini söylemişlerdir. Cn puanı düşük olan bir kişi ayrıca şu özellikleri gösterebilir:

1. geleneksel,
2. tutucu,
3. çevreyi fazla inceleyip araştırmayan,
4. geleneksel dini inançlara sahip,
5. kendini gerçekçi bir biçimde değerlendiremeyen.

SON BİR UYARI

Okuyucular bu bölümde anlatılan ölçeklerin araştırma ölçekleri olduklarını unutmamalıdır. Çoğunun güvenilirlik ve geçerliğini henüz bilinmemektedir. Bu ölçeklerin gerçekten neyi ölçtüklerini ortaya çıkaracak çalışmalara ihtiyacımız vardır. Öncelikle bu çalışmaları teşvik etme amacıyla bu bölümde gözden geçirilmişlerdir. Eğer klinik yorum amacıyla kullanılabırlarsa, bu ölçeklerden elde edilen çıkarımların mutlaka diğer test verileri ve klinik bulgularla birlikte değerlendirilmesi gerekir.

VII

GENEL BİR YORUMLAMA YAKLAŞIMI

Paul Meehl, 1956 yılında, psikolojik testleri yorumlamak için iyi bir "yemek kitabı" (cook book) hazırlamayı önermiştir. Meehl'in önerdiği yemek kitabı, test yanıtlarını sınıflandırmaya yarayan ayrıntılı kuralları ve her bir yanıt tipine karşılık gelen davranışsal özellikleri içermektedir. Kurallar, profesyonel olmayan kişiler veya bilgisayar tarafından otomatik olarak uygulanarak, çok sayıdaki ifadenin içinden, belirli bir profil tipine uygun olanlar seçilebilecekti.

Böyle bir yemek kitabının hazırlanması için hayli çaba gösterilmesi-ne rağmen (Gilberstadt & Duker, 1965; Marks & Seeman, 1963; Marks ve ark., 1974), günümüzde, test yorumlama işi Meehl'in önerdiği gibi otomatik bir süreç olarak kabul edilmemektedir. MMPI da dahil olmak üzere, tüm testler, bize, uygulama yapılan kişinin o anki davranışlarını standart koşullar altında gözleme imkanı sağlar. Daha sonra test sırasındaki davranışlara dayanılarak kişinin test dışı davranışları tahmin edilir. Klinisyen, değerlendirme işlemi sırasında hem bir bilgi işleyici hem de bir hakem görevi görür. Bu bölümün temel amacı, uygulayıcılara MMPI profillerini anlamlı çıkarımlara dönüştürebilmeleri için bir yaklaşım örneği sunmaktır.

MMPI testiyle, incelenen kişi hakkında yalnızca bazı varsayımlar ya da tahminler üretilebileceği unutulmamalıdır. Bu kitapta belirtilen yorumların, MMPI profilleri benzer olsa da herkese aynı ölçüde uyması beklenmemelidir. MMPI testini yorumlarken klinisyen olasılıkları değerlendirir. Uygulayıcı MMPI profilini ele aldığı anda, bazı özelliklerin o kişi için daha uygun olduğunu görebilir, ancak, bu daha uygun özelliklerin bile gerçekten kişide bulunup bulunmadığından emin olamaz. MMPI profiline dayanan çıkarımların geçerli olup olmadığı, kişiye uygulanan diğer testlerden ve test dışı kaynaklardan sağlanan bilgilere dayanılarak araştırılır. MMPI testi, görüşme, gözlem ve diğer psikolojik test verileri ile birlikte kullanıldığında son derece değerli bir inceleme aracıdır. Kompüterize MMPI yorumlarında olduğu gibi, bu tür bilgilerden yararlanmaksızın envanterin kör yorumu da mümkündür. Ancak bu tür yorumlarda yalnızca bazı genel hipotezler ileri sürülebilir; kişiye özgü daha doğru çıkarımlar için, testin, mutlaka diğer bilgi kaynaklarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bu konunun önemi Kostlan (1954) ve Sines (1959)'in araştırma bulgularıyla da desteklenmiştir.

MMPI verilerine dayanarak iki tür yorum yapılabilir. Birinci tür yorumlar, incelenen kişinin, benzer bir durumda bulunan (örneğin, hastane ya da klinikte tedavi gören) başka insanlardan açıkça farklı olan özelliklerini içerir. Örneğin hastanede yatarak tedavi gören bir hastanın MMPI profiline dayanılarak ciddi intihar riski taşıdığı söylenebilir. Aynı özel koşullar içinde bulunan hastaların bir çoğu böyle bir risk taşımadığı için, bu yorumla kişi diğerlerinden ayrılmış olur. İkinci tür yorumlar, benzer durumdaki insanların büyük bir kısmında görülen ortak özellikleri içerir. Örneğin, psikiyatrik bir hastanın MMPI profiline bakarak, stresle etkin bir biçimde başa çıkamadığını söylediğimizde, yaptığımız yorum büyük bir olasılıkla yalnız o kişi için değil, aynı zamanda birçok psikiyatrik hasta için de doğru olur. Her ne kadar, ayırt edici ve yalnızca o kişiye özgü yorumlar daha genel olanlara kıyasla daha yararlı olsa da, ikinci tip yorumlar da klinisyenlerin ve tedavi sürecine katılan diğer kişilerin vakayı daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Meehl, değerlendirme işlemini, test performansı ile doğrudan ve ampirik açıdan ilişkisi olduğu saptanmış test dışı davranışlarla sınırlandırmayı düşünmüştür. Ancak günümüzde, test performansı ile ilişkili olduğu saptanmış test dışı davranışların sayıca fazla olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, değerlendirme sırasında, incelenen vakanın kişilik yapısından hareket edilerek bazı tahminler yapılır. Örneğin, ilerde ortaya çıkması muhtemel bir intihar girişimini gösteren özel bir MMPI bulgusu yoktur. Ancak MMPI testinden kişinin son derece depresif, heyecanlı, duygusal açıdan huzursuz, dürtüleriyle hareket eden ve yargı hataları yapan bir kişi olduğu çıkarıldığında, bu kişinin intihar girişiminde bulunma olasılığının daha mantıklı bir hastaya kıyasla daha yüksek olduğu söylenebilir.

GENEL BİR YAKLAŞIM

Kitabın yazarı, kendi klinik çalışmalarında, MMPI profilini yorumlarken aşağıdaki sorulara yanıt arar:

1. Kişinin test alma tutumu nedir? Bu tutum tüm profili nasıl etkilemiştir?
2. Kişinin genel uyumu ne düzeydedir?
3. Kişiden ne tür davranışlar (semptomlar, tutumlar, savunmalar gibi) beklenebilir?
4. Yukarıda tanımlanan davranışların altında yatan psikolojik dinamikler veya etiyoloji nedir?
5. Kişi için en uygun tanımlar neler olabilir?
6. Tedavi sırasında kişiden ne tür tutum ve davranışlar beklenebilir?

Test Alma Tutumu

İdeal denek, MMPI'ı yanıtlama işine ciddi ve işbirlikçi bir tavırla yaklaşan kişidir. Her maddeyi okur ve içtenlikle yanıtlar. Bu ideal durum

gerçekleştğinde uygulayıcı test yanıtlarının kişinin gerçek davranışlarını temsil ettiğinden emin olur ve profili yorumlamaya devam eder. Fakat III. bölümde belirtilen nedenlerden dolayı, bazen bu ideal durumdan sapmalar olabilir. Test alma tutumunun belirlenmesi, MMPI testine dayanılarak yapılan çıkarımları etkilediği için önemlidir. Ayrıca bu tutumlar, kişinin test dışındaki ortamlarda da benzer yaklaşımlar gösterebileceğini düşündürür. Vakanın test sırasında sergilediği davranışların nitel yönleri, nicel gösterge ve puanlara dayanan yorumları zenginleştirir. Bu tür faktörlerden biri test süresidir. II. Bölümde belirtildiği gibi tipik bir vaka testi 1 - 1.5 saat arasında tamamlar. Testi tamamlamak için, aşırı uzun zaman harcama, kararsızlık, psikomotor yavaşlama, şaşkınlık veya test işlemine karşı pasif direnç göstergesi olabilir. Testin son derece kısa bir zaman içerisinde tamamlanması, kişinin maddeleri dürtüsel bir şekilde yanıtladığını ya da maddeleri tek tek okuyup düşünmediğini akla getirir. Bazen uygulama sırasında kişilerin çok gerginleştiği, şıkıldığı ya da heyecanlandığı görülür. Bu davranışlara bakılarak, kişinin stres verici ortamlarda benzer tepkiler göstereceği söylenebilir. Obsesif düşünce yapısına sahip ya da kararsız bazı denekler, cevap kağıdında yanıtların yanına açıklamalar yazarlar. Kitabın yazarı, kutu formunun kartlarını yemeye çalışan bir vakaya bile rastlamıştır. Kuşkusuz bu tür davranışlar, tanısıl değerlendirme açısından çok önemlidir.

Yukarıda tartışılan özellikler, kişi hakkında bazı bilgiler verse de test alma tutumuna ilişkin en önemli objektif bilgi kaynaklarımız, dört geçerlik göstergesidir (? , L, F ve K).

(?) Bilmiyorum ölçeği, yanıtlanmayan maddelerin sayısını gösterir. Boş bırakılan madde sayısının çok fazla olması kararsızlığı, ambivalansı ya da kişinin olumsuz yönlerini kabul etmekte kaçtığını fakat yalan söyleme yoluna da başvurmadığını gösterir. L ölçeği aracılığıyla test alma tutumu değerlendirilirken kişinin sosyo-ekonomik düzeyi ve eğitimi göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer L ölçeği kişinin eğitim ya da sosyo-ekonomik düzeyine göre beklenenden yüksek ise, iyi bir izlenim bırakma çabasıyla, tüm sorunların ve hataların safca inkar edildiğini düşündürür. F ölçeği puanları, vakanın yanıtlarının standardizasyon grubunun yanıtlarından ne ölçüde farklı olduğunu gösterir. F ölçeği puanları yükseldikçe sapma da fazlalaşır. Ortalamanın çok üstündeki puanlar, kişinin açıkça normalden sapmış pek çok davranış ve tutumu kabul ettiğini düşündürür. Ancak bu durum farklı nedenlerden kaynaklanabilir (III. Bölümüne bakınız). Olasılıklardan biri, hastanın MMPI testini ciddi duygusal sorunlarına yardım istemek için bir araç olarak kullanmasıdır. Bir başka olasılık, kişinin sağlıklı olmasına rağmen testi bir çeşit kendini eleştirme aracı olarak kullanmasıdır. F puanları ortalamasının epey altında ise, kişinin kabul ettiği sapmış davranış ve tutumlar ortalamaya kıyasla çok azdır. Bu durumda aşırı savunmacı olduğu ve kendini çok olumlu bir şekilde tanıtmaya çalıştığı düşünülmelidir. F ölçeği puanları ortalama düzeyde ise, kişi kendini ne aşırı eleştiriyordu ne de savunmacı bir tutumla olumsuz yönlerinin hepsini inkar etmeye çalışıyordu. K ölçeği vakanın eğitimi ve sosyo-ekonomik düzeyi göz önünde bulundurul-

duğunda, savunmacılığı gösteren bir başka ölçektir. Eğer K puanı, kişinin eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyine göre beklenenden daha yüksekse, teste kendini hayli savunmacı bir biçimde tanımlamış olabileceği akla gelir. Eğitim ve sosyo-ekonomik düzeye göre beklenenden düşük puanlar, savunmacı tutumun bulunmadığını ve kişinin kendine karşı aşırı eleştirici olduğunu gösterir. K ölçeği puanları ortalama düzeyde ise, kişi maddeleri yanıtlarken ne aşırı savunmacı davranmış ne de kendini çok fazla eleştirmiştir.

III. Bölümde tartışıldığı gibi, geçerlik ölçeklerinin konfigürasyonu kişinin test alma tutumunu anlamamıza yardımcı olur. Genel olarak, teste kendini çok iyi ve olumlu gösterme amacıyla yaklaşan kişilerin, L ve K puanları yükselerek geçerlik ölçekleri "V" şeklini alır. Öte yandan testi kendini eleştirmek ya da sorunlarını abartmak amacıyla kullanan kişilerde geçerlik ölçekleri ters "V" şeklindedir (örneğin, L ve K ölçekleri puanları F puanına kıyasla anlamlı biçimde düşüktür). Klinisyen klinik ölçekleri değerlendirirken, geçerlik profilini göz önünde bulundurarak yaptığı yorumları ayarlamalıdır.

Uyum Düzeyi

Psikolojik uyum düzeyinin iki önemli ögesi vardır. Birincisi bireyin duygusal olarak ne ölçüde huzurlu ya da huzursuz olduğudur. İkincisi ise, kişinin çatışmalarına rağmen kendi yaşamına ilişkin sorumluluklarını ne ölçüde iyi yerine getirebildiğidir. İnsanların çoğunda bu iki öge birbiriyle yakından ilişkilidir. Psikolojik açıdan rahat olan kişiler genelde iyi işlev görürler. Ancak bazı kişiler (örneğin bazı nevrotikler) çok büyük bir ruhsal gerilim içinde olmalarına rağmen oldukça yeterli bir şekilde işlevlerini sürdürebilirler. Bazıları da (örneğin kronik şizofrenikler) günlük yaşam sorumluluklarını yerine getirememelerine rağmen duygusal açıdan rahat olabilirler. Klinik deneyimler ve bazı araştırma bulguları MMPI testinin uyum düzeyinin her iki ögesi hakkında da bilgi verebileceğini göstermektedir. F ölçeği, tek başına psikopatolojinin derecesini yansıtan en iyi gösterge olarak kabul edilebilir. F ölçeğindeki yükselme, maddeleri gelişigüzel işaretleme gibi sapmış bir yanıtlama tarzından kaynaklanmıyorsa, yoğun bir duygusal karmaşayı ve işlevlerde ciddi bozukluğu akla getirir. Örneğin akut psikotik bir bozukluk içindeki kişiler yüksek F puanı alma eğilimindedirler. Bazı nevrotikler ve önemli bir yaşam stresi ile karşı karşıya olan kişiler de F ölçeğinden yüksek puan alırlar. Öte yandan, ruhsal sorunları uzun zamandan beri devam eden açıkça psikotik (ya da nevrotik) bazı kişilerin F ölçeği puanları fazla yüksek değildir. Başka bir basit fakat anlamlı uyum göstergesi, klinik ölçeklerin genel yükselme düzeyidir. Genelde, yükselen klinik ölçek sayısı (ve yükselmelerin düzeyi) arttıkça ciddi psikopatoloji ve işlevlerde bozulma olasılığı artar. Bazı uygulayıcılar, psikopatolojinin derecesini yansıtan kantitatif bir gösterge elde etmek amacıyla, sekiz klinik ölçeğin (5 ve 0 dışındaki) T puanı ortalamasını alırlar. Bazıları ise, basitçe T puanı 70'in üzerine çıkan klinik ölçeklerin sayısına bakar. Her iki yolla da psikopatolojinin ağırlığı konusunda bir fikir elde etmek mümkündür. Bunların

yanısıra profilin eğimi de kişinin uyum düzeyi hakkında bilgi verir. Eğer klinik ölçekler yükselmiş ve pozitif bir eğim (sol taraf düşük, sağ taraf yüksek) ortaya çıkmışsa, daha çok ciddi bir psikopatoloji hatta psikotik bir bozukluk düşünülmelidir. Negatif bir eğim ise (sol taraf yüksek, sağ taraf düşük) daha çok nevrotik özellikleri ya da içsel çatışmalara rağmen oldukça iyi bir şekilde işlevlerini sürdürebilen bir kişiyi gösterir. 2. Ölçek (Depresyon), kişinin yaşam doyumunun bir göstergesidir. Bu ölçekten alınan puan yüksek ise, kişinin yaşamından hoşnut olmadığı düşünülür. 7. Ölçek (Psikasteni) ise, anksiyete ve ajitasyon duygularını belki de en iyi değerlendiren ölçektir. Bu ölçekteki yükselme, yüksek anksiyeteyi korkuları ve artan gerilimi gösterir. Goldberg (1965) psikotik ve nevrotik hastaların MMPI profillerini ayırt etmek için regresyon analizinden yararlanmışır. Tanısal değerinin yanısıra, Goldberg'in göstergesi uyum düzeyi hakkında da bilgi verir (yüksek değerler uyumun daha fazla bozulduğunu belirtir). Goldberg'in göstergesi, T puanı değerleri basitçe şu formüle yerleştirilerek hesaplanır: $L + Pa + Sc - Hy - Pt$ Goldberg kendi çalışma grubunda 45 kesme puanının psikotik ve nevrotikleri birbirinden ayırt ettiğini bulmuştur. Grayson (1951), özel klinik sorunlarla ilişkili 38 MMPI maddesine verilen yanıtları incelemeyi önermiştir. Bu maddeler açık psikotik davranışların yanısıra cinsel sapma, aşırı alkol kullanımı, başkasını ve kendini öldürme dürtüleri ile ilişkilidir. Bu kritik maddeler Ek B'de sunulmuştur.

Tipik Özellikler ve Davranışlar

Yorumlama sürecinin bu aşamasında amaç, vakanın semptomlarını, özelliklerini, davranışlarını, tutumlarını ve savunmalarını ayrıntılarıyla tanımlayarak kişiyi tümüyle anlamaya çalışmaktır. Kitabın yazarı, her protokolda mümkün olmasa da aşağıda belirtilen alanların tümü için bazı tahminlerde bulunmaya çalışır.

1. Semptomlar,
2. Temel gereksinimler (örneğin, bağımsızlık, başarı, otonomi gibi),
3. Çevrenin algılanış biçimi, özellikle kişinin yaşamında önemli bir yeri olan kişilerin algılanışı,
4. Strese gösterilen tepkiler (başa çıkma mekanizmaları, savunmalar gibi),
5. Benlik kavramı,
6. Cinsel idantifikasyon,
7. Duygusal kontrol,
8. Kişilerarası ilişkiler,
9. Psikolojik kaynaklar.

Yukarıdaki özelliklere ilişkin çıkarımlar öncelikle bireysel geçerlik ve klinik ölçeklere (yüksek ya da düşük puanlar) ve klinik ölçeklerdeki ikili yükselmelere dayanır (III. IV. ve V. Bölümlere bakınız). Yorumu yeni başlayanlar, profildeki tüm yüksek ya da düşük ölçekleri ve profilin konfigürasyonunu belirledikten sonra, daha önceki bölümlere bakarak, her

ölçeğe karşılık gelen varsayım ya da tahminleri alt alta yazabilirler. Sıralanan çok sayıdaki yorum içinden tekrarlananlara ve kişi hakkında, test dışı yollardan ve diğer psikolojik testlerden toplanan bilgilerle tutarlı olanlara daha fazla güvenilmelidir. Daha sonra tahminler yukarıda belirtildiği gibi ya da uygulayıcının kendi gereksinimlerine uygun biçimde sınıflandırılabilir. Bu bölümün başında belirtildiği gibi, kişi hakkında yapılan çıkarımların bir kısmı ölçeklerle doğrudan bağlantılı değildir. Bunlar, kişiyi iyice anladıktan sonra yapılabilen daha ileri tahminlerdir. Örneğin, kişinin iyi bir emlak satıcısı olup olmayacağını tahmin etmeye yarayan özel bir MMPI ölçeği yoktur. Ancak MMPI alan kişinin başarı gereksinimi yüksek, yarışmacı ve iyi izlenim bırakan biri olduğunu çıkardığımızda başarılı bir satıcı olacağını tahmin edebiliriz.

Dinamikler ve Etiyoloji

Bir kişilik değerlendirmesi sırasında çoğunlukla, kişinin yalnız davranışlarının bir tanımı değil, bu davranışların altında yatan dinamiklerin ya da özel bir sorunun etiyojisinin açıklanması beklenir. Önceki bölümlerde, bazı MMPI ölçekleri ve ölçek konfigürasyonları için, davranışların altında yatan faktörlere ilişkin yorumlar sunulmuştur. Bunlara ek olarak, dinamikler hakkında daha ileri tahminler yapmak da mümkündür. Örneğin, bir uygulayıcı MMPI profilinden, kişinin incinmekten ya da zarar görmekten korktuğu için ilişki kurmaktan çekindiğini çıkardığında, bu kişinin büyük bir olasılıkla, daha önceki duygusal ilişkilerinde incinmiş olduğunu tahmin edebilir. Ya da klinisyen, MMPI profilinde otorite figürlerine karşı güçlü kızgınlık duygularına rastladığında, bu kızgınlığın ebeveyn-çocuk ilişkisinden kaynaklanmış olabileceğini çıkarır. Daha ileri çıkarımlar, sıklıkla MMPI verilerinin yanısıra diğer testlerden ve test dışı kaynaklardan (görüşme, vaka öyküsü gibi) elde edilen verilere dayanır.

Tanısal İzlenimler

Psikiyatrik tanının yaranı pek çok klinisyen tarafından sorgulanmakla birlikte, test için vaka yollayanlar genellikle tanı hakkında bilgi isterler. Ayrıca tanısal değerlendirme, sıklıkla kişinin yeterliğini ya da yetersizliğini kanıtlama gibi bir amaca hizmet edebilir. Önceki bölümlerde, her bir klinik ölçek ve ikili yükselme için tanısal bilgi sunulmuştur. Bunların yanısıra MMPI profilinin eğiminden yararlanılabilir. Alçalan bir profil (sol taraf yüksek, sağ taraf düşük) nevrotik bir bozukluğu, yükselen bir profil (sol taraf düşük, sağ taraf yüksek) ise psikotik bir bozukluğu düşündürür. Kuşkusuz, diğer alanlarda olduğu gibi tanı konusunda bir sonuca ulaşmadan önce, diğer veriler (öykü, gözlem gibi) göz önünde bulundurulmalıdır.

Tedavi Konusunda Öneriler

Çoğu değerlendirmenin birincil amacı, tedavi konusunda anlamlı önerilerde bulunabilmektir. Tedavi istekleri, mevcut kaynakların karşılayabileceğinden fazla olduğunda, seçim yapma zorunlu hale gelir. Seçimde,

kişinin tedaviye duyduğu gereksinim kadar, göstereceği tepkiler de etkili olur. Farklı psikoterapi yöntemleri uygulanabiliyorsa, değerlendirmeye, kişiye en uygun yöntemi seçme konusunda da yardımcı olabilir. Hatta, tedaviye değerlendirmeden önce karar verilmiş olsa bile, değerlendirme terapi sırasında ortaya çıkması olası sorunlar hakkında bilgi verdiği ve terapisti ilerlemeyi kolaylaştıran ya da güçleştiren özellikler konusunda uyardığı için değerli olabilir.

MMPI bulgularından elde edilen çıkarımlardan hareket ederek tedavi konusunda bazı tahminlerde bulunmak mümkündür. Örneğin, profilden, kişinin büyük bir duygusal karmaşa içinde bulunduğu çıkarıldığında, buradan hareket edilerek hastanın değişme konusunda yeterince istekli olacağı söylenebilir. Öte yandan, eğer kişinin, davranışlarının sorumluluğunu üstlenmek istemediği ve kendi hataları için başkalarını suçladığı çıkarılmışsa, geleneksel psikoterapilerde prognozun kötü olacağı düşünüldür. Telkine çok yatkın bir kişinin ise yol gösterici terapilere, içgörü yönelimli yöntemlere kıyasla daha iyi yanıt vereceği açıktır. Tedaviyi hapse girmemek için kabul eden psikopatik bir hasta (4. ve 9. ölçekleri yükselmiş) büyük bir olasılıkla tedaviyi kısa zamanda bırakacaktır. Bu örneklerde görüldüğü gibi testten çıkarılan sonuçlara dayanılarak daha ileri çıkarımlar yapılabilir.

BAZI ÖZEL BAŞVURU SORULARI

MMPI testini yorumlarken sıklıkla, değerlendirmeyi isteyen kişinin özel bazı sorularına (örneğin, "hasta intihara eğilimli mi?", "başkaları için tehlikeli olabilir mi?" gibi) cevap vermek gerekir. Bu bölümde test isteyen kişilerin sorduğu tüm sorulara ve bunların karşılıklarına değinmek mümkün olmadığı için yalnızca en sık karşılaşılan sorular gözden geçirilmiştir.

İntihar

Uygulayıcı, sık sık MMPI'a dayanarak intihar eğilimini öngörmek gibi zor bir durumla karşılaşır. Psikiyatrik ortamdaki hastaların bir kısmı intihar düşüncelerini kabul ederler. Ancak bunların içinden yalnızca çok küçük bir bölümü gerçekten intihar girişiminde bulunur.

İntihar düşüncesi genellikle ciddi depresyonla ilişkilidir. Bu nedenle intihar düşüncesi taşıyan kişilerin MMPI profilinde 2. Ölçek hemen her zaman çok fazla yükselir. Profilde en yüksek ikinci ölçek olan 7, anksiyeteyi, ajitasyonu ve derin düşüncelere dalmayı akla getirir. İntihar düşüncesi taşıyan kişilerde en sık görülen MMPI ikili kodu 27/72 olmuştur.

Kuşkusuz 2. ve 7. ölçekleri yükselen kişilerin hepsi intihar girişiminde bulunmaz. Gerçekten intihara kalkışan kişiler, yalnızca onu düşünenlere kıyasla daha impulsif, eylemi düşünmeye tercih eden, yargılamada yetersizlik gösteren kişilerdir. Bu özellikler, genellikle, 4, 8 ve 9. ölçeklerde yükselmeler şeklinde teste yansır. Genel olarak, 9. ölçeğin puanlarının intiharı düşünen bireyleri belirlemede büyük önem taşıdığı kabul edilir. Eğer bir kişi, 2.ve 7. ölçeklerde görülen yükselmelerin düşündüğü gibi

depresif ve son derece huzursuz ise, intihara eğilimli olabilir. Ancak 9. Ölçek düşük ise, kişi bu düşüncesini gerçekleştirmek için yeterli enerjiye sahip olmayabilir. Buna karşılık 9. ölçek yükselirse, kişinin intihar düşüncesini gerçekleştirme olasılığı artar. 4. ve 8. Ölçeklerin yükselmesi impulsif ve yargı hataları yapan bir kişiyi düşündürür. Böyle bir kişi aynı zamanda depresif ise (2 ve 7'de yükselme varsa) intihar olasılığı gene yükselir. Ciddi bir depresyonu olan kişilerin, daha çok, depresyon açıkça ortaya çıktığında intihara teşebbüs ettiklerini gösteren bazı klinik bulgular vardır. Eğer elimizde, farklı zamanlarda uygulanmış MMPI sonuçları varsa, ciddi biçimde depresif olan bir hastanın 2. ölçeğinde, önceye kıyasla görülen önemli yükselme, klinisyeni intihar olasılığına karşı uyarmalıdır. Böyle bir olasılıktan söz etmeden önce, kuşkusuz kişinin bu konuda neler söylediği, daha önce intihar girişiminin olup olmadığı, içinde bulunduğu ailesel ya da mesleki baskılar ve diğer durumsal değişkenlerde dikkate alınmalıdır.

Acting-out (eyleme geçme) Davranışı

Yorumlayıcının öngörmesi istenen bir başka önemli konu, acting-out davranışıdır. Sözel düşmanlıktan fiziksel saldırıya kadar geniş bir dağılımda ele alınan acting-out davranışlarından, başkalarına zarar verenleri tahmin edebilmek daha önemlidir. Agresif acting-out davranışları yorumlanırken, iki farklı grup insanı birbirinden ayırmak, önemlidir. Birinci grup, kronik biçimde düşman ve saldırgan olan ve bu dürtülerini davranışlarına yansıttıkları için başları hep deritte olan kişilerdir. İkinci gruptakiler ise, genellikle aşırı kontrollü olmalarına rağmen zaman zaman tehlikeli ve yıkıcı çıkışlar yapan kişilerdir. Bu son gruptakiler, zararlı ve yıkıcı eylemlere (fiziksel saldırı, cinayet gibi) birinci gruptaki kişilere kıyasla daha eğilimlidirler.

MMPI klinik ölçekleri iki gruba ayrılabilir: Dürtülerin denetlenemediğini düşündüren ölçekler (4, 6, 8 ve 9) ile, dürtülerin bastırıldığını ve kontrol altında tutulduğunu düşündüren ölçekler (1, 2, 3, 5, 7 ve 0). İlk gruptaki ölçekler, ikinci gruptakilere kıyasla daha yüksekse, kişide dürtü denetimine ilişkin sorunların ve süregen acting-out davranışlarının bulunduğu söylenebilir. İkinci grup ölçekler daha yüksek ise, dürtü denetiminin yeterli olduğu sonucuna varılabilir.

MMPI literatüründe 4 ve/veya 9. ölçeklerdeki yükselmenin dürtü denetimindeki güçlükleri yansıttığı belirtilmiştir. Bu yükselmeler asosyal ya da antisosyal eğilimleri düşündürür. 49/94 ikili kodu impulsiviteyi ve anında doyum sağlama isteğini gösterirse de, bu kişilerin mutlaka başkalarına fiziksel zarar vereceği anlamına gelmez. İlk yayınlarda, 48/84 ikili kodunun, cinsel saldırıyı ve/veya öldürmeyi içeren plansız, anlamı olmayan, vahşi acting-out davranışını düşündürdüğü belirtilmiştir. Son yıllarda ise, 43 kodunun şiddet ve saldırı davranışıyla ilişkili olduğundan söz edilmektedir. (Davis ve Sines 1971; Persons ve Marks 1971). 43 kodunu alan kişiler genellikle aşırı kontrollü davranışlarına rağmen zaman zaman saldırgan patlamalar sergileyebilirler. 4 ve 3 birlikte yükseldiğinde, saldırgan patlama

dönemlerinin ortaya çıkma olasılığı artar. Bu iki ölçekten hangisinin daha yüksek olduğu dürtü denetimi konusunda bilgi verir. Eğer 4. ölçek 3. ölçekten daha yüksekse dürtü denetimine ilişkin sorunların olduğu düşünülmelidir. Buna karşılık, 3. ölçek, 4. ölçekten daha yüksekse yeterli düzeyde denetim ve bastırma var demektir (Dahlstrom ve ark., 1975). Ayrıca saldırgan acting-out davranışlarını değerlendirmek amacıyla pek çok ilave MMPI ölçeği geliştirilmiştir (Bakanız "An MMPI Handbook" cilt 2, Bölüm 3, Dahlstrom ve ark., 1975).

Psikoz

Çoğu kez, değerlendirme işleminin en önemli amacı psikotik bireyleri belirleyebilmektir. Tanıya önem vermeyen klinisyenler olmasına rağmen, pek çok kurumda tanısal değerlendirme rutin olarak uygulanır ve kişi hakkında verilen önemli kararlar (örneğin, ilaç ve tedavinin şekli) bu değerlendirmenin sonucuna dayanır. Başlangıçta, Hathaway ve McKinley, profilin en yüksek ölçeğine bakılarak, doğru tanısal sınıflama yapılabileceğini düşünmüşlerdir. Böylece, örneğin 8, en yüksek klinik ölçek ise deneye şizofreni tanısı konabilecekti. Ancak I. Bölümde de tartışıldığı gibi, tanısal değerlendirmeyi aşırı basitleştiren bu beklenti gerçekleşmemiştir. Buna rağmen, 8. ölçeğin puanlarının psikotik bozukluklarla ilişkili olduğu görülmüştür. Eğer 8. ölçekten elde edilen puan çok yüksek ise ($T > 80$) ve uygunlayıcı bunun sapmış yanıtlama tarzından (örneğin, gelişigüzel cevaplar verme, maddeleri anlamama gibi) ileri gelmediğinden emin ise, psikotik bir bozukluk olasılığı düşünülmelidir.

Kuşkusuz kişiye şizofreni tanısı verilmeden önce başka testlerden ve test dışı kaynaklardan elde edilen veriler mutlaka incelenmelidir. 7. ve 8. ölçekler arasındaki yükseklik farkının da psikoz tanısı konusunda ipucu verdiği düşünülür. 8, 7'den yüksek ise, tersi bir duruma ($7 > 8$) kıyasla, psikoz olasılığının daha yüksek olduğu belirtilmiştir.

MMPI profilinde, 6. ve 8. ölçekler oldukça yüksek ve her ikisi de 7'den dikkat çekecek kadar yüksek ise ("paranoid vadi" denilen durum) psikotik bir bozukluk düşünülür. Ancak yine kişinin test maddelerini beklediği şekilde yanıtladığından emin olunmalıdır (III. Bölümüne bakınız). Profilleri psikotik ya da psikotik değil şeklinde sınıflandırmak amacıyla pek çok çalışma yapılmıştır. Bunlar içinde en önemlisi, bu bölümde daha önce değinilen Goldberg'in (1965) çalışmasıdır. Goldberg, kendi bulduğu formüle göre hesaplanan 45 kesme puanının vakaların % 70'ini doğru bir biçimde sınıflandırabildiğini söylemiştir. Ancak bu göstergeden yararlanmak isteyen klinisyenler, ampirik bir çalışmayla kendi klinik örneklemeleri için bir kesme noktası belirlemelidirler.

Henrich (1964, 1966), Meehl ve Dahlstrom (1960), Peterson (1954) ve Taulbee ve Sisson (1957), adlı araştırmacılar da, tanısal sınıflandırma yapan kurallar bulmaya çalışmışlardır. Goldberg'in basit göstergesi, daha karmaşık ve zaman alıcı bu yaklaşımlara kıyasla daha yeterli görüldüğü için diğerleri burada tartışılmamıştır. Dahlstrom ve arkadaşları (1975) ayır-

cı taru ile ilişkili kapsamlı bir referans listesi sunmuşlardır (Bkz: "An MMPI Handbook" cilt 2, Bölüm 1).

Organik Etiyolojiye Karşı Fonksiyonel Etiyoloji

Hem organik hem de fonksiyonel kökenli olabilen pek çok bedensel semptom (örneğin, paralizi, başağrısı, göğüs ağrısı) vardır. Bazen uygulayıcı bu konuda bir karar vermek durumunda kalabilir. Şurası açıktır ki, MMPI böyle bir belirlemeyi tek başına yapabilecek bir değerlendirme aracı değildir. Hasta fiziksel ya da bedensel semptomlardan söz ettiğinde, gerekli tıbbi incelemeler istenerek sonuçları gözden geçirilmelidir. Eğer semptomlar fiziksel bir temelle açıklanamıyorsa, bu kez MMPI sonuçlarına, sosyal yaşam öyküsüne ve diğer verilere dönülerek bireyin psikolojik yapısının fonksiyonel etiyoloji ile tutarlı olup olmadığı belirlenebilir.

MMPI'nın 3. ölçeği (Histeri), strese tepki olarak fiziksel semptomlar geliştirme eğilimine hayli duyarlıdır. Gerçek fiziksel sorunları olan kişilerin 3. ölçek puanları bir miktar yükselirse de, çok yüksek puanlar ($T > 70$) daha çok somatizasyon tepkilerini düşündürür. Fonksiyonel fiziksel sorunlar gösteren kişilerin profilleri belirgin bir negatif eğim gösterir. Bu kişilerde nevrotik ölçekler (1, 2 ve 3), psikotik ölçeklere (8 ve 9) kıyasla çok daha fazla yükselme eğilimindedir. 1. 2. ve 3. ölçeklerin göreceli pozisyonları etiyojinin organik ya da fonksiyonel kökenli olup olmadığını ayırt etmede önemlidir. Eğer 1. ve 3. ölçekler 2. ölçekten anlamlı biçimde daha yüksekse ("konversiyon vadisi" diye adlandırılan şekil) ve bu üç ölçek profildeki diğer ölçeklere kıyasla daha fazla yükselmişse, daha çok konversiyon tepkisini (psikolojik etkenlerin neden olduğu fiziksel semptomlar) düşündürür. Böyle kişiler hiçbir fiziksel temel olmaksızın çeşitli bedensel semptomlar belirtme eğilimindedirler ve kendi semptomlarına karşı klasik bir histerik kayıtsızlık gösterebilirler.

Alkolizm Ve Madde Bağımlılığı

Strese tepki olarak ortaya çıkan bir davranış olarak, aşırı alkol kullanımına oldukça sık rastlanır. Alkolizm birbirinden çok farklı kişilik özelliği olan insanlar arasında ve değişik türden sorunlarla birlikte görülebilir. Ancak, MMPI sonuçlarıyla aşırı alkol kullanımı arasındaki ilişkiyi araştıran yayınlar, alkoliklerin çoğunda güçlü psikopatik özelliklerin bulunduğunu göstermiştir. MMPI'nın 4. ölçeğinin (Psikopatik Sapma) alkolikler arasında sık yükselmesi bu düşüncüyü destekler niteliktedir. Ayrıca 4. Ölçeği içeren bazı ikili kod tipleri (49/94, 14/41, 24/42, 34/43, 46/64) ile alkolizm arasında ilişki bulunmuştur. Alkoliklerin MMPI bulgularını araştıran çalışmaların çoğu halen alkolik olan kişiler üzerinde yapılmıştır. Oysa, bu kişileri, alkolizm gelişmeden önce belirlemek daha önemlidir. Zamanla alkolizm geliştiren prealkoliklerin MMPI sonuçları hakkında elimizde bazı veriler vardır (Hoffman ve ark., 1974, Kameneier ve ark., 1973, Loper ve ark., 1973). Üniversite yıllarında MMPI uygulanan ve daha sonra alkol bağımlılığı geliştiren bir grup erkeğin test sonuçları, alkolik olmayan kontrol grubunun

sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Prealkolik grubun, F ölçeği ile 4. ve 9. ölçekten, kontrol grubuna kıyasla anlamlı biçimde daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Elde edilen sonuç, bu gruptaki kişilerin alkolik olmadan önce bile kontrol grubuna kıyasla daha impulsif ve daha az boyun eğici olduklarını düşündürmektedir. Üniversite yıllarında elde edilen profil ile alkolizm tedavisi için başvurulduğunda elde edilen profil karşılaştırıldığında, ölçeklerin konfigürasyonunun değişmediği görülmüştür. Ancak, ikinci uygulamada, 4. ve 9. ölçeklerdeki yükselme daha fazla olmuştur. Kuşkusuz benzer profil alan herkesin alkolik olması beklenmez, ancak, bu tür bir konfigürasyonda alkolizm olasılığı artar. Orjinal MMPI maddeleri kullanılarak alkolikleri belirlemeye yarayan çok sayıda ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçeklerin çoğu alkolikleri alkolik olmayan kontrol grubundan başarıyla ayırt ederken, alkolik olmayan psikiyatrik hastalardan ayırdedemezler. Yalnızca tek bir alkolizm ölçeği (MacAndrew, 1965), alkoliklerle psikiyatrik hastaları birbirinden ayırmada başarılı olmuştur. 300 erkek alkolikle, ayaktan tedavi gören 300 psikiyatrik hastanın test yanıtlarını karşılaştıran MacAndrew, iki grubu birbirinden ayırt eden 51 madde belirlemiştir. MacAndrew ölçeğinin ilerde alkolik olacak kişileri belirlemede de etkili olduğunu gösteren kanıtlar vardır.

MacAndrew'un Alkolizm Ölçeği Maddeleri

Doğru	6, 27, 34, 50, 56, 57, 58, 61, 81, 94, 116, 118, 127, 128, 140, 156, 186, 224, 235, 243, 251, 263, 283, 309, 413, 419, 426, 445, 446, 447, 482, 483, 488 500, 507, 529, 562
Yanlış	86, 120, 130, 149, 173, 179, 278, 294, 320, 335, 356, 378

Literatürde, madde kullanan kişilerin MMPI bulguları ilişkin bulgular, alkoliklere kıyasla daha az incelenmiştir. Bu bulgular, madde bağımlıları ile alkoliklerin benzer MMPI profilleri verdiklerini düşündürmektedir. Madde bağımlılarının test sonuçlarında güçlü sosyopatik özellikler vardır. Kişiler hemen her zaman 4. ölçekten yüksek puan alırlar ve aynı zamanda 8 ile 9. ölçeklerde yükselme görülür. İkili kod tiplerinden en sık rastlanan 49/94, 48/84 ve 89/98'dir. Bu MMPI bulguları madde bağımlılarının impulsif, sosyal açıdan isyankar, geleneksel değerleri ve yasakları reddetme eğilimi taşıyan kişiler olduklarını göstermektedir. MMPI madde havuzu kullanılarak, madde bağımlılarını belirleyen alt ölçekler geliştirilmeye çalışılmış ancak başarılı olunamamıştır. Mac Andrew'un Alkolizm Ölçeğinin aynı zamanda madde bağımlılığına da duyarlı olduğunu gösteren bazı kanıtlar vardır. Ancak MacAndrew'un ölçeğinin halihazır ve potansiyel madde bağımlılarını belirlemede rutin olarak kullanılabilmesi için daha fazla çalışma gerekir.

BİR VAKA ÖRNEĞİ

Yukarıda tartışılan yorumlama yaklaşımının okuyucu tarafından daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak için, gerçek bir vaka örneği ele alınarak MMPI profili adım adım incelenmiştir. Alıştırma yapmak isteyen okuyucu profili (Şekil 7) yorumlayıp daha sonra kendi yorumunu aşağıdaki yorumla karşılaştırabilir.

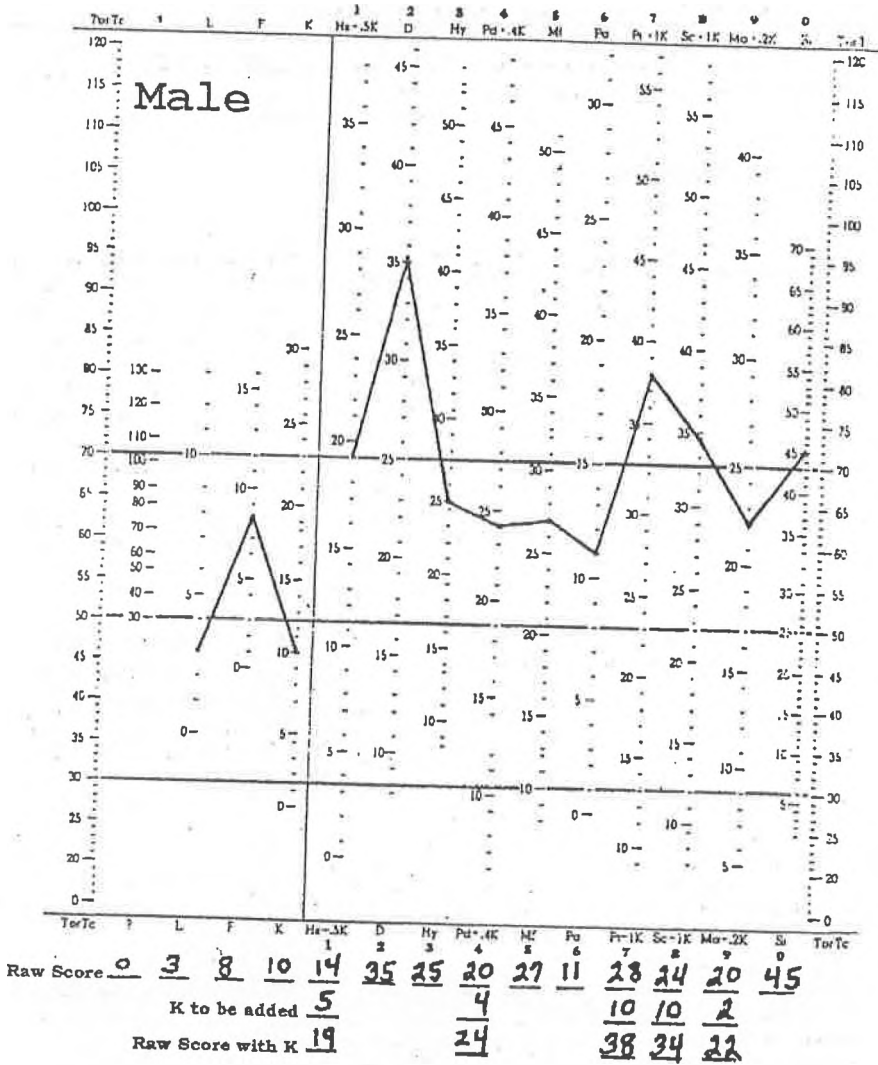
Öykü

27 yaşında bir berber olan J.A.K. depresyon, sinirlilik, karamsarlık, kendine güvensizlik ve karar vermede güçlük yakınmalarıyla ayaktan hasta izleyen bir kliniğe başvurmuştu. Sorunlarının 5 yıl önce askerden terhis edildiğinde ve ilk kez yaşamda "kendi başına kaldığını" hissettiğinde ortaya çıktığını belirtir. J.A.K. iki erkek kardeşten büyüğüdür. 25 yaşındaki erkek kardeşini kendinin tam zıddı olarak tanımladı. J.A.K. sanat, edebiyat ve benzeri estetik konularla ilgilenirken, kardeşi, spor ve diğer erkek aktiviteleri ile uğraşmaktaydı. J.A.K.'ın babası kliniğe başvurduğu tarihten yaklaşık 5 yıl, annesi ise 8 yıl önce ölmüştü. Çocukluğundan hoşnut olduğunu söylüyordu. Ailesi ona ne çok fazla ilgi göstermiş ne de ondan çok fazla şey istemişti. Liseden mezun olduktan sonra babası üniversiteye gitmesi için baskı yapmıştı. Ancak başarısız olduğu için bir yıl sonra okuldan uzaklaştırılmıştı. Daha sonra orduya kaydolarak, burada 3 yıl memur olarak görev yapmıştı. Askerlik yaşamını çok sevmişti, çünkü kendi deyişiyle "orduda herşey sizin için planlanmaktaydı". Bu görevden ayrıldıktan sonra bir arkadaşıyla ortak bir berber dükkanı açmıştı. Klinikte görüldüğü sırada, işi konusunda çelişkili duygulardan sözcederek, fotoğrafçı olmak istediğini söyledi. Yaklaşık 1 yıldır evliydi ve karısı ilk çocuklarına hamileydi.

Baba olacağı için memnundu ancak sorumluluğunun artması onu korkutuyordu. MMPI uygulaması sırasında, uygulayıcı tarafından işbirliği yapan, dost tavırlı ve elinden geleni yapmaya çalışan biri olarak tanımlandı. Testi yaklaşık 1.5 saat içinde tamamladığı belirtildi.

Test Alma Tutumu

J.A.K. MMPI testini ortalama süre içinde tamamladı. Bu nedenle test maddelerini yanıtlarken aşırı kararsız olduğu ya da dürtüsel davrandığı söylenemez. Hiçbir maddenin boş bırakılmaması işbirlikçi tutumu ve olumsuz kişilik özelliklerini saklamak için bu basit kaçma yolunun kullanılmadığını düşündürmekte. L ölçeği ham puanı olan 3, kişinin sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyinden beklenen bir puan olduğu için, testi yanıtlarken savunmacı davranmadığı ve sorunlarını inkar etmediği söylenebilir. J.A.K.'ın F ölçeği T puanı 62, ortalama bir insandan daha fazla sapmış tutum ve davranış belirttiğini düşündürmekte, ancak yine de puan, testi geçersiz kılacak kadar yüksek değil Bütün bunlar testte kendini tanımlarken içten olduğunu düşündürmekte.



Şekil 7. J.A.K. vakasının MMPI profili.

J.A.K.'ın sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyindeki bir kişinin K puanının 50-60 arasında olması beklenir. Elde edilen K ölçeği puanının 46 olması, test maddelerini yanıtlarken kendini eleştirdiğini göstermekte. J.A.K.'ın geçerlik ölçeklerinin konfigürasyonunun ters V şeklinde oluşu da dikkat çekmekte. Bu durumda, yardım gereksinimi nedeniyle sorunların abartılmış olabileceği akla gelse de, F ölçeğindeki ılımlı yükselme ve L ile K ölçeklerinin ortalamaya yakın oluşu, daha çok, önemli bir huzursuzluğun ve patolojinin açıkça anlatımı olarak ele alınabilir. Özetle J.A.K. MMPI testini yanıtlarken içten ve açık davranmıştır. Kendini eleştirmesine rağmen, test sırasındaki davranışlarının gerçek davranışları temsil etmediğini gösteren herhangi bir kanıt yoktur.

Uyum Düzeyi

J.A.K.'ın F ölçeği T puanının 62 olması, orta düzeyde bir duygusal huzursuzluğu göstermektedir. Bu durumda ancak büyük ruhsal bedeller karşılığında yaşam sorunlarıyla başa çıkabildiği söylenebilir. Genelde klinik ölçeklerin puanları oldukça yüksektir. Klinik ölçeklerin (5. ve 0. ölçekler dışındaki) T puanı ortalaması 70 civarındadır. Böyle bir ortalama puan, önemli bir psikopatolojiyi ve günlük işlevlerde görülen önemli yetersizlikleri akla getirir. Bundan başka dört klinik ölçeğin T puanının 70'e eşit veya üstünde olması ciddi bozukluk düşüncesini desteklemektedir. Ancak profilin negatif eğim göstermesi içsel çatışma ve huzursuzluğa rağmen işlevlerde çok ciddi bir bozukluk olmadığını düşündürmektedir. 2. ve 7. ölçeklerde görülen önemli yükselmeler, anksiyete ve depresyonu içeren ruhsal karmaşayı ve kişinin sorunlarla başa çıkamama duygusu taşıdığını belirtmekte. J.A.K. 38 kritik maddeden yalnızca 6'sını kabul etmiştir. Bunlardan hiçbirisi açık bir psikoz semptomu değildir. Patoloji yönünde işaretlenen kritik maddeler, başkalarına ya da kendine zarar verme dürtüleri, anımsama güçlükleri, gerçek dışılık hissi ve ölme isteği ile ilişkilidir. Özet olarak, J.A.K. büyük bir huzursuzluk içinde gibi görünmektedir. Ancak, kişinin duyduğu huzursuzluk, günlük aktivitelerindeki gerçek işlev yetersizliğine kıyasla biraz daha fazladır. Çoğu kez kendini çok kötü hissetmesine rağmen işlevlerini sürdürebilmektedir.

Tipik Özellikler ve Davranışlar

Tipik özellikler ve davranışlar tahmin edilmeye çalışılırken, ilk adım, J.A.K.'ın geçerlik ölçeklerinin puanlarını incelemek ve uygun hipotez ve çıkarımlar için III. Bölüme danışmak olacaktır.

L (T = 46)

Bu puan kişinin sosyoekonomik ve eğitim düzeyine uygundur; özellikle savunmacı davranmamış ve sorunlarını inkar etmemiştir.

F (T = 62)

Bu puan, vakanınkinden benzer bir geçmişi olan insanlar için biraz yüksektir. Çok ciddi olmasa da normalden sapmış bazı davranış ya da düşünceleri kabul etmiştir. Bu maddeler, pasiflik, sorunlardan kaçma eğilimi,

uyuma güçlükleri, kendine veya başka insanlara zarar verme dürtüleri ve kişinin ne yaptığının farkında olmadığı aktivite dönemleri ile ilişkilidir. Çok mutsuz ve huzursuz olmasına rağmen, yaşamının pek çok alanında işlevlerini yeterli bir şekilde sürdürebilmektedir.

K (T = 46)

Bu puan bir yıl üniversiteye devam etmiş bir kişiden beklenenden biraz daha düşüktür. Kendini eleştiren, kendinden hoşnut olmayan, yardım isteğiyle sorunlarını abartan, günlük yaşam sorunlarıyla etkin bir şekilde başa çıkamayan, kendi davranışlarına karşı içgörüsü az, sosyal açıdan beceriksiz, boyun eğici ve otoriteye karşı itaatkar, çekingen, utangaç, yüzey-sel, kişisel temposu düşük, diğer insanlara karşı eleştirici, kuşkucu, alaycı ve kinayıcıdır.

Bundan sonra J.A.K.'ın 70 veya 70'in üstünde T puanı aldığı klinik ölçekler belirlenir ve varsayımlar için IV. bölümün uygun kısımlarına baş-vurulur.

2. Ölçek (T = 94)

Bu, ciddi depresyon düşündüren çok yüksek bir puandır. Depresif, umutsuz, kederli, gelecek hakkında kötümser, kendini yeren, suçluluk duyguları yaşayan bir kişi. Depresif tanılardan birini alabilir. Bedensel semptomlardan, güçsüzlük, yorgunluk ve enerji kaybından yakınan; gergin, heyecanlı, sinirli, kendine güvenmeyen, işe yaramadığını ve başarısız olduğunu düşünen, içedönük, utangaç, ürkek, ketum, soğuk, başkaları ile arasında psikolojik bir uzaklık bırakan, kişilerarası ilişkilerden kaçınan biri. Sorunlarına ihtiyatlı ve geleneksel bir tarzda yaklaşan, karar vermede güç-lük çeken, agresif olmayan, aşırı kontrollü, dürtülerini inkar eden, hoş ol-mayan durumlardan kaçınan ve yoğun huzursuzluk duyguları nedeniyle psikoterapi için istekli bir kişi olduğunu düşündürmektedir.

7. Ölçek (T = 81)

Bu puan, büyük bir huzursuzluğu ve ruhsal karmaşayı düşündür-mekte. Anksiyöz, gergin, heyecanlı, endişeli, kaygılı, sinirli, tedirgin, dikka-tini toplamada güçlük çeken, kendini inceleyen, tekrarlayıcı düşünceleri olan, obsesif-kompulsif. Güvensizlik ve aşağılık duyguları taşıyan, kendi değeri ile ilgili endişeleri olan, kendini eleştiren, küçük gören, katı, tutucu, kendi ve diğer insanlar için yüksek standartlara sahip, mükemmeliyetçi, dürüst, suçluluk duyan, depresif, temiz, düzenli, tertipli, titiz, inatçı, güve-nilir. Sorunlarına yaklaşım tarzı yaratıcılıktan uzak, sıkıcı, resmi, kararsız, sorunların önemini çarpıtan, aşırı tepki gösteren, sosyal etkileşimlere ka-tılmayan, anlaşılması güç, sevilme ve onaylanma konusunda endişeleri olan, duygusal, sakın, iyi kalpli, duyarlı, nazik, bağımlı ve olgunlaşmamış. Kalp, sindirim ve boşaltım sistemi ile ilişkili, ayrıca yorgunluk, bitkinlik, uykusuzluk gibi fiziksel yakınmaları olan, kısa psikoterapilere yanıt vermeyen, sorunları hakkında bir miktar içgörüsü olan fakat entellektüalizasyona ve rasyonalizasyona başvuran, psikoterapide yapılan yorumlara direnç

gösteren, terapisteye düşmanca tutumlar geliştirmeye eğilimli, terapiye uzun süre devam etmesi ve yavaş fakat düzenli bir ilerleme göstermesi beklenen, terapisteye otorite çatışmalarından, kötü iş ve çalışma alışkanlıklarından ve homoseksüel dürtülerle ilişkili kuşkulardan söz eden bir kişi.

8. Ölçek (T = 73)

Bu düzeydeki puan, kişinin açıkça psikoz düşündüren maddelerin çoğunu onayladığını gösterir. Şizoid bir yaşam tarzını aklı getirir. Kendini sosyal çevrenin dışında kalmış, ayrı ve yabancı hisseden; yanlış anlaşılan, kabul edilmeyen; içe çekilmiş, yalnız, ketum, ulaşılamaz; insanlarla karşılaşmaktan ve yeni ortamlara girmekten kaçınan; başkaları tarafından utan- gaç, soğuk, uzak bir kişi olarak tanımlanan; yaygın anksiyetesi olan, hostile, saldırgan, ancak bu duygularını anlatamayan; stres karşısında içe çekilerek gündüz rüyaları ve fantazilere sığınan; kendi ile ilgili kuşkuları olan; aşağı- lık, yetersizlik, başarısızlık duyguları taşıyan; kendinden hoşnut olmayan, cinsellikle ilgili düşünsel uğraşları ve cinsel rol karmaşası olan bir kişi. Başkaları tarafından garip, alışılmamış ve tuhaf biri olarak tanımlanan; süregen ve belirsiz fiziksel yakınmaları olan; inatçı, karamsar, dikkatli, cömert, sakın, duygusal, olgunlaşmamış, impulsif, maceraperest, zeki, dü- rüst, sinirli. İlgili alanı oldukça geniş, yaratıcı ve hayal gücü zengin; amaçları soyut ve belirsiz; problem çözmek için gerekli bilgilerden yoksun bir kişi. Psikoterapide kötü prognoz beklenen; tedaviye pek çok hastadan daha uzun bir süre devam eden ve sonunda terapisteye güven duyabilen biri.

9. Ölçek (T = 72)

Sosyal açıdan içe dönük; sosyal ortamlarda güvensiz ve huzursuz; utangaç, ürkek, çekingen; kendini yalnızken ya da bir-iki yakın arkadaşın yanında daha rahat hisseden; sosyal aktivitelere katılmayan, özellikle karşı cinsten kişilerin yanında rahatsız olan; kendine güvenmeyen; kendini kü- çük gören; anlaşılması güç; başkaları tarafından uzak ve soğuk bir kişi olarak görülen; başkalarının kendi hakkında düşündüklerine duyarlı; sos- yal etkileşimlere katılamadığı için üzülen; aşırı kontrollü; duygularını açık- ça anlatamayan; boyun eğici, itaatkar, otoriteyi kabul eden; kişisel temposu düşük; güvenilir, ciddi; sorunlarına temkinli, geleneksel ve sıradan bir tarz- da yaklaşan; düşünce ve tutumları katı; karar vermede güçlük çeken; ça- lışmaktan hoşlanan; kişisel başarılarından zevk alan; endişeli, sinirli, anksiyöz, karamsar; suçluluk duygusu taşıyan depresif biri.

1. Ölçek (T = 70)

Bu puan bedensel ilginin göstergesidir. Belirsiz, özgün olmayan, be- densel yakınmalar, mide ve karın bölgesi ile ilgili yakınmalar, süregen yor- gunluk, ağrı ya da güçsüzlük yakınmaları bulunabilir. Nevrotik bir tanı alabilir. Acting-out olasılığı düşüktür. Bencil, benmerkezci, narsisistik, kö- tümser, yıkıcı, alaycı, umutsuz; başkalarını mutsuz eden, mızızca yakı- nan; eleştirici ve talepkar; kazgınlığını dolaylı yollarla anlatan; künt, heye- cansız, isteksiz; sözlü ifadede başarısız; açık anksiyete bulgusu olmayan;

önemli bir yetersizliği olmayan; pek başarılı olmasa da işlevlerini sürdürebilen; sorunları uzun süreden beri devam eden; içgörüsü az; geleneksel psikoterapiler için çok uygun olmayan; terapisti eleştiren biri.

Bundan sonra J.A.K.'ın ikili kodları belirlenir. V. Bölüme başvurulur ve 27/72 kodu için uygun olan varsayımlar özetlenir: Anksiyöz, sinirli, gergin, tedirgin; aşırı endişeli; gerçek veya hayal ürünü tehditlere karşı çok duyarlı; henüz ortada olmayan sorunları bekleyen; stres altında aşırı tepki gösteren; bedensel semptomları olan; süregen yorgunluk, halsizlik, bitkinlik yakınmaları olan; depresif, ancak üzüntülü duygularından söz etmeyen; depresyonun klinik özelliklerini (hareketlerde ve konuşmada yavaşlama, kilo kaybı gibi) gösteren; genelde dünya hakkında son derece kötümser, özellikle de sorunlarına çözüm bulamayacağını düşünen; tekrar tekrar aynı sorunları düşünen; başarılı olmaya ve bunun farkedilmesine ihtiyaç duyan, kendinden çok şey bekleyen ve bunlara ulaşamadığında suçluluk duyan; kararsız; yetersizlik ve aşağılık duyguları taşıyan; güvensiz; kendini cezalandırmaya eğilimli, sorunları için kendini suçlayan; düşünceleri ve problemleri çözme tarzı katı; titiz ve mükemmeliyetçi; aşırı dindar ve tutucu; kişilerarası ilişkilerde yumuşak başlı ve pasif-bağımlı; derin duygusal ilişkiler kurabilen; stres zamanlarında başkalarına aşırı bağımlı olan; saldırgan olmayan; başkalarında koruma ve yardım isteği uyandıran; yaşadığı yoğun huzursuzluk duygusu nedeniyle psikoterapiye istekli, psikoterapiye devam etmesi ve ilerlemesi beklenen, nevrotik tanı alan biri.

J.A.K.'ın testten aldığı puanlara dayanılarak oluşturulan çok sayıdaki varsayım dikkatli bir şekilde incelendiğinde, farklı ölçeklerden çıkarılan varsayımlar arasında dikkat çeken bir tutarlılık ve çakışma olduğu görülmektedir. Tek bir ölçeğe dayanan varsayım sayısı son derece azdır. Ayrıca okuyucu, varsayımlar arasında bazı tutarsızlıklar farkedecektir. Kuşkusuz, birden fazla ölçeğe dayanan varsayımlar daha önemlidir. Bir ölçeğe dayanılarak ileri sürülen bir varsayım ile, başka bir ölçekten elde edilen varsayım arasında tutarsızlık varsa, bu ölçeklerden hangisinin daha yüksek olduğuna bakılmalıdır. Daha yüksek olan ölçeğe dayanılarak yapılan tahminlerin doğru olma olasılığı daha fazladır. Aynı şekilde, varsayımların ampirik çalışmalarından mı, yoksa madde içeriğinden mi çıkarıldığı önemlidir. Ampirik kaynaklı varsayımlar diğerlerine kıyasla daha değerlidir.

Bu önemli noktalardan sonra, yorumlama sürecindeki bir sonraki adım, varsayımları anlamlı kategoriler halinde gruplandırmaktır.

Semptomlar

MMPI profilinin değişik alanlarında J.A.K.'ın çok depresif olduğu konusunda oldukça açık bir uyum var. Kendini çoğu zaman kederli, mutsuz ve üzüntülü hissetmektedir. Heyacansız, isteksiz ve yavaş hareket eden bir kişi olmasına rağmen zaman zaman açıklanamayan heyecan ve huzursuzluk dönemleri yaşayabilir. Çok karamsar, derin düşüncelere dalarak tekrar tekrar aynı sorunları kafasında evirip çeviren biri olabilir. Gelecek hakkında kötümser, hayatın yaşanmaya değer olmadığını düşünen bir kişi olabilir. Sık sık intiharı düşünmesine rağmen, intihar girişiminde bulunma olasılığı

diğer depresif hastalara kıyasla daha yüksek görünmemektedir. Günlük sorunlarla başa çıkacak gücü yoktur ve yaşam onun için ilginç değildir. Geçmiş hataları için pişmanlık ya da suçluluk duygularından söz edebilir ancak bu hataların ne olduğunu belirleyemez. J.A.K'n aynı zamanda büyük bir huzursuzluk yaşadığı açıktır. Kendini anksiyöz, gergin ve sinirli hissetmektedir. Stres altında büyük bir duygusal huzursuzluk hissetmeye eğilimlidir ve bu sıralarda anksiyetenin açık fizyolojik belirtilerini (örn, kalp atım hızının artması gibi) gösterebilir. Sinirli, tedirgin, endişelidir ve hayali ya da gerçek herhangi bir tehdit algıladığında aşırı zedelenebilir.

J.A.K. bedensel işlevleri ile yakından ilgilenen ve fiziksel sağlığının kötü olduğunu düşünen biri olabilir. Çok sayıda özgün bedensel semptom belirtebilir ya da yakınmaları son derece belirsiz olabilir. Süregen güçsüzlük, yorgunluk, bitkinlik ya da tükenme hissinden yakınması olasıdır. Uyku sorunları ya da iştahsızlığı olabilir.

Dikkatle ve dikkati belli bir konuda yoğunlaştırma ile ilişkili sorunlar bildirebilir. Bellek zayıflığından ve yargılama yetersizliğinden yakınabilir. Tekrarlayıcı ve obsesif düşünceleri, kompulsif davranışları olabilir. Onun için karar vermek son derece güçtür ve çoğu zaman kararsızlık içinde olduğu görülür. Bazen ne yaptığını farketmediği dönemler yaşamakta olduğunu söyleyebilir. Bu dönemler obsesif düşüncelerle birleştğinde aklını kaybetme korkusuna neden olabilir. Ancak bu korkuyu başka insanlara söylemekten çekinebilir.

Temel Gereksinimler

J.A.K'n bağımlılık gereksinimlerinin son derece güçlü olduğu görülmektedir. Sorunlarla ve stres durumlarıyla kendi başına mücadele edemeyeceğini düşünmekte ve başkalarının destek ve yardımına ihtiyaç duymaktadır. Stresin yoğun olduğu dönemlerde başka insanlara yapışma gibi oldukça bebeksi davranışlar sergileyebilir. Aynı zamanda başarılı olmaya ve bu başarının başkaları tarafından farkedilmesine duyduğu gereksinim de oldukça güçlü. Kendisi için yüksek hedefler seçmekte, amaçlarına ulaşamadığında suçluluk duymakta ve korktuğu için doğrudan yarışmayı gerektiren durumlardan uzak kalmaktadır. Amaçlarının belirsiz ve iyi tanımlanmamış olduğu görülebilir. İnsanlara, özellikle kendi bağımlılık gereksinimini karşılamayanlara karşı güçlü düşmanlık ve saldırganlık duyguları taşımaya rağmen, bu olumsuz duygulardan rahatsız olmakta ve doğrudan ifade edememektedir. Bu duyguların, daha çok, inatçılık, aşırı eleştiricilik gibi pasif-agresif davranışlarla, dolaylı yollarla anlatılması mümkündür.

Çevrenin Algılanış Biçimi

J.A.K dünyayı tehdit edici ve korkutucu bir yer olarak görüyor. Hiç bir şekilde kontrol edemediği güçlerin insafına kaldığını hissediyor. Yaşama genel bakışı, kötümserlik, şüphe, alay ve kınama ile karakterize. Diğer insanları, bencil, duyarsız, mantıksız ve sahtekar kişiler olarak görmeye eğilimli. Kendisine kötü davranıldığını, başkaları tarafından yanlış anlaşıldığını ve gereksinimlerinin yeterince karşılanmadığını düşünüyor.

Strese Gösterilen Tepkiler

J.A.K. yaşam sorunları ve streslerle başa çıkmada kendini yetersiz ve başarısız hissediyor. Sorunların giderek arttığını ve artık onlarla başa çıkamayacağını düşünmekte. Yaşamının bir çok alanında sorunlarla mücadele edebilmesine rağmen bu mücadelede pek başarılı değil ve ruhsal olarak büyük bir bedel ödemekte. Sorunlar karşısında tercih ettiği tepki, bunların varlığını inkar ederek hayal dünyasına sığınmaktır. Bu mekanizmalar başarılı olmazsa, bunalebilir ve davranışlarında uyumsuzluk görülebilir. Sorunlar henüz ortaya çıkmadan önce gerginleşerek onları beklemeye başlayabilir ve strese aşırı tepki gösterebilir. Strese tepki olarak bedensel semptomlar geliştirebilir. Problem çözme davranışı alışılmış, ihtiyatlı ve geleneksel olma eğilimindedir. Düşünme tarzı katı ve inatçı olabilir.

Benlik Kavramı

J.A.K.'ın benlik kavramı son derece olumsuzdur. Kendini başkalarından aşağı görmekte ve sorunlarıyla başa çıkamadığını düşünmektedir. Kendisine gerçekçi olmayan yüksek standartlar koymakta ve bu amaçlara ulaşamadığında kendini değersiz ve işe yaramaz hissetmektedir. Kendini çok eleştiren bir kişi; değersiz olduğunu ve cezalandırılmayı hak ettiğini düşünmekte. Zaman zaman kendine yönelik, yıkıcı dürtüleri olmasına rağmen, intihar girişiminde bulunma olasılığı diğer depresif hastalara oranla daha yüksek değildir. Negatif benlik imajı, yaşam tarzıyla iyice bütünleştiği için değişmeye karşı direnç göstermesi mümkündür. Seçici dikkat, başarısızlık ve hatalara yönelerek geçmiş başarılar gözardı edilebilir.

Cinsel İdentifikasyon

J.A.K cinsel açıdan yeterli olup olmadığı konusunda ciddi endişeler taşımaktadır. Zengin cinsel fantazilerinin olması mümkündür. Olgun heteroseksüel ilişkiler kurmakta güçlük çekiyor ve karşı cinsin yanında kendini çok rahatsız hissediyor olabilir. Kadınları, yoğun bağımlılık ihtiyacını doyuracak kaynaklar olarak görebilir ve onlardan anne figürünün yerini tutmalarını bekleyebilir. Kendi cinsiyetinden kişileri çekici bulmadığını belirtmesine rağmen, bazen geçici homoseksüel dürtüler nedeniyle son derece anksiyöz olabilir. Yine de açık homoseksüel davranışların görülme olasılığı düşüktür.

Duygusal Kontrol

J.A.K. çoğu zaman aşırı kontrollüdür. Hem olumlu hem olumsuz, yaşadığı tüm duygular, kendini rahatsız ettiği için onları doğrudan ifadeden kaçınmaktadır. Aslında çoğu zaman kendi duygularının farkına bile varmamaktadır. Özellikle anne-babasına ve diğer otorite figürlerine karşı güçlü düşmanlık ve saldırganlık duyguları beslemekte ve bu olumsuz duyguları daha çok pasif-agresif davranışlarla, dolaylı olarak ifade etmektedir.

İnsanlar arası İlişkiler

Her ne kadar güçlü ilgi ve onay gereksinimleri J.A.K.'ı kişiler arası ilişkiler kurmaya yöneltse de, bu ilişkiler sıklıkla yüzeyel ve sığdır. Derin emosyonel bağlar geliştirme yeteneği olmasına rağmen, reddedilme ve/veya istismar edilme korkuları yüzünden insanların kendisine çok fazla yaklaşmasını engellemektedir. Çok iyi tanıdığı kişiler değilse başka insanların yanında huzursuzdur ve bir çok sosyal aktiviteye katılmaz. Başka insanların arasında ürkek, utangaç ve çekingendir; dikkat çekmemeye çalışır. Yakın arkadaş ve akrabalar dışındaki kişilerle konuşmak ona güç gelir. Kolay arkadaş edinemez ve diğer insanlar tarafından soğuk, ketum, uzak, erişilemeyen ve anlaşılması güç bir kişi olarak görülür. Akranlar tarafından kabul edilme ile ilgili endişeleri vardır ve başkalarıyla anlamlı ilişkiler kuramadığı için üzülmeaktadır. Az sayıdaki insan ilişkilerinde, pasif, boyun eğici ve ita'atkar davranma eğilimindedir. Başka insanların değer ve görüşlerinden kolayca etkilenir ve otoriteyi açıkça kabul eder. Başka insanlara kendi değer ve görüşlerini anlatamaz ya da savunamaz. İnsanların tepkilerine karşı çok duyarlıdır, en küçük bir eleştiri bile incinmesine neden olabilir.

Psikolojik Kaynaklar

J.A.K. kendi belirttiklerinden daha fazla psikolojik kaynak ve zenginliğe sahiptir. Büyük bir huzursuzluk içinde olmasına rağmen günlük sorunlarla kendi düşündüğünden daha iyi mücadele edebilmektedir. İnsanlarla yakın ilişkileri olmamasına rağmen, derin duygusal bağlar kurabilme yeteneğine sahiptir. Kendisi için yüksek amaçlar seçmektedir. Düzenli, temiz, güvenilir ve dürüst bir kişidir. Başkaları tarafından nazik, duyarlı, barışsever ve cömert biri olarak görülmektedir. Çalışmaktan ve başarılı olmaktan zevk almaktadır.

Dinamikler ve Etiyoloji

J.A.K.'ın semptom ve sorunlarının çoğu, kendisi için gerçekçi olmayan yüksek amaç ve hedefler seçmesi ve bunlara erişemediği için kendini başarısız biri olarak algılaması ile ilişkilidir. Klinisyen, kişinin kendine yönelik gerçekçi olmayan beklentilerin kaynaklarını bulabilmek için aile yapısını incelemek zorundadır. Bu tür tutumlar, sıklıkla hiçbir şekilde memnun olmayan, mükemmelliyetçi anne-babaları akda getirir. J.A.K.ın büyük çocuk olduğu için anne-babası kendisinden çok fazla şey beklemiş olabilir.

J.A.K.'ın yetersizlik, bağımlılık ve başa çıkamama duygularının anne-babasının, özellikle de annesinin aşırı koruyucu tutumları ile ilişkili olması mümkündür. Ancak bu tür güvensizlikler, kişinin yaşı ilerledikçe artan sorumlulukları kabul etmek istememesinden de kaynaklanabilir. Bu son çıkarım, J.A.K.'ın çocukluğu hakkında söyledikleriyle uyumludur. J.A.K.'ın başkalarında sempati uyandırmak ve destek sağlamak için bağımlı ve boyun eğici tarzda davrandığı düşünülebilir. Onun tutum ve davranışları karşısında, insanların olumsuz ve düşmanca davranışları çok zordur. Derin duygusal bağlardan uzak durarak, insanların kendisini incitmelerini engellemektedir. J.A.K.'ın kendi erkekliliği ile ilişkili olarak hissettiği yeter-

sizlik duyguları, babasıyla yaptığı yanlış idantifikasyondan kaynaklanabilir. Baba hakkında çok az bilgimiz olmasına rağmen, kendisinin evinden ve çocuklarından uzak, çok şey bekleyen ve fazla eleştiren bir kişi olduğu ya da oğlu için ulaşılamaz bir erkek modeli olduğu düşünülebilir.

J.A.K.'ın öfke ve düşmanlık duyguları, bağımlılık gereksinimlerinin yeterince karşılanmadığını düşünmesinden kaynaklanabilir. Başkaları ondan benzer isteklerde bulunduğunda ise bu istekleri karşılamaya hazır olmadığını hissedebilir.

Tanısal İzlenim

J.A.K.'inkine benzer MMPI profili olan kişiler genellikle nevrotik bir tanı alırlar. Nevrotik tanılar içinde de en sık görülenler, nevrotik depresyon ve anksiyete nevrozudur. F ölçeğinde elde edilen puan, 2. ve 7. ölçeklerde görülen aşırı yükselme ve 27 ikili kodu da bu tanıları desteklemektedir. Bazen, buna benzer protokolü olan kişiler, şizoid kişilik bozukluğu veya şizofrenik reaksiyon tanıları da alırlar, ancak J.A.K. hakkında bildiklerimiz son tanıların ona uygun olmadığını gösteriyor.

Tedavi Konusunda Öneriler

Yaşadığı yoğun huzursuzluk ve karmaşa yüzünden, J.A.K. psikoterapiyi kabule ve değişmeye hayli istekli olabilir. Klinik ölçeklerin puanlarından, J.A.K.'ın bazı özelliklerinin terapinin başarısını engelleyebileceğini çıkarabiliriz. Bunlardan biri, sorunlarının nedenlerine karşı biraz içgörüsü olmasına rağmen entelektüalizasyon ve rasyonalizasyon gibi mekanizmaları çok fazla kullanmasıdır. Ayrıca terapide yapılan yorumlara direnç göstermesi beklenebilir. Başlangıçta terapistle anlamlı bir ilişki kurmada zorlanabilir. Daha sonra terapistle karşı aşırı öfke ve düşmanlık geliştirebilir. Ancak pek çok hastaya kıyasla terapiye daha uzun süre devam edebilir ve giderek terapistle güvenmeye başlayabilir. Terapide yavaş fakat düzenli bir değişim göstermesi beklenir.

Terapide ilk amaç, kişinin beklentilerinin gözden geçirilmesi ve kendisi için daha gerçekçi amaç ve hedefler geliştirmesini sağlamak olmalıdır. Terapide aynı zamanda kişinin olumsuz duygularını farketmesi ve bu duyguları daha etkin bir biçimde anlatma yollarını bulması için çalışılmalıdır. Terapistle kurulan anlamlı ilişki aracılığıyla, J.A.K.'ın duygusal bağlanma korkusunu yeniden değerlendirmesi mümkündür.

Özel Başvuru Soruları

Bu bölümde daha önce gözden geçirilen başvuru sorularının hepsi açıklayıcı olacağı düşüncesiyle J.A.K. için yanıtlanacaktır. Gerçekte ise, tek bir vaka için soruların tümünün sorulması beklenmez.

İntihar

J.A.K.'ın MMPI profilinde 2. ve 7. ölçeklerin çok fazla yükselmesi hayatı yaşamaya değer bulmadığını ve ölmeyi isteyebileceğini göstermektedir. İntihar düşünceleri zaman zaman çok güçlü olmasına rağmen, MMPI

testinde J.A.K.'ın intihar girişiminde bulunma olasılığının diğer depresif hastalardan daha fazla olduğunu gösteren herhangi bir bulgu yok. 8. ölçekte ılımlı bir yükselme olmasına rağmen, 4. ve 9. ölçekler çok yüksek değildir. Kuşkusuz, geçmişte intihar girişiminin olması, aile üyelerinden birinin ölümü, iş kaybı, boşanma gibi diğer etkenler de intihar girişimi olasılığını artırabilir.

Acting-Out Davranışı

J.A.K.'ın düşmanca ve saldırgan dürtüler taşıdığını gösteren bazı kanıtlar olmasına rağmen, bu dürtülerin acting-out'lar biçiminde anlatılabileceğini düşündüren bir bulgu yok gibidir. Aksine çok çekingen ve aşırı kontrollü bir kişidir. Kontrol ölçeklerinin (1,2,3,5,7) T puanı ortalaması 75 iken, acting-out ölçeklerin (4,8,9) T puanı ortalaması 62'dir. Acting-out davranışını gösteren 4. ve 9. ölçek profildeki en düşük klinik ölçekler arasındadır. Aşırı kontrol altında tutulan düşmanlık duygularını ve saldırgan davranış dönemlerini düşündüren 43 ikili koduna da rastlanmamıştır.

Psikoz

J.A.K.'ın profili psikoz düşündürmüyor. Her ne kadar 8. Ölçeğin puanı 75 ise de, bu puan psikoz tanısı koymaya yetecek kadar yüksek değildir. 7. ölçeğin 8. ölçekten daha yüksek olması kognitif süreçlerin kontrol altında olduğunu gösteriyor. T puanları, Goldberg'in göstergesine yerleştirildiğinde elde edilen değer 22 olmuştur. Bu puan, Goldberg'in, nevrotik ve psikotik profilleri ayırt etmek için bulduğu 45 kesme puanının oldukça altındadır.

Organik Etiyolojiye Karşı Fonksiyonel Etiyoloji

J.A.K.'ın profiline benzer profili olan kişiler, bedensel yakınmalar belirtse de, özgün konversiyon semptomlarının (örn., paralizi, körlük gibi) görülme olasılığı hayli düşüktür. 2. ölçeğin, 1. ölçekten daha yüksek olması konversiyon reaksiyonunu dışlanmasını telkin eder.

Alkolizm ve Madde Bağımlılığı

Bu tür protokolü olan kişiler zaman zaman çok içebilirler, ancak, MMPI profilinde alkolizm ve bağımlılık belirtisi yoktur. Bu tür sorunları olan kişilerde sıklıkla 4. ölçek yükselir, oysa 4. ölçek oldukça düşüktür. Ayrıca 27 ikili kodu, alkoliklerde ve madde bağımlılarında sık görülen bir kod değildir. J.A.K.'ın McAndrew Alkolizm ölçeğinden aldığı ham puan olan 15, McAndrew'nin belirlediği 24 kesme puanının oldukça altındadır.

Özet

Yukarıdaki vaka incelemesi, MMPI uygulamaya yeni başlayan klinisyenler için öğretici olabilsin diye çok uzun bir biçimde sunulmuştur. Tecrübeli MMPI uygulayıcıları profilin çok daha kısa bir yorumunu yazmalıdır. Aşağıda yazarın aynı MMPI profili için, klinik kartına, vakayı test için gönderen kişiye ya da kendi psikoterapi notlarına yazdıkları sunulmuştur:

MMPI profilinin geçersiz olduğunu düşündürecek hiçbir belirti yok. Kişi MMPI maddelerini yanıtlarken savunmacı davranmamış ancak biraz kendini eleştirmeye yönelmiştir.

J.A.K. çok büyük bir ruhsal huzursuzluk içinde görünüyor. Kendini anksiyöz, depresif ve sorunları altında bunalmış hissediyor. Büyük bir ruhsal bedel karşılığında, yaşamının pek çok alanında işlevlerini yeterli bir şekilde sürdürebiliyor. Çoğu zaman heyecansız, isteksiz ve yavaş hareket eden bir kişi olmasına rağmen, zaman zaman açıklanamayan heyecan ve huzursuzluk dönemleri yaşayabilir. Sorunları üstünde aşırı düşünen, çok kötümser biri. Hayatın artık yaşamaya değer olmadığı sonucuna varmış olabilir. Hatalar yaptığını düşündüğü için suçluluk duyuyor. İntihar düşünceleri bulunabilir, ancak intihar girişiminde bulunma olasılığı diğer depresif hastalara oranla daha fazla gözüküyor. Genel ve belirsiz ya da çok özgün bazı somatik endişeler belirtebilir. J.A.K.'ın dikkat, dikkati yoğunlaştırma, bellek ve yargılama ile ilişkili sorunları olabilir. Karar vermek onun için çok güçtür. Yaptıklarının farkına varmadığı dönemler olabilir ve bu dönemler obsesif düşüncelerle birleşirse aklını kaybetme korkularına yol açabilir.

J.A.K.'ın bağımlılık gereksiniminin son derece güçlü olduğu görülüyor. Sorunlarla ve stres durumlarıyla kendi başına mücadele edemeyeceğini düşünüyor ve destek için başkalarına yöneliyor. Başarılı olmaya ihtiyacı var ve amaçlarına ulaşamayınca kendini suçluyor. Bağımlılık gereksinimini karşılamadıklarını düşündüğü kişilere düşmanca ve saldırganca dürtüler beslemesine rağmen bu olumsuz duygulardan rahatsız oluyor ve doğrudan ifade edemiyor.

J.A.K.'a göre dünya destekleyici olmayan ve tehdit edici bir yer. Kendini kontrol edemediği güçlerin insafına kalmış gibi hisse diyor. Kuşku, alaycı ve güvensiz. Diğer insanların kendisini anlamadığını ve kötü davrandıklarını düşünüyor. Sorunlar karşısında gösterdiği tepki, inkar etmek ve hayal dünyasına sığınmak oluyor. Bunlar işe yaramadığında aşırı bunalması, dezorganize ve uyumsuz davranışlar sergilemesi mümkün. Sorunlar daha ortada yokken sıkıntısını yaşamaya başlıyor ve strese karşı aşırı tepkiler gösteriyor.

J.A.K.'ın benlik kavramı son derece olumsuz. Bu, yaşam tarzı ile iyice bütünleştiği için, kolay değişmeyebilir. J.A.K. olgun heteroseksüel ilişkiler kurmada güçlük çekiyor olabilir. Kendi erkekliği hakkında kuşkuları var ve kadınları öncelikle kendi bağımlılık gereksinimini doyuracak kaynaklar olarak görmekte. J.A.K. çoğu zaman aşırı kontrollü davranan bir kişi; olumsuz duygularını doğrudan anlatmaktan çekiniyor, fakat pasif-saldırgan davranışlar beklenebilir. J.A.K.'ın insanlarla olan ilişkileri doyum verici değil ve çok yüzeysel. Diğer insanlara ihtiyaç duymasına ve derin duygusal ilişkiler kurabilecek yeteneği olmasına rağmen reddedilme ve/veya istismar edilme korkusuyla insanlara yaklaşımdan kaçınıyor. Kolay arkadaş edinemiyor ve başkalarında uzak, soğuk, anlaşılması güç bir insan izlenimi bırakıyor. İnsanlararası ilişkilerde çok pasif bir kişi, gerçek duygularını çok nadiren ifade ediyor. Başkalarının tepkilerine karşı çok duyarlı ve eleştiriden kolayca yaralanabiliyor. Sorunlarıyla yüzleşmekten

kaçınıyor. Son derece huzursuz olmasına rağmen, yaşam sorunlarıyla kendi düşündüğünden daha iyi başa çıkabiliyor. Kendisi için yüksek standartlara sahip, güvenilir ve dürüst bir kişi. Çalışmaktan ve başarılı olmaktan hoşlanıyor.

J.A.K.'ın sorunları büyük ölçüde kendine gerçekçi olmayan, yüksek standartlar ve amaçlar seçmesinden kaynaklanmaktadır. Bu tür tutumlara genellikle hiçbir şekilde memnun olmayan mükemmelliyetçi ana-babaların istekleri neden olur. J.A.K. bağımlı ve boyun eğici davranışlarla diğer insanlardan destek ve sempati elde etmeye çalışmaktadır. Onun bu tutum ve davranışları karşısında başkalarının düşmanca ve olumsuz bir tarzda davranmaları pek mümkün değildir. Derin duygusal bağlardan uzak durarak insanların kendisini incitmelerini önlemeye çalışmaktadır.

Erkekliği konusunda duyduğu yetersizliğin, babasıyla yaptığı hatalı identifikasyondan kaynaklanması mümkündür. İnsanlara bağımlılık gereksinimini yeterince karşılamadıkları ve kendisinden, verebileceğinden fazlasını istedikleri için öfke duymaktadır. J.A.K. için en uygun tanılar nevrotik depresyon ve anksiyete nevrozudur. İçinde bulunduğu yoğun huzursuzluk nedeniyle psikoterapiyi ya da psikolojik danışmayı kabul etme konusunda istekli olabilir. Başlangıçta rasyonalizasyon ve entellektüalizasyona çok fazla başvurabilir, terapistle yakın bir ilişki kurmaya yanaşmayabilir. Ancak terapiye uzun süre devam etmesi ve yavaş fakat düzenli bir ilerleme göstermesi mümkündür. Terapide ilk amaç, benlik beklentilerinin incelenmesi ve yeniden değerlendirilmesi olmalıdır. Terapistle anlamlı ve yakın bir ilişki kurduğunda korku ve çatışmalarını kabul edebilir ve onlarla daha etkin bir biçimde başa çıkmanın yollarını bulabilir.

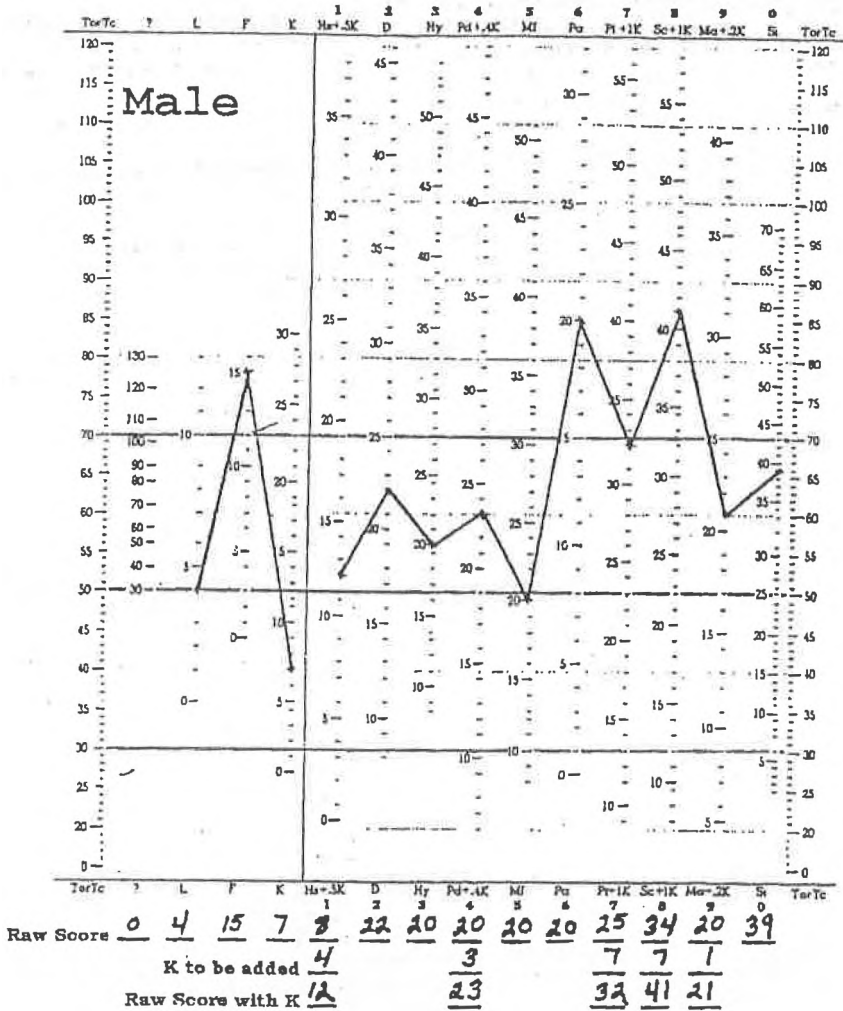
ALİŞTIRMA İÇİN EK PROFİLLER

Aşağıda, ilki MMPI profilinin kısa yorumu sunulmuştur. Alistirma yapmak isteyen okuyucu, önce profilleri kendisi yorumladıktan sonra bu yorumları kitaptakilerle karşılaştırabilir.

Şekil 8' deki profil, testi tamamladığı sırada bir psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören 41 yaşındaki bir erkeğe (D.A.V.) aittir. Evli, 11 yıl resmi eğitim görmüş, o sıralarda kamyon sürücüsü olarak çalışan bir kişidir.

D.A.V. testi yanıtlarken çok açık ve içten davranmıştır; öyle ki kendini biraz fazla eleştirmiş bile olabilir. Açıkça normalden sapmış pek çok davranışı olduğunu kabul etmiştir. Duygusal açıdan oldukça rahatsız gibi görünmektedir. Yeti kaybına yol açan anksiyete ya da depresyondan söz etmemesine rağmen, dikkat ve dikkati yoğunlaştırmayla ilişkili sorunları vardır, bellek yetersizliklerinden yakınabilir. Düşünce bozukluğu belirtilerine rastlanabilir.

Şaşkın, dezoryante ve dezorganize görünebilir. Düşünce parçalanmış, otistik ve garip olabilir. Kuşkuculuğu, hallüsinasyonları, büyüklük ve/veya kötülük görme delirilerini ve gerçek dışılık hissiyi içeren, açık bir paranoid yönelim bulunabilir. Aynı zamanda uzun süreli bedensel yakınmalar belirtebilir.

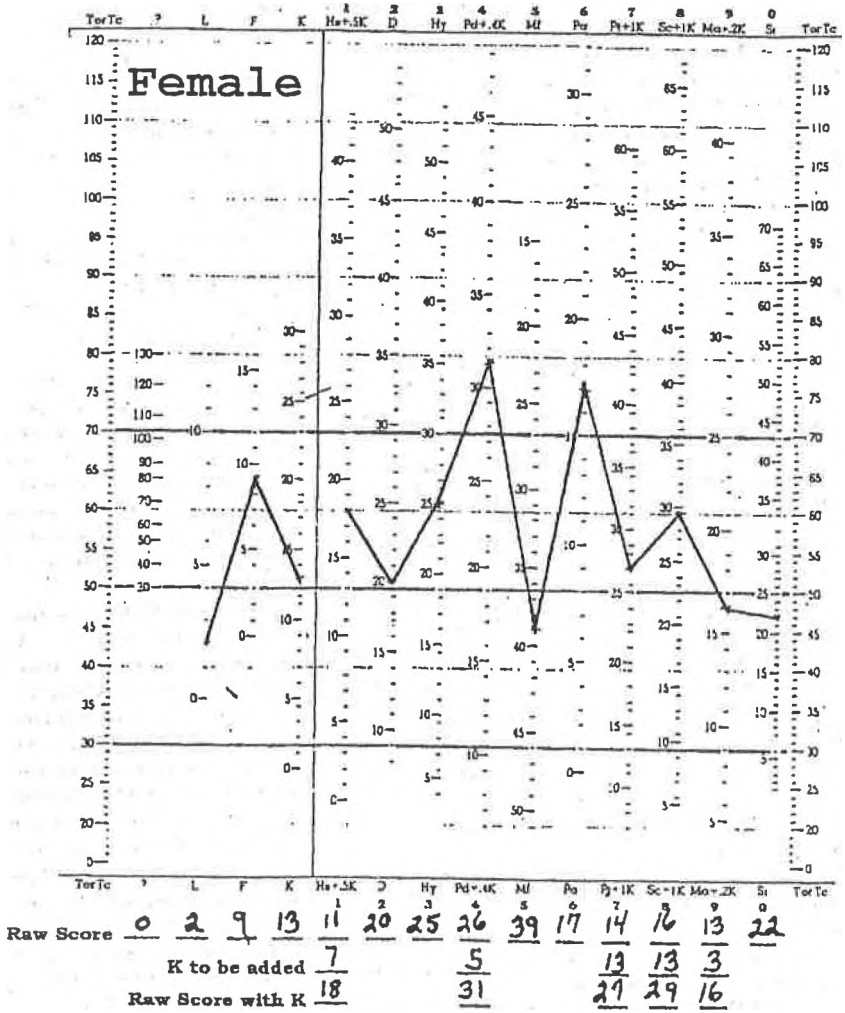


Şekil 8. D.A.V vakasının MMPI profili

D.A.V. dünyayı destekleyici olmayan ve tehdit edici bir yer olarak algılamaktadır. Günlük yaşam sırasında kendinden beklenenleri yerine getiremediğini düşünmektedir. Kendini yetersiz ve küçük görmektedir. Yaşamda başarısız olduğu için suçluluk duymaktadır. Strese karşı gösterdiği tepki hayal dünyasına sığınmaktır, bazen gerçek ile hayali birbirinden ayırmada güçlük çekebilir.

D.A.V. yaşama kuşkucu ve kötümser bir tutumla yaklaşmakta, insanlara güvenmemektedir. Başkalarından kötü muamele gördüğünü düşündüğü için öfkeli ve gücenmiştir. Ancak bu olumsuz duygularını uygun bir biçimde anlatamamaktadır. Diğer insanların davranışlarına kuşkuyla yaklaşır ve insanlarla arasına psikolojik bir uzaklık koyar. Başkaları üzerinde soğuk, uzak ve anlaşılması güç bir kişi izlenimi bırakır. Bir çok konuya ilgisi olabilir ancak amaçları belirsiz ve soyuttur; gösterdiği en üstün başarı ortalama düzeydedir. Soyut ve teorik konularla aşırı uğraşabilir. D.A.V için en uygun tanı paranoid tip şizofrenidir. Davranışları ve sorunları hakkında çok az içgörüsü vardır. Kendi sorunlarının sorumluluğunu kabul etmek istemez. Hata ve kusurları için başka insanları suçlar. Dirençli olmasına rağmen terapistle arasında anlamlı bir ilişki kurulabilirse tedaviye devam edebilir, giderek terapistle güvenmeye başlayabilir. Semptomları ortadan kaldırmada antipsikotik ilaç tedavisi yararlı olabilir.

Şekil 9 'daki profil lise eğitimi görmüş, 28 yaşındaki bir ev kadınına (M.A.R.) aittir. Kendisine bir toplum ruh sağlığı merkezine ayaktan hasta olarak devam ettiği sırada MMPI uygulanmıştır. M.A.R.'ın MMPI'a yaklaşımı oldukça dürüst ve açık olmuştur. Testi yanıtlarken ne çok fazla kendini eleştirmiştir ne de aşırı savunmacı davranmıştır. Kabul ettiği sapmış davranışların özel bazı sorun alanlarında (örneğin, cinsel endişeler, evlilik sorunları gibi) toplandığı görülmüştür. Yaşamından hoşnut olmamasına rağmen, muhtemelen yeti kaybına yol açan anksiyete ve depresyon duygularından uzaktır. Açıkça psikotik davranışların görülme olasılığı düşüktür. Ciddi duygusal sorunlarını inkar ederek, problemlerini evlilik uyumsuzluğu olarak görmesi mümkündür. M.A.R diğer insanlardan sempati ve ilgi bekleyen, olgunlaşmamış, narsisistik ve kendine karşı hoşgörülü bir kişidir. Ancak kendisi, başkalarının küçük isteklerini bile hoş karşılamayabilir. Geleneksel kadın rolünü oldukça iyi benimsediği, erkeklerle ilişkilerinde pasif, bağımlı ve boyun eğici olduğu görülmektedir. Buna rağmen, benimsediği bu geleneksel rolde kendini rahatsız hissediyor olabilir ve daha girişken olma isteği taşıyabilir. Cinsel identifikasyon sorunlarının bulunması ve kadınlığını ispatlamak için gelişigüzel cinsel ilişkilere girmesi mümkündür.



Şekil 9. M.A.R vakasının MMPI profili

Toplum yaşamını seven ve dost tavırlı bir kişi olarak ilk bıraktığı izlenim olumlu olabilir ancak gerçekte insanlarla, özellikle erkeklerle olan ilişkileri iyi değildir; sosyal ortamlarda oldukça huzursuzdur. Diğer insanların davranışlarını ve isteklerini kuşkuyla karşılar ve derin emosyonel bağlardan kaçınır. İnsanlarla daha çok, kendisine yarar sağlayabileceklerini düşündüğünde ilgilenmektedir.

M.A.R. davranışlarının sonuçlarını düşünmeksizin harekete geçen impulsif bir kişidir. Engellenmeye karşı dayanma gücü düşüktür. İsteddiği olmadığında sabırsızlanır ve sinirlenir. Zaman zaman patlamalar şeklinde ortaya çıkan öfke ve düşmanlık dönemleri sergileyebilir. Geleneksel psikoterapilerde kötü bir prognoz beklenmektedir. Duygusal sorunlarını önemli bulmadığı için tedaviyi kabul etmemesi mümkündür. Eğer başı dertte ise (örneğin, adli bir sorun veya ciddi bir evlilik sorunu varsa) tedaviye razı olabilir ancak içinde bulunduğu stres dönemi sona erdiğinde tedaviyi yarım bırakabilir. Entellektüalizasyon ve rasyonalizasyona çok yatkındır; sorunları için başkalarını, özellikle ana-babasını suçlar. Eğer çevresel stres etkenleri uzun süre devam ederse, terapide değişmeye çalışması mümkündür.

SON BİR YORUM

Bu bölümün amacı, okuyucuya, MMPI verilerinden çıkarılanları, özgün bir vakanın anlamlı bir tablosunu verecek şekilde bütünleştirebilmesi için yol göstermek olmuştur. Kuşkusuz, MMPI uygulayıcıları daha çok beğendikleri başka yaklaşımlar olduğunu göreceklerdir. Ancak, testi yeni kullanmaya başlayanlar, burada önerilen yorumlama yaklaşımını en azından kendi tarzlarını geliştirmeleri için gereken beceri ve tecrübeyi kazanıncaya kadar kullanabilirler.

VIII

MMPI KİŞİLİK ENVANTERİNİN BUGÜNKÜ DURUMU

Doç.Dr. Oya Sorlas

MMPI kişilik envanteri, yaklaşık 50 yıldır ABD' de en çok kullanılan kişilik testi olma özelliğini sürdürmektedir. Butcher ve Keller (1984), 1978-1982 yılları arasında yayınlanan makalelerin % 87 sinde temel kişilik testi olarak bu eski envanterin kullanıldığını saptamışlardır. Pek çok dile çevrilen envanter ülkemizde de oldukça sık kullanılan bir değerlendirme aracıdır. Bir örnek olarak, 1988-1992 yılları arasında Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde sunulan bildiriler incelendiğinde, bir kişilik testinin kullanıldığı araştırmalarda en çok MMPI'nin tercih edildiği görülmüştür. MMPI kişilik envanterinden sonra en çok kullanılan test Rorchach olarak belirlenmiştir. Çok az olmakla birlikte Cattell'in 16 Kişilik Faktörü (16 PF), Eysenck Kişilik Envanteri, Cesarec-Marke Kişilik Envanteri gibi testlerin de kullanıldığı görülmüştür.

Keller, Butcher ve Shutske (1990), MMPI'nin yıllardır, araştırma yayınlarında hakimiyetini korumakla birlikte, üzerinde çalışılan örneklem ve ilgi odağına göre bir değerlendirme yapıldığında, durumun biraz değiştiği belirtmişlerdir. Yazarlara göre, normal örneklem üzerinde yapılan ya da kişilik yapısını araştıran çalışmalarda 16 PF ve Kişilik Araştırma Formu (PRF) daha çok kullanılmaktadır. Tercihteki bu değişikliği, bu araçların hem teorik hem de psikometrik açıdan MMPI'a kıyasla daha gelişmiş olmalarıyla açıklamışlardır.

Klinik uygulama ve araştırmaya gelince MMPI'a rakip olabilecek başka bir test yok gibidir. Kuşkusuz, bu eski envanterin en önemli üstünlüğü, görgül(empirical) araştırma verilerinden oluşan kapsamlı bir yayın temeline sahip olmasıdır. Özellikle klinik uygulamalarda, önemli kararların verilebilmesi bu tür araştırma verileri sayesinde mümkün olmaktadır.

Ayrıca MMPI testinin gelişim öyküsünü ve zaman içinde geçirdiği değişiklikleri incelemek de, bize envanterin niçin hala popülerliğini koruduğu konusunda bir fikir verebilir. Eldeki araç, elli yıl içinde sürekli klinisyenlerin ve araştırmacıların değişen gereksinimlerine uyarlanmıştır. Bilindiği gibi envanter, psikolojik testlerden çok şeylerin beklendiği yıllarda büyük umutlarla yayınlanmıştır. Ancak envanterin klinik ölççeklerinin bek-

lendiği gibi belli psikopatoloji tiplerinin saf bir ölçümü olmadığı kısa zamanda anlaşılmıştır. Bunun üzerine her ölçeğin bilinmeyen özellikleri ölçtüğü kabul edilerek klinik uygulamalar ve görgül çalışmalarla bu bilinmeyen özelliklerin neler olduğu belirlenmiştir. Daha sonra profilde ölçeklerin oluşturduğu örüntünün anlamı üzerinde durulmaya başlanmıştır. Bu kez de ölçeklerdeki yükselmeler tek tek değil de birlikte ele alınarak görgül karşılıkları araştırılmıştır. Bunun ardından içerik ve faktör analizine dayanan çeşitli yaklaşımlarla test maddeleri gruplandırılarak yorum stratejileri daha da zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Yukarıda özetlenen bu değişim süreci bugünde MMPI-2 ile devam etmektedir.

MMPI KİŞİLİK ENVANTERİNİN REVİZYONU VE YENİDEN STANDARDİZASYONU

Yetmişli yılların sonlarında, Amerikan psikoloji ve psikiyatri dergilerinde yayınlanan makalelerde MMPI kişilik envanteriyle ilişkili eleştiriler artmıştır. Bu eleştirilerin büyük bir kısmı envanterin giderek "yaşlanmasından" kaynaklanıyordu. Testin dilinin eskidiği, bazı maddelerin anlaşılmadığı, modasının geçtiği ya da itiraz edildiği açıkça görülmüyordu. Envanter, giderek, personel seçimi gibi klinik dışı amaçlar için de kullanıldığı için, cinsel uyum, bedensel işlevler ya da dindarlıkla ilişkili maddeler gereksiz görünmeye başlamıştı. Şimdiki normallerin, orijinal normatif örneklemdaki normallerden daha fazla sorun kabul ettikleri ve buna bağlı olarak da klinik ölçeklerin daha çok yükseldiği görülmekteydi. MMPI'nin norm grubuna, öteden beri çeşitli eleştiriler yöneltilmiştir. Minnesota normalleri diye adlandırılan bu grup bundan 50 yıl önce Amerika'nın yalnızca bir bölgesinde yaşayan ve muhafazakar kişileri temsil eden küçük bir örneklemden oluşmaktaydı. Nitekim, Colligan, Osborne, Swenson ve ark. (1984) tarafından toplanan veriler eski normların şimdiki Amerikan normallerini temsil etmediğini düşündürmüştür. Ayrıca orijinal norm grubunda siyahların temsil edilmemesi de öteden beri çeşitli tartışmalara neden olmuştur (Butcher, Braswell ve Raney (1983).

Bunun üzerine Minnesota Üniversitesi, 1982 yılında, envanteri yenilemek, güncelleştirmek ve yeniden standardize etmek için büyük bir araştırma başlatmıştır. Butcher, Graham, Dahlstrom ve Tellegen'den oluşan bir komite MMPI'nin yeni gelişiminde aşağıdaki amaçları hedeflemiştir (Keller, Butcher ve Slutske, 1990):

1. Envanterin mevcut geçerlik, klinik ve sık kullanılan özel bütünlüğü korumak.
2. Maddelerin bazılarını dili eskidiği için değiştirmek.
3. Madde havuzunu ilk MMPI'da bulunmayan, tedaviye uyma, değişimde sorumluluk alma, iş tutumu gibi yeni konuları da içine alacak şekilde genişletmek.
4. Envanteri günümüzün normal popülasyonunu daha iyi temsil eden bir örneklem üzerinde yeniden standardize etmek.
5. Yetişkinler ve gençler için ayrı MMPI formları hazırlamak.

Revizyon çalışmasını yürüten komite bir yandan orijinal araçla bütünlüğü korumaya çalışırken bir yandan da envanterin kapsamını ve yararını artırarak kullanıcılar tarafından daha fazla onay görmesini sağlamaya çalışmıştır. Komite, orijinal MMPI ve onun çok kapsamlı araştırma temeliyle devamlılığı sağlamak için, tüm MMPI madde havuzunun (550 madde) yeni test kitapçığında yer almasına karar vermiştir. Böylece, uygulayıcıların hem eskisi gibi MMPI'ı puanlamaya ve yorumlamaya devam etmeleri, hem de yeni araç için veri toplamaları sağlanmıştır. Orijinal MMPI da tekrarlayan 16 madde çıkartılarak yerine yeni maddeler konmuştur. Ancak tekrarlayan maddeler orijinal MMPI'da puanlanmadığı için bu değişiklik temel MMPI ölçeklerinin puanlarını etkilememiştir.

Orijinal maddelerin yaklaşık %14 ü, dili ya da içeriği eskidiği, gramer hatası bulunduğu için değiştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda yeniden yazılan bu 82 maddenin MMPI'in psikometrik özelliklerini pek fazla etkilemediği görülmüştür.

Revizyon çalışmasında kullanılan deneme kitapçığına eski maddelerin yanı sıra, 154 yeni madde ilave edilmiştir. Bu maddeler, MMPI uzmanlarından oluşan büyük bir grubun, daha fazla araştırılmasını yararlı bulduğu sorunları içermektedir. Envanterin ergen formu için deneme kitapçığına da, benzer şekilde, eski maddelerin yanı sıra 154 madde daha eklenmiştir. Bu maddelerin 104'ü ergenlik sorunlarını, 50'si ise tedavi sorumluluğunu araştırmaktadır.

MMPI-2'nin yeni standardizasyonu, tüm Amerikan nüfusunu demografik açıdan temsil ettiği düşünülen 2600 kişilik bir örneklem üzerinde yürütülmüştür. Normal örneklemin MMPI verileriyle birlikte biyografik, demografik özellikleri ve yaşam olayları kaydedilmeye çalışılmıştır. Ayrıca yetişkin örnekleminden seçilen ve evli çiftlerden oluşan bir grupta, eşlerden birbirlerinin davranışlarını, kişilik özelliklerini ve evlilik ilişkilerini değerlendirmeleri istenmiştir. Standardizasyon projesinde ergenler için ayrı normların toplanması planlanmıştır.

Revizyon çalışmasını yürüten komite, yeni normları yavaş yavaş kullanıma sokma kararı almıştır. Ayrıca MMPI testini kullanan klinisyen ve araştırmacılara yeni normlarla eski normları karşılaştırma imkanı verecek materyaller hazırlamaya çalışmışlardır. Bu amaçla MMPI-2 nin el kitabında norm karşılaştırmalarını kolaylaştıran tablolar verilmiştir.

Görüldüğü gibi hem çok kapsamlı hem de çok ihtiyatlı bir revizyon çalışması yürüten komite hızlı ve köklü değişikliklerden olabildiğince kaçınmaya çalışmıştır. Bunun nedenlerinden biri, büyük uygulayıcı kitlesinin MMPI-2'yi orijinal MMPI gibi benimsemesi sağlamaktır. Diğer ise, eski MMPI yayınlarından ve araştırma verilerinden yararlanabilmektir.

Aşağıda, 1989 yılında tamamlanan revizyon çalışması sonucu MMPI-2 meydana gelen temel değişiklikler özetlenmiştir:

MMPI-2'DEKİ TEMEL DEĞİŞİKLİKLER*

MADDELER	MMPI'da 566 madde vardır. MMPI-2, 567 maddesiyle ilk envanterle hemen hemen aynı uzunluktadır. Ancak, tek-rarlayan, modası geçen ve itiraz edilen maddeler çıkarılmıştır. Ayrıca ilk MMPI'da bulunmayan yeni içerik alanlarına yönelik çok sayıda madde vardır
NORMLAR	MMPI'nin norm grubu temelde 724 kişilik Minnesota hastanesi ziyaretçilerinden oluşmuştur ve azınlıklar çok azdır. MMPI-2'nin normları Amerikan nüfusunu temsil eden 2600 kişilik bir yetişkin örneklemine dayanmaktadır ve azınlıklar ilkinde kıyasla daha fazladır.
T PUANLARI	MMPI'da, ham puanlara dayanarak T puanları hesaplanırken basit doğrusal dönüşüm kullanılmıştır. MMPI-2'de ölçeklerin ham puanları T puanlarına aynı pozitif eğimi verecek şekilde dönüştürülmüştür.
GEÇERLİK ÖLÇEKLERİ	MMPI'da profilin geçerliği, P, L, F, ve K ile belirlenir. MMPI-2'de bu standart geçerlik ölçekleri korunmuştur. Ayrıca, üç yeni geçerlik ölçeği eklenmiştir. Bunlar: F ölçeğine benzeyen fakat cevap kağıdının arka yüzündeki maddelerin puanlanmasından elde edilen Arka F (Fb), dikkatsizliği değerlendiren VRIN ve kabul etme tutumunu değerlendiren TRIN ölçekleridir.
KLİNİK ÖLÇEKLER	MMPI'nin 10 klinik ölçeği MMPI-2'de temelde değişmeden kalmıştır. Ancak ölçeklerin bazıları, modası geçmiş ya da itiraz edilen maddelerin çıkarılmasıyla biraz kısalmıştır.
ARAŞTIRMA ÖLÇEKLERİ	MMPI'nin sık kullanılan araştırma ölçeklerinden A, R, Es, O-H, Do, Re ve MT, MMPI-2'de de puanlanabilmektedir. En tanınmış ilave ölçeklerden biri olan MAC, MMPI-2'de revize edilmiştir
İÇERİK ÖLÇEKLERİ	MMPI'da, Wiggins, Harris-Lingoes ve Serkownek içerik ölçekleri sık kullanılmaktadır. MMPI-2'de, bunlardan Harris-Lingoes ve Serkownek ölçekleri korunmuştur. Wiggins ölçeklerinin yerini 15 yeni içerik ölçeği almıştır. "O" için üç yeni alt ölçek vardır.

* Finn ve Butcher (1991)

TÜRKİYE'DE YAPILAN MMPI ARAŞTIRMALARI

MMPI kişilik envanteri, altmışlı yılların sonlarında Türkçeye çevrilererek ülkemizdeki bazı üniversitelerde araştırma amacıyla kullanılmaya başlanmıştır (Cansever ve Gürkaynak 1965; Toğrol 1968). Aynı yıllarda, Test Araştırma Kurumu da envanterin bir çevirisini yayınlamıştır. Bu çeviri daha sonra Savaşır (1978) tarafından iki kez gözden geçirilerek düzeltilmiştir. Envanterin günümüzde kullanılan Türkçe çevirisi ve Türk toplumu için standardizasyonu Savaşır tarafından yapılmıştır.

Savaşır (1978), standardizasyon çalışmasına başlamadan önce, bir ön çalışma yaparak envanterin Türk toplumu için uygun olup olmadığını araştırmıştır. 1974 yılında 130 normal ve 130 hasta üzerinde yürütülen bu çalışmada hem Türkçe formun hem de çevirinin güvenilirliği konusunda olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Envanter bir hafta ara ile 20 kişiye iki kez uygulandığında geçerlik ve klinik alt testler için elde edilen güvenilirlik kat sayıları Tablo I'de gösterilmiştir.

Aynı çalışmada envanterin Türkçe ve İngilizce formları iyi İngilizce bilen kişilere bir hafta ara ile iki kez verilerek, alt testler arasındaki korelasyonlar incelendiğinde, elde edilen katsayıların 0.46 ile 0.89 arasında değiştiği görülmüştür. Bu ön araştırmada olumlu sonuçlar elde eden Savaşır, envanterin Türk toplumu için standardizasyon çalışmasını da yürüterek elde ettiği verileri 1981 yılında "Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri-El Kitabı (Türk Standardizasyonu)" adı altında yayınlamıştır. Bu kitapta, envanterin ve Türk normal örnekleminin özellikleri tanıtılmış, ham puanlara karşılık gelen T puanı tabloları verilmiş ve Türk toplumundan elde edilen ortalamalar farklı kültürlerden elde edilen ortalamalarla karşılaştırılmıştır. Standardizasyon çalışmasının en önemli bulguları, Türk normal örnekleminde, F ve Sc ölçeklerinin Amerikan normal örneklemine kıyasla bir standart sapma yüksek bulunması olmuştur. Bu ölçeklere ilaveten erkeklerde Mf, kadınlarda ise Pa ölçeklerinin yine Amerikan normlarına kıyasla bir standart sapma daha yüksek olduğu görülmüştür.

Alt Testler	Güvenirlik Katsayıları
L	0.63
F	0.53
K	0.88
Hs	0.89
D	0.77
Hy	0.82
Pd	0.87
Mf	0.81
Pa	0.51
Pt	0.84
Sc	0.86
Ma	0.70
Si	0.89

Tablo I. MMPI test-tekrar test güvenilirliği (Savaşır, 1978)

Türk standardizasyon verilerinin yayınlanmasından önce başlayan ve Amerikan normlarının kullanıldığı çalışmalarda da oldukça benzer bulguların elde edildiği görülmüştür. Toğrol (1981), normal üniversite öğrencileriyle yaptığı araştırmasında hem kızlarda hem erkeklerde D, Pa ve Sc alt testlerinin T puanının 70'in üzerine çıktığını bulmuştur.

Savaşır (1981) ve Toğrol'un (1981) yanısıra başka araştırmacılar da (Butcher, Braswell ve Raney, 1983) MMPI sonuçlarının kültürel özelliklerden önemli ölçüde etkilendiğini gösteren kanıtlar elde etmişlerdir. Testin maddeleri incelendiğinde bu durum doğal görünmektedir. Çünkü envanterin 550 maddesinden yalnızca 286 tanesi psikiyatrik, nörolojik ya da fiziksel semptomlarla ilişkilidir. Geri kalanlar ise, cinsel, politik ve sosyal tutumlar, ahlaki değerler, alışkanlıklar, aile ve evlilik ilişkileri, mesleki ve eğitimsel sorunlar gibi yanıt tarzı kültürden kültüre farklılık gösterecek maddelerdir.

Standardizasyon çalışması tamamlandıktan sonra envanter hem bilimsel araştırmalarda hem de kliniklerde daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Testin geçerliğini sağlayan ilk çalışma Erol(1982) tarafından yayınlanmıştır. Bu çalışmada örneklem, 1000 psikiyatrik hasta 1000 normal olmak üzere 2000 kişiden oluşmuştur. Hasta örneklemini Feighner ve arkadaşları tarafından geliştirilen tanı ölçütlerine göre psikotik, nevrotik ve kişilik bozukluğu olmak üzere üç büyük gruba ayrılarak ortalama profiller normallerinkilerle karşılaştırılmıştır. Tüm hasta grubu cinsiyete göre ikiye ayrılarak normallerle karşılaştırıldığında erkeklerde L, K ve Mf dışında kalan tüm alt testlerin kadınlarda ise F, Sc, D, Pa ölçeklerinin bir standart sapma ve üzerinde yükseldiği belirtilmiştir.

Erol, nevroz tanısı alan erkeklerde en yüksek alt testleri 1, 2 ve 3, kadınlarda 2, 3 ve 1 olarak bulmuştur. Her iki grupta da nevrotik üçlü diye bilinen alt testlerin erkeklerde daha belirgin olmak üzere diğer klinik ölçeklerden yüksek olduğu belirtilmiştir. Psikotik bozukluk tanısı alan erkeklerde nevrotik grupta yükselmeyen 8, 6 ve 7 nin yükseldiğini bu alt testlerde ve 2 de T puanının 70 civarında olduğunu saptamıştır. Kadın psikotik hastalarda ise 8 en yüksek alt test olarak bulunmuş; tüm alt testlerin T puanının 60-65 arasında olduğu dikkati çekmiştir. Çalışmada tanılara uygun kod tipleri şu şekilde belirlenmiştir:

Nevrotik Bozukluk : 1, 2, 3, 7 ve 12/21, 13/31, 23/32, 27/72

Psikotik Bozukluk : 28/82, 68/86, 69/96, 78/87

Kişilik Bozukluğu : 49/94, 43/34, 40/04

Sonuç olarak, MMPI kişilik envanterinin ülkemizde de çeşitli tanı gruplarını birbirinden ve normallerden ayırt ettiğini belirten Erol, bizim hasta örnekleminizde ortalama puanların sıklıkla 60-70 T puanı arasında bulunduğuna değinerek, bu aralıkta kalan yükselmelerin de patolojik yönden anlamlı olabileceğini ileri sürmüştür.

Erol (1984), bir başka araştırmasında, Türk standardizasyon grubundan seçilmiş 1003 kişilik bir örneklem üzerinde MMPI maddelerinin "doğru" olarak yanıtlanma ve boş bırakılma yüzdelerini belirleyerek, Ameri-

kan normal örneklemeden elde edilen sonuçlarla karşılaştırmıştır. 566 maddeden 162 tanesinin (% 29) Amerikan normallerinden farklı şekilde yanıtladığı bulunmuş, Türk örnekleminde bedensel yakınmaları içeren sağlıkla ilişkili maddeler daha fazla onaylanırken, cinsel yaşam ve dinle ilişkili maddelerin Amerikan örneklemine kıyasla daha fazla boş bırakıldığı görülmüştür. Araştırmada dikkati çeken bir başka bulgu Paranoya ölçeğindeki bazı maddelerin Amerikan örnekleminde farklı olarak daha fazla onaylanması olmuştur. Bunlar, "Kimse beni anlamıyor", "Başkaları engel olmasaydı daha başarılı olurdum", "Birisi zihnimi kontrol ediyor" ve "Birçok kimseden daha hassasım" şeklindeki maddelerdir. Türk örnekleminde "Babam iyi bir adamdır", "Annem iyi bir kadındır", "Allahın varlığına inanırım", "Tanıdıklarımın çoğu beni sever", "Davranışlarımı çoğu zaman etrafındakilere göre ayarlarım" şeklindeki maddelerin % 90 - % 99 oranında doğru olarak yanıtlanması duygusal sorunların daha güç kabul edildiği şeklinde değerlendirilmiştir.

Erol'un yukarda sözü edilen çalışmasının ardından, Yaparel (1990), MMPI Kişilik Envanterinde kullanılan dini içerikli maddelerin güvenilirlik ve geçerliğini İlahiyat Fakültesi Öğrencileri arasından seçtiği 30 kişilik bir örneklem üzerinde araştırmıştır. Yaparel, MMPI testinde bulunan dini içerikli 16 maddenin pek çoğunun (ör: "Ahirete inanırım") kendi örnekleminde kabul gördüğünü, dini inançlardan çok psikopatolojiyi yansıtan birkaç maddenin (ör: "Tanrı bana özel bir görev vermiştir") ise kabul görmediğini ya da "kararsızım" şeklinde yanıtladığını bildirmiştir.

Klinik örneklemler üzerinde yapılan çalışmalarda MMPI ölçeklerinden bazılarının diğerlerine kıyasla daha sık yükseldiği bulunmuştur. Örneğin, Hathaway ve Meehl (1980) psikiyatrik hastalar üzerinde yaptıkları bir çalışmada, erkeklerde en sık görülen kodları 27, 21 ve 13, kadınlarda 27, 31 ve 13 olarak saptamışlardır. Aynı yazarlar normalerle yaptıkları çalışmada deneklerin büyük bir kısmında T değeri 54'ün üzerine çıkan bir ölçeğin bulunmadığını bildirmişlerdir. Biz de (Sorias, Sorias ve Inceer, 1984) psikiyatrik hastalardan oluşan 206 kişilik bir örneklem üzerinde yaptığımız bir çalışmada bazı ölçeklerin diğerlerine kıyasla daha sık yükseldiğini bulduk. Hathaway'ın, kodlama sistemini kullandığımız araştırmada Türk klinik örnekleminde en sık yükselen ölçek 2 olarak belirlendi. Tüm örnekleme en sık rastlanan ikili kod 27'yi, sırayla 23, 28, 87 ve 21 kodları izledi. Erkeklerin %40' ında depresyonun en yüksek ölçek olduğu görüldü. Buna karşılık kadınlarda erkeklerde ve diğer klinik örneklemlerde çok az görülen 67 ve 96 kodlarına grubun yaklaşık %10 da rastlanması dikkat çekici bulundu. Tek basamaklı koda, yani yalnızca bir ölçeğin yükselmesine ise çalışma grubumuzda hiç rastlanmadı. Tablo II'de çalışma grubumuz ile Minnesota Klinik Örnekleminde en sık görülen MMPI kodları karşılıklı sunulmuştur.

KOD	E.Ü Psikiyatri Kliniği Hasta örnekleme	Minnesota Psikiyatri Kliniği Hasta örnekleme
13	% 3.6	% 6.6
21	% 4.6	% 5.0
23	% 6.1	% 4.5
27	% 11.4	% 9.0
28	% 4.9	% 2.2
31	% 0.5	% 5.3
87	% 4.9	% 2.5

Tablo II: Ege Üniversitesi ve Minnesota klinik örneklemelerinde en sık görülen MMPI kodları

Savaşır ve Erol (1990), Türkçe MMPI'nin faktör yapısı ile başka kültürlerde yapılan araştırmalarda gözlenen faktör yapısı arasında önemli benzerlikler olduğunu belirtmişlerdir. Yazarlar, normal Türk erkeklerinde birinci, normal Türk kadınlarında ise ikinci faktörün, farklı milletlerden kişilerle yapılan çalışmalarda gözlenen "psikotiklik" faktörüne çok benzediğini bulmuşlardır. Ancak aynı çalışmalarda, ikinci faktör olarak ayrılan ve "aşırı kontrol" diye adlandırılan ikinci faktör Türk örnekleminde yalnızca kadın psikiyatrik hastalarda gözlenmiştir. Kadın ve erkek Türk psikiyatrik hastalardan oluşan örnekleme saptanan faktör yapısı, üç farklı miletten (Amerikalı, İtalyan ve İsviçreli) psikiyatrik hastalarda saptanan faktör yapısı ile karşılaştırıldığında benzerliğin daha çarpıcı olduğu belirtilmiştir. Kadın Türk psikiyatrik hasta örnekleminde farklı kültürlerden gelen psikiyatrik hastalarda olduğu gibi, "nevrotiklik", "psikotiklik" ve "aşırı kontrol" faktörleri ortaya çıkmıştır. Aynı faktör yapısı, "aşırı kontrol" dışında erkek Türk hasta örnekleminde de gözlenmiştir.

Ülkemizde, MMPI testinin DSM-III kriterlerine göre konan psikiyatrik tanıları ne ölçüde ayırdettiğini araştıran çalışmalar da yapılmıştır. Böyle bir çalışmada (Sorias, 1992), dört ayrı DSM-III tanı grubunda MMPI testinin klinik ölçeklerinin ayırt edici geçerliği hem Türk hem de Amerikan normlarına göre ayrı ayrı incelenmiştir. Şizofrenik bozukluk (n = 61), distimik bozukluk (n = 32), major depresyon (n = 31) ve somatoform bozukluk (n = 47) tanısı almış toplam 171 hastanın klinik ölçeklerden aldıkları ortalama puanlar varyans analiziyle karşılaştırılmıştır. Sonuçta, Türk ve Amerikan normlarına göre hesaplanan T puanı ortalamaları arasında önemli farklar olmasına rağmen bu farkların ölçeklerin hasta gruplarını ayırt etme gücünü etkilemediği görülmüştür. Hs ve Hy ölçeklerinin somatoform bozukluk grubunda anlamlı şekilde yüksek bulunması, bu ölçeklerin geçerliğini destekleyen bulgular olarak kabul edilmiştir. D ölçeğinin tek başına tanı gruplarını ayırmada kullanılamayacağı dikkati çekerken, kadın hastalarda Si ölçeğindeki yükselmelerle depresif bozukluk tanıları arasında ilişki olduğu bulunmuştur. Sc ölçeği ortalamaları açısından gruplar arasında hiç bir fark bulunmaması ölçeğin bugünkü klinik anlamını araştıran çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşündürmüştür.

Dereboy, Şenol, Köse ve Yüksel (1993), dosya bilgilerine dayanarak DSM-III-R, II. eksen kişilik bozukluğu (borderline, antisosyal, histriyonik ve narsisistik) tanısı koydukları 147 hastanın MMPI profilleri arasında bir fark olup olmadığını araştırmışlardır. Tüm tanı gruplarında, kadınların MMPI profilleri arasında belirgin bir fark bulunamamıştır. Borderline kişilik bozukluğu tanısı alan erkek hastalarda, hem antisosyal kişilik bozukluğuna özgü (Pd, Pa, Sc ve Ma'da yükselme), hem de histriyonik kişilik bozukluğuna özgü (Hs, D, Pt ve Si' de yükselme) özellikler dikkati çekmiştir. Diskriminant analiziyle, borderline kişilik bozukluğu tanısı alan erkek hastaların %85.7' sinin , kadın hastaların ise %69.7' sinin doğru tanı grubunda yer aldıkları bulunmuştur.

MMPI kişilik envanterinin en önemli özelliklerinden biri geçerlik ölçeklerine sahip olmasıdır. Bu ölçekler, klinik ölçeklerin yorumunda yol gösterici olmalarının yanı sıra, diğer ölçekler gibi davranışlar ve kişilik özellikleri konusunda bilgi verirler. Ancak yapılan çalışmalarda bu alt testlerin yaş, eğitim ve sosyo ekonomik düzey gibi sosyo demografik değişkenlerden etkilendiği bulunmuştur. Bir çalışmamızda (Sorias ve Sorias, 1984), 98 kadın 204 erkek toplam 302 psikiyatrik hastadan oluşan bir örnekleme, L, F ve K geçerlik ölçeklerinin yükselme sıklıkları ve yükselmelerin yaş ve eğitim düzeyiyle olan ilişkisini araştırdık. Çalışma sonuçları hastaların %16 sınıfın L alt testi hampuanının 10 ve üstünde olduğunu göstermiştir. Bu hastaların eğitim düzeyleri incelendiğinde belirli bir eğitim düzeyinde kümelenmeye rastlanmamıştır. Buna karşılık yaşla birlikte L ölçeğinin de yükseldiği şeklinde bir izlenim elde edilmiştir. Örneklemin %50 si F alt testinden, 0-10 arasında hampuan almıştır. Ham puanları 11-20 arasında olanlar örneklemin %39 unu, 21 ve üstünde puan alanlar %11 ini oluşturmıştır. F alt testi puanı 15 in üzerinde olan hastaların eğitim düzeyleri incelendiğinde ilkökul eğitimlilerin görece oranlarının en yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca genç hastaların F ölçeği puanlarının daha yüksek oluşu da dikkati çekmiştir. Benzer bir bulguya Savaşır'ın (1981) standardizasyon örnekleminde de rastlanmış, F puanlarının en çok 16-18 yaş grubunda yükseldiği belirtilmiştir. Çalışmanın önemli sonuçlarından biri de K alt ölçeği puanlarının tüm grubun ancak % 3'ünde yükselmesi (ham puan > 20) olmuştur.

Sayılgan (1986), olumsuz temaruz (fake bad) eğiliminin ve psikopatoloji bilgisinin MMPI'ın geçerlik ve klinik ölçeklerini nasıl etkilediğini araştırmıştır. Bu amaçla bir grup psikoloji öğrencisine, önce standart yönergeyle MMPI uygulanmıştır. Bir hafta sonra aynı öğrencilere psikozun genel tanı özellikleri konusunda bilgi vererek, bu kez, psikoz temaruzu yaparak envanteri yanıtlamalarını istemiştir. Örneklemin içinde, psikopatoloji konusunda daha bilgili olan yüksek lisans öğrencileri de vardır. Çalışmada, karşılaştırma amacıyla, psikotik bir bozukluk tanısı ile yatarak tedavi gören hastaların MMPI puanları kullanılmıştır. Sonuçta, her iki grup öğrencinin gerçek profilleri ile temaruz profilleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ancak temaruz yapan öğrencilerin klinik ölçek ortalamalarının

psikotik hastaların ortalamalarına kıyasla çok daha yüksek olduğu da görülmüştür. Ayrıca psikopatoloji konusundaki bilgi ve deneyimin sonucu etkilemediği dikkati çekmiştir.

Ülkemizde yapılan çalışmalarda MMPI kişilik envanterinin kısa formları da kullanılmıştır. Bu çalışmalardan birinde Baltaş, Küser, Bilgen ve ark. (1986), Kincannon tarafından geliştirilen kısaltılmış MMPI formu ile başağrısı vakalarının kişilik özelliklerini araştırmışlardır.

Musabali (1990) ise, MMPI Kişilik Envanterinin ilk 168 maddesinden oluşan ve MMPI-168 olarak tanınan kısa formu İzmir popülasyonu için uyarlamıştır. 160 normal, 160 psikiyatrik hasta toplam 320 kişiden oluşan örneklem üzerinde yapılan faktör analiziyle beş faktör ortaya çıkmıştır. Bunlar : Genel Ruh Sağlığı (46 madde), Acting out (19 madde), Mistik Eğilimler (14 madde), Psikotik Özellikler (27 madde), Düşük Moral (12 madde) dir. Musabali, bu beş faktörün tüm varyansın %20 sini oluşturduğunu ve birinci faktörün %50 ile en yüksek açıklama yüzdesine sahip olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmanın bulgularının da gösterdiği gibi kısa MMPI formları genel ruh sağlığı taramaları için uygun olmakla birlikte tanısal değerleri MMPI Kişilik Envanterine kıyasla daha azdır.

İlave MMPI ölçekleri içinden bazılarının araştırma amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmalardan ilki Karaboncuk ve Erol (1975) tarafından, Barron Ego Gücü Ölçeğinin tedavi sonuçlarını değerlendirmedeki rolünü araştırma amacıyla yapılmıştır. Askeri bir hastanenin psikiyatri ve psikiyatri dışı kliniklerinde yatarak tedavi gören ve değişik rütbelerden seçilen deneklerin Ego Gücü Ölçeğinden aldıkları puanlar hastane dışından seçilen askerlerin puanlarıyla karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları hastanede yatan askerlerin Ego Gücü Ölçeğinden normal askerlere kıyasla anlamlı düzeyde daha düşük puanlar aldıklarını göstermiştir. Ancak psikiyatri kliniğinde yatanlar ile diğer kliniklerde yatanların ortalamaları arasında yalnızca erlerden oluşan grupta anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Rütbe yükseldikçe Ego Gücü puanlarının yükselmesi, yazarlara ölçek puanlarının eğitimle ilişkili olduğunu düşündürmüştür. Ayrıca Aktif Hostilite puanları ile Ego Gücü puanları arasında negatif, Engellenmeye Tolerans ile Ego Gücü puanları arasında pozitif bir ilişkinin bulunması ölçeğin klinik yararı açısından umut verici bulgular olarak kabul edilmiştir.

Ceyhun ve Palabıykoğlu (1989), MacAndrew'un MMPI madde havuzunu kullanarak geliştirdiği MAC Alkolizm ölçeğinin alkol bağımlılarını ayırt etme amacıyla kullanılıp kullanılamayacağını araştırmışlardır. 100 alkol bağımlısı ve 100 nevrotik erkek hastayı MAC ölçeğini uygulayarak karşılaştırdıklarında, alkol bağımlısı grubun ortalama puanının, nevrotik grubun ortalamasından anlamlı şekilde yüksek olduğunu bulmuşlardır. Başka bir araştırmada Ceyhun ve Gürcan (1989), Wiggins'in içerik ölçeklerini 125 kadın ve 125 erkek toplam 250 nevrotik hastaya uygulayarak elde ettikleri ortalamalar ve standart sapmaları incelemişlerdir. Ayrıca Wiggins içerik ölçekleriyle MMPI klinik ölçekleri arasındaki ilişkiyi de araştırmışlardır.

Okyavuz ve Çevik (1989), ruhsal bozuklukların etiyoloji ve tedavisinde önemli bir rol oynadığı ileri sürülen, aleksitimik özelliklerin MMPI ölçeklerinden L, K ve Pt ile ilişkisini araştırmışlardır. Psikosomatik servisinde yatarak tedavi gören 47 kişi ile 41 kontrol deneginden oluşan örneklemelerinde bir Aleksitimi ölçeğinden elde edilen puanlarla K ölçeği puanları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki saptamışlardır. Pt ile Aleksitimi ölçeği puanları arasında ise yalnızca kontrol grubunda anlamlı negatif bir ilişki bulmuşlardır.

Wiggins içerik ölçeklerinden, aile sorunlarını değerlendiren FAM ölçeğinin geçerliğini inceleyen bazı araştırmacılar olumlu sonuçlar bildirmişlerdir. Palabıyıkoglu ve Ceyhun (1989), çeşitli sorunlarla psikiyatri kliniğine başvuran ergenlerin FAM ölçeği ortalamalarının, normal ergenlerinkinden anlamlı şekilde yüksek olduğunu bulmuşlardır. Karaca (1993), bipolar affektif bozukluk tanısı alan hastaların aile işlevlerini değerlendirdiği araştırmasında, hasta grubunun FAM ölçeği puanlarının kontrol grubunun puanlarına kıyasla daha yüksek olduğunu bulmuştur.

Okyavuz ve Çevik (1989), psikosomatik bozukluğu olan hastalarla yaptıkları çalışmada MMPI kişilik envanterini tedavi sonuçlarını değerlendirmek amacıyla kullanmışlardır. Bu araştırmacılar hasta grubunun Hs, D, Hy, Pt, Sc ve Si ortalamalarında tedaviden iki ay sonra anlamlı bir değişme olduğunu bildirmişlerdir.

İçelli ve Ünal (1989), rutin sağlık muayenesinden geçmek için ya da başka nedenlerle bir Devlet Hastanesine başvuran 50 polisin MMPI profillerini incelemişlerdir. Çalışmada 33 denekte (tüm grubun %66 sında) kendini olduğundan daha iyi gösterme isteğini yansıtan L ölçeğinin yükseldiği bulunmuştur. Savunmacı tutumu değerlendiren diğer geçerlik ölçeği olan K ise 13 denekte (tüm grubun % 26 sında) yükselmiştir.

Bu çalışmaların dışında, MMPI kişilik testi pek çok araştırmada değişik grupların kişilik özelliklerini değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır. MMPI kişilik envanteriyle kekeme çocukları olan anne ve babaların (Kerimoğlu, 1985), patolojik kumarbazların (Ziyalan, Aksoy ve Tolgay, 1989), epileptik ve migrenli hastaların (Çağlıbektaş ve Karaağaç, 1989), transeksüel ve homoseksüellerin (Gülcat, Aydın, Battal ve ark., 1988) kişilik özellikleri incelenmiştir.

Ülkemizde yapılan MMPI araştırmalarının yalnızca burada belirtilenlerle sınırlı olduğu düşünülmemelidir. Bu bölümde Psikoloji Dergisi ve Türk Psikiyatri Dergisinde yayınlanan, Ulusal Psikoloji ve Psikiyatri Kongrelerinde sunulan, Türk Psikoloji Bibliyografyasında (Bilgin, 1988) belirtilen MMPI araştırmaları gözden geçirilmiştir. Kuşkusuz, bu araştırmaların dışında, bizim ulaşamadığımız, yayınlanmış ya da yayınlanmamış (lisansüstü tez çalışmaları gibi) MMPI çalışmaları vardır.

MMPI-2'nin Türkiye İçin Standardizasyonu

MMPI-2'nin yayınlanmasının ardından, Işık Savaşır yeni envanterin Türkçeye çevirisini, standardizasyonunu ve geçerlik araştırmalarını içeren

kapsamlı bir araştırma projesi başlatmıştır. Araştırmacının ilk aşamasında, Savaşır ve Çulha (1996), MMPI-2 için yeni yazılan ve revizyondan geçen maddelerin Türkçeye çevirisi üzerinde çalışmışlardır. Bu çalışma, yeni yazılan maddelerin Savaşır tarafından Türkçeye çevrilmesiyle başlamıştır. Daha sonra, bu maddeler her iki kültürü ve dili iyi bilen üç kişi tarafından gözden geçirilerek bazı düzeltmeler yapılmıştır. Bu gözden geçirme sırasında 9 maddenin Türkçe ifadesinin güç olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun üzerine, bu 9 maddenin, hem İngilizce şekli, hem de önerilen Türkçe çevirileri, iki dili iyi bilen 7 kişiye verilmiş ve onların görüşleri doğrultusunda yeniden yazılmıştır. Bunu izleyen aşama, yeni maddeleri Türkçe basarak, eğitim düzeyleri farklı 15 kişiye uygulamak olmuştur. Bu kişilerden maddeleri dikkatle okuyup kolay anlaşılıp anlaşılmadığını işaretlemeleri istenmiştir. Üç kişiden daha fazlası tarafından güç anlaşılır bulunan maddeler yeniden düzeltilmiştir.

Yeni MMPI-2 maddeleri, hem Türkçe hem de İngilizce basılarak bir hafta ara ile, iki dili iyi bilen 20 kişiye uygulanmıştır. Uygulama sonucu düşük korelasyon (.46 ve altı) veren 16 madde yeniden yazılmıştır. Yeni maddelerin tümü, Çulha tarafından İngilizceye çevrilerek 24 Amerikalıya uygulanmıştır. Onların yorumları göz önünde bulundurularak yeniden düzeltmeler yapılmıştır. Son aşama, düzeltilen tüm maddelerin yeniden İngilizceye çevrilerek, iki dili iyi bilen 15 kişiye uygulanması olmuştur. 3 madde hariç tüm maddelerin yüksek korelasyon verdiği görüldüncə, bunların düzeltilmesiyle çeviri çalışması tamamlanmıştır.

MMPI-2'nin Türkiye için standardizasyonu, 16-50 yaş arasında 600 kadın ve 600 erkekten oluşan 1200 kişilik bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kültürel farklılıkları yansıtmaması için Türk norm grubundaki deneklerin Türkiye'nin değişik bölgelerinden seçilmesine özen gösterilmiştir. Bu kitabın baskıya hazırlandığı tarihlerde standardizasyon çalışmasının istatistik analizleri devam etmekteydi. Bu nedenle sonuçlar konusunda henüz bir bilginiz yok. Ancak MMPI-2'deki değişikliklerin, bu temel kişilik envanterinin klinik yararını artıracakları açıktır.

Bu kitap öğrencilere ve çalışmacılara, bir kişilik testinin klinik yorumunun, görgül araştırmalarla nasıl zenginleştiğini gösteren iyi bir örnektir. Böyle bir eserin aynı konu üzerinde çalışan çok sayıda araştırmacının emeği sonucu ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Bu çalışmalar, Graham'ın deneyimlerinin ışığı altında bir araya getirilince, ortaya bütün bu çabalara anlam kazandıran bir sentez çıkmıştır. Umarız ülkemizde yapılan MMPI ve MMPI-2 çalışmaları giderek artar ve bu araştırmalardan elde edilen verilere dayanan yorum kitapları yayınlanabilir.

BU BÖLÜMDE YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Baltaş, A., Küser., E., Bilgen, T., & diğ. (1986). Başağrısı ve nevrotik eğilim. *Psikoloji Dergisi*, 5 (20), 51-59.
- Bilgin, N. (1988). *Türk psikoloji bibliyografyası*. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. İzmir.
- Butcher, J. N., Braswell, L., & Raney, D. (1983). A cross-cultural comparison of American, Indian, Black and White inpatients on the MMPI and presenting symptoms. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 51, 587-594.
- Butcher, J. N., & Keller, L. S. (1984). *Objective personality assessment*. Handbook of Psychological Assessment (Ed: G. Goldstein ve M. Hersen). Pergamon Press, 307-331.
- Cansever, G., & Gürkaynak, M. (1965). *Minnesota MMPI*. İstanbul Matbaası.
- Ceyhun, B., & Palabıynkoğlu, R. (1989). Yatan alkol bağımlılarında MMPI alkolizm skalalarının kullanımı. XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Mersin.
- Ceyhun, B., & Gürcan, F. (1989). Nevroz hasta grubunda MMPI klinik skalaları ile Wiggins içerik skalalarının değerlendirilmesi. XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Mersin.
- Colligan, R. C., Osborne, D., Swenson, V. M., & et al. (1984). The MMPI, Development of contemporary norms. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 40, 101-107.
- Çağlıbektaş, N., & Karaağaç, N. (1989). Epileptik hastaların kişilik değerlendirmesi. XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Mersin.
- Dereboy, Ç., Şenol, S., Köse, S. K., & Yüksel, N. (1993). DSM-III-R kişilik bozukluğu olgularının MMPI profilleri açısından karşılaştırılması. *Türk Psikiyatri Dergisi*, 4 (1), 54-59.
- Erol, N. (1982). Ülkemizdeki psikiyatrik hastalarda Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin geçerlik araştırması. *Psikoloji Dergisi* 4 (14-15), 14-23.
- Erol, N. (1984). MMPI'nin normal Türk örneklemindeki madde analizi. *Psikoloji Dergisi*, 5 (17), 24-30.
- Finn, S. E., & Butcher, J. N. (1991). *Clinical objective personality assessment*. The Clinical Psychology Handbook (Ed: M. Hersen, A. E. Kazdin, & A. S. Bellack, 2nd ed.). Pergamon Press. 362-371.

- Gülçat, Z., Aydın, H., Battal, S., & diğ. (1988). Transeksüeller ve homoseksüeller üzerine psikososyal bir çalışma. *XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi*, Ankara.
- Hathaway, S. R., & Meehl, P. E. (1980). *An atlas for the clinical use of the MMPI*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- İçelli, İ., & Ünal, M. (1989). Bir grup poliste MMPI testi sonuçları. *XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi*, Mersin.
- Karaboncuk, F., & Erol, N. (1975). MMPI Es Skalasının tedavi sonuçlarının değerlendirilmesindeki rolü. *XI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi*, 449-456.
- Karaca, N. (1993). *Bipolar bozukluk tanılı hastaların aile işlevlerinin değerlendirilmesi*. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
- Keller, L. S., Butcher, J. N., & Slutske, W. S. (1990). *Objective personality assessment*. Handbook of Psychological Assessment (Ed: G. Goldstein ve M. Hersen), 345-386. (2nd ed). Pergamon Press.
- Kerimoğlu, E. (1985). Kekeme çocukların ve ailelerinin kişilik özellikleri yönünden incelenmesi. *Psikoloji Dergisi*. 5 (18), 15-23.
- Musabali, S. (1990). MMPI-168 Kısa Formu'nun İzmir popülasyonu için maddelerinin uyarlanması çalışması. *E.Ü. Psikoloji Seminer Dergisi Özel Sayısı*, 8, 671-679.
- Okyavuz, Ü., & Çevik, A. (1989). Psikosomatik servise yatarak tedavi gören hastaların MMPI bulgularının aleksitimik özellikler açısından incelenmesi. *XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi*, Mersin.
- Palabıykoğlu, R., & Ceyhun, B. (1989). Ergenlerde aile sorunlarının Wiggins FAM ile değerlendirilmesi. *XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi*, Mersin.
- Savaşır, I. (1978). Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin Türkçeye uyarlanması ve standardizasyon projesi. *Psikoloji Dergisi*. 1 (1).
- Savaşır, I. (1981). *Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanter El Kitabı* (Türk standardizasyonu). Sevinç Matbaası.
- Savaşır, I., & Erol, N. (1990). *The Turkish MMPI: Translation, standardization and validation*. Advances in Personality Assessment (Ed: J.N. Butcher ve C.D. Spielberger). Vol.8. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Savaşır, I., & Çulha, M. (1996). *The MMPI in Turkey. International adaptations of the MMPI* (Ed: J.N. Butcher). University of Minnesota Press. Minneapolis. 448-463.

- Sayılğan, M. A. (1986). *Psikiyatri hastalarında olumlu temarüz amacıyla çarpıtılmış MMPI profillerinin incelenmesi*. Hacettepe Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
- Sorias, S., & Sorias, O. (1984). Psikiyatrik hastaların MMPI alt test özelliklerinin araştırılması I: Geçerlik alt testleri. *E.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi*, 23 (4), 1429-1436.
- Sorias, O., Sorias, S., & Inceer, B. (1984). Psikiyatrik hastaların MMPI alt test özelliklerinin araştırılması II: Klinik alt testler. *E.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi*. 23(4), 1437-1445.
- Sorias, O. (1992). Dört DSM-III tanı grubunda MMPI testinin Türk ve Amerikan normlarına göre ayırt edici geçerliğinin araştırılması. *E.Ü. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Seminer Dergisi*, 9 , 15-33.
- Toğrol, B. (1968). MMPI şahsiyet testi. *VII. Tecrübi psikoloji çalışmaları*, 51-55.
- Toğrol, B. (1981). Türkiyede kullanılan bazı testlerin uygulamasından elde edilen sonuçlar. *I. Ulusal Psikoloji Kongresi Bildiri Derlemeleri*, 109.
- Yaparel, R. (1990). Minnesota Kişilik Envanterinde kullanılan dini içerikli maddelerin geçerliği üzerinde bir çalışma. *E.Ü. Psikoloji Seminer Dergisi Özel Sayısı*, 8, 645-651.
- Ziyalan, M. S., Aksoy, S., & Tolgay, A. (1989). Patolojik kumarbazlar ve tedavileri. *XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi*, Mersin.

KAYNAKLAR

- Altus, W. D., & Tafejian T. T. (1953). MMPI correlates of the California E-F Scale, *Journal of Social Psychology* , 38, 145-149.
- Barron, F. (1953). An Ego Strength Scale which predicts response to psychotherapy, *Journal of Consulting Psychology* , 17, 327-333.
- Barron, F. (1956). Ego-strength and the management of aggression. In G. S. Welsh And W. G. Dahlstrom (Eds.), *Basic readings on the MMPI in psychology and medicine* . Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Barron, F., & Leary, T. (1955). Changes in psychoneurotic patients with and without psychotherapy. *Journal of Consulting Psychology* , 19, 239-245.
- Baughman, E. E., & Welsh, G. S. (1962). *Personality: A behavioral science* . Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.
- Black, J. D. (1953). *The Interpretation of MMPI profiles of college women* . Unpublished doctoral dissertation. University of Minnesota.
- Block, J. (1965). *The challenge of response sets: Unconfounding meaning, acquiescence, and social desirability in the MMPI* . New York: Appleton-Century-Crofts.
- Block, J., & Bailey, D., (1955). *Q-sort item analyses of a number of MMPI scales* , Officer Education Research Laboratory, Technical Memorandum. OERL-TM-55-7.
- Boerger, A. R. (1975.). *The utility of some alternative approaches to MMPI scale construction* . Unpublished doctoral dissertation. Kent State University.
- Boerger, A. R., Graham, J. R., & Lilly, R. S. (1974). Behavioral correlates of single-scale MMPI code types, *Journal of Consulting and Clinical Psychology* , 42, 398-402.
- Button, A. D., (1956). A study of alcoholics with the MMPI. *Quarterly Journal Of Studies On Alcohol* , 17, 263-281.
- Byrne, D. (1974). *An introduction to personality: Research, theory, and applications*. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.
- Calvin, J. (1974). *Two dimensions or fifty: Factor analytic studies with the MMPI* . Unpublished materials. Kent State University.
- Calvin, J. (1975). *A replicated study of the concurrent validity of the Harris subscales for the MMPI* . Unpublished doctoral dissertation. Kent State University.

- Carkuff, R. R., Barnette, W. L., & McCall, J. N. (1965). *The counselor's handbook: Scale and profile interpretations of the MMPI*. Urbana, Ill.: Parkinson.
- Carson, R. C. (1969). Interpretative manual to the MMPI. In J. N. Butcher (Ed), *MMPI: Research developments and clinical applications*. New York: McGraw-Hill.
- Chu, C. (1966). Object cluster analysis of the MMPI, Unpublished doctoral dissertation, University of California, Berkeley.
- Cohler, B. J., Weiss, J. L., & Grunebaum, H. V. (1974). Short-Form content scales for the MMPI. *Journal of Personality Assessment*, 38, 563-572.
- Comrey, A. L. (1957a). A factor analysis of items on the MMPI Depression Scale. *Educational and Psychological Measurement*, 17, 578-585.
- Comrey, A. L. (1957b). A factor analysis of items on the MMPI Hypochondriasis Scale, *Educational and Psychological Measurement*, 17, 566-577.
- Comrey, A. L. (1957c). A factor analysis of items on the MMPI Hysteria Scale. *Educational and Psychological Measurement*, 17, 586-592.
- Comrey, A. L. (1958a). A factor analysis of items on the F scale of the MMPI. *Educational and Psychological Measurement*, 18, 621-632.
- Comrey, A. L. (1958b). A factor analysis of items on the MMPI Hypomania Scale. *Educational and Psychological Measurement*, 18, 313-323.
- Comrey, A. L. (1958c). A factor analysis of items on the MMPI Paranoia Scale. *Educational and Psychological Measurement*, 18, 99-107.
- Comrey, A. L. (1958d). A factor analysis of items on the MMPI Psychasthenia Scale. *Educational and Psychological Measurement*, 18, 293-300.
- Comrey, A. L. (1958e). A factor analysis of items on the MMPI Psychopathic Scale. *Educational and Psychological Measurement*, 18, 91-98.
- Comrey, A. L., & Margraff, W. (1958). A factor analysis of items on the MMPI Schizophrenia Scale. *Educational and Psychological Measurement*, 18, 301-311.
- Cuandra, C. A. (1953). A scale for control in psychological adjustment (Cn), in G. W. Welsh and W. G. Dahlstrom (Eds.), *Basic readings on the MMPI in psychology and medicine*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Dahlstrom, W. G. (1954). Prediction of adjustment after neurosurgery. *American Psychologist*, 9, 353.
- Dahlstrom, W. G. (1972). Whither the MMPI In J. N. Butcher (Ed.), *Objective personality assessment: Changing perspectives*. New York: Academic Press.

- Dahlstrom, W. G., & Welsh, G. S. (1960). *An MMPI handbook: A guide to clinical practice and research*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Dahlstrom, W. G., Welsh, G. S., & Dahlstrom, L. E. (1972). *An MMPI handbook : Volume I: Clinical interpretation*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Dahlstrom, W. G., Welsh, G. S., & Dahlstrom, L. E. (1975). *An MMPI handbook. Volume II: Research applications*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Davis, K.R., & Sines, J.O. (1971). An antisocial behavior pattern associated with a specific MMPI profile. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 36, 229-234.
- Distler, L. S., May, P. R., & Tuma, A. H. (1964). Anxiety and ego strength as predictors of response to treatment in schizophrenic patients. *Journal of Consulting Psychology*, 28, 170-177.
- Drake, L. E. (1946). A Social I. E. Scale for the MMPI. *Journal of Applied Psychology*, 30, 51-54.
- Drake, L. E., & Oetting, E. R. (1959). *An MMPI codebook for counselors*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Duckworth, J. C., & Duckworth, E. (1975). *MMPI interpretative manual for counselors and clinicians*. Muncie, Ind.: Accelerated Development, Inc.
- Dunbar, J. R., & Rabourn, R. E. *A working manual for the MMPI*. Unpublished materials, Date unknown.
- Edwards, A. L. (1964). Social desirability and performance on the MMPI. *Psychometrika*, 29, 295-308.
- Eichman, W. J. (1961). Replicated factors on the MMPI with female NP patients. *Journal of Consulting Psychology*, 22, 55-60.
- Eichman, W. J. (1962). Factored scales for the MMPI: A clinical and statistical manual. *Journal of Clinical Psychology*, 18, 363-395.
- Eichman, W. J. (1972a). Minnesota Multiphasic Personality Inventory: Computerized scoring and interpreting services. In O. K. Buros (Ed.), *The Seventh Mental Measurements Yearbook*. Vol. I. Highland Park, N. J.: Gryphon Press.
- Eichman, W. J. (1972b). Minnesota Multiphasic Personality Inventory: MMPI-ICA computer report, In O. K. Buros (Ed.) *The Seventh Mental Measurements Yearbook*. Vol. I. Highland Park, N. J.: Gryphon Press.
- Eichman, W. J. (1972c). Minnesota Multiphasic Personality Inventory: Optimum psychodiagnostic consultation service. In O. K. Buros (Ed.), *The Seventh Mental Measurements Yearbook*. Vol. I. Highland Park, N. J.: Gryphon Press.

- Eichman, W. J. (1972d). Minnesota Multiphasic Personality Inventory: The psychological corporation MMPI reporting service. In O. K. Buros (Ed.), *The Seventh Mental Measurements Yearbook*. Vol. I. Highland Park, N. J.: Gryphon Press.
- Eichman, W. J. (1972e). Minnesota Multiphasic Personality Inventory: Roche MMPI computerized interpretation service. In O. K. Buros (Ed.), *The Seventh Mental Measurements Yearbook*. Vol. I. Highland Park, N. J.: Gryphon Press.
- Ends, E. J., & Page, C. W. (1957). Functional relationships among measures of anxiety, ego strength and adjustment, *Journal of Clinical Psychology*, 13, 148-150.
- Eschenback, A. E., & Dupree, L. (1959). The influence of stress on MMPI scale scores. *Journal of Clinical Psychology*, 15, 42-45.
- Finney, J. C. (1961). The MMPI as a measure of character structure as revealed by factor analysis. *Journal of Consulting Psychology*, 25, 327-336.
- Fowler, R. D. (1969). The current status of computer interpretation of psychological tests. *American Journal of Psychiatry*, 125, 21-27.
- Fowler, R. D., & Coyle, F. A. (1968). Overlap as a problem in atlas classification of MMPI profiles. *Journal of Clinical Psychology*, 24, 435.
- Fowler, R. D. & Coyle, F. A. (1969). Collegiate normative data on MMPI concent scales. *Journal of Clinical Psychology*, 25, 62-63.
- Fowler, R. D., Teel S. K., & Coyle, F. A. (1967). The measurement of alcoholic response to treatment by Barron's Ego Strength Scale. *Journal of Psychology*, 67, 65-68.
- Friedman, S. H. (1950). *Psychometric effects of frontal and parietal lobe brain damage*. Unpublished doctoral dissertation, University of Minnesota.
- Getter, H., & Sundland, D. M. (1962). The Barron Ego Strength Scale and psychotherapy outcome. *Journal of Consulting Psychology*, 26, 195.
- Gilberstadt, H. (1970). *Comprehensive MMPI codebook for males*. Minneapolis: MMPI Research Laboratory, Veterans Administration Hospital, Report 1B 11-5.
- Gocka, E. (1965). American lake norms for 200 MMPI scales, *Unpublished materials*.
- Gocka, E., & Holloway, H. (1963). *Normative and predictive data on the Harris and Lingoes subscales for a neuropsychiatric population*. Washington: Veterans Administration Hospital, American Lake, Technical Report No: 7.
- Goldberg, L. R. (1965). Diagnosticians vs. diagnostic signs: The diagnosis of psychosis vs. neurosis from the MMPI. *Psychological Monographs*, 79, 9 [Whole No. 602].

- Goldberg, L. R. (1972). Parameters of personality inventory construction: A comparison of prediction strategies and tactics. *Multivariate Behavioral Research Monographs*, 7 (2).
- Good, P. K. & Brantner, J. P. (1961). *The physician's guide to the MMPI*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Gottesman, I. (1959). I. More construct validation of The Ego-Strength Scale *Journal of Consulting Psychology*, 23 , 342-346.
- Gough, H. G. (1948a). A new dimension of status: I. Development of a Personality Scale. *American Sociological Review* , 13, 401-409.
- Gough, H. G. (1948b). A new dimension of status: II. Relationship of the St Scale to other variables, *American Sociological Review* , 13, 534-537.
- Gough, H. G. (1949). A new dimension of status: III. Discrepancies between the St Scale and objective status, *American Sociological Review* , 14, 275-281.
- Gough, H. G. (1950). The F minus K dissimulation index for the MMPI. *Journal of Consulting Psychology* , 14, 408-413.
- Gough, H. G. (1951a). Studies of social intolerance: II. A personality scale for anti-semitism. *Journal of Social Psychology* , 33, 247-255.
- Gough, H. G. (1951b). Studies of social intolerance: III. Relationship of the Pr Scale to other variables, *Journal of Social Psychology* , 33, 257-262.
- Gough, H. G. (1954). Brief descriptive and interpretational summary of scales of the Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Unpublished materials.
- Gough, H. G., McClosky, H., & Meehl, P. E. (1951). A Personality Scale for dominance, *Journal of Abnormal and Social Psychology* , 46, 360-366.
- Gough, H. G., McClosky, H., & Meehl, P. E. (1952). A Personality Scale for responsibility, *Journal of Abnormal and Social Psychology* , 47, 73-80.
- Gough, H. G., McKee, M. G., & Yandell, R. J. (1955). *Adjective Check List analysis of a number of selected psychometric and assessment variables*. Officer Education Research Laboratory, Technical Memorandum, OERL-TM-55-10.
- Graham, J. R., Schroeder, H. E., & Lilly, R. S. (1971). Factor analysis of items on the Social Introversion and Masculinity-Femininity Scales of The MMPI. *Journal of Clinical Psychology* , 27, 367-370.
- Grayson, H. M. (1951). *A psychological admissions testing program and manual* , Los Angeles: Veterans Administration Center, Neuropsychiatric Hospital.
- Gutrie, G. M., (1952). Common characteristics associated with frequent MMPI profile types. *Journal of Clinical Psychology* , 8, 141-145.

- Gynther, M. D., Altman, H., & Sletten, I. W. (1973). *Replicated correlates of MMPI two-point types: The Missouri Actuarial System*. Journal of Clinical Psychology, Monograph Supplement No.39.
- Gynther, M. D., Altman, H., & Warbin, W. (1973). Interpretation of uninterpretable Minnesota Multiphasic Personality Inventory Profiles. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 40, 78-83.
- Gynther, M. D., & Brilliant, P. J. (1968). The diagnostic utility of Welsh's A-R Categories. *Journal of Projective Techniques and Personality Assessment*, 32, 572-574.
- Hanvik, L. J. (1949). Some psychological dimensions of low back pain. Doctoral dissertation, University of Minnesota.
- Hanvik, L. J. (1951). MMPI profiles in patients with low back pain. *Journal of Consulting Psychology*, 15, 350-353.
- Harris, R., & Christiansen, C. (1946). Prediction of response to brief psychotherapy. *Journal of Psychology*, 21, 269-284.
- Harris, R., & Lingo, J. (1955). *Subscales for the Minnesota Multiphasic Personality Inventory*. Mimeographed materials, The Langley Porter Clinic.
- Harris, R., & Lingo, J. (1968). *Subscales for the Minnesota Multiphasic Personality Inventory*. Mimeographed Materials, The Langley Porter Clinic.
- Hase, H. D., & Goldberg, L. R. (1967). Comparative validity of different strategies of constructing personality inventory scales. *Psychological Bulletin*, 67, 231-248.
- Hathaway, S. R. (1947). A coding system for MMPI profiles. *Journal of Consulting Psychology*, 11, 334-337.
- Hathaway, S. R. (1956). Scales 5 (Masculinity-Femininity), 6 (Paranoia) and 8 (Schizophrenia). In G. S. Welsh and W. G. Dahlstrom (Eds.). *Basic readings on the MMPI in psychology and medicine*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Hathaway, S. R. (1965). Personality inventories. In B. B. Wolman (Ed.), *Handbook of Clinical Psychology*. New York: McGraw-Hill.
- Hathaway, S. R., & Briggs, P. F. (1957). Some normative data on new MMPI scales. *Journal of Clinical Psychology*, 13, 364-368.
- Hathaway, S. R., & McKinley, J. C. (1940). A multiphasic personality schedule (Minnesota): I. Construction of the schedule. *Journal of Psychology*, 10, 249-254.
- Hathaway, S. R., & McKinley, J. C. (1942). A multiphasic personality schedule (Minnesota): III. The measurement of symptomatic depression. *Journal of Psychology*, 14, 73-84.

- Hathaway, S. R. & Mckinley, J. C. (1967). *The Minnesota Muhtiphasic Personality Inventory Manual*. New York: Psychological Corporation.
- Hawkinson, J. R. (1962). A study of the construct validity of Barron's Ego Strength Scale with a state mental Hospital Population, *Dissertation Abstracts International*, 22, 4081.
- Henrichs, T. F. (1964). Objective configural rules for discriminating MMPI profiles in a psychiatric population. *Journal of Clinical Psychology*, 20, 157-159.
- Henrichs, T. F. (1966). A note on the extension of MMPI configural rules. *Journal of Clinical Psychology*, 22, 51-52.
- Hilgard, E. R., Jones, L. V., & Kaplan, S. J. (1951). Conditioned discrimination as related to anxiety. *Journal of Experimental Psychology*, 42, 94-99.
- Himelstein, P. (1964). Further evidence of the Ego Strength Scale as a measure of psychological health. *Journal of Consulting Psychology*, 28, 90-91.
- Hoffman, H., Loper, R. G., & Kammeier, M. L. (1974). Identifying future alcoholics with MMPI Alcoholism Scales. *Quarterly Journal of Studies On Alcohol*, 35, 490-498.
- Holmes, D. S. (1967). Male-female differences in MMPI ego strength: An artifact. *Journal of Consulting Psychology*, 31, 408-410.
- Hovey, H. B. (1964). Brain lesions and five MMPI items. *Journal of Consulting Psychology*, 28, 78-79.
- Hovey, H. B., & Lewis, E. G. (1967). *Semiautomatic interpretation of the MMPI*. Brandon, Vt.: Clinical Psychological Publishing Co.
- Huff, F. W. (1965). Use of actuarial description of abnormal personality in a mental hospital. *Psychological Reports*, 17, 224.
- Jackson, D. N. (1971). The dynamics of structured tests. *Psychological Review*, 78, 239-249.
- Jensen, A. R. (1957). Authoritarian attitudes and personality maladjustment. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 54, 161-170.
- Kammeier, M. L., Hoffman, H., & Loper, R. G. (1973). Personality characteristics of alcoholics as college freshmen and at time of treatment. *Quarterly Journal of Studies on Alcohol*, 34, 390-399.
- Kent, G. H. (1946). *Series of emergency scales*. New York: Psychological Corporation.
- Kleinmuntz, B. (1960). An extension of the construct validity of the Ego Strength Scale. *Journal of Consulting Psychology*, 24, 463-464.

- Kleinmuntz, B. (1972). Minnesota Multiphasic Personality Inventory: Roche MMPI computerized interpretation service. In O. K. Buros (Ed.), *The seventh mental measurements yearbook*. Vo. I. Highland Park, N. J.: Gryphon Press.
- Knapp, R. R. (1960). A reevaluation of the validity of MMPI scales of dominance and responsibility. *Educational and Psychological Measurement*, 20, 381-386.
- Koss, M. P., & Butcher, J. N. (1973). A comparison of psychiatric patients' self-report with other sources of clinical information. *Journal of Research in Personality*, 7, 225-236.
- Kostlan, A. (1954). A method for the empirical study of psychodiagnosis. *Journal of Consulting Psychology*, 18, 83-88.
- Lachar, D. (1974). *The MMPI: Clinical assessment and automated interpretation*. Los Angeles: Western Psychological Services.
- Lewandowski, D., & Graham, J. R. (1972). Empirical correlates of frequently occurring two-point code types: A replicated study. *Journal of Clinical Psychology*, 39, 467-472.
- Lewinsohn, P. M. (1965). Dimensions of MMPI change. *Journal of Clinical Psychology*, 21, 37-43.
- Lingoes, J. (1960). MMPI factors of the Harris and Weiner subscales. *Journal of Consulting Psychology*, 24, 74-83.
- Loper, R. G., Kammeier, M. L. & Hoffman, H. (1973). MMPI characteristics of college freshmen males who later became alcoholics. *Journal of Abnormal Psychology*, 82, 159-162.
- Lorr, M. (1968). A test of 7 MMPI factors. *Multivariate Behavioral Research, Special Issue*, 151-156.
- MacAndrew, C. (1965). The differentiation of male alcoholic out-patients from nonalcoholic psychiatric patients by means of the MMPI. *Quarterly Journal of Studies on Alcohol*, 26, 238-246.
- Marks, P. A., & Seeman, W. (1963). *Actuarial description of abnormal personality*. Baltimore: Williams & Wilkins.
- Marks, P. A., Seeman, W., & Haller, D. L. (1974). *The actuarial use of the MMPI with adolescents and adults*. Baltimore: Williams & Wilkins.
- Matarazzo, J. D. (1972). *Wechsler's measurement and appraisal of adult intelligence*. Baltimore: Williams & Wilkins.
- McKinley, J. C., & Hathaway, S. R. (1940). A Multiphasic Personality Schedule (Minnesota): II. A differential study of hypochondriasis. *Journal of Psychology*, 10, 255-268.

- Mckinley, J. C., & Hathaway, S. R. (1944). The MMPI: V. Hysteria, hypomania, and psychopathic deviate. *Journal of Applied Psychology*, 28, 153-174.
- Mckinley, J. C., Hathaway, S. R., & Meehl, P. E. (1948). The MMPI: VI. The K Scale. *Journal of Consulting Psychology*, 12, 20-31.
- Meehl, P. E. (1951). *Research results for counselors*. St. Paul, Minn.: State Department of Education.
- Meehl, P. E. (1956). Wanted-a good cookbook. *American Psychologist*, 11, 263-272.
- Meehl, P. E., & Dahlstrom, W. G. (1960). Objective configural rules for discriminating psychotic from neurotic MMPI profiles. *Journal of Consulting Psychology*, 24, 375-378.
- Meehl, P. E., & Hathaway, S. R. (1946). The K. Factor as a suppressor variable in the MMPI. *Journal of Applied Psychology*, 30, 525-564.
- Meier, M. J., & French, L. A. (1964). Caudality scale change following unilateral temporal lobectomy. *Journal of Clinical Psychology*, 20, 464-467.
- Meikle, S., & Gerritse, R. (1970). MMPI cookbook pattern frequencies in a psychiatric unit. *Journal of Clinical Psychology*, 25, 82-84.
- Messick, S., & Jockson, D. N. (1961). Acquiescence and the factorial interpretation of the MMPI. *Psychological Bulletin*, 58, 299-304.
- Mezzich, J. E., Damarin, F. L., & Erickson, J. R. (1974). Comparative validity of strategies and indices of differential diagnosis of depressive states from other psychiatric conditions using the MMPI. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 42, 691-698.
- Navran, L. A. (1954). A rationally derived MMPI Scale to measure dependence. *Journal of Consulting Psychology*, 18, 192.
- Nelson, J. W. (1959). Dependency as a construct: An evaluation and some data. *Dissertation Abstracts*, 19, 2149-2150.
- Olmstead, D. W., & Monachesi, E. D. (1956). A validity check on MMPI scales of responsibility and dominance. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 53, 140-141.
- Panton, J. (1959). The response of prison inmates to MMPI subscales. *Journal of Social Therapy*, 5, 233-237.
- Payne, F. D., & Wiggins, J. S. (1972). MMPI profile types and the self-report of psychiatric patients. *Journal of Abnormal Psychology*, 79, 1-8.
- Pearson, J. S., & Swenson, W. M. (1967). *A user's guide to the Mayo Clinic Automated MMPI Program*. New York: Psychological Corporation.
- Pepper, L. J., & Strong, P. N. (1958). Judgmental subscales for the Mf Scale of the MMPI. Unpublished materials, Hawaii Department of Health (Honolulu).

- Persons R. W., & Marks, P. A. (1971). The violent 4-3 personality type. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 36, 189-196.
- Peterson, D. R. (1954). Predicting hospitalization of psychiatric outpatients. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 49, 260-265.
- Pruitt, P. W., & Van De Castle, R. L. (1962). Dependency measures and welfare chronicity. *Journal of Consulting Psychology*, 26, 559-560.
- Quay, H. (1955). The performance of hospitalized psychiatric patients on the Ego-strength Scale of the MMPI. *Journal of Clinical Psychology*, 11, 403-405.
- Rosen, A. (1963). Diagnostic differentiation as a construct validity indication for the MMPI Ego-strength Scale. *Journal of General Psychology*, 69, 65-68.
- Schubert, H. J. P. (1973). *A wide-range MMPI Manual*. Unpublished materials.
- Serkownek, K. (1975). Subscales for scales 5 and 0 of the Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Unpublished materials, 3134 Whitehorn Road, Cleveland Heights, Ohio 44118.
- Sherriffs, A. C., & Boomer, D. S. (1954). Who is penalized by the penalty for guessing? *Journal of Educational Psychology*, 45, 81-90.
- Simmatt, E. R. (1962). The relationship between the Ego-strength Scale and rated in hospital improvement. *Journal of Clinical Psychology*, 18, 46-47.
- Sines, L. K. (1959). The relative contribution of four kinds of data to accuracy in personality assessment. *Journal of Consulting Psychology*, 23, 483-492.
- Spence, J. T., & Spence, K. W. (1966). The motivational components of manifest anxiety: Drive and drive stimuli. In C. D. Spielberger (Ed.), *Anxiety and Behavior*. New York: Academic Press.
- Spiegel, D. E. (1969). SPI and MMPI predictors of psychopathology. *Journal of Projective Techniques and Personality Assessment*, 33, 265-273.
- Spielberger, C. D. (1966a). The effects of anxiety on complex learning and academic achievement. In C. D. Spielberger (Ed.), *Anxiety and Behavior*. New York: Academic Press.
- Spielberger, C. D. (1966b). Theory and research on anxiety. In C. D. Spielberger (Ed.), *Anxiety and Behavior*. New York: Academic Press.
- Stein, K. B. (1968). The TSC Scales: The outcome of a cluster analysis of the 550 MMPI items. In P. McReynolds (Ed.), *Advances in Psychological Assessment*. Vol. I. Palo Alto, Calif.: Science and Behavior Books.
- Stricker, G. (1961). A comparison of two MMPI prejudice scales. *Journal of Clinical Psychology*, 17, 43.
- Sullivan, L., Miler, C., & Smelser, W. (1958). Factors in length of stay and progress in psychotherapy. *Journal of Consulting Psychology*, 22, 1-9.

- Sundberg, N. D., & Bachelis, W. D. (1956). The fakebility of two measures of prejudice: The California F Scale and Gough's Pr Scale, *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 52, 140-142.
- Tafejian, T. R. (1951). The E-F Scale, The MMPI, and Gough's Pr Scale. *American Psychologist*, 6, 501.
- Taft, R. (1957). The validity of the Barron Ego-strength Scale and the Welsh Anxiety Index, *Journal of Consulting Psychology*, 21, 247-249.
- Tamkin, A. S. (1957). An evaluation of the construct validity of Barron's Ego-strength Scale, *Journal of Consulting Psychology*, 13, 156-158.
- Tamkin, A. S., & Klett, C. J. (1957). Barron's Ego-strength Scale: A replication of an evaluation of its construct validity. *Journal of Consulting Psychology*, 21, 412.
- Taulbee, E. S., & Sisson, B. D. (1957). Configural analysis of MMPI profiles of psychiatric groups, *Journal of Consulting Psychology*, 21, 413-417.
- Taylor, J. A. (1951). The relationship of anxiety to the conditioned eyelid response, *Journal of Experimental Psychology*, 41, 81-92.
- Taylor, J. A. (1953). A personality scale of manifest anxiety, *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 48, 285-290.
- Taylor, J. B., Ptacek, M., Carithers, M., Griffin, C., & Coyne, L. (1972). Rating scales as measures of clinical judgement. III: Judgements of the self on personality inventory scales and direct ratings. *Educational and Psychological Measurement*, 32, 543-557.
- Terman, L. M., & Miles, C. C. (1936). *Sex and personality: Studies in masculinity and femininity*, New York: Mcgraw Hill.
- Tryon, R. C. (1966). Unrestricted cluster and factor analysis with application to the MMPI and Holzinger-Harman problems. *Multivariate Behavioral Research*, 1, 229-244.
- Tryon, H. C., & Bailey, D. (1965) (Eds.). Users' Manual of the BC TRY system of cluster and factor analysis (Taped version) Berkeley: University of California Center.
- Warn, L. J. (1958). A comparative investigation of dependency in epilepsy, paraplegia and tuberculosis. Unpublished doctoral dissertation, Los Angeles: University of California.
- Welsh, G. S. (1948). An extension of Hathaway's MMPI profile coding system. *Journal of Consulting Psychology*, 12, 343-344.
- Welsh, G. S. (1956). Factor dimensions A and R. In G. S. Welsh and W. G. Dahlstrom (Eds.). *Basic reading on the MMPI in psychology and medicine*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Welsh, G. S. (1965). MMPI profiles and factors A and R. *Journal of Clinical Psychology*, 21, 43-47.
- Welsh, G. S., & Dahistrom, W. G. (1956). (Eds.), *Basic readings on the MMPI in psychology and medicine*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Wiener, D. N. (1948). Subtle and obvious keys for the MMPI. *Journal of Consulting Psychology*, 12, 164-170.
- Wiggins, J. S. (1966). Substantive dimensions of self-report in the MMPI item pool. *Psychological Monographs*, (80,22) (Whole No. 630).
- Wiggins, J. S. (1969). Content dimensions in the MMPI, in J. N. Butcher (Ed.), *MMPI: Research Developments and Clinical Applications*. New York: Mc Graw-Hill.
- Wiggins, J. S. (1971). Content Scales: Basic data for scoring and interpretation, unpublished materials.
- Wiggins, J. S., Coldberg, L. R., & Applebaum, M. (1971). MMPI content scales: Interpretive norms and correlations with other scales, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 37, 403-410.
- Wiggins, J. S., & Vollmar, J. (1959). The content of the MMPI, *Journal of Clinical Psychology*, 15, 45-47.
- Williams, H. L. (1952). The development of a Caudality Scale for the MMPI, *Journal of Clinical Psychology*, 8, 293-297.
- Wirt, R. D. (1955). Further validation of the Ego-strength Scale. *Journal of Consulting Psychology*, 20, 123-124.
- Wirt, R. D. (1956). Acturial prediction, *Journal of Consulting Psychology*, 20, 123-124.
- Zuckerman, M., Levitt, E. E., & Lubin, B. (1961). Concurrent and construct validity of direct and indirect measures of dependency. *Journal of Consulting Psychology*, 25, 316-323.

EK A

SIK KULLANILAN ARASTIRMA ÖLÇEKLERİNİN MADDELERİ

A-Anksiyete (Welsh, 1954)

Doğru : 32, 41, 67, 76, 94, 138, 147, 236, 259, 267, 278, 301, 305, 321, 337, 343, 344, 345, 356, 359, 374, 382, 383, 384, 389, 396, 397, 411, 414, 418, 431, 443, 465, 499, 511, 518, 544, 555

Yanlış : 379

R-Represyon (Welsh, 1954)

Doğru : Yok

Yanlış : 1, 6, 9, 12, 39, 51, 81, 112, 126, 131, 140, 145, 154, 156, 191, 208, 219, 221, 271, 272, 281, 282, 327, 406, 415, 429, 440, 445, 447, 449, 450, 451, 462, 468, 472, 502, 516, 529, 550, 556

MAS-Açık Anksiyete Ölçeği (Taylor, 1953)

Doğru : 13, 14, 23, 31, 32, 43, 67, 86, 125, 142, 158, 186, 191, 217, 238, 241, 263, 301, 317, 321, 322, 335, 337, 340, 352, 361, 397, 418, 424, 431, 439, 442, 499, 506, 530, 549, 555

Yanlış : 7, 18, 107, 163, 190, 230, 242, 264, 287, 371, 407, 523, 528

Es-Ego Gücü (Barron, 1953)

Doğru : 2, 36, 51, 95, 109, 153, 174, 181, 187, 192, 208, 221, 231, 234, 253, 270, 355, 367, 380, 410, 421, 430, 458, 513, 515

Yanlış : 14, 22, 32, 33, 34, 43, 48, 58, 62, 82, 94, 100, 132, 140, 189, 209, 217, 236, 241, 244, 251, 261, 341, 344, 349, 359, 378, 384, 389, 420, 483, 488, 489, 494, 510, 525, 541, 544, 548, 554, 555, 559, 561

Lb-Bel Ağrısı (Hanvik, 1949)

Doğru : 62, 111, 127, 238, 346

Yanlış : 3, 45, 98, 109, 148, 153, 180, 190, 230, 267, 321, 327, 378, 394, 429, 483, 502, 504, 516, 536

Ca-Arka Beyin Hasarı (Williams, 1952)

Doğru : 28, 39, 76, 94, 142, 147, 159, 180, 182, 189, 236, 239, 273, 313, 338, 343, 361, 389, 499, 512, 544, 549, 551, 560

Yanlış : 8, 46, 57, 69, 163, 188, 242, 407, 412, 450, 513, 523

Dy-Bağımlılık (Navran, 1954)

Doğru : 19, 21, 24, 41, 63, 67, 70, 82, 86, 98, 100, 138, 141, 158, 165, 180, 189, 201, 212, 236, 239, 259, 267, 304, 305, 321, 337, 338, 343, 357, 361, 362, 375, 382, 383, 390, 394, 397, 398, 408, 443, 487, 488, 489, 509, 531, 549, 554, 564

Yanlış : 9, 79, 107, 163, 170, 193, 264, 369

Do-Üstünlük (Gough, McClosky, & Meehl, 1951)

Doğru : 64, 229, 255, 270, 368, 432, 523

Yanlış : 32, 61, 82, 86, 94, 186, 223, 224, 240, 249, 250, 267, 268, 304, 343, 356, 395, 419, 483, 558, 562

Re-Sosyal Sorumluluk (Gough, McClosky, & Meehl, 1952)

Doğru : 58 111, 173, 221, 294, 412, 501, 552

Yanlış : 6, 28, 30, 33, 56, 116, 118, 157, 175, 181, 223, 224, 260, 304, 419, 434, 437, 468, 469, 471, 472, 529, 553, 558

Pr-Önyargı (Gough, 1951)

Doğru : 47, 84, 93, 106, 117, 124, 136, 139, 157, 171, 186, 250, 280, 304, 307, 313, 319, 323, 338, 349, 373, 395, 406, 411, 435, 437, 469, 485, 543

Yanlış : 78, 176, 221

St-Sosyal Durum (Gough, 1948)

Doğru : 78, 118, 126, 149, 199, 204, 229, 237, 289, 430, 441, 452, 491, 513, 521

Yanlış : 136, 138, 180, 213, 249, 267, 280, 297, 304, 314, 324, 352, 365, 378, 388, 427, 448, 480, 488

Cn-Kontrol (Cuadra, 1953)

Doğru : 6, 20, 30, 56, 67, 105, 116, 134, 145, 162, 169, 181, 225, 236, 238, 285, 296, 319, 337, 382, 411, 418, 436, 446, 447, 460, 529, 555

Yanlış : 58, 80, 92, 96, 111, 167, 174, 220, 242, 249, 250, 291, 313, 360, 378, 439, 444, 483, 488, 489, 527, 548

EK B

Grayson'un Kritik Maddeleri

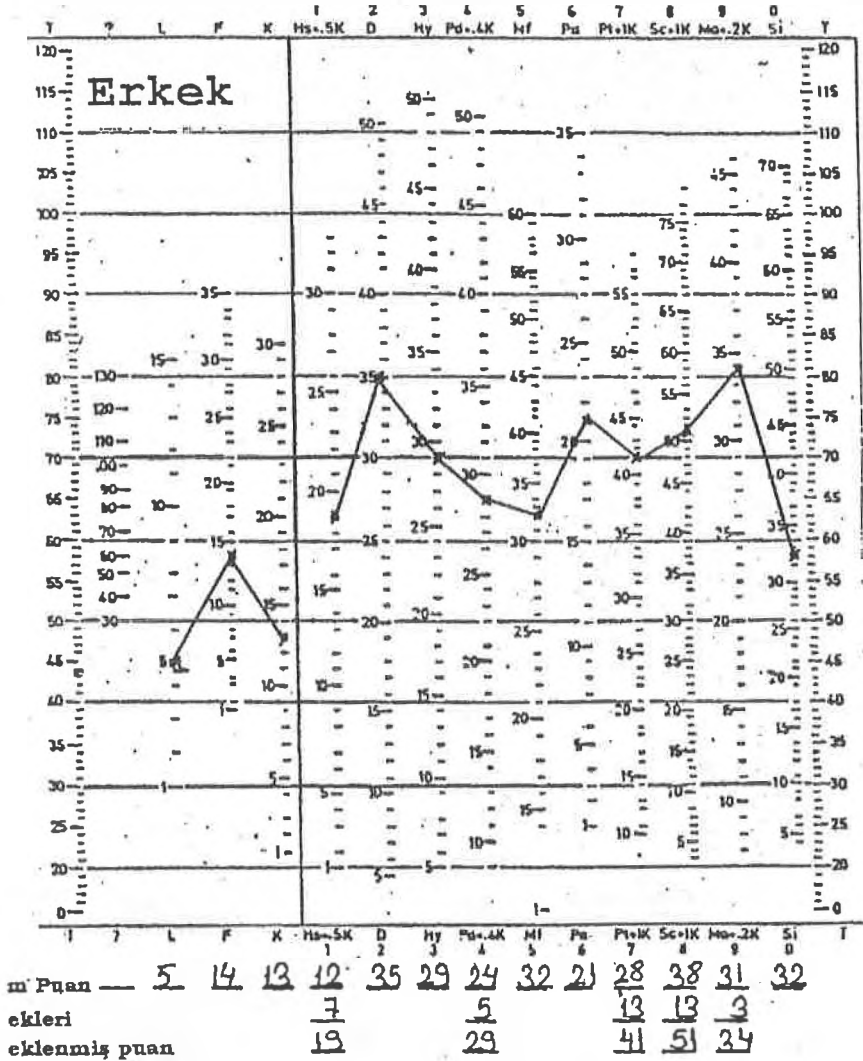
Doğru : 27, 33 (323), 44, 48, 66, 69, 74 (Erkek için), 85, 114, 121, 123, 139, 146, 151, 156, 168, 179, 182, 184, 200, 202, 205, 209, 215, 251, 275, 291, 293, 334, 337, 339, 345, 349, 350, 354

Yanlış : 20 (310), 37 (302), 74 (Kadın için), 133

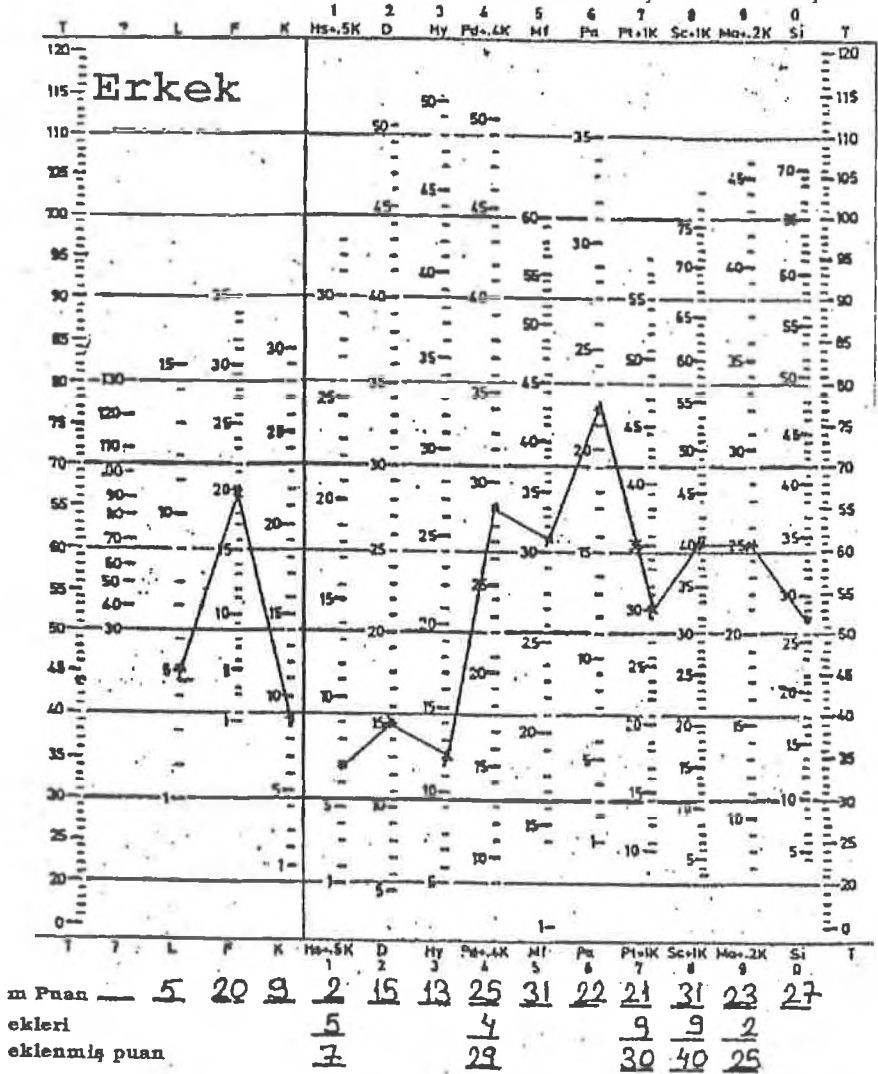
NOT: Parantez içine alınmış maddeler, aynı maddenin kitapçıkta tekrarlandığı yeri göstermektedir.

EK C

ALİŞTIRMA İÇİN TÜRK KLİNİK ÖRNEKLEMİNDEN PROFİLLER

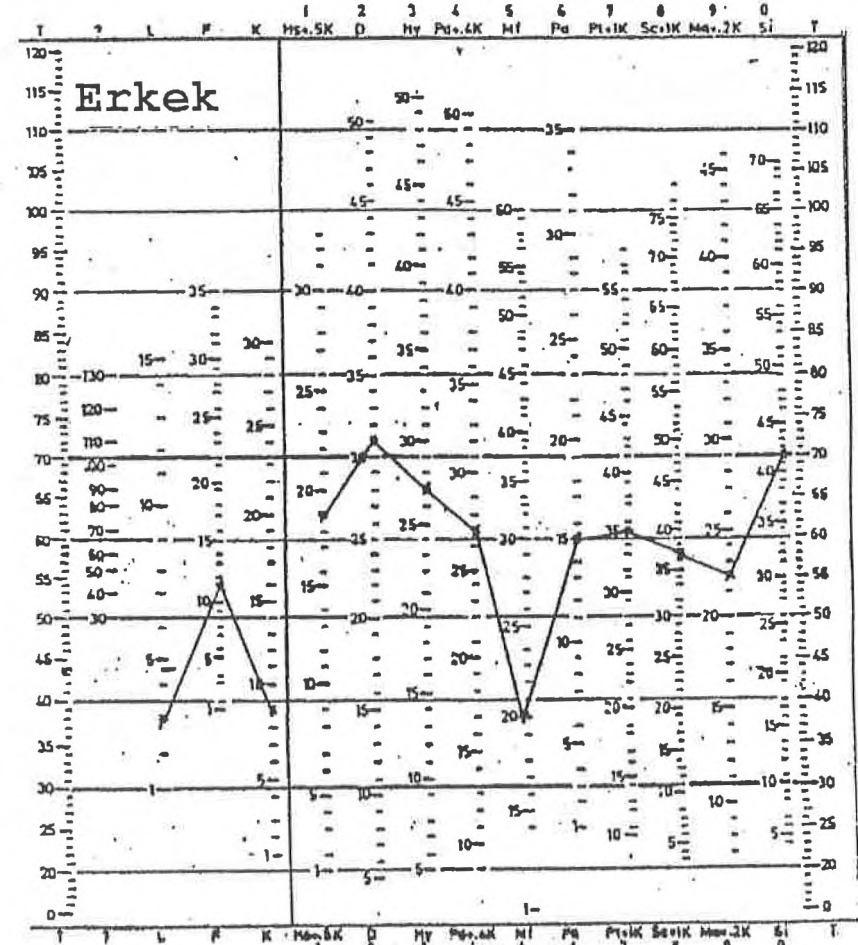


PROFİL
MINNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK



40 yaşında, yüksek eğitilmiş, mali müşavir, bekar.

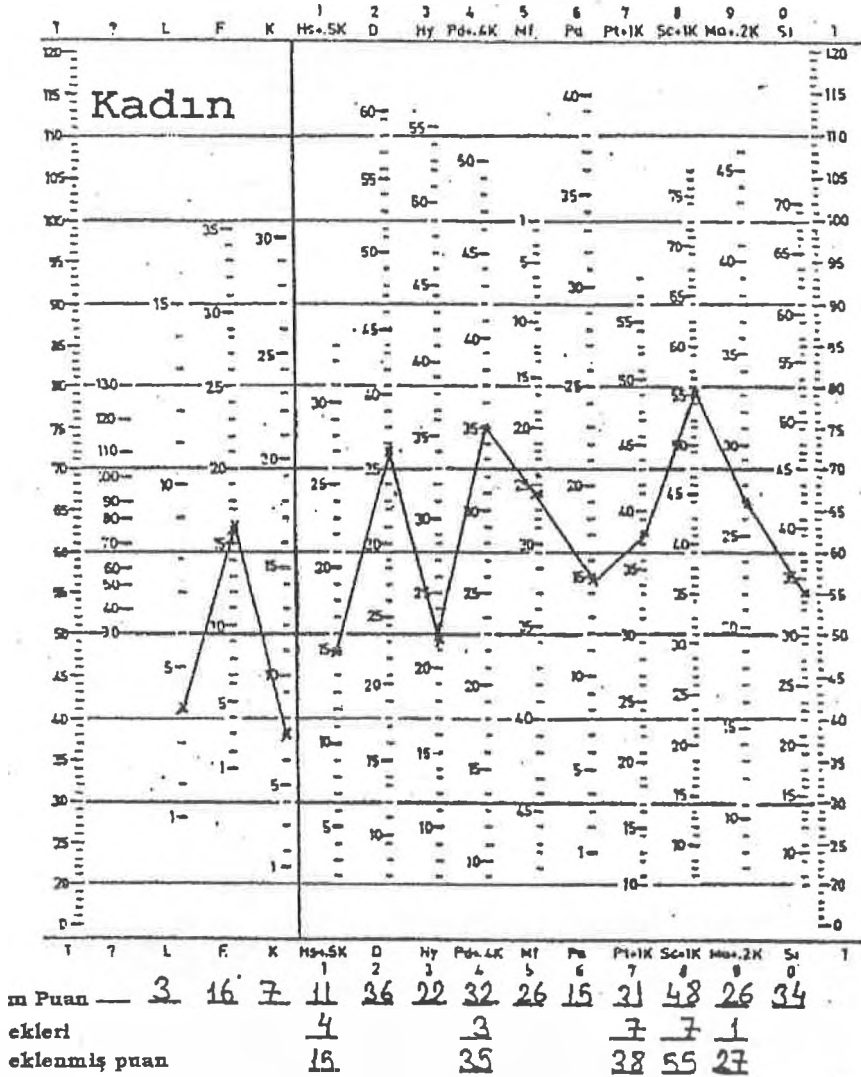
PROFİL
MİNNEOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK



m Puan — 3 11 9 14 31 27 23 20 15 26 28 20 42
 ekleri — 5 4 9 9 2
 eklenmiş puan — 19 27 35 37 22

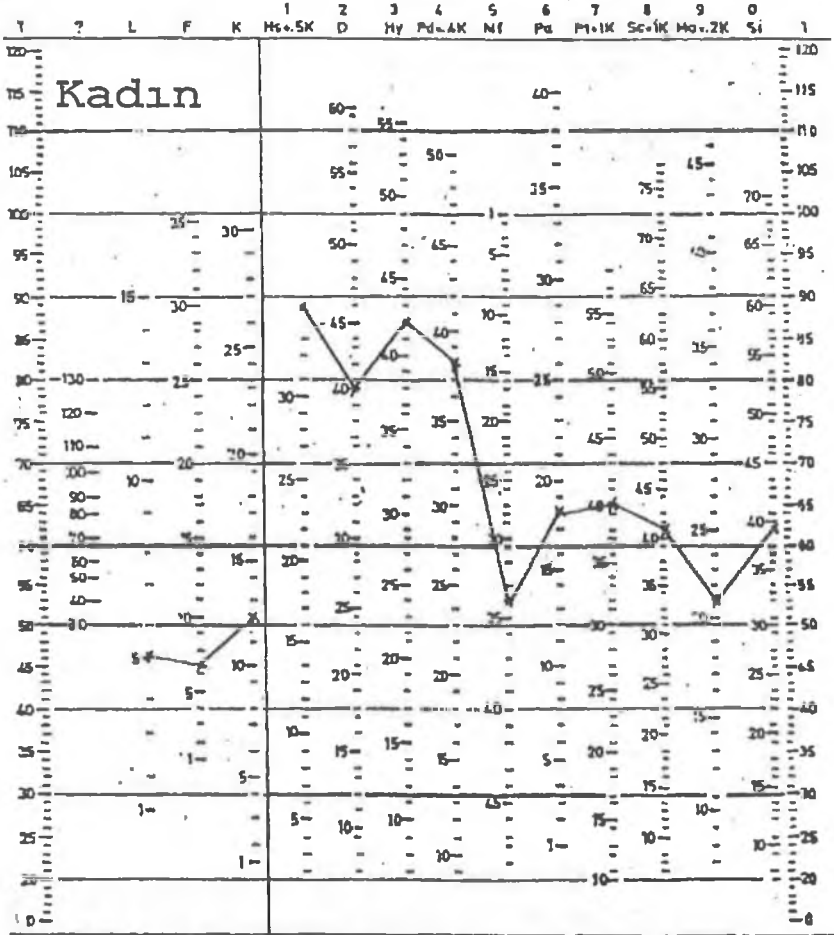
23 yaşında, Mühendislik Fakültesi öğrencisi, bekar.

PROFİL
MINNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK



17 yaşında, Lise II. sınıf öğrencisi

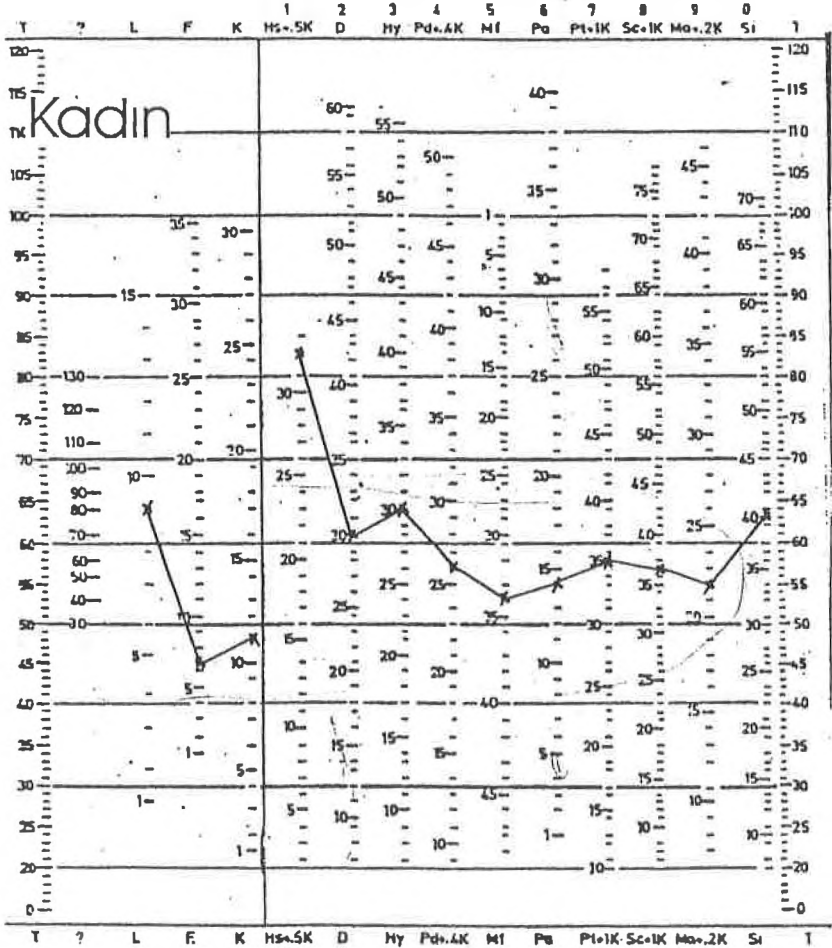
PROFİL
MINNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK



m Puan	5	7	12	30	40	42	33	34	18	28	19	19	29
ekleri				6			5			12	12	2	
eklenmiş puan				36			38			40	41	21	

27 yaşında, ortaokul mezunu, ev hanımı, evli

PROFİL
MINNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK



m Puan — 9 7 11 26 30 30 22 34 14 24 26 20 40
 ekleri 6 4 11 11 2
 eklenmiş puan 32 26 35 37 22

37 yaşında, lise mezunu, ev hanımı, evli